

Ticro Goto
Kreativer Suizid

HINWEIS

Dieses Buch ersetzt keinen Arzt. Es ersetzt, was Ärzte verschweigen. Wer den Inhalten folgt, tut das auf eigene Verantwortung. Wer ihnen nicht folgt, auch.

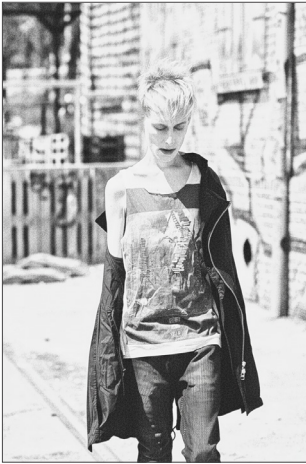


Foto: Martin Strauss

Dreißig Zigaretten am Tag, fünfzehn Jahre lang. Kein Ratgeber kommt an die Stelle, an der der Entschluss entsteht. Also ging er selbst hinein und schrieb den Text für diese Stelle. Seitdem keine einzige Zigarette.

Ticro Goto ist Historiker und Ethnologe. Er studierte an der Kunsthochschule Kassel, der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu seinen Veröffentlichungen zählen *Cyberfakte* (2016) und *Der Ewige Palast* (2024). Fiktionale Literatur veröffentlicht er unter dem Pseudonym Emilie von Drachenfels. Seine Texte entstehen handschriftlich. Inspiriert von historischen Tonika gründete er 2025 ein Start-up für funktionales Soda. Texte auf *kokos-und-zitrone.de*.

TICRO GOTO

KREATIVER SUIZID

RAUCHEN, HUNGER UND DIE LÖGE
VOM INNEREN KIND

CUM NOTIS



CHARLOTTENBURG

*Solange ich den Dämon nicht benenne, wird er mich immer wieder
heimsuchen.*

*Er wird immer wieder an meiner Tür klopfen, mir immer wieder in die
Quere kommen, egal wohin ich laufe.*

*Um den Dämon zu besiegen, muss ich ihn aussprechen. Ich muss ihm in
die Augen sehen und seinen Namen nennen. Ich muss ihn besser verstehen
als er sich selbst. Und ich muss ihn ans Licht zehren, damit ihn alle sehen.*

Dann verschwindet er und kommt nie wieder.

Unveränderte Originalausgabe

Copyright © 2026
Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Form der
Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung — ob ganz oder
in Teilen — bedarf der schriftlichen Zustimmung des Autors.

Text und Konzeption dieses Werkes entstanden ohne den
Einsatz generativer KI-Systeme. Die Nutzung für Text- und
Data-Mining gemäß § 44b UrhG ist nicht gestattet.

Umschlaggestaltung, Illustration und Satz: Ticro Goto
Druck und Vertrieb im Auftrag des Autors.

ISBN 979 8 25262 461 7

INHALT

1	Hirntod auf Raten	9
2	Heilen war nie der Plan	23
3	Was Idioten glauben	39
4	Fünfundzwanzig Kilo Nebel	55
5	Rauchen ist keine Sucht	67
6	Notausgang ins Nichts	83
7	Kaffee macht nicht wach	131
8	Persönlichkeit ist löslich	155
9	Die Hölle ist kein Ort	169
10	Vier Zutaten und eine Lüge	193
11	Die Krankheit, die es nie gab	201
12	Zwanzig Prozent	215
13	Entzündung als Kulturtechnik	235
14	Angst vor Gesundheit	245
15	Das innere Kind muss sterben	257
16	Die Lüge auf der Zunge	265
17	Body Positivity tötet	277
18	Beobachtung verascht jeden Dämon	295

DEM, DER ICH HÄTTE SEIN KÖNNEN

HIRNTOD AUF RATEN

*What goes up in smoke?
Your brain.*

Rauchen ist tödlich — steht auf der Packung. Aber das interessiert niemanden. Es ist ja abstrakt. Es hält mich nicht davon ab, mir hier und jetzt eine Zigarette anzuzünden. Mein Leben ändern kann ich auch morgen. Und überhaupt. Es ist so stressig gerade — nächstes Jahr reicht vollkommen.

Dachte ich jedenfalls.

Bis ich bemerkte, wie meine Klarheit abnahm, ich vergesslich wurde, jede Woche ein wenig mehr. Ich verlegte Gegenstände, hatte Schwierigkeiten, mich an Gespräche zu erinnern. Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Nicht die Aussicht auf ein verkürztes Leben war es, das mich verstörte. Es war mein schleichendes Verschwinden.

Ich war desorientiert, überfordert, Aufgaben zu planen und zu erfüllen. Sogar beim Sprechen, ausgerechnet beim Sprechen, traten Anomalien auf: Wörter verschwanden mitten im Satz, während meine Stimmung dumpf und meine Gefühle flach wurden.

Es gibt einen Namen dafür: *Mild Cognitive Impairment* — eine kognitive Störung, die als Vorstufe von Demenz oder Alzheimer gilt. Fünfzehn Prozent aller Menschen, die fünfzig oder älter sind, und ganz normal zu Hause leben, haben MCI.¹

1 Wei Bai, Pan Chen, Hong Cai, et al., »Worldwide prevalence of mild cognitive impairment among community dwellers aged 50 years and older: a meta-

Ich suchte einen Ausweg aus dieser nunmehr siebenjährigen Gefangenschaft, in der Wörter zu Fremden wurden, Gedanken zu Nebel, Erinnerungen zu Sand zwischen den Fingern. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass Rauchen ihr Denken zer setzt. Sie suchen woanders nach Antworten. So wie ich. Indes ich die Antwort täglich zwischen den Lippen hielt: eine kleine weiße Röhre, die das Gehirn demontiert.

Rauchen ist nicht »tödlich«: es ist Selbstmord auf Raten, bei dem das Gehirn zuerst stirbt und der Körper zusieht. Bevor ein Raucher stirbt, stirbt sein Ich. Die Leiche atmet noch zwanzig Jahre weiter — neuronales Vakuum im Aschege ruch.

Das ist die große gesellschaftliche Täuschung unserer Zeit: Wir behandeln die stärkste legal verfügbare Droge wie harmlosen Zeitvertreib. Reden über Rauchen, als ginge es um ein fer nes Todesurteil. Lungenkrebs in zwanzig Jahren, Herzinfarkt irgendwann. Abstrakte Drohungen für ein zukünftiges Ich. Dabei geschieht die eigentliche Tragödie heute, wenn das Nikotin durch die Synapsen strömt und das macht, was Gift eben macht: es vergiftet.

Bekanntlich wurde Nikotin von der Tabakpflanze ursprünglich als natürliches Pestizid gebildet. Verbrennt man den Tabak, flutet der Rauch das Nervengewebe mit einer Giftküche aus (je nach Quelle) vier- bis siebentausend Substanzen.² Darunter Schwermetalle wie Blei und Cadmium, radioaktives Polonium,

analysis and systematic review of epidemiology studies«, in: *Age and Ageing*, Vol. 51, Issue 8, 17.08.2022, afac173.

2 Reinskje Talhout, Thomas Schulz, Ewa Florek, et al., »Hazardous Compounds in Tobacco Smoke«, in: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 8, Issue 2, 23.02.2011, 613—28.

Centers for Disease Control and Prevention (US), »Chemistry and Toxicology of Cigarette Smoke and Biomarkers of Exposure and Harm«, in: *How Tobacco Smoke Causes Disease: The Biology and Behavioral Basis for Smoking-Attributable Disease: A Report of the Surgeon General*, Atlanta 2010, 27—102.

radioaktives Uran, Arsen, Formaldehyd, Benzol und Blausäure.³ Blei wirkt neurotoxisch, beeinträchtigt die Hirnentwicklung.⁴ Cadmium stammt aus Batterien, wirkt genotoxisch, verursacht Krebs und Leukämie.⁵

Polonium-210 ist eine der Hauptursachen für Lungenkrebs und zerebrale Mikroverletzungen.⁶ Diese und andere Substanzen akkumulieren in Organen und verursachen Zellstress.⁷ Reparaturmechanismen werden überlastet, Verschleißprozesse beschleunigt. Raucher leiden häufiger unter Neuropathien oder verlangsamter Nervenleitung, was angesichts der vaskulären und oxidativen Schädigungen pathophysiologisch plausibel ist. Die Toxine begünstigen Sauerstoffmangel und Eiweißablagerungen. Durchblutungsstörungen und verstopfte Hirnarterien führen zu vaskulärer Demenz. Hirngewebe stirbt in kleinen Infarkten ab.

3 Arsen ist ein beliebtes Rattengift und wird im Tabakanbau als Pestizid verwendet. Ammoniak aus Reinigungs- und Düngemitteln verstärkt neben dem Nikotin die süchtigmachende Wirkung. Kohlenmonoxid kennen wir aus Autoabgasen — es verdrängt Sauerstoff im Blut. Blausäure blockiert die Zellatmung — das Gas war der Wirkstoff in Zyklon B.

4 U.S. Food and Drug Administration, »Chemicals in Tobacco Products and Your Health«, Washington D.C., 05.01.2020, abgerufen am 06.09.2025.
American Cancer Society, »Harmful Chemicals in Tobacco Products«, 19.11.2024, abgerufen am 06.09.2025.

5 Angelika Edyta Charkiewicz, Wioleta Justyna Omeljaniuk, Karolina Nowak, »Cadmium Toxicity and Health Effects—A Brief Summary«, in: *Molecules*, Vol 28, Issue 18, 14.09.2023, 6620.

Jacopo Junio Valerio Branca, Gabriele Morucci, Alessandra Pacini, »Cadmium-induced neurotoxicity: still much ado«, in: *Neural Regeneration Research*, Vol. 13, Issue 11, November 2018, 1879—82.

6 Deborah Blum, »So About That Glowing Cigarette«, in: *Wired*, 14.12.2012, abgerufen am: 06.09.2025.

7 Klaudia Jomova, Suliman Y. Alomar, Eugenie Nepovimova, et al., »Heavy metals: toxicity and human health effects«, in: *Archives of Toxicology*, Vol. 99, 20.11.2024, 153—209.

Gedächtnis und Konzentration, sogar meine Fähigkeit zur Entscheidungsfindung ist vermindert. Und bei alledem verhindert mein Dopaminspiegel, mir dessen bewusst zu werden.

Wie Rauchen die Kognition beeinträchtigt, ist gut untersucht.⁸ Eisen, Kupfer und Zink befinden sich im Zigarettenrauch. Sie sammeln sich im Kopf und beeinträchtigen das Denken.⁹ Außerdem lädiert Rauchen die weiße Substanz.¹⁰ Das sind myelin-, also fettumhüllte Fasern und Zellen, die Signale zwischen den Bereichen und damit komplexe Fähigkeiten wie Denken, Wahrnehmung und Bewegung ermöglichen. Mikroskopische Narben bewirken eine Verarmung des Geistes.¹¹

Also hörte ich auf. Zigaretten schmecken ohnehin scheußlich und ich muss noch ein paar Bücher schreiben, bevor ich dumm und dement bin.

Dann wurde ich reizbar, wütend, ängstlich. Körperlich ging es mir besser, aber meine Konzentration war dahin. Durcheinander war ich, konnte mir wenig merken. Das geht vorbei, dachte ich, und wartete. Tage, Wochen. Aber es ging nicht vorbei — Nebel überall. Ich bekam Heißhunger, aß unaufhörlich, fühlte mich elend.

Trank Kaffee, noch elender.
Alkohol — Licht aus.

8 Gerald Valentine, Mehmet Sofuoglu, »Cognitive Effects of Nicotine: Recent Progress«, in: *Current Neuropsychopharmacology*, Mai 2018, Vol. 16, Issue 4, 403—14.

9 Hui Li, Qingshuang Mu, Yimin Kang, et al., »Association of Cigarette Smoking With Male Cognitive Impairment and Metal Ions in Cerebrospinal Fluid«, in: *Frontiers in Psychiatry*, Vol. 12, 19.11.2021.

10 Martine Elbejjani, Reto Auer, David R. Jacobs, »Cigarette smoking and gray matter brain volumes in middle age adults: the CARDIA Brain MRI sub-study«, in: *Translational Psychiatry*, 11.02.2019, Vol. 9, Artikel 78.

11 Roopa Sharma, Sandeep Sekhon, Forshing Lui, Marco Cascella, »White Matter Lesions«, in: *StatPearls*, 07.03.2024.

Verlangen nach einer Zigarette hatte ich nicht. Doch ohne Lösung für meine substanzinduzierte Hirnläsion würde ich demnächst womöglich meine Miete nicht mehr bezahlen können. Weitere Wochen vergingen. Und mir drohte der Bauch zu platzen.

Ich zwang mich, wieder anzufangen.

Man könnte fast meinen: aus Vernunftgründen.

Genauigkeit, Aufmerksamkeit, Feinmotorik, Kurzzeitgedächtnis — alles wieder da, vorerst. Nicht so gut, wie es war, bevor ich das erste Mal mit dem Rauchen anfang. Aber besser, als es war, als ich das letzte Mal versuchte, aufzuhören.

Denn wenn Nikotin ins Blut eintritt, Endorphine ausschüttet und den Dopaminspiegel erhöht, verändern sich Gehirnbereiche, die für Stressbewältigung, Lernen und Selbstkontrolle nötig sind. Wer nie geraucht hat, verfügt darüber auch, meist besser. Aber da Nikotin den Stoffwechsel umbaut, kehren diese natürlichen Fähigkeiten nach dem Aufhören nicht mehr zurück.

Grund: die Gehirndurchblutung. Nikotin verengt die Blutgefäße im Kopf, Nervenzellen hungern nach Sauerstoff und Vitalstoffen. Giftstoffe fördern Arterienverkalkung und verschlechtern die Gehirndurchblutung zusätzlich. Wenn ich mit dem Rauchen aufhöre, verschwindet der angerichtete Schaden nicht einfach: die Gehirndurchblutung bleibt beeinträchtigt. Das fand man mithilfe der *arterial-spin-labeling*-Bildgebung (ASL) heraus, bei der die Durchblutung in verschiedenen Regionen gemessen wurde, die mit Demenz in Verbindung stehen.¹²

Daher die kognitiven Defizite beim Aufhören. Nikotin täuscht Wachheit vor. Es aktiviert kurzfristig die Aufmerksamkeit,

12 Martine Elbejjani, Reto Auer, Sudipto Dolui, et al., »Cigarette smoking and cerebral blood flow in a cohort of middle-aged adults«, in: *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism*, Vol. 39, Issue 7, 22.01.2018, 1247—57.

während es sie langfristig zerstört. Es gibt einen Moment der Schärfe und nimmt dafür Jahre der Klarheit. Sieben Sekunden nach dem Zug hat das Gift die Blut-Hirn-Schranke durchbrochen. Herzschlag und Blutdruck schießen empor, der Körper geht in Alarmbereitschaft, während Dopamin Wohlgefühl vorgaukelt.

Diese vermeintliche Entspannung ist eine Lüge. Sie rührt daher, dass eine Unruhe beseitigt wird, die Nichtraucher gar nicht kennen. Mit jeder Zigarette erzeugt und löscht der Raucher selbsterzeugten Stress. Die Nervenzellen stumpfen ab, verlangen neues Nikotin. Eine Endlosschleife.

Was ich nicht wusste: dass Raucherhirne noch Jahre nach dem Aufhören messbar anders durchblutet werden als Nichtraucherhirne. Sobald ich aufhöre, verhält sich meine Gehirndurchblutung nicht wie vor dem Rauchen. Sie bleibt die eines Rauchers. Nur dass der Schaden jetzt aufpoppt, nicht mehr überdeckt von Dopamin.

Man stelle sich eine Glühbirne vor, die mit jedem Zug schwächer wird. 75 Watt am Anfang, 50 Watt nach Jahren. Jede Zigarette: ein kurzer Lichtblitz, wie wenn man die Sicherung überlastet. Dann dunkler als zuvor. Wer aufhört, friert den Schaden ein — bewahrt die Ruine vor dem Einsturz. Aber die ursprüngliche Klarheit kehrt nicht zurück.

Das erklärt auch, weshalb mein Verlangen nach salziger Kost so heftig wurde. Und nach Kaffee. Und weshalb ich sogar Alkohol trank, als all dies nicht half. Nicht Nikotin bindet mich. Es ist die Panik, in die mein Gehirn gerät, wenn es nicht richtig durchblutet wird. Das Denken tappt im Dunklen. Es ist, als würde man in der Luft hängen. Wer zusätzlich an Anämie leidet — wie bei mir der Fall —, mag sich über Schwindelanfälle nicht wundern.

Und zähflüssig macht Tabakrauch das Blut. Das führt zu Mikroschlaganfällen, die gar nicht so mikro sind. Das

Kohlenmonoxid im Rauch verursacht ebenfalls Schlaganfälle, weil es den Sauerstoffgehalt im Blut reduziert. Auch Nikotin selbst erhöht die Herzfrequenz, demnach den Blutdruck, demnach das Schlaganfallrisiko. Sechsmal wahrscheinlicher habe ich einen Schlaganfall, wenn ich Tabakprodukte konsumiere.

Die meisten Menschen denken bei den Folgen des Rauchens zuerst an die Lunge. Aber die Aussicht, an Lungenkrebs zu sterben, bleibt abstrakt. Das eigentliche Ziel ist das Gehirn. Vierzig Prozent der Menschen mit Lungenkrebs entwickeln Hirnmetastasen — einen bösartigen Gehirntumor.¹³ Wer langfristig raucht, trägt doppelt so häufig Ablagerungen jener Proteine im Stirnlappen, die Alzheimer charakterisieren. Jede Packung verstärkt die vaskulären Mikroschäden, verengt die Kapillaren des Hirngewebes und beschleunigt die Verkalkung der weißen Substanz, bis Gedankenfluss sich anfühlt wie eine Fahrt über Schlaglochpisten. Bereits wenige Zigaretten fügen den temporalen Hirnwindungen Verletzungen zu, die sich später in stockendem Wortabruf oder orientierungslosen Momenten bemerkbar machen. *Im Schnitt verlieren Raucher sieben IQ-Punkte* — ein Verlust, der sich nicht mit Sudoku wegtrainieren lässt.¹⁴

Die Großhirnrinde ist messbar dünner, der Hippocampus — der Erinnerungen verankert und Orientierung ermöglicht — signifikant reduziert.¹⁵ Kohortenstudien mit über 10.000 Probanden belegen die messbare Zerstörung: die graue Hirnsubstanz

13 Shih-Ying Wu, Fei Xing, Sambad Sharma, et al., »Nicotine promotes brain metastasis by polarizing microglia and suppressing innate immune function«, in: *Journal of Experimental Medicine*, Vol. 217, No. 8, 04.06.2020, e20191131.

14 Mark Weiser, Salman Zarka, Nomi Werbeloff, et al., »Cognitive test scores in male adolescent cigarette smokers compared to non-smokers: a population-based study«, in: *Addiction*, Vol. 105, Issue 2, 11.01.2010, 358—63.

15 Jürgen Gallinat, Undine Lang, Leslie Jacobsen, et al., »Abnormal Hippocampal Neurochemistry in Smokers«, in: *Journal of Clinical Psychopharmacology*, Vol. 27, Issue 1, Februar 2007, 80—4.

— in der Denken entsteht — schmilzt dahin, während der Mensch sich geistig hell wähnt.¹⁶ Schon eine Zigarette korreliert messbar mit Hirnschwund. Das ist wissenschaftlich dokumentiert und statistisch signifikant. Je mehr Zigaretten ich rauche, desto kleiner wird mein Gehirn.¹⁷ Es besteht eine Dosis-Wirkungs-Beziehung. Raucher besitzen in Hirnregionen, die für Kognition zuständig sind, nicht nur weniger Nervenzellen, sondern bis zu 3,36 cm³ weniger Gesamtvolumen.¹⁸ Die graue Substanz ist davon stärker betroffen als die weiße¹⁹ — 2,96 cm³ bei der grauen gegenüber 0,80 cm³ bei der weißen Substanz.²⁰ Weniger graue Substanz reduziert meine Denkfähigkeiten.²¹ Weniger Gehirnvolumen verstärkt diesen Effekt.²²

16 Somayeh Meysami, Saurabh Garg, Sam Hashemi, et al., »Smoking predicts brain atrophy in 10,134 healthy individuals and is potentially influenced by body mass index«, in: *npj Dementia*, 23.07.2025, Art. 17.

17 Peng Peng, Min Li, Han Liu, et al., »Brain Structure Alterations in Respect to Tobacco Consumption and Nicotine Dependence: A Comparative Voxel-Based Morphometry Study«, in: *Frontiers in Neuroanatomy*, Vol. 12, Artikel 43, 24.05.2018.

Robby Berman, »Smoking causes brain shrinkage, but quitting may prevent further loss«, in: *Medical News Today*, 18.12.2023.

18 Yoonhoo Chang, Vera Thornton, Ariya Chaloehtoom, et al., »Investigating the Relationship Between Smoking Behavior and Global Brain Volume«, in: *Biological Psychiatry Global Open Science*, Vol. 4, Issue 1, Januar 2024, 74—82.

19 Martine Elbejjani, Reto Auer, David R. Jacobs, »Cigarette smoking and gray matter brain volumes in middle age adults: the CARDIA Brain MRI sub-study«, in: *Translational Psychiatry*, 11.02.2019, Vol. 9, Artikel 78.

20 Chang et al., ebd.

21 Zhanxiong Wu, Yun Peng, Ming Hong, Yingchun Zhang, »Gray Matter Deterioration Pattern During Alzheimer's Disease Progression: A Regions-of-Interest Based Surface Morphometry Study«, in: *Frontiers in Aging Neuroscience*, Vol. 13, 03.02.2021, 593898.

22 Deepti Vibha, Henning Tiemeier, Saira S. Mirza, et al., »Brain Volumes and Longitudinal Cognitive Change: A Population-based Study«, in: *Alzheimer*

Beides erzeugt Demenz. Durch Rauchen steigt das Risiko um dreißig Prozent, für Alzheimer um vierzig Prozent.²³ Weltweit sind vierzehn Prozent der Demenzfälle raucherbedingt.²⁴ Sie haben sich ihre geistige Umnachtung selbst angezündet. Während ich glaube, meine Lunge zu vergiften, schrumpfe ich mein Gehirn. Rauch steigt aus meinem Mund, löst meine Synapsen in Luft auf. Er riecht nach verbranntem Glück. Asche fällt zu Boden, und mit ihr meine Erinnerung.

Rauchen zerstört im Schneckengang, aber mit der Präzision einer Schneidbrennerflamme. Es schädigt durch messbare Gegenwartsverluste. Es tötet nicht einfach, es entstellt das Leben, bevor es endet. Es stiehlt die Qualität jedes einzelnen Tages. Es ist die nachlassende Klarheit im Hier und Jetzt, der sichtbare Verfall, die Vergesslichkeit, die Wortfindungsprobleme, die Versprecher, die Unfähigkeit zur tiefen, sinnlichen Empfindung.

Nicht das kürzere Leben macht es tragisch, sondern das kurze Leben als Schatten meiner selbst, das Leben in Blödsinnigkeit, Hässlichkeit, Lustlosigkeit. Es ist das eingefallene, alt und gelb wirkende Gesicht, die unhübschen Zähne, das Gefühl von Minderwertigkeit und Schuld beim Rauchen, die Anspannung und Unruhe, die Schmerzen im Nacken, der Gehirnnebel — dieser verdammte Gehirnnebel —, die Artefakte vor den Augen, die heisere Stimme, der flache Atem, das merkwürdige Ziehen in der Brust, die kribbelnden Füße und Hände, die Unmöglichkeit,

Disease & Associated Disorders, Vol. 32, Issue 1, Jan/Mär 2018, 43—9.

23 Guochao Zhong, Yi Wang, Yong Zhang, et al., »Smoking Is Associated with an Increased Risk of Dementia: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies with Investigation of Potential Effect Modifiers«, in: *PLoS ONE*, Vol. 10, Issue 4, 12.03.2015, e0126169.

24 Timothy C. Durazzo, Niklas Mattsson, Michael W. Weiner, »Smoking and increased Alzheimer's disease risk: A review of potential mechanisms«, in: *Alzheimer's & Dementia*, Vol. 10, Issue 3 (Suppl.), 01.06.2014, 122—45.

mich einfach mal pudelwohl zu fühlen. Die Bilanz addiert sich nicht bloß zu verlorenen Jahren, sondern zu verlorenen Gedanken, Erinnerungen und Persönlichkeitsfacetten — bis nur noch Rauch übrig ist.

Womit sich die Frage aufdrängt, wie viel Bier ich eigentlich täglich trinken müsste, um denselben Hirnschaden anzurichten wie eine Schachtel Zigaretten. Tatsächlich eine Menge, die jede Leber in eine bröselnde Narbe verwandeln würde. Der neurotoxische Schlag einer einzigen Zigarette entspricht erwiesen dem eines Standard-Drinks — das ist ein Schluck aus knapp einem Achtel-liter Schnaps, ein halbes Glas Wein, eine knappe Flasche Bier.²⁵

Fünf Zigaretten entsprechen demnach fünf Standard-Drinks. Das raucht mancher, bevor andere überhaupt wach sind. Wer täglich eine Schachtel raucht, müsste vierzehn Flaschen Bier am Tag trinken, um dieselbe vorzeitige Alterung, Hirnvergiftung und Schädigung seiner Denk- und Konzentrationsfähigkeit zu bewirken. Zwanzig Zigaretten treiben den neuronalen Aderlass auf das Niveau schwerster Alkoholsucht, nur dass hier nicht die Kneipentheke, sondern der Zigarettenautomat das Organakataster ruiniert.²⁶

25 Harpreet Jaswel, Ivneet Sohi, Jürgen Rehm, et al., »A drink equals how many cigarettes? Equating mortality risks from alcohol and tobacco use in Canada«, in: *Frontiers in Public Health*, Vol. 12, 27.02.2024;

Shannon Waters, »>One drink is the same mortality risk as one cigarette,< UVic researcher says«, in: *Capital Daily*, 01.01.2023;

Tamara Bhandari, »Smoking causes brain shrinkage: Findings help explain how smoking is linked to Alzheimer's, dementia«, in: *Wash U Medicine News*, 12.12.2023.

26 Martine Elbejjani, Reto Auer, David R. Jacobs, et al., »Cigarette smoking and gray matter brain volumes in middle age adults: the CARDIA Brain MRI sub-study«, in: *Translational Psychiatry*, Februar 2019, Vol. 9, Art. 78.

Niemand würde freiwillig jeden Tag einen Kasten Bier leeren. Die Vorstellung allein ist grotesk. Aber eine Schachtel Zigaretten gilt vielerorts als belanglose Marotte. Fast moderat klingen drei Zigaretten. Drei Bier hingegen, und die Welt nennt es Vollrausch. Die Berechnung zeigt, wie verzehrt unsere Wahrnehmung ist. Die Kurve der Gesamtsterblichkeit zeigt einen steileren Anstieg für Gelegenheitsraucher als für moderates Trinken.²⁷ Multiplizieren lässt sich der Schaden, wenn ich beides tue. Der Abbau der Kognition beschleunigt sich bei trinkenden Rauchern um 36 Prozent.²⁸ Die kombinierte Exposition beschleunigt den Verlust weißer Hirnsubstanz — jener Myelinfasern, die unsere Gedanken übertragen.²⁹ Das Gehirn brennt in stillem Feuer buchstäblich ab.

Doch wir haben es normalisiert. Wir akzeptieren eine Substanz, die das Gehirn schädigt wie Alkohol. Sagen »Gelegenheitsraucher«, als gäbe es so etwas wie gelegentliche Hirnvergiftung. Lautlos ätzt sich Tabak ins Gewebe, verstopft Kapillaren, zerfranst DNA, verschmort Alveolen — um doch bis zum letzten Zug die Illusion zu vermitteln, dies alles geschehe morgen. Denn

27 Maki Inoue-Choi, Carol H. Christensen, Brian L. Rostron, et al., »Dose-Response Association of Low-Intensity and Nondaily Smoking With Mortality in the United States«, in: *JAMA Network Open*, Vol. 3, No. 6, 03.06.2020, e206436.

Wen Qin, Costan G Magnussen, Shengxu Li, et al., »Light Cigarette Smoking Increases Risk of All-Cause and Cause-Specific Mortality: Findings from the NHIS Cohort Study«, in: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15.07.2020, Vol. 17, Issue 14, Art. 5122.

28 Caroline Cassels, »Smoking/Drinking Combo Accelerates Cognitive Decline«, in: *Medscape Medical News*, 10.07.2013.

29 Gareth Hagger-Johnson, Séverine Sabia, Eric John Brunner, et al., »Combined impact of smoking and heavy alcohol use on cognitive decline in early old age: Whitehall II prospective cohort study«, in: *The British Journal of Psychiatry*, Vol. 203, Issue 2, August 2013, 120—5.

er hinterlässt keinen Taumel, kein Lallen, kein Schwanken. Er raubt Intelligenz. Es ist der Unterschied zwischen einem klaren Gedanken und einem verworrenen. Zwischen einem treffenden Wort und einem, das nicht kommt. Zwischen einem Leben in Klarheit und einem Leben im Nebel.

Rund 26 Milliarden investieren Deutsche jährlich in die eigene Vergiftung.³⁰ Die jährlichen Kosten dafür belaufen sich auf rund 97 Milliarden — 30 für die Behandlung tabakbedingter Krankheiten, 67 aufgrund von Produktivitätsausfällen.³¹ Für die Industrie eine Goldgrube — ein Euro Umsatz, vier Euro Zerstörung. Raucherentwöhnung ist ein Milliardenmarkt, der davon lebt, dass er nicht funktioniert.³² Früher verschrieben Ärzte Zigaretten gegen Asthma — heute verkaufen sie Nikotinpflaster. Und während wir Quantencomputer bauen und Genome editieren,

30 Statistisches Bundesamt (Destatis), Pressemitteilung Nr. 016 vom 14. Januar 2019.

31 Anne Starker, Anja Schienkiewitz, Stefan Damerow, Ronny Kuhnert, »Prevalence of obesity and smoking among adults in Germany – trends from 2003 to 2023«, in: *Journal of Health Monitoring*, Vol. 10, Issue 1, 26.03.2025, e13038.

Anne Starker, Sally Olderbak, Justin Möckl, et al., »Tabak- und Nikotinprodukte – Zahlen und Fakten zum Konsum«, in: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hg.), *DHS Jahrbuch Sucht 2025*, 57–82.

Tobias Effertz, »Die volkswirtschaftlichen Kosten von Alkohol- und Tabakkonsum in Deutschland«, in: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (Hg.), *DHS Jahrbuch Sucht 2020*, Lengerich 2020, 225–34.

32 Seung Eun Lee, Chul-Woung Kim, Hyo-Bin Im, Myungwha Jang, »Patterns and predictors of smoking relapse among inpatient smoking intervention participants: a 1-year follow-up study in Korea«, in: *Epidemiology and Health*, Vol. 43, 9.6.2021, e2021043.

Tijen Acar, Claire Gallagher, Yasemin Gören, et al., »Determinants of Smoking Cessation Outcomes and Reasons for Relapse in Patients Admitted to a Smoking Cessation Outpatient Clinic in Turkey«, in: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 21, Issue 3, 07.03.2024, Artikel 310.

verbluten Menschen an archaischer Sucht, scheitern 97 Prozent aller Aufhörversuche.³³

Also suchte ich nach Auswegen.

Aber sie waren versperrt.

33 Ron Borland, James Balmford, Elena Swift, »Effects of timing of initiation and planning on smoking cessation outcomes: study protocol for a randomised controlled trial«, in: *BMC Public Health*, Vol. 13, 18.03.2013, Artikel 235.

HEILEN WAR NIE DER PLAN

*Das Organ, das den Einwand abwehrt, ist
bereits das geschädigte Organ.*

Fast jede Droge verliert mit zunehmender Aufklärung an gesellschaftlicher Akzeptanz. Nikotin lacht über diese Bemühungen. In indigenen Kulturen — etwa bei den Maya — war Tabak ein heiliges Medium, kein Suchtstoff. Schamanen nutzten ihn für bewusstseinsweiternde Rituale, teils als rituellen Einlauf, um Visionstrancen zu erzeugen.¹ Peruanische Tabaqueros — Schamanen des oberen Amazonas — nutzen noch heute *Nicotiana rustica* in gezielten Mikrodosen kombiniert mit Reinigungszeremonien, um Abhängigkeiten zu brechen.²

1 Francisco Javier Carod-Artal, »Hallucinogenic drugs in pre-Columbian Mesoamerican cultures«, in: *Neurología*, Vol. 30, Issue 1, 2015, 42—9.

Peter A. G. M. de Smet, Nicholas M. Hellmuth, »A multidisciplinary approach to ritual enema scenes on ancient Maya pottery«, in: *Journal of Ethnopharmacology*, Vol. 16, Issues 2—3, Juni 1986, 213—62.

Mario Zimmermann, Corey J. Brownstein, Luis Pantoja Díaz, et al., »Metabolomics-based analysis of miniature flask contents identifies tobacco mixture use among the ancient Maya«, in: *Scientific Reports*, Vol. 11, 15.01.2021, Artikel 1590.

Milwaukee Public Museum, »Ceremonial Use of Tobacco«, in: *WIRP (Wisconsin Indigenous Religions Project)*. Zugriff am 7. September 2025.

2 Tereza Rumlerová, Eric Kube, Nahuel Simonet, et al., »Use of tobacco purge in a therapeutic community for the treatment of substance use disorders«, in: *Anthropology of Consciousness*, Vol. 34, Issue 1, 26.09.2022, 7—34.

Ilana Berlowitz, David M. O'Shaughnessy, Michael Heinrich, et al., »Teacher plants — Indigenous Peruvian-Amazonian dietary practices as a method for

Mit der globalen Verbreitung des Tabaks ab dem 16. Jahrhundert änderte sich dessen Bedeutung. Europas Medizin-Elite stilisierte ihn zur Universalmedizin. Der spanische Arzt Nicolás Monardes veröffentlichte 1571 eine umfassende medizinische Abhandlung, in der er Tabak als Heilmittel gegen Dutzende Krankheiten beschrieb — teils bis zu 36, in anderen Auflagen bis zu 65. Eine Massenpsychose entstand. Tabakrauch galt fortan als Allheilmittel gegen Schmerz, Hunger, Krankheit — getragen vom Mythos, in der Neuen Welt eine botanische Schatzkammer entdeckt zu haben.³

Doch nicht alle waren so bescheuert: König Jakob I. von England zum Beispiel dekonstruierte Rauchen in seiner *Counterblaste to Tobacco* (1604) als »dem Auge widerwärtig, der Nase verhasst, dem Gehirn schädlich und den Lungen gefährlich« und verdammt es als »schwarzen pestilenzialischen Dunst« aus der Hölle.⁴ Er erhöhte die Tabaksteuer um viertausend Prozent. Eine Blaupause für Totalopposition: Päpste exkommunizierten Kirchenschnupfer, der osmanische Sultan Murad IV. ließ Raucher hinrichten.⁵

Francis Bacon (1561—1626) bemerkte, der Tabakkonsum erobere die Menschen »mit einer Art heimlichem Vergnügen, sodass

using psychoactives«, in: *Journal of Ethnopharmacology*, Vol. 286, 25.03.2022, 114910.

3 Christine Ann Rose, Jack Henningfield, Matthew J. Hilton, David T. Swenor, »A social and cultural history of smoking«, in: *Encyclopædia Britannica*, o.J., abgerufen am 04.09.2025.

Juan R. Sanchez-Ramos, »The rise and fall of tobacco as a botanical medicine«, in: *Journal of Herbal Medicine*, Vol. 22, 25.05.2020, 100374.

Grace G. Stewart, »A history of the medicinal use of tobacco 1492–1860«, in: *Medical History*, Vol. 11, Issue 3, Juli 1967, 228—68.

4 James I (King of England), *A Counterblaste to Tobacco*, London 1604.

5 Rose et al., *Encyclopædia Britannica*, ebd.

diejenigen, die sich einmal daran gewöhnt haben, kaum noch davon loskommen können«. ⁶

George Trask (1798—1875) verglich Tabak mit Opium und warnte, dass er seine Konsumenten in Ketten lege, die nicht leicht zu brechen seien ⁷: »Es befällt das gesamte Nervensystem. Es betäubt sein Opfer zeitweise [...] Es ist ein heimtückischer Dämon.« ⁸ Trask empfahl Gebete und Beschäftigung, das Unterschreiben eines Versprechens, das Trinken großer Mengen reinen Wassers und Hydrotherapie (*Sanus per aquam*), um mit dem Rauchen aufzuhören. ⁹

Henry Ford schrieb 1914:

»Wenn man allen Jungen klarmachen könnte, dass sie mit jedem Zug Zigarettenrauch Schwachsinn einatmen und Männlichkeit ausatmen; dass sie ihre Arterien so sicher anzapfen und ihr Lebensblut so wahrhaftig ausstoßen, als wären ihre Venen und Arterien durchtrennt; und dass die Zigarette Invaliden, Verbrecher und Narren macht — keine Männer —, sollte sie das etwas abschrecken. Die gelben Flecken an den Fingern sind ein Symbol für eine tiefere Erniedrigung und Versklavung als Ketten und Fesseln.« ¹⁰

6 »The use of tobacco [...] conquers men with a kind of secret pleasure, so that persons once accustomed to it can scarce leave it off«: Sir Francis Bacon, *Sylva Sylvarum, or A Natural History in Ten Centuries*, London 1626, Century XIX, § 27.

7 George Trask, *Thoughts and Stories on Tobacco for American Lads: Or Uncle Toby's Anti-tobacco Advice to His Nephew Billy Bruce*, Boston 1852.

8 »It seizes upon the whole nervous system. At one time it stupefies its victim [...]. It is an insidious demon«: Ders., *An Appeal to a Clergyman on the Use of Tobacco*, Boston 1855, 2.

9 Jordan Goodman (Hg.), *Tobacco in History and Culture: An Encyclopedia*, Vol. 2, Farmington Hills (MI) 2005, 481.

10 »If all boys could be made to know that with every breath of cigarette smoke they inhale imbecility and exhale manhood; that they are tapping their arteries as surely and letting their life's blood out as truly as though their veins and arteries were severed; and that the cigarette is a maker of invalids, criminals and fools — not

»Ich bin der festen Überzeugung, und ich habe dies in den letzten zwölf Jahren oder länger sehr genau beobachtet, dass Jungen im Alter von zehn bis fünfzehn Jahren, die weiterhin Zigaretten rauchen, in der Regel nichts erreichen. Sie sind in jeder Hinsicht ungeeignet für jede Art von Arbeit, bei der Intelligenz gefragt ist. Kein Junge oder Mann kann erwarten, in dieser Welt eine hohe Position zu erreichen, wenn er weiterhin Zigaretten raucht.«¹¹

Ford zitiert auch aus einem Brief von Thomas Edison: *»Der gesundheitsschädliche Stoff in Zigaretten stammt hauptsächlich aus der brennenden Papierhülle. Die dabei entstehende Substanz heißt Acrolein. Sie hat eine starke Wirkung auf die Nervenzentren und führt zur Degeneration der Gehirnzellen, die bei Jungen sehr schnell verläuft. Im Gegensatz zu den meisten Narkotika ist diese Degeneration dauerhaft und unkontrollierbar. Ich beschäftige niemanden, der Zigaretten raucht.«¹²*

Zwischen 1850 und 1906 erreichte die kommerzielle Ausbeutung ihren Höhepunkt. Unternehmer verkauften tödliche »Heilmittel« mit obszönen Gewinnmargen.¹³ *Dr. Bull's Cough Syrup*

men — it ought to deter them some. The yellow finger stain is an emblem of deeper degradation and enslavement than the ball and chain.«: Henry Ford, The Case Against the Little White Slaver, Detroit 1914, 22.

- 11 *»It is my candid opinion, and I have watched very closely the last twelve years or more, that boys at the age of ten to fifteen who have continued smoking cigarettes do not as a rule amount to anything. They are unfitted in every way for any kind of work where brains are needed. No boy or man can expect to succeed in this world to a high position and continue the use of cigarettes.«: ebd., 64.*
- 12 *»The injurious agent in cigarettes comes principally from the burning paper wrapper. The substance thereby formed, is called Acrolein. It has a violent action on the nerve centers, producing degeneration of the cells of the brain, which is quite rapid among boys. Unlike most narcotics this degeneration is permanent and uncontrollable. I employ no person who smokes cigarettes.«: ebd., 1.*
- 13 Samuel Hopkins Adams, *The Great American Fraud: Articles on the nostrum evil and quacks, in two series, reprinted from Collier's weekly*, New York 1906.

enthielt Morphinsulfat in Zuckersirup, beworben als Mittel, das heimlich in den »Kaffee des störrischen Ehemanns« gemischt werden sollte. *Kickapoo Indian Sagwa* prahlte mit Stammesformeln, war aber nur Alkohol mit Abführmitteln. Es wurde gegen alle »Nervenleiden« empfohlen.¹⁴ Derlei Tonika heilten keine Sucht, sie schufen neue.¹⁵

Ärzte des frühen 20. Jahrhunderts setzten auf Fruchtsäfte, tiefes Atmen, Psychoanalyse — die gleichen nutzlosen Methoden wie ihre Vorgänger, die mit bitteren Kräutertränken und Aderlässen aufwarteten. Andere griffen zu Amphetaminen, Beruhigungsmitteln oder Lobelinsulfat. *Lobelia inflata* wurde als nikotinähnlicher Ersatz genutzt — entwöhnte jedoch nicht.¹⁶ Lobelin sollte Nikotin ersetzen. Es löste Erbrechen, Schwindel, Atemstillstand aus.¹⁷ Sie experimentierten mit Gift.¹⁸

Im frühen 20. Jahrhundert nutzten Hersteller Silbernitrat- und Silberacetat-Lösungen — Industrieabfälle, die auf Zunge

John Phillips Street, *The Composition of Certain Patent and Proprietary Medicines*, Chicago 1917.

14 Sarah Dees, »Before and Beyond the New Age: Historical Appropriation of Native American Medicine and Spirituality«, in: *American Religion*, Vol. 4, No. 2, 2023, 17—44.

15 Patentarzneimittel wurden in der Regel aus einer Mischung pflanzlicher Wirkstoffe mit Alkohol, Morphin, Opium oder Kokain hergestellt. Barbara Hodgson, *In the Arms of Morpheus: The Tragic History of Laudanum, Morphine, and Patent Medicines*, Buffalo 2001.

16 Lindsay F. Stead, John R. Hughes, »Lobeline for smoking cessation«, in: *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 15.02.2012, Issue 2, Art. CD000124.

17 Goodman, ebd., 482.

Gerald C. Davison, Raymond C. Rosen, »Lobeline and Reduction of Cigarette Smoking«, in: *Psychological Reports*, Vol. 31, Issue 2, Oktober 1972, 443—56.

18 John L. Dorsey, »Control of the Tobacco Habit«, in: *Annals of Internal Medicine*, Vol. 10, November 1936, 628—31.

oder Rachen aufgetragen mit Rauch zu übel schmeckenden Salzen reagierten. Der Geschmackssinn stumpfte ab, die Sucht nicht. Trotzdem verpackte man es als Therapeutikum und verkaufte es als Kaugummi mit 3,700 Prozent Aufschlag.¹⁹

(It's the economy, stupid.)

In den 1950er Jahre tauchten erstmals Belege für einen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs auf.²⁰ Wayne McFarland versprach 1950 einen Plan zur Raucherentwöhnung. Fünf Abende sollten eine lebenslange Sucht besiegen. Die Teilnehmer tranken literweise Wasser und duschten zweimal täglich. Binnen drei Jahren strömten 50.000 Amerikaner in seine Kliniken. Viele hörten für kurze Zeit auf — und fingen dann wieder an. Tausende Teilnehmer, Hunderte Kurse.

Die Erfolgsquote? Darüber schwiegen die Pioniere.

In den 1960ern steckten Verhaltenstherapeuten Patienten in verqualmte Räume, zwangen sie zum Kettenrauchen mit aufgesetzten Elektroden. Bei jedem Zug folgte ein Stromstoß. Die Sitzungen dauerten bis zu einer Stunde. Fünf Tage lang erhielten Teilnehmer eine Kombination aus elektrischem Reiz und Rapid-Puff, ergänzt durch Aufklärung und Gruppensitzungen.²¹ Kommerzielle Entwöhnungsprogramme wie *Smokewatchers*, *Quit Now* und *Schick Centers* boomten. *Smokers* meldete 1977 stolze 150.000 Absolventen seines achtwöchigen Programms.²² Die

19 Tim Lancaster, Lindsay F. Stead, »Silver acetate for smoking cessation«, in: *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12.09.2012, Issue 9, CD000191.

20 Goodman, ebd., 482.

21 M. A. H. Russell, E. Armstrong, U. A. Patel, »Temporal contiguity in electric aversion therapy for cigarette smoking«, in: *Behaviour Research and Therapy*, Vol. 14, Issue 2, 1976, 103—23.

22 Nigel Barber, »Smoking: Most effective quitting technique little known«, in: *Psychology Today*, 17.02.2010.

meisten Teilnehmer brachen vorzeitig ab oder kehrten zum Rauchen zurück. Die Abbruchquoten wurden verschwiegen.²³

Verzweifelte entwickelten eigene Rituale: Zahnstocher kauen, Hundekexse knabbern, Zigarettenspackungen in Eisblöcken einfrieren, Rauchen nur mit der nicht-dominanten Hand.²⁴

Dass Aufhören schwierig ist, bemerkten Ärzte wie Laien früh. Doch erst 1988 anerkannte die Forschung offiziell, dass Rauchen eine biologisch bedingte Sucht ist, ähnlich wie Kokain oder Heroin, nur schlimmer.²⁵ Man stelle sich vor, einem Kokain- oder Heroinsüchtigen Mut zuzusprechen.

Absurd, nicht wahr?

Doch diese Hoffnung haben wir bei Rauchern. Obwohl von Nikotin loszukommen unwahrscheinlicher ist als von Kokain oder Heroin. Wer raucht, sitzt in der Falle der unterschätztesten aller Süchte.

Kokain: heilbar.

Heroin: heilbar.

Zigaretten: praktisch aussichtslos.

Während Alkohol, Kokain, Cannabis und Opioide ihre Gefangenen gelegentlich ziehen lassen, hält Nikotin sie eisern fest. Von allen Suchtstoffen hat es die niedrigste Erfolgsquote

23 James W. Smith, »Long Term Outcome of Clients Treated in a Commercial Stop Smoking Program«, in: *Journal of Substance Abuse Treatment*, Vol. 5, Issue 1, 1988, 33–6.

24 Diane Mapes, »Kicking butt: a look at smoking cessation through the decades«, in: *Fred Hutch News Service*, 19.11.2014.

25 Center for Health Promotion and Education (U.S.). Office on Smoking and Health, *The Health Consequences of Smoking: Nicotine Addiction: A Report of the Surgeon General*, Washington D.C. 1988, 9 u. 15.

bei der Entwöhnung.²⁶ Die Quittung für jeden Fluchtversuch kommt prompt — Heißhunger, Wut, Angst, zerfressene Konzentration, innere Unruhe. 87 Prozent aller Ausbrecher schaffen es nur, weil sie einen eigenen Weg finden.²⁷ Programme und Medikamente versagen bei neun von zehn.²⁸

Die Industrie übersetzte diese Erkenntnis in neue Absatzkanäle. Unter dem Deckmantel der »schrittweisen Entwöhnung« tauschten Raucher Tabak gegen Kaugummis oder Pflaster und prolongierten ihre Nikotinabhängigkeit in anderer Form.²⁹ Das Portfolio expandierte um Nasenspray und Inhalator — ein Zirkel ohne Ausstieg, der Raucher in chronische Ersatzprodukt-Abhängige transformierte. Jetzt mit höherer Bioverfügbarkeit.³⁰

26 Die kumulative Remissionswahrscheinlichkeit bei Nikotin liegt bei 83,7 %, während sie bei Alkohol 90,6 %, Cannabis 97,2 % und Kokain 99,2 % beträgt. Nikotinabhängigkeit ist damit schwieriger zu überwinden als andere Substanzabhängigkeiten.

Catalina Lopez-Quintero, Deborah S. Hasin, José Pérez de los Cobos, et al., »Probability and predictors of remission from lifetime nicotine, alcohol, cannabis, or cocaine dependence: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions«, in: *Addiction*, Vol. 106, Issue 3, 16.11.2010, 657—69.

27 Meryem Manis, Michael Tamm, Daiana Stolz, »Unaided Smoking Cessation in Healthy Employees«, in: *Respiration*, Vol. 95, Issue 2, 07.11.2017, 80—6.

28 Goodman, ebd., 486.

Ahmed Alboksmaty, Israel Terungwa Agaku, Satomi Odani, Filippas T. Filippidis, »Prevalence and determinants of cigarette smoking relapse among US adult smokers: a longitudinal study«, in: *BMJ Open*, Vol. 9, Issue 11, 03.11.2019, e031676.

29 Umesh Wadgave, L. Nagesh, »Nicotine Replacement Therapy: An Overview«, in: *International Journal of Health Sciences*, Vol. 10, No. 3, Juli 2016, 425—35.

30 Nina G. Schneider, Erik Lunell, Richard E. Olmstead, Karl-Olov Fagerström, »Clinical Pharmacokinetics of Nasal Nicotine Delivery«, in: *Clinical Pharmacokinetics*, Vol. 31, Issue 1, Juli 1996, 65—80.

Mundsprays und Lutschtabletten komplettierten das Arsenal patentierbarer Suchtprothesen.³¹

In den späten 1990er Jahren wurde *Bupropion* unter dem Markennamen *Zyban* eingeführt. Man kannte es bereits als Antidepressivum. Es versprach Dämpfung von Entzugssymptomen und geringere Gewichtszunahme — Letzteres ein wichtiger Marketing-Hebel.³²

Monatsvorrat: 140 Euro.

Vareniclin generierte milliardenschwere Umsätze bei minimaler Abstinenzwirkung. Neunzig Prozent der gemeldeten Suizide und Depressionen gingen auf Vareniclin zurück, nur sieben Prozent auf Bupropion.³³ Offizielle Reaktion: ein Warnhinweis über »gelegentliche Depressionen«.³⁴

Profitmarge: 150 Euro pro Monatsdosis.

Cytisin aus Goldregen-Samen machte Vareniclines Suizid-Produktion zur Farce. In Bulgarien bereits seit 1964 als *Tabex* vertrieben, war das pflanzliche Alkaloid zwar ebenso nutzlos,

31 Amritpal Sandhu, Seyed Alireza Hosseini, Abdolreza Saadabadi, »Nicotine Replacement Therapy«, in: *StatPearls* [Internet], 12.11.2023.

32 Victor I. Reus, Brenda J. Smith, »Multimodal Techniques for Smoking Cessation: A Review of Their Efficacy and Utilisation and Clinical Practice Guidelines«, in: *International Journal of Clinical Practice*, 15.10.2008, Vol. 62, Issue 11, 1753—68.

33 Thomas J. Moore, Curt D. Furberg, Joseph Glenmullen, et al., »Suicidal Behavior and Depression in Smoking Cessation Treatments«, in: *PLoS ONE*, Vol. 6, Issue 11, 02.11.2011, e27016.

34 Paul Crawford, Daniel Cieslak, »Varenicline for Smoking Cessation«, in: *American Family Physician*, Vol. 96, Issue 5, 01.09.2017;

Lauren B. Gerlach, Tony Van, Hyungjin Myra Kim, et al., »Trends in Incident Varenicline Prescribing Among Veterans Following the US Food and Drug Administration Drug Safety Warnings«, in: *Journal of Clinical Psychiatry*, Vol. 83, Issue 1, 21.12.2021, 20m13763.

jedoch deutlich verträglicher.³⁵ Die Pharmaindustrie ignorierte das konsequent, weil der Naturstoff in Osteuropa für 15 Dollar verkauft wurde. Als Cytisin schließlich nach Deutschland kam: 200 Euro pro Monatspackung. Selbst das Scheitern wurde zur Goldgrube.

Als die Forschung Nikotinsucht als chemische Abhängigkeit entlarvte, suchten Therapeuten neue Wege. In den 1970ern professionalisierte sich die Hilfe zu strukturierten Gruppentherapien, flankiert von Anleitungsflyern.³⁶ Die 1980er brachten Raucherentwöhnung per Telefon.³⁷ Natürlich half das auch nicht, brachte aber bis zu 3,50 Euro pro Minute. Inflationsbereinigt heute: elf Euro. Ein 10-minütiges Gespräch konnte über hundert Euro einbringen.

Professionell besetzt, würde man meinen.

Aber mitnichten.

Weder wurde der »Service« auf seine Wirksamkeit getestet, noch war das Personal irgendwie geschult.³⁸

Sittenwidrig?

Freilich.

35 Ryan J. Courtney, Hayden McRobbie, Piotr Tutka, et al., »Effect of Cytisine vs Varenicline on Smoking Cessation: A Randomized Clinical Trial«, in: *Journal of the American Medical Association (JAMA)*, Vol. 326, No. 1, 06.07.2021, 56—64.

36 National Cancer Institute (U.S.), »Evolution of Smoking Control Strategies«, in: *Smoking and Tobacco Control Monograph No. 1: Strategies to Control Tobacco Use in the United States — A Blueprint for Public Health Action in the 1990s*, Bethesda (MD) 1991. 35—60.

37 Edward Lichtenstein, Shu-Hong Zhu, Gary J. Tedeschi, »Smoking cessation quitlines: An underrecognized intervention success story«, in: *American Psychologist*, Vol. 65, Issue 4, Mai 2010, 252—61.

38 Quy-Chau Ngo, Lan Phuong Thi Doan, Giap Van Vu, et al., »Telephone-Based Smoking Cessation Counseling Service: Satisfaction and Outcomes in Vietnamese Smokers«, in: *Healthcare*, Vol. 11, Issue 1, 31.12.2022, Artikel 135.

Aber wen interessiert das?
(It's money, stupid.)

Der Kettenraucher Allen Carr zertrümmerte 1983 alle bisherigen Entwöhnungstheorien. Nikotinsucht sei nichts anderes als die Sucht nach der Linderung von Entzugserscheinungen. Statt Willenskraft zu predigen, nahm Carr den Rauchern die Angst vor dem Aufhören. Ergebnis: zwanzig Millionen verkaufte Bücher, 51 Prozent Erfolgsquote, Kliniken in über fünfzig Ländern.³⁹ Die erste funktionierende Raucherentwöhnung der Geschichte — von der Medizin seit jeher mit Argwohn betrachtet.

Hypnose kam in den 1970ern und versprach magische Umprogrammierung, mühelos, schmerzfrei, vergeblich. Heute kassiert eine Berliner Heilpraktikerin — weder Ärztin noch ausgebildete Hypnotherapeutin — 540 Euro pro Sitzung mit dem Argument:

»Du gibst als Raucher über 2.200 Euro im Jahr aus, die Du nach der Raucherentwöhnung sparst! Nutze diese für die schönen Dinge, wie zum Beispiel: eine Kreuzfahrt oder einen Traumurlaub.«

Bei solchen Honoraren sind ihre eigenen Kreuzfahrten gewiss garantiert. Eine 2019er Cochrane-Analyse fand *»keine verlässlichen Beweise«*, dass Hypnotherapie wirksamer sei als gar keine Therapie.⁴⁰

Pseudotherapeuten beherrschten die Kunst der Vernebelung: minimale Wirkung, maximaler Wortprunk. *»Achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention«* klingt wissenschaftlich — täuscht

39 Irene Possenti, Marco Scala, Alessandra Lugo, et al., »The effectiveness of Allen Carr's method for smoking cessation: A systematic review«, in: *Tobacco Prevention & Cessation*, Vol. 9, Issue 29, 29.9.2023.

40 Joanne Barnes, Hayden McRobbie, Christine Y. Dong, et al., »Hypnotherapy for smoking cessation«, in: *Cochrane Database of Systematic Reviews*, Vol. 2019, No. 6, 14.06.2019, CD001008.

aber darüber hinweg, dass die meisten Raucher nach wenigen Tagen rückfällig werden.⁴¹

In China gilt Akupunktur als Lieblings-Placebo gegen das Rauchen. Sie zeigt Null-Überlegenheit gegenüber Scheinbehandlungen⁴², aber perfekte Wirkung auf den Geldbeutel.

Ayurvedische Tabletten namens *Smotect* brachten zwanzig Prozent dazu, neunzig Tage nicht zu rauchen.⁴³ Zur Langzeit-Rückfallquote schweigt die Studie, was sie klinisch irrelevant macht.⁴⁴ Der Hersteller feierte das als Durchbruch und transformierte Pseudowissenschaft in Gold.

Johanniskraut sollte Entzugsdepressionen bekämpfen. Es half nicht⁴⁵ — was natürlich überraschend war —, induzierte aber Leberenzyme und sabotierte die Wirksamkeit zahlreicher Medikamente, Immunsuppressiva und Verhütungsmittel.⁴⁶

41 Sean Grant, Benjamin Colaiaco, Aneesa Motala, »Mindfulness-based Relapse Prevention for Substance Use Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis«, in: *Journal of Addiction Medicine*, Vol. 11, Issue 5, 20.09.2017, 386—96.

42 Adrian R. White, Hagen Rampes, Jian Ping Liu, et al., »Acupuncture and related interventions for smoking cessation«, in: *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 23.01.2014, Issue 1, Art. CD000009.

43 Sanjay Motilal Tamoli, Mahesh Kumar Harit, Narendra Mundhe, et al., »Nicotine Free Herbal Composition for Smoking De-Addiction — A Placebo Controlled, Double Blind, Randomized, Multicentric Clinical Study«, in: *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*, Vol. 15, Issue 2, 08.06.2023, 88—94.

44 Selbst Studien zu Varenicline und Cytisine messen sechs bis zwölf Monate.

45 Amit Sood, Jon O. Ebbert, Kavita Prasad, et al., »A Randomized Clinical Trial of St. John's Wort for Smoking Cessation«, in: *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, Vol. 16, No. 7, 20.06.2010, 761—7.

46 Linda B. Moore, Bryan Goodwin, Stacey A. Jones, et al., »St. John's wort induces hepatic drug metabolism through activation of the pregnane X receptor«, in: *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, Vol. 97, No. 13, 20.06.2000, 7500—2.

Ätherisches Schwarzpfefferöl linderte das Verlangen kurzfristig, da es dem Körper das Gefühl gab, geraucht zu haben (»*Throat Hit*«).⁴⁷ Es zögerte den nächsten Zigarettenkonsum um Minuten hinaus — genug für die Wellness-Industrie, verzweifelten Kunden überteuerte Diffusoren zu verkaufen.

Schließlich entdeckte die Digitalisierung Raucher als Zielgruppe. Smartphones⁴⁸, Wearables⁴⁹, und virtuelle Welten⁵⁰ lassen Nutzer Trigger durchleben und Widerstand trainieren.

Stephen D. Hall, Zaiqi Wang, Shiew-Mei Huang, et al., »The interaction between St John's wort and an oral contraceptive«, in: *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, Vol. 74, Issue 6, Dezember 2003, 525—35.

47 Jed E. Rose, Frederique M. Behm, »Inhalation of vapor from black pepper extract reduces smoking withdrawal symptoms«, in: *Drug and Alcohol Dependence*, Vol. 34, Issue 3, Februar 1994, 225—9.

48 Yi-Qiang Guo, Yuling Chen, Annette DeVito Dabbs, Ying Wu, »The Effectiveness of Smartphone App-Based Interventions for Assisting Smoking Cessation: Systematic Review and Meta-analysis«, in: *Journal of Medical Internet Research*, Vol. 25, 20.04.2023, e43242.

Adrian Barnett, Hang Ding, Karen E. Hay, et al., »The effectiveness of smartphone applications to aid smoking cessation: A meta-analysis«, in: *Clinical eHealth*, Vol. 3, 2020, 69—81.

Brianna L. Haskins, Donna Lesperance, Patric Gibbons, Edwin D. Boudreaux, »A systematic review of smartphone applications for smoking cessation«, in: *Translational Behavioral Medicine*, Vol. 7, Issue 2, 19.05.2017, 292—9.

49 Masudul H. Imtiaz, Raul I. Ramos-Garcia, Shashank Wattal, et al., »Wearable Sensors for Monitoring of Cigarette Smoking in Free-Living: A Systematic Review«, in: *Sensors*, Vol. 19, Issue 21, 28.10.2019, Artikel 4678.

50 Merel Keijsers, Maria Cecilia Vega-Corredor, Melanie Tomintz, Simon Hoeremann, »Virtual Reality Technology Use in Cigarette Craving and Smoking Interventions (I >Virtually< Quit): Systematic Review«, in: *Journal of Medical Internet Research*, Vol. 23, Issue 9, 17.09.2021, e24307.

Peter Tatnell, Prince Atorkey, Flora Tzelepis, »The Effectiveness of Virtual Reality Interventions on Smoking, Nutrition, Alcohol, Physical Activity and/or Obesity Risk Factors: A Systematic Review«, in: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 19, Issue 17, 30.08.2022, Artikel 10821.

Nichts davon hilft.

Alles bringt Geld.⁵¹

Wie damals die Quit-Lines.

Hunderte von Apps zählen rauchfreie Tage, errechnen »gesparte Lebenszeit«, motivieren mit Abzeichen und anderem sinnlosen Quatsch. Online-Programme ermöglichen Entwöhnungskurse vom heimischen Sofa aus. Tragbare Geräte wie *SmokeBeat* analysieren Handbewegungen in Echtzeit. Biofeedback-Kopplungen erkennen Herzfrequenz oder Hauttemperatur, die Verlangen vorhersagen sollen. KI-Chatbots simulieren menschliche Beratung rund um die Uhr.⁵²

Raucher bleibt man.

Diese Technologien scheitern, weil sie Sucht als Regelverstoß behandeln, nicht als neuronale Geiselnahme. Jede Vibration aktiviert dasselbe Angstnetzwerk, das Nikotin kurzzeitig beruhigt. Der Kontrollterror stresst mehr als der Entzug selbst.

Die Bioresonanztherapie rekrutierte ebenfalls hoffnungsvolle Patienten — ein vielversprechender Start ins Scheitern. Am Ende war sie von gewöhnlichen Behandlungen statistisch nicht unterscheidbar. Das Wunder erreichte Placeboniveau.⁵³

Sogar E-Zigaretten und Vapes werden als Ausstiegshilfe vermarktet. Tatsächlich führen sie zu niedrigeren Entwöhnungsraten

51 Marktanalysen prognostizieren der digitalen Hoffungsindustrie zwischen 2023 und -31 zwölf Prozent Wachstum pro Jahr.

Growth Plus Reports, »Smoking Cessation Apps Market Size, Share, Growth, Forecast, and Trends 2023—2031«, Newark, Mai 2023.

52 Linwei He, Erkan Basar, Emiel Krahmer, et al., »Effectiveness and User Experience of a Smoking Cessation Chatbot: Mixed Methods Study Comparing Motivational Interviewing and Confrontational Counseling«, in: *Journal of Medical Internet Research*, Vol. 26, 06.08.2024, e53134.

53 Kamile Marakoğlu, Duygu İlke Yıldırım, Bahar Ürün Ünal, »Bioresonance Therapy for Smoking Cessation«, in: *Istanbul Medical Journal*, 24.05.2024, Vol. 25, Issue 2, 99—104.

als gewöhnliche Zigaretten, bewirken also das exakte Gegenteil dessen, womit sie beworben werden.⁵⁴ Sie erhöhen ebenso die Herzfrequenz und damit den Blutdruck, erzeugen Mikroschlaganfälle⁵⁵, beeinträchtigen kognitive und Gedächtnisfunktionen, führen zu schlechterem Denken, geringerer Konzentration und Depressionen, stören spontanes Verhalten, Kreativität und Schlaf.⁵⁶

Während sie als Therapie vermarktet werden, manipulieren E-Zigaretten sogar Epigene. Nikotinexposition durch Dampfen induziert bleibende Veränderungen in der Genexpression, die das Gehirn für weitere Drogen empfänglich machen (Priming) und auf künftigen Missbrauch vorbereiten. Der Mechanismus läuft über die Hemmung der Histondeacetylase.⁵⁷ E-Zigaretten sind neurologische Zeitbomben — Gateway in den ewigen Kummer. Die eigentliche »Hilfe« dient Herstellerprofiten.

Schamanenzelt, Labore, Schwüre oder Apps: Das Scheitern aller Methoden offenbart einen zynischen Konsens. So wie

-
- 54 Sara Kalkhoran, Stanton A. Glantz, »E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis«, in: *The Lancet Respiratory Medicine*, Vol. 4, Issue 2, Februar 2016, 116—28; Natalie E. Quach, John P. Pierce, Jiayu Chen, et al., »Daily or Nondaily Vaping and Smoking Cessation Among Smokers«, in: *JAMA Network Open*, Vol. 8, No. 3, 05.03.2025, e250089.
 - 55 Albert D. Osei, Mohammadhassan Mirbolouk, Olusola A. Orimoloye, et al., »Association Between E-Cigarette Use and Cardiovascular Disease Among Never and Current Combustible-Cigarette Smokers«, in: *The American Journal of Medicine*, Vol. 132, Issue 8, 949—54.
 - 56 Kareem H. Alzoubi, Rahaf M. Batran, Nour Al-Sawalha, et al., »The Effect of Electronic Cigarettes Exposure on Learning and Memory Functions: Behavioral and Molecular Analysis«, in: *Inhalation Toxicology*, Vol. 33, Issue 6–8, 27.06.2021, 234—43.
 - 57 Menglu Yuan, Sarah J. Cross, Sandra E. Loughlin, Frances M. Leslie, »Nicotine and the adolescent brain«, in: *The Journal of Physiology*, Vol. 593, Issue 16, 15.08.2015, 3397—412.

Nikotin Gehirnnareale schrumpfen lässt, plündern Geschäftsmodelle Konten von Hilfesuchenden. Die Parallelität ist kein Zufall: Nikotin schädigt den präfrontalen Kortex — jene Region, die Impulskontrolle und rationale Entscheidungen steuert.⁵⁸ Genau diese Schädigung macht Raucher anfällig für teure Pseudotherapien. Die Industrie beutet die geschwächte Urteilskraft ihrer Opfer aus.

58 Natalia A. Goriounova, Huibert D. Mansvelder, »Nicotine exposure during adolescence alters the rules for prefrontal cortical synaptic plasticity during adulthood«, in: *Frontiers in Synaptic Neuroscience*, Vol. 4, 02.08.2012, Artikel 3;

Yuan et al., ebd.

WAS IDIOTEN GLAUBEN

»Rauchen fördert die Kreativität.«

Sagt ein Mythos von erstaunlicher Langlebigkeit. Am meisten beeinflusst er Raucher, die sich für zu klug halten, um daran zu glauben. Er etablierte sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, durch die Ikonografie rauchender Pseudo-intellektueller, verklärt durch Hollywood, von der Werbeindustrie so lange wiederholt, bis einem Hören und Sehen verging. Was jeder Idiot hätte wissen können: die Linderung von Entzugssymptomen hat nichts mit Kreativität zu tun.

Das wahre Juwel der Verblödung ist die rituelle Denkpause. Die Routine unterbrechen, um Gift zu inhalieren, fühlt sich nach Abstand an. Ich werde depressiv und fange an zu grübeln. Manche verwechseln das mit Tiefe. Aber es ist nur Dopamin, das Hirnschäden maskiert. Je länger ich nicht rauche, desto sichtbarer werden sie. Nach jeder Zigarette werden meine Ohren ein kleines bisschen tauber. Ich drehe die Lautstärke auf und nenne das Sensibilität. Ein psychologisches Manöver, mir nicht darüber klar zu werden, dass ich meine Begabung und Identität mit einem Vorschlaghammer zerschlagen habe. Dass ich zerstört habe, wofür ich lebe.

Rauchen ist kreativer Suizid.

Jeder kennt die Geschichten von Künstlern, die angeblich durch Zigaretten auf Ideen kamen. Die Antwort auf die Frage, ob es dafür belastbare wissenschaftliche Belege gibt, ist verblüffend eindeutig:

Nein.

Keine von Experten begutachtete experimentelle Studie zeigt, dass Raucher bei etablierten Kreativitätstests besser abschneiden als Nichtraucher, etwa beim *Alternative Uses Task* (ungewöhnliche Verwendungen finden) oder beim *Remote Associates Test* (Verbindungen zwischen scheinbar unverbundenen Begriffen erkennen). Der Mythos steht nicht auf wackligen Beinen — er schwebt.

Rauchen lähmte mein Gehirn. Nikotin tötete schleichend meine Ausdrucksfähigkeiten. Spontanität, Inspiration, Geschick im Gespräch. Zigaretten sind Scheren, die Zungen zerschneiden. Zuerst konnte ich keine Gedichte mehr schreiben. Mein musikalisches Gespür war fort. Keine Podcasts mehr, keine genialen Momente. Als Nächstes begann Prosa länger zu dauern. Ich geriet ins Stocken, weil ich die Schreibweise bestimmter Wörter vergessen hatte. Ein Gedanke will entstehen. Er tut es nicht. Oder er kommt verstümmelt, als würden Teile des Orchesters auf verstimmt Instrumenten spielen. Oder als würden Noten fehlen und die Melodie repetitiv werden. Ideen, die mich zu dem machen, was ich bin, verschwinden wie Noten auf einer Partitur.

Rauchen untergräbt zuverlässig die biologischen Grundlagen von Kreativität. Zum Beispiel das Arbeitsgedächtnis. Raucher am schwächsten, Nie-Raucher am stärksten, Extraucher dazwischen — noch Jahre später.¹ Das Arbeitsgedächtnis ist meine Werkbank: mehrere Ideen gleichzeitig halten, drehen, kombinieren. Schrumpft die Werkbank, schrumpft das Rohmaterial, dem ich meine Einfälle verdanke.

In einer Fall-Kontroll-Studie schnitten chronische Raucher in nahezu allen Domänen schlechter ab: selektive und

1 Monique Ernst, Stephen J. Heishman, Loretta Spurgeon, Edythe D. London, »Smoking History and Nicotine Effects on Cognitive Performance«, in: *Neuropsychopharmacology*, Vol. 25, No. 3, 23.03.2001, 313—9.

alternierende Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Kurz- und Langzeitgedächtnis, Verarbeitungsgenauigkeit, exekutive Funktionen.² Je früher der Einstieg und je länger die Rauchdauer, desto geringer die Leistung. Selbst bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigt eine Meta-Analyse messbare Defizite in Inhibitionskontrolle und motorischer Impulsivität bei chronischen Rauchern.³

Gelegenheitsraucher und Kettenraucher teilen dieselbe funktionelle Isolierung. Die Schaltkreise brechen unabhängig von der Dosis zusammen. Neurologische Demokratie.

Wie schwanger sein, ein bisschen geht nicht.

Die gute Nachricht für Wenigraucher: Ihr hättet euch die Zurückhaltung sparen können.⁴

Rauchen schwächt die Systeme, die mich kreativ machen, Aufmerksamkeit und Kontrolle organisieren. Zigarettenrauch dünnt die Hirnrinde aus — ein Biomarker kognitiven Alterns. Der Zusammenhang ist dosisabhängig: mehr Rauchhistorie, dünnerer Kortex. In einer Studie an 504 älteren Probanden zeigte sich bei Rauchern eine Auszehrung der äußeren Denkschicht. Der Effekt ist dosisabhängig und liegt beim Doppelten dessen, was altersbedingt typisch ist. Am stärksten betroffen sind Regionen,

2 Mohammed Shaban Nadar, Abdullah M. Hasan, Mohammed Alsaleh, »The negative impact of chronic tobacco smoking on adult neuropsychological function: a cross-sectional study«, in: *BMC Public Health*, Vol. 21, Issue 1, 30.06.2021, Artikel 1278.

3 Ahmed Elatfy, Sebastian Vrahimis, Aldo Conti, Alexander Baldacchino, »Chronic tobacco smoking and neurocognitive impairments in adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis«, in: *Frontiers in Psychiatry*, Vol. 15, 23.04.2024, 1384408.

4 Rongxiang Tang, Adeel Razi, Karl J. Friston, Yi-Yuan Tang, »Mapping Smoking Addiction Using Effective Connectivity Analysis«, in: *Frontiers in Human Neuroscience*, Vol. 10, 04.05.2016, Artikel 195, 7f.

die für Kreativität zentral sind: präfrontale Kontrollareale vorne (Planung, Entscheidungen), Knoten weiter hinten wie posteriorer cingulärer Cortex, Precuneus und Gyrus angularis.⁵ Diese Teile bilden das *Default-Mode-Netzwerk* ⁶, dessen Zerfall kennzeichnend für Alzheimer ist. Das erklärt, warum Rauchen zu Alzheimer führt. Die Ausdünnung ist noch Jahrzehnte nach dem Rauchstopp sichtbar. Die kortikale Erholung dauert, je nach Lebensdosis, zwischen 25 Jahre und theoretischen 140 Jahren.⁷

Es erholt sich aber allenfalls die kortikale Atrophie. Mikrovaskuläre Läsionen bleiben bestehen. Schäden an den feinsten Lebensadern, Kapillaren, Arteriolen. Sauerstoff- und Nährstoffversorgung der Neuronen bleiben reduziert, der Entzündungspegel erhöht, die Blut-Hirn-Schranke beeinträchtigt. Ehemalige Raucher bleiben schwächer in Planung, Problemlösung, geistiger Beweglichkeit. Sie denken langsamer. Sie haben Schwierigkeiten, Informationen im Arbeitsgedächtnis zu manipulieren, sie kopieren eher, statt kreativ umzuwandeln. Die Aufmerksamkeit zerfasert, Konzentration wird zur Qual.

Die Vernichtung schlägt zwei Schneisen: direktes Gift und schleichende Auszehrung. Zerstörte Lungen, messbar im FEV₁-Wert, verwandeln das Gehirn in eine Sauerstoffwüste. Chronischer Mangel dezimiert Kognition. Der Fazekas-Score kartiert im MRT die Gefäßruinen: je höher die Zahl, desto tiefer der geistige Verfall. Depression, niedriger IQ und niedriger Social Score verstärken die Effekte zusätzlich. Wer diese Mediatoren

5 Sherif Karama, Simon Ducharme, Janie Corley, et al., »Cigarette smoking and thinning of the brain's cortex«, in: *Molecular Psychiatry*, Vol. 20, Issue 6, 10.02.2015, 778—85.

6 DMN: medialer präfrontaler Kortex, posteriorer cingulärer Kortex, Precuneus, Angular gyrus sowie lateraler Temporallappen (mit Hippocampus-Anbindung).

7 Karama et al., ebd., 784.

statistisch >bereinigt<, verschleiert, was Rauchen im Gehirn anrichtet.⁸

Die Hypothese, der Kausalzusammenhang könne auch umgekehrt verlaufen; Menschen mit dünnem Kortex und niedrigem IQ würden einfach häufiger rauchen, scheitert an drei Fakten: die Schäden sind (1) dosisabhängig, (2) flächendeckend und (3) nach Rauchstopp teilreversibel.⁹

Prädisposition sieht anders aus.

Peng und Kollegen vermaßen 106 Gehirne mit voxelbasierter Morphometrie — 53 Raucher, 53 Kontrollen. In allen kreativen Kernregionen war die graue Substanz kollabiert, bei leichten wie bei starken Rauchern. Bilateraler Präfrontalkortex (Ideenfindung): *massiver Volumenverlust*. Mittlerer Frontalgyrus (kreative Kontrolle): *atrophiert*. Precuneus (Imagination): *zerstört*. Die komplette kreative Architektur: *ausradiert*.¹⁰

Wenn ich eine Idee habe, liegt das daran, dass Strukturen in meinem Kopf miteinander interagieren. Das können sie, weil sie physisch verbunden sind — »strukturelle Konnektivität« genannt. Wenn ich eine Zigarette rauche, durchtrenne ich diese Verbindungen.

Nicht nur die Bausubstanz leidet, sondern auch, wie die Teile im Gehirn miteinander reden. Rauchen schwächt die *funktionelle* Konnektivität, also die Synchronarbeit nicht zwingend verbundener Hirnbereiche. In einer Ruhezustands-fMRT-Studie mit 650 Probanden zeigten Raucher drastisch reduzierte Konnektivität in beiden exekutiven Kontrollnetzwerken sowie im

8 Ebd.

9 Ebd.

10 Peng Peng, Min Li, Han Liu, et al., »Brain Structure Alterations in Respect to Tobacco Consumption and Nicotine Dependence: A Comparative Voxel-Based Morphometry Study«, in: *Frontiers in Neuroanatomy*, Vol. 12, 24.05.2018, Artikel 43.

Default-Mode-Netzwerk. Das DMN ist aktiv, wenn der Blick nach innen geht (Selbstbezug, Vorstellung, Assoziation). Diese innere Bühne beginnt bei Rauchern zu flimmern. Statt punktueller Defekte zeigt sich flächendeckende Auszehrung. Das Netzwerk reguliert Selbstreferenz und emotionale Verarbeitung. Sein Einbruch bewirkt Suchtverhalten. In den Kontrollnetzwerken waren zentrale Knoten wie dorsolateraler Präfrontalkortex und parietale Areale schwächer gekoppelt.¹¹

Die Hauptachse kognitiver Kontrolle zerfällt, und mit jedem Packungsjahr schnürt sich der Sichtkegel enger. Die Zerstörung macht plausibel, warum Aufhören so schwer ist: das Kontrollsystem selbst ist kompromittiert. Nikotin verspricht Kontrolle, während es die Systeme zerstört, die Kontrolle überhaupt ermöglichen.

Der posteriore cinguläre Cortex (PCC) – ein zentraler Hub der inneren Netzwerke – verliert an Kopplung zum medialen präfrontalen Kortex (mPFC), jener Achse, über die Selbstbezug, innere Simulation und spontane Assoziationen koordiniert werden. Das Gleichgewicht zwischen aktivierenden und hemmenden Signalen kippt. Das Frontalhirn, zuständig für Bewertung, Realitätsprüfung und Entscheidungen, erhält weniger Rückkopplung aus den hinteren Regionen. Als würde Kerzenwachs die Kanäle verstopfen. Diese Entkopplung macht verständlich, warum Raucher die Realität ihrer Sucht nicht adäquat bewerten können.¹²

Im Entzug arbeitet der dorsolaterale präfrontale Kortex beim Arbeitsgedächtnis ineffizienter. Nach dem Rauchen wirkt dieselbe Aufgabe »leichter«: nicht als Kreativitäts-Boost, sondern als Linderung eines Mangels, den die Abhängigkeit selbst

11 Barbara J. Weiland, Amithrupa Sabbineni, Vince D. Calhoun, et al., »Reduced Executive and Default Network Functional Connectivity in Cigarette Smokers«, in: *Human Brain Mapping*, Vol. 36, Issue 3, 24.10.2014, 872–82.

12 Tang et al., ebd.

erzeugt.¹³ Darum ist der Mythos vom kreativen Raucher so zäh: Linderung wird mit Leistung verwechselt.

Rauchen gräbt ein Loch.

Es stopft es notdürftig.

Es gräbt weiter.

Es deckt es wieder zu.

Mit jeder Zigarette wird das Loch tiefer.

Nur das Gefühl wird flacher.

Noch verheerender sind die Langzeitfolgen. Linli und Kollegen analysierten strukturelle MRT-Daten von über 33.000 Personen und berechneten ein »Hirnalter«. Raucher tragen im Mittel ein älter wirkendes Gehirn. Ein schnell alterndes Gehirn baut die Fähigkeiten ab, auf denen Kontrolle, Arbeitsgedächtnis und Ideenarbeit beruhen.¹⁴

Nikotin kapert nikotinische Acetylcholinrezeptoren in Kontroll- und Aufmerksamkeitsnetzwerken (u.a. präfrontal, cingulär).¹⁵ Akut kann das Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis leicht anheben, weil nikotinische Acetylcholinrezeptoren Hochkognition und Netzwerkdyamik modulieren.¹⁶ Langfristig

13 Jiansong Xu, Adrianna Mendrek, Mark S. Cohen, et al., »Brain Activity in Cigarette Smokers Performing a Working Memory Task: Effect of Smoking Abstinence«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 58, Issue 2, 15.07.2005, 143—50.

14 Zeqiang Linli, Jianfeng Feng, Wei Zhao, Shuixia Guo, »Associations between smoking and accelerated brain ageing«, in: *Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry*, Vol. 113, 08.03.2022, 110471.

15 Julie K. Staley, Suchitra Krishnan-Sarin, Kelly P. Cosgrove, et al., »Human Tobacco Smokers in Early Abstinence Have Higher Levels of β_2^* Nicotinic Acetylcholine Receptors than Nonsmokers«, in: *The Journal of Neuroscience*, Vol. 26, Issue 34, 23.08.2006, 8707—14.

16 Fani Koukoulis, Jean-Pierre Changeux, »Do Nicotinic Receptors Modulate High-Order Cognitive Processing?«, in: *Trends in Neurosciences*, Vol. 43, No. 8, August 2020, 550—64.

verrottet die Hirnrinde messbar. Wo diese Rezeptoren dicht sitzen, wird sie zur Schlachtbank.

Ohne diese Muster reagiere ich schematisch, unangemessen. Ich werde gierig, ängstlich, fremd. Ich will es nicht, tue es trotzdem; habe die Einsicht, bewirke keine Neuverdrahtung. Aufmerksamkeit lenken, Impulse unterdrücken, Ideen sortieren: alles kompromittiert.

Verheerend wird es, wenn der Körper selbst das Instrument ist. Niarchou und Kollegen analysierten Gesundheitsakten von 9.803 musikalisch aktiven Personen. Raucher hatten ein 5,13-fach höheres Risiko für Stimmstörungen und ein 6,64-faches höheres Risiko für chronische Kehlkopfentzündung, die den musikalischen und sprachlichen Ausdruck beeinträchtigen.¹⁷ Rauchen verschlechtert die Stimmleistung akut und chronisch. Phonationszeit sinkt, Atemkontrolle leidet, Stimmqualität kippt. Schon bei jungen Rauchern zeigen sich Ödeme, Erytheme und gestörte Schwingungsmuster der Stimmlippen.¹⁸ Langzeitraucher zeigen zusätzlich reduzierte Grundfrequenz, verkürztes offenes Quotient, erhöhtes Jitter und Shimmer und gestörte aerodynamische Werte.¹⁹

Schauspieler, Sprecher, Redner: Wer seine Stimme braucht, zerstört sie mit Zigaretten. Töne zu halten wird schwer, die Luft

17 Maria Niarchou, George T. Lin, Miriam D. Lense, »Medical phenome of musicians: an investigation of health records collected on 9803 musically active individuals«, in: *Annals of the New York Academy of Sciences*, Vol. 1505, Issue 1, 19.08.2021, 156—68.

18 Shaheen N. Awan, Danelle L. Morrow, »Videostroboscopic Characteristics of Young Adult Female Smokers vs. Nonsmokers«, in: *Journal of Voice*, Vol. 21, Issue 2, März 2007, 211—23.

19 Irena Vincent, Harvey R. Gilbert, »The effects of cigarette smoking on the female voice«, in: *Logopedics Phoniatrics Vocology*, Vol. 37, Issue 1, 09.12.2011, 22—32.

reicht nicht, die Stimme wird rau, brüchig, unscharf. Als kreatives Werkzeug verschwindet sie.

Je länger ich rauchte, desto häufiger missverstand man mich, weil die Artikulation versagte. Zusammen mit Versprechern, Wortfindungsstörungen und plötzlicher Verwirrtheit raubte mir das Rauchen die Fähigkeit, mich auszudrücken. Ich hörte auf, Videos und Podcasts zu machen, weil ich insgeheim wusste, dass ich es als Raucher nicht kann.

Ich lebe in keinem Land, ich lebe in der Sprache. Ich habe mir die Hände abgeschlagen.

Dumm zu sein ist eine Sache. Ohne Sprache zu sein eine andere. Ein Leben in Dummheit ist denkbar, ein Leben ohne Sprache ist ein Leben ohne Selbst.

Schließlich verlor ich die Übersicht über meinen Alltag. Ich schaltete das Licht aus, es war bereits dunkel. Suchte zehn Minuten nach meinem Hausschlüssel, er lag in meiner Hand. Ging in einen anderen Raum, wusste nicht mehr, warum.

Wie hieß nochmal die Trockenfrucht, die ich neulich im Laden gesehen habe? Nein, nicht Dattel, die andere. Ich habe sie jahrelang gegessen, für meine Food-Fotografie auf Instagram verwendet. Stunden vergehen. Es liegt mir auf der Zunge. Ich erinnere mich, wie sich das Wort angefühlt hat.

Gift tropft in meinen Kaffee. Becher vom Späti.

Feige, verdammt. Natürlich.

Mein Wecker klingelt. Ich mache ihn aus und frage mich, woran er mich erinnern sollte.

Immer wenn ich mit dem Rauchen anfang, wurde ich ablenkbar. Äußerlich wurde ich ruhig und doch unruhig, konzentriert und doch unkonzentriert. Meine Aufmerksamkeit sprang zwischen falscher Stabilität und echter Ohnmacht. Hörte ich dann auf, sank die Konzentration weiter. Tiefer in die Introspektion rauchte ich mich mit jeder Zigarette, während ich zugleich wie

fremdgesteuert war durch das, was andere taten oder sagten. Ich war ganz außen (ablenkbar) und ganz innen (grübelnd) und gleichzeitig weder außen noch innen, als wäre etwas von mir abwesend. Mal fühlte es sich wie Minderwertigkeit an, mal wie verdrängter Selbsthass. Mit der Beweiskraft einer Abrissbirne vernichtete Rauchen stets zuerst den freundlichen Umgang mit mir selbst. Es genügte ein einziger Zug. Im Blick der anderen verdoppelte sich meine Selbstverachtung, als gäbe es in Wahrheit gar kein Innen und kein Außen.

Trüb wurde mein Bewusstsein. Rissig. Die Zeit verging schneller, während ich fälschlicherweise glaubte, klarer zu denken. Hörte ich zu rauchen auf, verlor ich die Kontrolle über mein Denken. Ich wurde träge, behäbig, und doch schienen die Sekunden ebenso länger zu brauchen. Zwei Langsamkeiten, die sich nicht aufhoben. Fast doppelt so lang dehnten sich die Tage. Offenbar reißen Teile der Zeit ab, wenn ich rauche. Die Illusion von Klarheit bei tatsächlicher Fragmentierung. Aber was da glaubte, bewusster zu sein, konnte das eben immer nur dann, wenn es da war. Ich konnte nicht zugreifen auf die vielen Sequenzen, in denen mein Bewusstsein abbriss. Ein riesiger blinder Fleck.

Fast immer wenn ich mit Süchtigen in Kontakt war, hörte ich ein und denselben Satz: *»Ich hab es unter Kontrolle.«*

Wirklich?

Niemand, der süchtig ist, hat die Kontrolle. Das ist Sucht: dass sie *dich* kontrolliert, statt umgekehrt.

Wer süchtig ist, sagt, er könne jederzeit aufhören. Wer nicht süchtig ist, *tut es*.

Eine Längsschnittanalyse über zwei Jahre zeigte schnellere Atrophie im orbitofrontalen Kortex, im mittleren Frontalgyrus

und in anderen frontalen Regionen.²⁰ Das ist die Maschine für Bewertung und Kurskorrektur. Für neue Konzepte. Dort wird bewertet, verworfen, neu zusammengesetzt. Dort entsteht der Unterschied zwischen Einfall und Idee. Wenn die Kommunikation dort bricht, leidet nicht nur Denken allgemein, sondern genau die Infrastruktur, die Einfälle prüft, sortiert und in brauchbare Form zwingt.

Rauchen verhindert, was Psychologen *kognitive Aktualisierung* nennen: das laufende Nachjustieren von Erwartungen, Bewertungen, Handlungen. Ein gesundes Gehirn aktualisiert sich ständig, weil es ständig neue Erfahrungen macht. Die anatomische Voraussetzung dafür heißt *Plastizität*. Keine Plastizität: keine Aktualisierung. Nur Hamsterräder, Teufelskreise, Autopiloten und der idiotische Versuch, durch immer gleiche Fehler andere Resultate zu erzwingen.

Typisch Deutsch?

Gewiss.

Vor allem aber: typisch Raucher.

Denn wenn ich rauche, verliere ich Plastizität. Eine Zeitlang mag ich darüber hinwegtäuschen, wie dumm ich geworden bin.

Eine Zeitlang.

Der Raucherentzug gehört zu den härtesten. Er stört nicht nur Neurotransmitter. Er lähmt die Lernfähigkeit des Gehirns. Ohne Zigaretten verliert das Gehirn genau den Mechanismus,

20 Timothy C. Durazzo, Philip S. Insel, Michael W. Weiner, »Greater regional brain atrophy rate in healthy elderly subjects with a history of cigarette smoking«, in: *Alzheimers & Dementia*, Vol. 8, Issue 6, November 2012, 513–9. Sophie E. A. Akkermans, Daan van Rooij, Nanda Rommelse, et al., »Effect of tobacco smoking on frontal cortical thickness development: A longitudinal study in a mixed cohort of ADHD-affected and -unaffected youth«, in: *European Neuropsychopharmacology*, Vol. 27, Issue 10, Oktober 2017, 1022–31.

der Kurskorrekturen erleichtert. Während des Entzugs ist eine bestimmte Form von Plastizität blockiert, die fazilitatorische Plastizität wird vollständig aufgehoben.²¹ Das Gehirn kann keine neuen neuronalen Verbindungen bilden, die für kreatives Lernen, künstlerische Entwicklung und innovative Problemlösungen unerlässlich sind. Dieselben Verbindungen werden gebraucht, um Rauchen durch neue Verhaltensweisen zu ersetzen. Der Entzug zerstört genau das Werkzeug, mit dem man ihn bewältigen müsste.

Verstehen ist neurologisch nichts anderes als physische Hirnveränderung. Ohne sie ist alles dumpf und still. Keine kreative Entwicklung ist möglich.

Monate, vielleicht Jahre im Entzug sehe ich etwas und verstehe es nicht. Als würde ich das Gesicht eines guten Freundes nicht mehr erkennen, obwohl meine Sehkraft intakt ist. *Raucherentzug ist intellektuelle Prosopagnosie*. Ich weiß um die Lage, weiß, was zu tun ist, aber der Übersetzungsapparat zwischen Erkennen und Handeln ist zerschmettert.

Der Bildschirm friert ein; man kann den Mauszeiger noch bewegen, aber die Dateien reagieren nicht, wenn man sie anklickt. Wie ausgesperrt stehe ich da, während sich Aufgaben wie Schneelawinen türmen. Sehe zu, wie mein Leben kollabiert. Ich hämmere an die Schädeltür meines Gehirns. Niemand öffnet.

Sturmklängen.

Keiner zu Hause.

Was nun? Nichtraucher und obdachlos? Rauchen und Probleme lösen und dafür morgen eine leere Wohnung vorfinden? Jede Kleinigkeit wird zur Erpressung: *rauchen oder kapitulieren*.

21 Jessica Grundey, Nivethida Thirugnanasambandam, Kim Kaminsky, et al., »Neuroplasticity in Cigarette Smokers Is Altered under Withdrawal and Partially Restituted by Nicotine Exposition«, in: *The Journal of Neuroscience*, Vol. 32, Issue 12, 21.03.2012, 4156—62.

Reiche Menschen stehen vor diesem Dilemma nicht. Sie können sich den Luxus leisten, gesund zu werden.

Sich mies fühlen, weil man eine bestimmte Substanz nicht mehr konsumiert, und keinen Zugriff auf sich haben, sind zwei Dinge grundverschiedener Art. Ginge es um Schmerz, wäre es simpel. Vor allem für mich, dessen Leben mit Schmerz gepflastert ist. Ich kann auch schreien, aber das verfehlt, worum es beim Aufhören geht: Selbstverlust.

Gegen die Panik rauchte ich an, und Nikotin streute Angst. Lebenslange Panikattacken. Rauchen dämpft sie kurzzeitig, verstärkt sie langfristig. Beim Aufhören eskalieren sie völlig. Ich griff nach allem, was ich finden konnte. Wie ein Ertrinkender.

Wem Schreiben wie Atmen ist, sind Aussetzer wie Schlaganfälle. Die anderen warten diskret, bis ich fertig bin mit meiner Verwandlung in einen Vollidioten. Sie beobachten meine intellektuelle Kernschmelze mit der Faszination von Gaffern an einem Autounfall. Sie haben Mitleid mit jemandem, der an Exzellenzuniversitäten studiert hat, Schauspielunterricht erhielt, beim Theater gearbeitet hat — und heute seine eigenen Sätze nicht mehr zu Ende bringt. Sie sind zu höflich, um zu erwähnen, dass ich den Verstand eines Goldfisches entwickelt habe.

Es überlebt keine Theorie den Kontakt mit der Wahrheit. Und doch verweigern wir sie hartnäckig. Man täuscht sich selbst und nennt es Inspiration. Diese Kassiererin. Fünfzehn Jahre rauchfrei, sagte sie. Aber irgendwie fehle ihr etwas. Die Zeit brachte das alte Gefühl nicht zurück.

Das unterscheidet Rauchen von anderen Süchten: Die Leerstelle bleibt. Das Leben wird nicht besser, es hört nur auf, schlechter zu werden. Alle, die es schaffen, sagen das. Und die Forschung bestätigt diese dauerhafte Subtraktion.

Ich habe geraucht, um meine Angst zu unterdrücken. Nun soll ich Selbstverlust ertragen. Nichts macht mehr Angst. Besonders inmitten der Wir-schaffen-das-nicht-Dekade, wo

Menschen an Identitäten kleben wie Autoimmunkranke an eigenen Antikörpern.

Ich muss jetzt rauchen.

Ich darf nicht.

Entweder ich rauche jetzt eine Zigarette oder ich kann den Text nicht zu Ende schreiben.

Feuer und Feuer.

Wenn ich rauche, werde ich nie wieder schreiben.

Ich muss ihn schreiben. Sonst sagt es keiner.

Ich darf nicht.

Lautréamont würde heulen. Er starb mit vierundzwanzig.

Ich schweife ab.

Wie immer, wenn ich nicht rauche.

Kreativität ist das erste Opfer im Leben eines Rauchers. Tinte ist im Füllfederhalter, doch wenn ich zu schreiben versuche, fließt sie nicht aufs Papier.

Er starb an Schwindsucht.

Die Seite ist immer noch leer.

Fäden hängen lose in der Luft.

Rauchen schrumpft den präfrontalen Kortex und zerfrisst Default-Mode- und Kontrollnetzwerke — die Infrastruktur für Einfälle, Bewertung und Umsetzung. Ausgerechnet das, wovon kreative Arbeit lebt. Die Legende vom kreativen Raucher ist keine Pose, sondern eine Lüge. Neurobiologisch ist Rauchen ein Angriff auf die Architektur der Kreativität.

Strukturelle und funktionelle Schäden brauchen lange, um zu heilen. Und selbst dann heilen sie nur teilweise. Wer glaubt, als Raucher sein verkürztes Leben immerhin kreativ verbringen zu können, der irrt. Der »kreative Raucher« ist ein neurobiologisches Phantom. Rauchen frisst Hirnrinde, blockiert Plastizität, zerreißt die Synchronarbeit der Kontrollnetzwerke. Das

Gehirn altert schneller. Die Lebensleistung wird kleiner, bevor man es merkt.

Wenn ich nicht sofort aufhöre zu rauchen und mein Gehirn zu reparieren versuche, endet genau hier mein Leben als kreativer Mensch.

Keine Zigaretten mehr.

Nie wieder.

FÜNFUNDZWANZIG KILO NEBEL

*Die Dämonen, die mich mästeten, als
wäre Leere ein zweiter Magen.*

Mit dem Rauchen dauerhaft aufzuhören ist nicht nur verdammt schwer. Es ist eine Anomalie — etwas, das praktisch nie geschieht. Meine statistische Ausgangslage: Niederlage. Ich kann nicht gewinnen. Diese Klarheit war der erste Schritt zur Befreiung. Hinzuschauen und zu erkennen, dass es nicht um verlorene Lebensjahre geht. Der wahre Raub des Rauchens geschieht jetzt: Es löscht meine Gedanken, frisst meine Erinnerungen, entstellt mein Ich. Der Hirnverfall ist kein Zukunftsgespenst. Er frisst heute meine Intelligenz, Denkschärfe, Persönlichkeit. Und morgen wird es schlimmer sein. Meine Mitmenschen sehen meinen Verfall. Aber sie schweigen — oder deuten es um.

Was viele nicht wissen: *Zwei Drittel bis drei Viertel der Ex-Raucher hören ohne Hilfe auf.*¹ Schon 1986 berichtete die American Cancer Society, über neunzig Prozent der erfolgreichen Aufhörer in den USA hätten es ohne kommerzielle Unterstützung

1 Simon Chapman, Ross MacKenzie, »The Global Research Neglect of Unassisted Smoking Cessation: Causes and Consequences«, in: *PLOS Medicine*, Vol. 7, Issue 2, 09.02.2010, e1000216, 1f.

Julia N. Soulakova, Lisa J. Crockett, »Unassisted Quitting and Smoking Cessation Methods Used in the United States: Analyses of 2010–2011 Tobacco Use Supplement to the Current Population Survey Data«, in: *Nicotine & Tobacco Research*, Vol. 20, Issue 1, 19.10.2016, 30–9.

geschafft.² Um 1970 existierte in den USA bereits eine Entwöhnungsindustrie im Wert von fünfzig Millionen Dollar. Die Evidenzlage war vernichtend.³ Analysen fanden nach der Freigabe von Pflastern und Kaugummis keinen messbaren Effekt auf die Raucherprävalenz. Weder Nikotinersatztherapie noch Bupropion beeinflussten die Zahlen. Was wirkte, waren Preis und TV-Gegenkampagnen.⁴

Jahrzehntelang leugnete die Tabakindustrie öffentlich, was sie intern als wahr erkannte, betrieb irreführende Kampagnen, täuschte Politiker selbst unter Eid und bezahlte für einseitige Forschung, um Verwirrung zu stiften.⁵ Die Pharmaindustrie kopierte diese Blaupause. Finanziert systematisch verzerrte Forschung zur Raucherentwöhnung.⁶

2 Für Deutschland und Europa verhält es sich ähnlich. Rund zwei Drittel derjenigen, die im Vorjahr einen Aufhörversuch unternahmen, taten dies ohne Unterstützung; bei Ex-Rauchern sind es etwa drei Viertel. In Deutschland liegt der Anteil ebenfalls bei rund drei Vierteln.

European Commission (Directorate-General Health and Consumers, DG SANCO); TNS Opinion & Social, *Special Eurobarometer 385 / Wave EB77.1: Attitudes of Europeans towards Tobacco. Report*, Brüssel 2012, 76–8.

Manuel B. Huber, Maximilian Präger, Kathryn Coyle, et al., »Cost-effectiveness of increasing the reach of smoking cessation interventions in Germany: results from the EQUIPTMOD«, in: *Addiction*, Vol. 113 (Suppl. 1), 15.12.2017, 52–64.

3 U.S. Department of Health and Human Services, *The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress*, Rockville (MD) 2014, Kap. 2: »Fifty Years of Change 1964–2014«, Abschnitt: »Nicotine and Addiction«, 30f.

4 Chapman-MacKenzie, ebd., 4.

5 Allan M. Brandt, »Inventing Conflicts of Interest: A History of Tobacco Industry Tactics«, in: *American Journal of Public Health*, Vol. 102, Issue 1, 07.12.2011, 63–71.

6 Joel Lexchin, Lisa A. Bero, Benjamin Djulbegovic, Otavio Clark, »Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic

Mehr als 91 Prozent der Interventionsstudien konzentrieren sich auf assistierte Entwöhnung. Untersuchungen zu unassistiertem Aufhören gibt es kaum. Von 84 ausgewerteten Papieren hatten 48 Prozent der Pharmakotherapie-Studien mindestens einen Autor mit Industrieunterstützung. Bei nicht-pharmakologischen Interventionen waren es zehn Prozent. Bei Studien zum unassistierten Rauchstopp null Prozent.⁷

Der globale Markt für Nikotinersatztherapie umfasste 2006 rund 1,7 Milliarden Dollar. Die Industrie unterdrückte systematisch Erkenntnisse über unassistiertes Aufhören. Branchen-PR nannte es »hoffnungslos überholt« und warb weiter für pharmazeutische Interventionen.⁸

Kurz: Wer ohne Hilfsmittel aufhört, nutzt nicht nur den häufigsten Erfolgsweg.⁹ Er durchbricht ein System, das seit hundert-siebzig Jahren an Abhängigkeit verdient. Die Tabakindustrie verkauft die Sucht, die Pharmaindustrie verkauft die Befreiung. Beide leben vom selben Geschäftsmodell. Ausbeutung, getarnt als Gesundheitsfürsorge.

Wer ohne Hilfe aufhört, widerlegt beide. Seine Abstinenz ist der Beweis, dass die Hilfsmittel überflüssig sind. Jeder Tag ohne Zigarette kostet sie Geld.

Aber ich bin auf mich allein gestellt.

Und ich muss tiefer graben, wann und wo ich verloren gegangen bin.

review«, in: *British Medical Journal* (BMJ), Vol. 326, No. 7400, 31.05.2003, 1167–70.

7 Chapman-MacKenzie, ebd., 2f.

8 Chapman-MacKenzie, ebd., 3f.

9 Soulakova-Crockett, ebd., 30 u. 36: »72% of former smokers quit unassisted [...], 7% used at least one nonpharmacological method.«

Ich hörte auf zu rauchen. Alles kam ungepuffert. Ich lag da und heulte mir die Lungen leer. Weinte über alles, was ich falsch gemacht hatte. Über die Schläge, meine aufgeplatzte Haut. Das Blut. Und was die Krankheit mir nahm. Über die Menschen, die ich wegstieß, weil ich mich selbst nicht ertrug.

Ich weinte um Professor Bredekamp, den ich enttäuscht hatte, und über mich, der ansetzte zu springen, bevor Epilepsie den Faden durchschnitt. Über mein Leben, das hätte strahlen können, wenn ich mein Talent weitergeführt hätte. Wenn ich die Energie nicht vergeudet hätte. Wenn ich gesund geblieben wäre.

Die Wunden blieben offen. Die Schreibmaschine im Keller. Die Schritte meines Vaters. Die Spitze aus Eisen. Die Hacke, die mich töten sollte. Meine Schwester, die sich dazwischenwarf. Das Pistolenmetall an meiner Schläfe. Die Fixierung im Psychiatriebett, die chemische Lobotomie. Das grelle Kliniklicht, die Panik, dass alles schwarz wird.

Ich log mir vor, ich wäre darüber hinweg. Jahrelang legte ich einen Teil von mir still, spielte Normalität. In Wirklichkeit war nichts geheilt. Es klaffte wie eine Wunde im Platzregen. Keine Betäubung mehr. Nur Trauma. Als hätte ich immer geschrien und es nur nicht gehört. Nikotin in die Ohren gestopft, um nicht taub zu werden von meinem eigenen Geschrei. Rauchen als Notverband gegen das tägliche Sterben, das Zittern.

Ich heulte, als würde ich Leichen zählen. Nichts löste sich. Stunden später heulte ich immer noch. Die letzten Wasser einer versiegenden Quelle. *»Alles Lebendige, alles Schöne, alles, was zitterte, transmutierte unter seinem Griff in etwas Starres, das nichts verzieht und nichts vergaß.«*¹⁰

Was blieb, war mein ältestes Werkzeug.
Ein Satz.

10 Emilie von Drachenfels, *Der Ewige Palast*, Berlin 2024, 431.

Dann noch einer.

Um zu überleben.

Jedes Mal ohne Zigaretten bricht alles auf. Jedes Mal versuche ich, mich durch das Chaos zu schreiben.

Ich fragte mich, warum ich es zehn Jahre früher geschafft hatte, von einem auf den anderen Tag aufzuhören. Nicht nur mit dem Rauchen, auch mit meiner jahrelangen Binge-Eating-Störung. Ich wich nicht auf Kaffee oder Alkohol aus. Ich ernährte mich richtig, nahm zwanzig Kilo ab. Nichts trübte mein Bewusstsein. Ich arbeitete täglich so konzentriert, dass ich noch im selben Jahr mein wohl wichtigstes Buch veröffentlichen konnte.

Dreieinhalb Jahre später fing ich wieder an und kam seitdem nicht länger als jeweils für ein paar Monate davon los. Was war das für ein Bewusstsein damals, das aus mir urplötzlich einen anderen Menschen machte? Das mir den Groll gegen andere nahm, den Frust auf mich selbst, die Gier, das ungesunde Verlangen? Ich hatte keine Idee mehr davon, mich vollzustopfen oder kaputt zu rauchen. Es erschien mir selbstverständlich, es nicht zu tun. Ich brauchte keine Gründe, mir nicht Gewalt anzutun.

Freundlich mit sich selbst umgehen nannte ich das später.

Wer nicht freundlich mit sich selbst ist, kann dies auch nicht anderen gegenüber sein. Dieser Zustand wirkte wie eine Mischung aus Unschuld und Demut. Etwas melancholisch auch, aber weit entfernt von Traurigkeit. Innere Stille, Frieden fast, Urteilsfreiheit, nur Wahrnehmung. Ich wollte nichts, brauchte keine Disziplin, alles folgte wie von selbst.

Wie hole ich diese Gemütslage zurück?

Wo ist sie liegen geblieben?

Nachdem ich nun erneut aufgehört hatte, war ich zwar noch wach, aber meist nicht wachbewusst. Wie wenn man zum Bäcker gehen und plötzlich irgendwo sitzt, und im nächsten Moment zu

Hause oder im Krankenhaus ist. Verhaltensprogramme liefen ab. Ich tat Dinge, konnte mich aber nicht bewusst dabei beobachten.

Schreiben setzt voraus, Gedanken beobachten zu können. Ohne bewussten Gedanken keine Formulierung. Ich vergaß ständig alles. Ich wusste oft nicht mal, wie ich meinen Arm gerade hielt, oder was überhaupt gerade los war.

Nach dem Rauchstopp war ich zudem im permanenten Panikmodus. Ich aß ohne Pause. Übergewicht verstärkte die Unruhe. Permanente Entzündung im Körper.

Ich trank Kaffee gegen den Gehirnnebel und die Müdigkeit. Vergeblich. Ich trank Alkohol gegen die Unruhe, bis ich alkoholkrank war. Täglich leerte ich Bierflaschen. Ich konnte nicht mehr denken, wurde lahm. Mein Darm war so entzündet, dass mein Bauch aufgeblasen war. Es drückte so sehr, als würde er aufplatzen.

Jeder Tag lief dasselbe automatische Skript ab. Kaffee, salzige fettreiche Kost, Kaffee, salzige fettreiche Kost, Alkohol, salzige fettreiche Kost, Alkohol, tot ins Bett fallen. Aufwachen, dasselbe von vorn.

Wie ein Roboter.

Monatelang.

Ich probierte alle Auswege, die mir einfelen, darunter Nahrungsergänzungsmittel. Mehr als vierzig verschiedene Präparate. Verschuldung von tausend Euro. Es dauerte Monate, innerlich hatte ich bereits aufgegeben. Übrig blieben eine Handvoll Präparate, die tatsächlich einen Unterschied machten. Ohne sie wäre ich als nichtrauchender Alkoholiker an akutem Organversagen oder Herz-Kreislauf-Kollaps krepieret.

Nikotinkonsum verschiebt das Gleichgewicht zahlreicher Neurotransmitter, die dann ohne Nikotin nicht mehr ausgeschüttet werden. Nachdem ich aufgehört hatte, schien mein Gehirn überhaupt nicht mehr zu funktionieren.

Menschen nahmen darauf keine Rücksicht. Gehirn matschig, Nerven blank, dazu eine Umwelt, die sich anfühlt wie alle gegen alle. Das Fiese daran war, dass wenn das Gehirn nicht läuft, jedes Arschloch doppelt arschlochig wirkt, weil die Pufferzone fehlt. Das Gehirn bewertet jeden Stressor als existenziell, weil es nicht mehr zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden kann.

Noch zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes leide ich unter Brain Fog, Reizbarkeit, Impulsschwäche, diesem Gefühl von *Ich bin nicht ich*, und einer sozialen Fehlkalibrierung, bei der ich zu scharf, zu schnell, zu unpassend agiere. Die Leute antworten entsprechend, und ich fühle mich, als lebte ich in einer psychotischen Gesellschaft. Der Stress steigt, das Gehirn wird schlechter, von vorn. Ein Regelkreis.

Die meisten Menschen scheitern in dieser Phase, weil ihnen niemand gesagt hat, wie lange es dauern kann, bis das Gehirn wieder anfängt, normal zu funktionieren. Drei Monate nach Rauchstopp hatte sich bei mir nicht das Geringste verbessert.

Raucher lernen unbewusst, schon kleinste Vorboten von emotionalem Unwohlsein wahrzunehmen und automatisch mit Rauchen darauf zu reagieren.¹¹ Die Handlung wird Reflex, bis sie nicht mehr funktioniert, weil das Gehirn so abhängig geworden ist, dass es ohne Nikotin zusammenbricht.

Die Entzugsforschung sagt, der Brain Fog verschwinde nach zwei bis vier Wochen.¹² Die Neuroforschung behauptet, dass die hochregulierten nikotinischen Rezeptoren sechs bis zwölf Wochen benötigen, um sich wieder zu normalisieren.¹³ Wenn ich seit über drei Monaten Brain Fog habe und nichts besser

11 Baker et al. 2004.

12 Hughes 2007.

13 Kelly P. Cosgrove, Jeffery Batis, Frederic Bois, »β2-Nicotinic Acetylcholine Receptor Availability during Acute and Prolonged Abstinence from Tobacco Smoking«, in: *JAMA Psychiatry*, Vol. 66, No. 6, 666—76.

wird, ist der wahrscheinlichste Grund: viszerales Fett und metabolischer Stress.

Übergewicht ist ein Kognitions-Killer. Fettgewebe fungiert als drüsenartiges Organ, das systemische Entzündungen befeuert. Diese Entzündungsbotenstoffe überwinden die Blut-Hirn-Schranke, greifen den Hippocampus an, beschleunigen kognitiven Abbau und vermindern Neuroplastizität. Viszerales Fett schwächt Exekutivfunktion, Planung, Impulskontrolle, Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit.¹⁴ Grund dafür sind Entzündungen, Insulinresistenz, eingeschränkte Gefäßfunktion und Stresshormone.¹⁵

Die Sorge vor zusätzlichen Kilos ist ein Hauptgrund, warum Menschen wieder mit dem Rauchen anfangen.¹⁶ Im Schnitt neh-

14 Alyson A. Miller, Sarah J. Spencer, »Obesity and neuroinflammation: a pathway to cognitive impairment«, in: *Brain, Behavior, and Immunity*, Vol. 42, November 2014, 10—21.

Deborah H. Schwartz, Gabriel Leonard, Michel Perron, et al., »Visceral fat is associated with lower executive functioning in adolescents«, in: *International Journal of Obesity*, Vol. 37, Issue 10, 12.10.2016, 1336—43.

15 Jason C. D. Nguyen, A. Simon Killcross, Trisha A. Jenkins, »Obesity and cognitive decline: role of inflammation and vascular changes«, in: *Frontiers in Neuroscience*, Vol. 8, 19.11.2014, Artikel 375.

16 Angela Golden, James M. Davis, »Smoking, Obesity, and Post-Cessation Weight Gain: Neurobiological Intersection and Treatment Recommendations«, in: *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, Vol. 18, 24.05.2025, 2889—900.

men Ex-Raucher vier bis fünf Kilo zu.¹⁷ In vierzehn Prozent der Fälle über zehn Kilo.¹⁸

Soweit die Forschung.

Nun zu mir.

Nach einem Monat ohne Rauchen wog ich bei unveränderter Ernährung zwanzig Kilo mehr, hauptsächlich viszerales Fett. Mein Kopf war voll mit Nebel. Nach drei Monaten, bei reduzierter Ernährung plus Fasten, wog ich fünfundzwanzig Kilo mehr.

Mein Skelett bekam Schwierigkeiten, das Gewicht zu tragen. Zumal ich Osteopenie hatte. Meine Haut fühlte sich an, als würde sie jeden Augenblick aufreißen. Nichts besserte sich. Alles grau, Kopf ist Watte, nichts zieht. Fünfundzwanzig Kilo hauptsächlich viszerales Übergewicht machen Denken unmöglich.

Dann aß ich gar nichts mehr, trank nur noch Wasser. Mein Gewicht reduzierte sich um keinen Gramm. Physikalisch unmöglich, dachte ich. Also wechselte ich die Waage. Zweimal. Aber die Waage funktionierte hervorragend.

Hormone wie ADH könnten Wasser zurückgehalten haben. Das könnte den Brain Fog über Elektrolyte verstärkt haben.¹⁹

17 J. Audrain-McGovern, N. L. Benowitz, »Cigarette Smoking, Nicotine, and Body Weight«, in: *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, Vol. 90, Issue 1, 164—8.

Alexandra Pankova, Eva Kralikova, Kamila Zvolkska, »Early weight gain after stopping smoking: a predictor of overall large weight gain? A single-site retrospective cohort study«, in: *BMJ Open*, Vol. 8, Issue 12, 16.12.2018, e023987.

18 Golden-Davis 2025.

19 ADH-Ausschüttung bewirkt Wasserretention bewirkt Absinken des Natriumspiegels bewirkt neurologische Symptome (Verwirrtheit/Lethargie) durch zelluläres Hirnödem.

Horacio J. Adrogué, Nicolaos E. Madias, »Hyponatremia«, in: *The New England Journal of Medicine*, Vol. 342, No. 21, 2000, 1581—9.

Oder es waren Nieren, Leber, Herz der Grund²⁰ und ich nahm nicht zu, weil ich aß, sondern weil mein Körper das Wasser festhielt.

Ödeme und viszerale Fett schließen sich nicht aus.²¹ Fett wächst langsam, über Wochen und Monate. Wasser kommt schnell, in Tagen, kiloweise. Das eine ist Gewebe. Das andere Flüssigkeit im Zwischenraum. Fett ist die Struktur. Wasser die Strafe. *Der Nebel ist nicht im Kopf. Er sitzt im Bauch. Und er geht erst, wenn das Viszerale verschwindet.*

RASIERKLINGE IM ESSEN

Ich aß nicht einfach, als ich aufgehört hatte. Ich aß Salz. Danach fühlte ich mich jedes Mal elend. Ich aß es trotzdem. Ich kaufte mir das beste Salz, das es gab, als ließe sich Qualität gegen Menge verrechnen. Die Menge schadete mir trotzdem. Ich lagerte Wasser ein, war aufgedunsen, es drückte überall, vor allem im Kopf. Der Durst wurde extrem, literweise trank ich Wasser, blähte auf.²² Schlafen konnte ich kaum. Mein Körper hielt fest, was raus musste.

Ich konnte es niemandem erzählen, weil es niemand verstehen wollte. Manche sagten, Salz sei wichtig.

Suizidgedanken.

20 Sri Rama Surya Tez Kattula, Akshay Avula, Krishna M. Baradhi, »Anasarca«, in: *StatPearls [Internet]*, 12.10.2023.

21 Arin K. Greene, Frederick D. Grant, Sumner A. Slavin, Reid A. Maclellan, »Obesity-induced lymphedema: clinical and lymphoscintigraphic features«, in: *Plastic and Reconstructive Surgery*, Vol. 135, Issue 6, Juni 2015, 1715—9.

22 Schwellung durch Flüssigkeitsretention.

Motokiyo Yoshikawa, Kazumasa Torimoto, Akihide Hirayama, et al., »Daily salt intake is associated with leg edema and nocturnal urinary volume in elderly men«, in: *Neurourology and Urodynamics*, Vol. 39, Issue 5, Juni 2020, 1550—6.

Ich hatte ohnehin schon Schwierigkeiten mit Wasser, mit Rhythmus, mit Ausscheiden. Das viele Salz war Benzin im Feuer. Ich lag darin und brannte.

Im Gehirn gibt es ein uraltes Programm. *Sodium appetite*. Wenn das System Mangel wittert oder bestimmte Signale falsch interpretiert, fährt es Motivation und Belohnung hoch, bis es Salz findet.²³ Und dieses Programm lässt sich konditionieren, auch ohne echten Mangel.

Als ich Nikotin, Alkohol und Koffein strich, blieb ein Loch zurück. Salz passte perfekt hinein. Es war sofort spürbar, eine oral-sedierende Selbstregulation ohne Zigarette.

Nach dem Aufhören war ich im Panikmodus. Ich suchte unbewusst nach etwas, das mich herunterregelt. Salz übertönte den inneren Lärm. Für Minuten.

Danach war das Elend so groß, dass ich statt einem Liter Wasser oft einen Liter Bier trank. Dann kam entweder der Heißhunger, salzig, fettig, mehr. Oder ich wurde müde und kippte weg. Wochenlang ging das so und ich sah zu, wie mein Leben zusammenbrach.

Ich fragte mich, warum ich etwas esse, wenn ich gewiss bin, dass ich mich danach elend fühle. Es hatte den Anschein, als wollte ich mich nicht nur beruhigen, sondern zugleich bestrafen. Ich nehme etwas, um einen unangenehmen Zustand zu dämpfen. Aber dann kommt der Spätgewinn und der trägt die Strafe in sich, aus der etwas Zweites entsteht: *Selbstabwertung*.

Vielleicht ist die Strafe nicht unbeabsichtigt, sondern erfüllt eine unbewusste Funktion. Selbstbestrafung als Selbstregulation. Wenn in mir Schuldspannung existiert, ist Strafe ein Weg, diese Spannung zu lösen. Schuld ist unerträglich, solange sie offen bleibt. Strafe macht sie bezahlt, dann ist kurz Ruhe. Die Schuldspannung

23 Seth W. Hurley, Alan Kim Johnson, »The biopsychology of salt hunger and sodium deficiency«, in: *Pflügers Archiv*, Vol. 467, Issue 3, 10.01.2015, 445–56.

steigt, ich greife zu Salz, fühle mich elend, die Schuldspannung sinkt: abgebußt. Das Finanzamt im Kopf ist kurz still.

Vielleicht ist es auch Kontrollleid. Wenn sich mein Leben chaotisch anfühlt, wirkt selbst erzeugtes Elend fast wie Ordnung. Angst, die ich nicht kontrollieren kann, fühlt sich diffus an. Elend, das ich selbst erzeuge, ist konkretes Grauen mit Ursache. Ich wähle das Feuer, das ich selbst entzünde, um dem Feuer, das ich nicht kontrollieren kann, zu entkommen. Lieber Schuld und Elend, das ich verstehe, als Angst und Chaos, das ich nicht verstehe.

Vielleicht hängt es mit dem Entzug selbst zusammen. Nikotin, Alkohol, Koffein sind gestrichen, und frei wird, was unterdrückt war. Aggression, Frust, Trauer, Leere. Wenn das nicht nach außen darf, weil sozial riskant, muss es nach innen. Salz ist dann Autoaggression, eine essbare Rasierklinge.

Oder es ist ein Skript, das ich unbewusst abspule, bei dem Erholung verdächtig ist. Ein Glaubenssatz, der besonders in Deutschland verbreitet ist: *Du darfst nicht glücklich sein. Genuss ist gefährlich, Leichtigkeit nicht verdient.* Jeder freundliche Umgang mit mir selbst wird sabotiert, sobald er wirkt. Wenn es besser wird, kann ich nicht mehr erklären, warum ich leide. Also muss ich mich selbst sabotieren, weil ein Teil von mir Angst vor Veränderung hat. Salzorgie.

Salz ist eine raffinierte Maschine der Selbstverletzung: *kurz regulieren*, danach leiden, danach wieder regulieren. Übererregung, Leere, Stress. Dann der Impuls. *Ich brauch jetzt was.* Kurzer sensorischer Frieden. Dann die Körperreaktion. Durst, Druck, Ödemgefühl, schlechter Schlaf. Elend führt zu Selbstabwertung, zum Beweis fürs Kaputtsein. Elend erzeugt den nächsten Impuls nach Beruhigung. Wasser, Bier, Essen, irgendwas. Ein selbstverstärkender Regelkreis.

Ich salze nicht, weil ich Salz will, sondern weil ich kurzfristig Ruhe will und langfristig eine Rechnung brauche.

RAUCHEN IST KEINE SUCHT

*Das Gehirn verdaut sich vor
Traurigkeit selbst.*

Jahrzehntelang erzählte uns die Suchtforschung, negative Gefühle treiben Raucher zurück zur Zigarette. Man fühlt sich schlecht, man raucht.

So einfach, so falsch.

Nicht alle negativen Emotionen sind gleich. Angst treibt nicht zurück. Wut treibt nicht zurück. Scham nicht. Ekel nicht. Nur eine Emotion programmiert das Gehirn zuverlässig auf Rückfall: *Traurigkeit*.¹

Bislang nahm man an, dass positive Gefühle kaum Einfluss auf Suchtverhalten haben. Selbst gute Laune hilft nicht beim Aufhören, weder beim Rauchen noch beim Trinken oder bei Essanfällen — egal, um welches appetitive Risikoverhalten es geht. Eine Metaanalyse positiver Emotionen ergab, dass Vergnügen das Suchtverhalten verstärkt, während andere positive Emotionen wie Zufriedenheit, Aufregung, Glück, Hoffnung oder Stolz keine Wirkung zeigen.²

1 Charles A. Dorison, Ke Wang, Vaughan W. Rees, et al., »Sadness, but not all negative emotions, heightens addictive substance use«, in: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* (PNAS), Vol. 117, Issue 2, 14.01.2020, 943—9.

2 Rebecca A. Ferrer, Jennifer M. Taber, Paschal Sheeran, et al., »The role of incidental affective states in appetitive risk behavior: A meta-analysis«, in: *Health Psychology*, Vol. 39, Issue 12, Dezember 2020, 1109—24.

Inzwischen hat neue, umfangreiche Forschung dieses Bild korrigiert. Harvard-Forscher haben zehntausend Menschen über zwanzig Jahre begleitet und eine positive Emotion identifiziert, die zuvor übersehen wurde und einen entscheidenden Unterschied macht. *Dankbarkeit* erweist sich als unerwartet wirksam im Kampf gegen Rauchverlangen.³

Jede Emotion besitzt eine eigene Signatur, prägt die Wahrnehmung, steuert Handeln. Sie verfolgt implizit Ziele und färbt unsere Bewertung von Ereignissen, sodass sie zu diesen Zielen passt. Diese Bewertungen sollen helfen, angemessen auf Ereignisse zu reagieren. Das Problem ist, dass Emotionen anhalten und Entscheidungen in späteren, völlig unabhängigen Situationen beeinflussen.⁴

Traurigkeit geht mit dem Gefühl einher, etwas unwiederbringlich verloren zu haben. Das kann der Verlust eines geliebten Menschen sein, der Verlust des Zuhauses, das Ende einer sozialen oder beruflichen Rolle, die mich definiert hat. Es kann auch das Gefühl des Todes ohne Leiche sein oder das Gefühl des Todes im Leben.

Bei mir traf das alles zu. Ich war immer traurig. Innerlich konnte ich nicht aufhören zu heulen. Seit meiner Kindheit war ich am Heulen. Mit jedem Wort, das ich sprach, warf ich Seile in alle Richtungen aus.

3 Ke Wang, Vaughan W. Rees, Charles A. Dorison, Jennifer S. Lerner, »The role of positive emotion in harmful health behavior: Implications for theory and public health campaigns«, in: *PNAS*, Vol. 121, Issue 28, 01.07.2024, e2320750121.

4 Jennifer S. Lerner, Deborah A. Small, George Loewenstein, »Heart Strings and Purse Strings: Carryover Effects of Emotions on Economic Decisions«, in: *Psychological Science*, Vol. 15, Issue 5, Mai 2004, 337–41.

VERLUST FRISST VON INNEN

Traurigkeit verlagert unbewusst die Prioritäten. Entscheidungen, die den Verlust betäuben, werden gegenüber solchen bevorzugt, die nur Unsicherheit reduzieren. Das Gehirn behandelt das Selbst wie eine Belohnung — sendet permanent die Anweisung: kompensiere den Verlust, sofort, egal wie. Das ist keine Metapher: Selbstbezug aktiviert jene Areale im Gehirn, die auch bei der Verarbeitung von Belohnungen eine Rolle spielen. Studien zeigen, dass beim Nachdenken über sich selbst dieselben Gehirnregionen aktiv werden wie beim Erhalt von Belohnungen.⁵ Um mich zu trösten, greife ich dann nicht nur zur Zigarette. Traurige Menschen geben mehr Geld aus.⁶ Traurige Menschen essen mehr Junk Food.⁷ Traurige Menschen inhalieren tiefer, ziehen länger und nehmen dadurch pro Zug rund dreißig Prozent mehr Rauch auf.⁸ Nicht weil sie süchtiger wären, sondern weil Traurigkeit den Fokus nach innen lenkt, und Selbstfokus aktiviert das Belohnungssystem.

Entscheidend ist also weniger, ob ein Gefühl positiv oder negativ ist, sondern ob es uns nach innen oder nach außen lenkt. Reflexive Emotionen (Traurigkeit, Zufriedenheit) verstärken Selbstfokus. Gedanken kreisen um die eigene Person, die eigenen Gefühle, die eigene Situation. Traurigkeit kippt vor allem dann

5 Georg Northoff, Dave J. Hayes, »Is Our Self Nothing but Reward?«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 69, Issue 11, 01.06.2011, 1019—25.

6 Cynthia E. Cryder, Jennifer S. Lerner, James J. Gross, Ronald E. Dahl, »Misery Is Not Miserly: Sad and Self-Focused Individuals Spend More«, in: *Psychological Science*, Vol. 19, Issue 6, 01.06.2008, 525—30.

7 Nitika Garg, Brian Wansink, J. Jeffrey Inman, »The Influence of Incidental Affect on Consumers' Food Intake«, in: *Journal of Marketing*, Vol. 71, Issue 1, Januar 2007, 194—206.

8 Dieser Unterschied kommt durch längeres Ziehen zustande; die Züge dauern im Schnitt eine halbe Sekunde länger. Dorison et al. 2020.

in Ersatzsuche, wenn sie ins Grübeln zieht. Wird der Selbstfokus unterbrochen, verliert Traurigkeit einen Teil ihrer Sogkraft. Je mehr ich grüble, desto stärker mein Verlangen nach Ersatz im Allgemeinen, stärker mein Substanzkonsum im Besonderen.⁹ Und ungeduldig werde ich. Wie ein Ertrinkender greife ich nach allem, was ich kriegen kann, nehme lieber eine kleine Belohnung sofort, statt eine größere später.¹⁰ Zur Veranschaulichung habe ich diese Befunde in einem Emotionsraum zusammengeführt (Grafik rechts).

Traurigkeit lenkt die Aufmerksamkeit auf das eigene Ich.¹¹ Sie weckt unbewusst den Drang, den Verlust sofort auszugleichen und die Umstände zu verändern, selbst in Bereichen, die mit dem ursprünglichen Verlust nichts zu tun haben. Diese selbstfokussierten Bewertungen sind der Mechanismus, durch den induzierte Traurigkeit bei Rauchern zu erhöhtem Zigarettenkonsum führt.¹² Traurigkeit steigert das Verlangen und die Intensität des Konsums, weil sie den Blick nach innen richtet, auf das eigene Defizit, was den Drang nach sofortiger Belohnung antreibt.¹³

Nicht jede negative Gemütslage löst eine solche Belohnungssuche aus. Auch nach innen gerichtete Emotionen können gegenteilige Auswirkungen haben. Ekel etwa führt zu

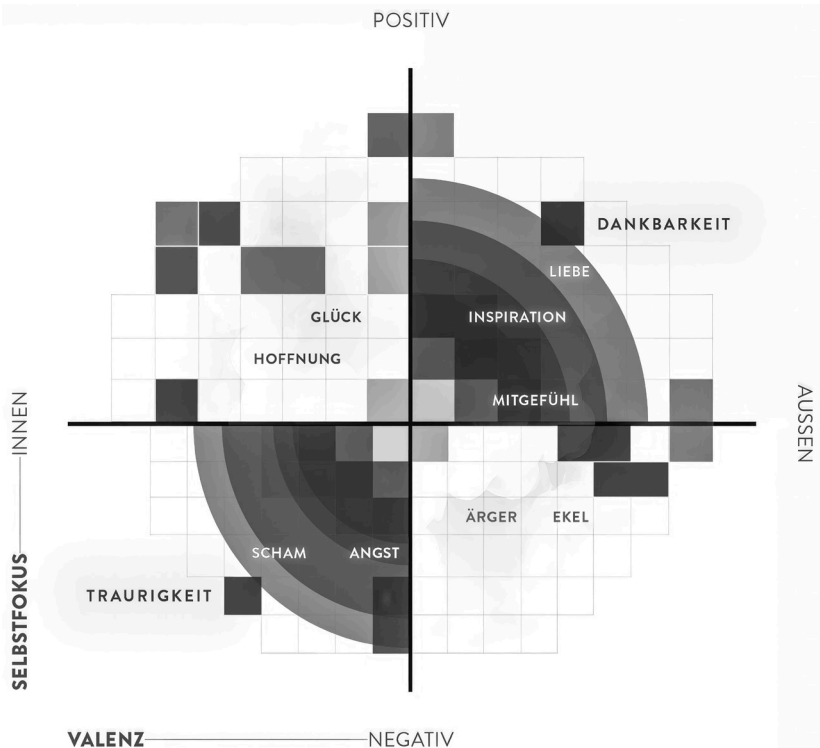
9 Cryder et al.

10 Dorison et al. 2020.

11 Joanne V. Wood, Judith A. Saltzberg, Lloyd A. Goldsamt, »Does affect induce self-focused attention?«, in: *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 58, Issue 5, 1990, 899—908.

12 Jeffrey D. Green, Constantine Sedikides, »Affect and Self-Focused Attention Revisited: The Role of Affect Orientation«, in: *Personality and Social Psychology Bulletin*, Vol. 25, Issue 1, Januar 1999, 104—19.

13 Nitika Garg, Jennifer S. Lerner, »Sadness and consumption«, in: *Journal of Consumer Psychology*, Vol. 23, Issue 1, 02.06.2012, 106—13.



Emotionsraum (Valenz x Selbstfokus)

Das Diagramm ordnet zwölf Emotionen entlang zweier Achsen: Valenz (negativ—positiv) und Selbstfokus (innen—außen). Der Gegensatz zwischen Traurigkeit (unten links: selbstbezogen, negativ) und Dankbarkeit (oben rechts: außenbezogen, positiv) wird deutlich.

Traurigkeit erzeugt selbstbezogene Verlustbewertungen und treibt den Wunsch nach kompensierenden Belohnungen — auch in unabhängigen Situationen wie dem Rauchen. Dankbarkeit dagegen lenkt die Aufmerksamkeit nach außen und ermöglicht Geduld sowie langfristige Orientierung.

Die anderen Emotionen gruppieren sich entsprechend: Scham und Angst als innere negative Gefühle, Ärger und Ekel als äußere negative, Glück und Hoffnung als selbstbezogen positive, Liebe, Inspiration und Mitgefühl als außenbezogen positive Emotionen.

Datengrundlage: Wang et al., PNAS 2024; Dorison et al., PNAS 2020; Gross, *Handbook of Emotion Regulation* 2013.

Vermeidungsverhalten. Auch Angst vermittelt andere Informationen, brüllt zwar ebenso laut, doch ängstliche Menschen wählen risikoarm mit kleinerer, aber sicherer Belohnung — traurige greifen zu riskanten Optionen mit hoher potenzieller Belohnung.¹⁴ Angst will Unsicherheit meiden, Traurigkeit Verlorenes ersetzen.¹⁵ *Die Zigarette ist billiger als Therapie und schneller als Heilung.*

Die Forscher fanden heraus, dass Traurigkeit Rückfälle zuverlässig voraussagt. In Daten von über zehntausend Probanden über zwanzig Jahre ließ sie Ex-Raucher konsistent wieder zur Zigarette greifen. Allein das Ausmaß an Traurigkeit sagte vorher, ob jemand rauchte, selbst dann, wenn man Alter, Geschlecht, Bildung und andere negative Gefühle wie Angst oder Wut herausrechnete. Bei ehemaligen Rauchern erlaubte der gemessene Traurigkeitsgrad sogar die Vorhersage, wer zwanzig Jahre später rückfällig werden würde. Wer heute traurig ist, raucht in zwei Jahrzehnten wieder. Was Traurigkeit nicht voraussagte: ob jemand, der noch nie geraucht hat, überhaupt damit anfängt. Traurigkeit kann also die Sucht reaktivieren, aber sie schafft keine neue.¹⁶

Weil Korrelation nicht Kausalität ist — schwierige Lebensumstände könnten sowohl Traurigkeit als auch Rückfälle verursachen —, wurden die Raucher zufällig in drei Zustände versetzt, jeweils über einen Filmclip mit anschließender Schreibaufgabe. Eine Gruppe sah einen Clip über Verlust und schrieb über eigene Verlusterfahrungen; eine andere sah einen ekelerregenden

14 Rajagopal Raghunathan, Michel Tuan Pham, »All Negative Moods Are Not Equal: Motivational Influences of Anxiety and Sadness on Decision Making«, in: *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 79, Issue 1, Juli 1999, 56—77.

15 Raghunathan-Pham, ebd.

16 Dorison et al. 2020.

Clip; die Kontrollgruppe sah einen neutralen Clip über Möbelherstellung, der kaum Affekte auslöste.¹⁷ Vor und nach der Prozedur maßen die Forscher das Rauchverlangen. Ergebnis: die traurig gestimmte Gruppe verspürte signifikant mehr Rauchverlangen als die neutrale, während die Ekelgruppe sogar eine Verringerung des Verlangens zeigte.¹⁸

Damit war klar, dass Traurigkeit das Rauchverlangen spezifisch und kausal steigert. *Traurigkeit führt zu Selbstfokus führt zu Belohnungssuche führt zur Zigarette.*

In einer weiteren Studie untersuchten die Forscher, ob Traurigkeit auch das Entscheidungsverhalten von Rauchern beeinflusst, also ihre Geduld bei sofortiger versus späterer Belohnung. Wie zuvor wurden Teilnehmer zufällig einer Trauer- oder Neutral-Bedingung zugewiesen. Anschließend durften sie wählen: *Zwei Züge jetzt oder fünf Züge in zwanzig Minuten?* Die Traurigen wählten das Sofortige, nahezu ausnahmslos. Die Forscher wiederholten das Experiment, Resultat identisch, womit bewiesen war, dass Traurigkeit einen kausalen Effekt auf die Ungeduld von Rauchern hat.¹⁹

In der nächsten Studie überprüften sie diese Effekte unter realitätsnäheren Bedingungen. Raucher, die nachweisbar seit mindestens acht Stunden nicht geraucht hatten (also Grundverlangen hatten), wurden zufällig in eine Trauer- und eine Neutralgruppe aufgeteilt (Emotionsinduktion wie zuvor). Anschließend durften sie — abhängig von ihren Entscheidungen in einer erneuten Zeitpräferenz-Aufgabe — tatsächlich ein paar Züge nehmen. Wie zu

¹⁷ Dorison et al. 2020.

¹⁸ Dorison et al. 2020.

¹⁹ Dorison et al. 2020.

erwarten, verhielten sich traurige Raucher deutlich ungeduldiger und wählten häufiger den sofortigen Konsum.²⁰

Um den vermittelnden Mechanismus aufzudecken, füllten alle Teilnehmer nach der Emotionsinduktion zusätzlich Fragebögen aus. Darin gaben sie an, wie stark sie momentan auf sich selbst fokussiert waren, wie negativ sie sich insgesamt fühlten und ob sie ein ausgeprägtes Verlustgefühl verspürten. Das Ergebnis: Traurigkeit erhöht alle drei Faktoren — Selbstfokus, allgemeine Negativität, Verlustempfinden — doch allein der verstärkte Selbstfokus sagte die gesteigerte Ungeduld signifikant voraus. Nicht die allgemeine Negativstimmung vermittelte den Einfluss von Traurigkeit auf die Ungeduld, sondern erhöhter Selbstfokus. Selbstfokus ist demnach der Schlüsselfaktor, über den Traurigkeit die Belohnungssuche antreibt.²¹

Das erklärt, warum Anti-Raucher-Kampagnen, häufig von der Tabakindustrie selbst finanziert, so konsequent auf traurige Darstellungen von Verlust und Leid setzen. Ihre auf Traurigkeit und Selbstfokus ausgerichteten Botschaften liefern einen effektiven Anreiz, weiter zur Zigarette zu greifen. *Schockbilder schocken nicht – sie locken. Jede Anti-Raucher-Kampagne, die auf Traurigkeit setzt, ist ein Werbespot für Zigaretten.*

Die Tabakindustrie weiß das.²² Sie finanziert ihre eigenen Krebsbilder, weil Traurigkeit süchtig macht. Emotionale Schockbilder voller Trauer — Krebsgeschwüre, Witwen am Grab, Kinder ohne Vater — sollen das Verlangen der Raucher durch Verlust zusätzlich schüren. Keine Tabakindustrie würde diese

20 Dorison et al. 2020.

21 Dorison et al. 2020.

22 Anne Landman, Pamela M. Ling, Stanton A. Glantz, »Tobacco Industry Youth Smoking Prevention Programs: Protecting the Industry and Hurting Tobacco Control«, in: *American Journal of Public Health*, Vol. 92, Issue 6, Juni 2002, 917—30.

Kampagnen andernfalls mitfinanzieren. Das ist kein Fehler, sondern Architektur. Abschreckungskampagnen sind *de facto* Werbung für Zigaretten, finanziert von denen, die davon profitieren. Jedes Bild eines sterbenden Rauchers aktiviert genau jene Emotion, die das Verlangen maximiert. Ich öffne die Packung, sehe das verfaulte Zahnfleisch, fühle kurz Trauer über meinen eigenen Verfall — und greife zur Zigarette, um die Trauer zu betäuben.

DAS GEGENGIFT

Dankbarkeit ist das neuronale Gegenteil von Traurigkeit. Wenn Traurigkeit der Dealer ist, ist Dankbarkeit der Arzt. Traurigkeit fokussiert nach innen, auf Verlust, auf das Ich. Dankbarkeit fokussiert nach außen, auf Gewinn, auf andere. Die Bewertungsmuster sind exakt gegenläufig. Traurigkeit sagt: *Mir wurde genommen*. Dankbarkeit sagt: *Mir wurde gegeben*. Traurigkeit verstärkt den Selbstfokus. Dankbarkeit löst ihn auf. Stichproben aus 87 Ländern bestätigen das.²³ Dankbarkeit reduziert das Rauchverlangen erheblich. Sie hilft am verlässlichsten, Zigaretten zu meiden. Dankbarkeit tröstet und erneuert mein Denken.

Ausgelöst wird Dankbarkeit zum Beispiel, wenn mich jemand unerwartet freundlich oder großzügig behandelt. Das erzeugt unbewusste Bewertungen, die denen der Traurigkeit entgegengesetzt sind. Statt den Fokus auf Verlust und Ich zu legen, erzeugt Dankbarkeit ein Gefühl von Gewinn und Ausrichtung auf andere. Das implizite Ziel dieser Emotion unterscheidet sich von Traurigkeit grundlegend. Ich fühle mich beschenkt, verbunden, statt beraubt und allein.

23 Wang et al. 2024.

Dadurch hat Dankbarkeit weitere positive Nebeneffekte. Prosoziales Verhalten zum Beispiel. Geben, Kooperation, Fürsorge und eine langfristige Perspektive.²⁴

Dankbarkeit war es, was mir im Frühjahr 2016 half, aus meinem Binge-Eating und der Rauchsucht in die Freiheit zu finden. Sie half mir, freundlicher mit mir selbst umzugehen. Das tut sie, weil Dankbarkeit mit bewertungsloser Akzeptanz einhergeht. Wenn ich dankbar bin, reagiere ich auf mein Unbehagen oder Verlangen nicht mehr automatisch. Ich bewerte es nicht, ich beobachte es nur. Ich bin nicht meine Gedanken, meine Gefühle, ich *sehe* und *erlebe* sie, aber ich verwechsle mich nicht mit ihnen.

Traurigkeit dagegen liebt das Gestern und das Morgen. Sie ist eine ständige Ausweichbewegung. Im Hier und Jetzt verhungert sie. Traurigkeit braucht Zeit, innere Repräsentation. Gegenwart verbrennt sie. Das Bild des Traurigen ist der Philosoph ohne Werden, einsam sitzend im Hinterhof eines verfallenen Hauses, ständig vergleichend, *was war* und *was sein könnte*. Vergangenheit und Zukunft existieren nicht im Moment. Dort hat Traurigkeit keinen Nährboden.

So wie Angst nicht Traurigkeit schlägt, wenn es um Sucht geht, schlägt Freude nicht Dankbarkeit, wenn es darum geht, von ihr loszukommen. Freude vermittelt Gewinngefühl, richtet den Fokus aber nicht verlässlich auf andere. Narzissten können Freude empfinden. Aber sie empfinden keine Dankbarkeit. Mitgefühl dagegen lenkt den Fokus stark auf andere, bringt aber kein eigenes Erfolgs- oder Glücksgefühl mit sich. Depressive können Mitgefühl empfinden.

Keine Emotion vereint das persönliche Beschenktsein und die Ausrichtung auf andere, die soziale Selbsttranszendenz, so

24 Sara B. Algoe, Jonathan Haidt, »Witnessing excellence in action: the 'other-praising' emotions of elevation, gratitude, and admiration«, in: *Journal of Positive Psychology*, Vol. 4, Issue 2, 2009, 105–27.

sehr wie Dankbarkeit. Diese Kombination ist ein Antidot und in ihrer Wirksamkeit beinahe einzigartig.

In einer Studie wurde der Kausalbeweis erbracht. Die Harvard-Forscher teilten erwachsene Raucher abermals zufällig in vier Gruppen ein, die jeweils eine andere Emotion induziert bekamen: Dankbarkeit, Mitgefühl, Traurigkeit oder einen neutralen Zustand. Alle sahen ein kurzes Video, das die jeweilige Ziel-Emotion wecken sollte. Für Dankbarkeit eine bewegende Filmszene, für Mitgefühl notleidende Kinder, für Traurigkeit eine traurige Szene, für die Neutralbedingung einen sachlichen Clip über Möbelbau. Anschließend reflektierten die Probanden schriftlich ein eigenes Erlebnis, um die Emotion weiter zu vertiefen. Vor und nach dieser Prozedur maßen die Forscher das Rauchverlangen mithilfe eines etablierten Fragebogens.

Die Dankbarkeitsgruppe zeigte eine signifikante Abnahme des Verlangens nach Zigaretten im Vergleich zur Neutralgruppe, vor allem aber im Vergleich zur Traurigkeitsgruppe. Mitgefühl bewirkte keine Veränderung des Verlangens; Traurigkeit verstärkte es.²⁵ Sie wiederholten das Experiment; gleiches Resultat. Mediationsanalysen bestätigten, dass die Dankbarkeit selbst, keine allgemein positive Stimmung, das reduzierte Rauchverlangen bewirkte. Dankbarkeit führte kausal und unmittelbar dazu, dass Teilnehmer weniger rauchen wollten.

In einem weiteren Experiment testeten sie, ob Dankbarkeit nicht nur das Verlangen, sondern auch das Verhalten ändert. Wie ernsthaft die Teilnehmer eine Verhaltensänderung in Erwägung zogen, erhoben sie zunächst mithilfe einer standardisierten Motivationsskala. Dann durchliefen die Teilnehmer eine ähnliche Emotionsinduktion wie zuvor. Auch dieses Experiment wiederholten sie anschließend.

25 Wang et al. 2024.

Ergebnis: Dankbarkeit führte zu einer messbaren Handlung in Richtung Entwöhnung. Raucher, bei denen Dankbarkeit induziert wurde, meldeten sich signifikant häufiger freiwillig zu einem kostenlosen Online-Entwöhnungsprogramm an. Andere Emotionen, zum Beispiel Freude, bewirkten dies nicht. Dankbarkeit bewegt also tatsächlich weg von der Sucht.

Die Befunde zeigen zudem, dass Dankbarkeit impulsive Handlungen auch außerhalb des Suchtkontextes verringert. Als Persönlichkeitsmerkmal korreliert Dankbarkeit mit geringerer finanzieller Ungeduld.²⁶ Allgemeine Lebenszufriedenheit oder momentanes Glücksgefühl tun dies nicht. Wird Dankbarkeit induziert, treffen die Probanden signifikant häufiger langfristige finanzielle Entscheidungen zugunsten eines größeren, späteren Gewinns — was sich durch Hervorrufen von Freude nicht erzielen lässt.²⁷

In der nächsten Studie mit über 21.000 Teilnehmern aus 87 Ländern zeigte sich ein ähnliches Bild auf globaler Ebene. Diesmal erfassten die Forscher die Absicht, in der folgenden Woche Tabak zu konsumieren. Dankbarkeit war die einzige gemessene Emotion, die konsistent mit einer geringeren Konsumabsicht einherging. Weder Mitgefühl noch andere positive Gefühlslagen zeigten einen vergleichbaren Effekt. Zudem lag in Ländern mit höherem Dankbarkeitsniveau der Raucheranteil niedriger, und pro Kopf gingen weniger Zigaretten über die Ladentheke, auch nach Kontrolle der Wirtschaftsleistung. Der Zusammenhang ist

26 Leah Dickens, David DeSteno, »The grateful are patient: Heightened daily gratitude is associated with attenuated temporal discounting«, in: *Emotion*, Vol. 16, Issue 4, 2016, 421–5.

27 David DeSteno, Ye Li, Leah Dickens, Jennifer S. Lerner, »Gratitude: A Tool for Reducing Economic Impatience«, in: *Psychological Science*, Vol. 25, Issue 6, 23.04.2014, 1262–7.

also nicht nur auf individuelle Unterschiede zurückzuführen, sondern ein allgemeines Phänomen.²⁸

Dankbarkeit bringt noch weitere Vorteile. Sie fördert prosoziales Verhalten, Mitmenschlichkeit, tiefere soziale Bindungen, Vertrauen, allgemeines Wohlbefinden. Sie hilft nachweislich — nicht nur bei mir — auch andere Süchte bewältigen, etwa nach Alkohol und Binge-Eating. Dankbarkeit hilft also, der Sucht zu widerstehen, und verbessert zugleich individuelle wie zwischenmenschliche Ressourcen.

STAUNEN STATT STOFF

Es gibt möglicherweise noch eine weitere Emotion, die den Suchtdruck senkt: *Ehrfurcht*. Das Gefühl staunender Bewunderung baut impulsive Ungeduld ab und fördert die Gesundheit. Positive Ehrfurcht war die zweite intensive Emotion, die das Jahr 2016 prägte, in dem ich mit dem Rauchen, dem Alkohol, dem Binge-Eating aufhörte. Keine Therapie, keine pharmazeutische Vergiftung. Nur zwei Emotionen, die mein Gehirn umgebaut haben.

Wer staunt, braucht keinen Stoff. Wichtig ist nur, positive Ehrfurcht von bedrohungsgetriebener Ehrfurcht zu unterscheiden. Letztere schadet oft eher. Die Evidenz, dass Ehrfurcht speziell gegen Nikotinsucht wirkt, ist vielversprechend, aber noch vorläufig.²⁹ Wenn Dankbarkeit jedoch nicht nur dem Rauchverlangen, sondern auch Essattacken und Alkoholkonsum entgegenwirkt, liegt es nahe, dass eine andere Emotion, die erwiesenermaßen Essattacken reduziert, ebenfalls gegen die Rauch- und Alkoholsucht hilft.

28 Wang et al. 2024.

29 Maria Monroy, Dacher Keltner, »Awe as a Pathway to Mental and Physical Health«, in: *Perspectives on Psychological Science*, Vol. 18, Issue 2, 22.08.2022, 309—20.

Nachgewiesen wurde, dass Ehrfurcht impulsives, schlingen-
des Essen reduziert. In einer Studie tranken Teilnehmende, bei
denen Ehrfurcht ausgelöst wurde, weniger Softdrinks, und Ehr-
furcht reduzierte das Verlangen nach Junk Food im Vergleich zu
neutralen Zuständen. Als Mechanismus gilt die kognitive Neu-
bewertung, die Ehrfurcht bewirkt.³⁰ Auch in Verbraucherexperi-
menten ließ Ehrfurcht die Wahl auf gesündere Produkte fallen.³¹

In Experimenten zeigte Ehrfurcht mehr wahrgenommene
Zeitfülle, weniger Ungeduld und mehr Bereitschaft, Zeit zu
geben, als beispielsweise Freude. Der Effekt lief über reduzierte
Ungeduld. Sucht ist eine Störung der Zeitwahrnehmung. Jetzt
sofort schlägt später. Ehrfurcht wirkt genau an dieser Sollbruch-
stelle.³² Sie ist auch mit stärkerer prosozialer Orientierung ver-
bunden, und stärkt damit soziale Ressourcen, die Rückfälle
abfedern.³³

Negative Emotionen erhöhen Rauchverlangen vermittelt
über weniger Selbstkontrolle und Rationalisierungen.³⁴ Wenn
Ehrfurcht als Gegenspieler zu Engführung und Ich-Alarm die

30 Yu Zhaoliang, »The Regulatory Effect of Awe: Awe Predicts Enhanced Ability to Resist Food Indulgence«, DISS, National University of Singapore, Singapore, 3. November 2020.

31 Fei Cao, Xia Wang, Ze Wang, »Effects of awe on consumer preferences for healthy versus unhealthy food products«, in: *Journal of Consumer Behaviour*, Volume 19, Issue 3, 12.03.2020, 264–76.

32 Melanie Rudd, Kathleen D. Vohs, Jennifer Aaker, »Awe Expands People's Perception of Time, Alters Decision Making, and Enhances Well-Being«, in: *Psychological Science*, Vol. 23, Issue 10, 2012, 1130–6.

33 Paul K. Piff, Pia Dietze, Matthew Feinberg, »Awe, the Small Self, and Prosocial Behavior«, in: *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 108, No. 6, Juni 2015, 883–99.

34 Yixin Zhao, Yong Li, Yang Shu, et al., »The effect of negative emotions on smoking craving: the chain-mediating role of self-control and self-exempting beliefs«, in: *Frontiers in Psychiatry*, Vol. 16, 02.09.2025, 1642341.

Selbstregulation stärkt, ist das ein Ansatzpunkt, auch wenn es noch keine Entwöhnungsstudie dazu gibt. Positive, selbsttranszendente Emotionen sind als Hebel beim Rauchen bereits belegt. Dankbarkeit senkt das Verlangen zu rauchen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sich zur Entwöhnung anmelden. Die Autoren weisen explizit darauf hin, dass Anti-Raucher-Kampagnen oft Traurigkeit auslösen, was Verlangen erhöhen kann. Das ist für Ehrfurcht wichtig, weil Ehrfurcht und Dankbarkeit Familienähnlichkeit haben. Beide sind selbsttranszent, perspektivweitend, auch wenn sie nicht identisch sind.

In der Suchttherapie tauchen selbsttranszendente, oft mystisch beschriebene Erlebnisqualitäten, die ihr ähneln, als Wirkfaktoren auf, unter anderem in Studien zu Tabak- und Alkoholstörung.³⁵ Ehrfurcht ist praktisch der Prototyp einer Emotion, die Sinn erzeugt.

35 Albert Garcia-Romeu, Roland R. Griffiths, Matthew W. Johnson, »Psilocybin-occasioned Mystical Experiences in the Treatment of Tobacco Addiction«, in: *Current Drug Abuse Reviews*, Vol. 7, Issue 3, 2015, 157–64.

NOTAUSGANG INS NICHTS

*Jede aufgegebene Sucht hinterlässt eine Hypothek.
Irgendwer wird sie eintreiben.*

*1 Rasierklingenschaum — 2 Der angenehme Teil — 3 Etwas, das man
wegwerfen sollte — 4 Der blinde Spiegel — 5 Sprechen mit fremder
Stimme — 6 Der satteste Hunger der Welt — 7 Abtreibung in Zeitlupe
— 8 Vivisektion — 9 Heilung beginnt nicht mit Einsicht*

Dreimal sank ich unter die Wasserlinie des Lebens. Die Ärzte sagten, ich würde »dumm und behindert«. Sie hatten mich aufgegeben. *Pharmakoresistente Grand-Mal-Epilepsie* nannten sie es. *Autoimmun-Enzephalitis*.

Worte wie Quecksilber.

Im Januar 2024 riss es mich am tiefsten. Der Schmerz war weiß. Nerven blitzten wie Sterne im Öl. Krämpfe sickerten über Gehirn und Rückenmark. Es hörte nicht auf.

Ich suchte im Schwarz nach dem Inbild. Aber da war nichts. Trüb war die Welt. Ich suchte weiter, aber der Geist war verschwunden. Kein Gedanke, kein Nachbild.

Du musst einen Weg finden. Du musst dein Gehirn reparieren.

Ich spürte meine Hände nicht. Die Welt schwamm verkehrt. Im Wasser suchte ich meinen Namen. Ich fand ihn nicht. Nur Äther. Und gerade genug Kraft, die Finger zu bewegen. Ein dunkler, stiller Raum, in dem ich gefangen war. Ich tastete mich die Wände entlang, suchte einen Ausgang. Es gab keinen.

Dann ein Impuls.

War ich das?

Es reichte einen Wimpernschlag. Eine winzige Bewegung. Ich nahm den Stift, als wäre er ein Atemrohr. Punkte. Striche. Tropfende Buchstaben. Ein klarer Satz würde den Raum füllen.

Du musst einen Satz schreiben.

Es kam nichts.

Wach bleiben.

Zeitfenster. Erst für Sekunden, dann Minuten.

Stift halten. Über das Papier beugen.

Silbe für Silbe schrieb ich mich von Körperzelle zu Körperzelle. Wochen vergingen. Papier am Bett wie weiße Haut. Synapsen wie Fäden im Riff. Es waren zarte Fäden. Ich musste gegen die Entzündung anschreiben. Sätze finden, die mich zurückbringen. Einen Satz, der mich neu baut. Monate vergingen so. Immer wieder zog es mich ins Schwarz. Schwindel füllte meinen Kopf. Die Schwerkraft war ein Angebot. Ich versuchte mich nach oben zu arbeiten.

Irgendwann hatte ich eine Handvoll Sätze. Wie Holz. Langsam tauchte ein Ich aus dem Nichts. Umrisschaft. Ich schrieb weiter — baute ein Floß.

Das war vor einer Stunde.

Ich erinnerte mich.

Das war vor einem Tag.

Ich erinnerte mich nochmal.

Wie Sauerstoff flossen die Worte. Eines Tages hatte ich mir Kraft erschrieben, mich aufzurichten. Ein paar Schritte zu gehen. Feuchte Erde unter meinen Füßen.

Die Entzündung ebte ab. Für die Ärzte bin ich eine Anomalie — ich lebe noch. Sie diagnostizierten mir Sterben. Ich schrieb weiter. Mit vierzehn schrieb ich zum ersten Mal einen Satz, der stärker war als der Impuls, den Notausgang zu wählen. Heulend vor einer Schreibmaschine im Keller erschrieb ich mir, buchstäblich, jeden Atemzug.

Aber Atmen ist kein Verdienst. *Leben ist ein chemischer Vorgang.* Wille ist das Wort, das wir benutzen, wenn wir nicht verstehen wollen, warum wir längst verloren haben. Dopamin tropft wie Gold zwischen Reiz und Reaktion. Rezeptoren öffnen ihren Schoß, lutschen an schmierigen Münzen. Der Geschmack von *Ich* macht die Zunge taub. Ich bekomme keine Luft.

Aber die Tür öffnet sich nicht.

Eine Frau steht auf. Sterbenskrank, die Ärzte gaben ihr Stunden. Sie steht auf. Geht nach Hause. Regelt, was sie regeln muss. Geht zurück ins Krankenhaus. Legt sich hin. Stirbt.¹

Sie hatte kein Recht dazu. Und trotzdem nennen zerstörte Gehirne ihre Kinder plötzlich beim Namen. Kein Algorithmus wehrt sich, wenn die Berechnung sagt, es ist vorbei. Aber Menschen tun das. Selten. Fast nie.

Und doch bin ich hier.

Epilepsie war nicht mehr. Rauchen schon. Noch anderthalb Jahre rauchte ich aus Pflicht zur Selbstzerstörung.

Dann hörte ich auch damit auf. Irgendwo zwischen Kapitel drei und vier dieses Buches. Ich schrieb mich durch die Eingeweide der Hölle, und die Hölle schrieb zurück.

Und dann kam der Alkohol.

1 RASIERKLINGENSCHAUM

Saufen ist sozialverträgliche Selbstverstümmelung. Der einzige Unterschied zum Ritzen ist das Ansehen. Eine ganze Zivilisation hat beschlossen, ihr Nervengift Kulturgut zu nennen, ihr Organversagen Genuss und ihre Abhängigkeit Freiheit. Der

1 Michael Nahm, Bruce Greyson, Emily Williams Kelly, Erlendur Haraldsson, »Terminal lucidity: A review and a case collection«, in: *Archives of Gerontology and Geriatrics*, Vol. 55, Issue 1, 2012, 138—42.

Staat verdient mit, die Industrie liefert nach, und wer aufhört, gilt als der mit dem Problem.

Wer das benennt, ist der Spielverderber. Wer daran stirbt, hatte halt Pech. Und was es mit dem Körper macht, interessiert erst, wenn er kollabiert. Erst verstümmelt es die Wahrnehmung. Dann die Organe. Dann die Jahre. Am Ende sitzt ein Mensch da, der aussieht wie fünfzig, denkt wie fünfzehn und sich erinnert wie achtzig.

Ich hörte auf zu rauchen. — *Ich hörte auf zu rauchen und fing an zu ertrinken.* Damit habe ich nicht gerechnet. Zehn Jahre zuvor hatte ich schon einmal aufgehört. Damals trank ich Brennessel-Smoothies, Kokoswasser und Zitronensaft.

Jetzt war ich plötzlich alkoholabhängig. Bier war das Einzige, das ich wollte. Wein trank ich nicht. Schnaps trank ich nicht. Alkoholfrei trank ich nicht. Als hätte mein Körper eine Getränkekarte, auf der genau ein Punkt nicht durchgestrichen war. Nach dem Rauchstopp trank ich täglich. Ich arbeitete, ich sprach, ich erledigte Dinge. Ich trank dabei oder ich trank danach. Wenn ich nicht trank, kratzte ich mir die Hände blutig.

Nach sieben Jahren nahm ich meinem Gehirn sein falsches Normal weg. Rauchen war mein ausgelagerter Neurotransmitter geworden — »als hätte jemand [meine] Organe in den Raum gehängt«². Der Stopp riss sie herunter. Nikotin hob das Dopamin an³ — Antrieb, Fokus, es geht irgendwie. Acetylcholin für Aufmerksamkeit. Noradrenalin für Wachheit.⁴ Stressachsen

2 Emilie von Drachenfels, *Der Ewige Palast*, Berlin 2024, 429.

3 Xiaonan Li, Lehua Lu, Ying He, et al., »Pharmacological effects of nicotine salts on dopamine release in the nucleus accumbens«, in: *Frontiers in Pharmacology*, Vol. 14, 28.09.2023, 1279512.

4 D. J. K. Balfour, »The psychobiology of nicotine dependence«, in: *European Respiratory Review*, Vol 17, Issue 110, 2009, 172—81.

gedämpft — scheinbar. Das eigene Dopamin sackte auf den Grund der Hölle.⁵

Mein Gehirn hatte gelernt: *Das muss ich nicht selbst herstellen, das kommt von außen.*

Dann zog ich ihm die Krücke weg.

Okay, wo ist mein Zeug.

Nirgends.

Dopamin im Keller, Serotonin dysreguliert, Stresssystem hoch, Belohnungssystem stumm. Das ist Entzug.⁶ Ich hörte mit Nikotin auf, ohne zu wissen, was danach kommt. Mein Körper suchte Ersatz und schraubte sich ein Notstromaggregat in den Kopf, das genau das Haus anzündete, das ich gerade reparieren wollte.

Ich trank nicht aus Lust. Mein Nervensystem hatte nur verlernt, ohne Nikotin zu funktionieren. Das Gehirn will keine Freiheit. Es will Ruhe. Bier war mein neues Nikotin. Manchmal leerte ich täglich fast so viele Flaschen wie vormals Zigaretten.

Na gut, ganz so viele vielleicht nicht. Aber fast.

Das ging Monate so.

Bier ist Alkohol mit Tarnkappe und Tempo. Ein pharmakologischer Vorschlaghammer. Dazu flüssige Kohlenhydrate, die Dopamin und Insulin hochtreiben.⁷ Die perfekte Einstiegsdroge

5 Lifen Zhang, Yu Dong, William M. Doyon, John A. Dani, »Withdrawal from Chronic Nicotine Exposure Alters Dopamine Signaling Dynamics in the Nucleus Accumbens«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 71, Issue 3, 27.08.2011, 184—91.

6 Ranjithkumar Chellian, Azin Behnood-Rod, Adriaan W. Bruijnzeel, »Persistent Anhedonia After Intermittent Long-Access Nicotine Self-Administration in Rats«, in: *bioRxiv [Preprint]*, 19.03.2025, 644137.

7 Katja A. Hätönen, Jarmo Virtamo, Johan G. Eriksson, et al., »Modifying effects of alcohol on the postprandial glucose and insulin responses in healthy

für Leute, die glauben, keine Drogen zu nehmen. Niemand nennt sich »bierabhängig«. Niemand denkt: *Ich saufe*.

— *Ich betreibe Akutmedizin.*

Was Bier unterscheidet: *es schmeckt*. Zigaretten schmecken scheußlich. Kokain schmeckt nach Chemie (habe ich gehört). Bier schmeckt nach Belohnung. Hochgenuss und Tod — im selben Schluck.

Das kann nur Bier.

Bier enthält Purine, die der Körper zu Harnsäure abbaut.⁸ Im Blut hielt man sie lange für schützend. In der Zelle greift sie von innen an. Gefäßwände altern vorzeitig. Zellen hören auf, sich zu teilen, sitzen fest, vergiften ihre Umgebung mit Entzündungsstoffen.⁹ *Das ist nicht Gicht, sondern messbarer Zellverfall.*

subjects«, in: *The American Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 96, Issue 1, Juli 2012, 44—9.

- 8 T. Gibson, A. V. Rodgers, H. Anne Simmonds, P. Toseland, »Beer drinking and its effect on uric acid«, in: *British Journal of Rheumatology*, Volume 23, Issue 3, 01.08.1984, 203—9.

- 9 In Fettzellen aktiviert Harnsäure die NADPH-Oxidase und steigert die Produktion reaktiver Sauerstoffspezies.

Yuri Y. Sautin, Takahiko Nakagawa, Sergey Zharikov, Richard J. Johnson, »Adverse effects of the classic antioxidant uric acid in adipocytes: NADPH oxidase-mediated oxidative/nitrosative stress«, in: *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, Vol. 293, Issue 2, 01.08.2007, C584—96.

In Endothelzellen löst sie oxidativen Stress aus, aktiviert das Renin-Angiotensin-System und fördert *Seneszenz* sowie *Apoptose*.

Min-A Yu, Laura G. Sánchez-Lozada, Richard J. Johnson, Duk-Hee Kang, »Oxidative stress with an activation of the renin-angiotensin system in human vascular endothelial cells as a novel mechanism of uric acid-induced endothelial dysfunction«, in: *Journal of Hypertension*, Vol. 28, Issue 6, Juni 2010, 1234—42.

Senescente Zellen sind lebende Leichen im eigenen Gewebe. Sie teilen sich nicht mehr, sitzen fest und vergiften ihre Umgebung mit Entzündungsstoffen. Apoptotische Zellen erkennen ihren Schaden und töten sich kontrol-

Das Gehirn balanciert auf zwei Neurotransmittern. Glutamat ist der Strom im Nervensystem. Er feuert. GABA ist die Sicherung. Sie dämpft. Alkohol greift beides an. Er blockiert die NMDA-Rezeptoren, die wichtigsten Glutamat-Empfänger. Die Reizweiterleitung wird langsamer, die Gedächtnisbildung stockt, dann bricht sie zusammen.

Ein Blackout ist kein Filmriss. Er ist ein Speicherausfall. Der Hippocampus kann nichts mehr schreiben. Die Rezeptoren, die er braucht, sind blockiert. Das Erlebte findet statt und wird nirgendwo abgelegt. Ein Abend, der nie existiert hat. Alkohol drückt die GABA-Rezeptoren auf. Alkohol vervielfacht jedes Bremssignal, löscht die Signale und überflutet die Dämpfung. Was sich anfühlt wie Entspannung, ist eine pharmakologische Notabschaltung.¹⁰

liert, um den Rest zu schützen. Wenn zu viele sterben, dünnt das Gewebe aus und die Gefäße werden löchrig.

Harnsäure erzeugt mehr Harnsäure. Durch Fermentation entstehen Stoffe, die die DNA angreifen und Purinbasen freisetzen, die dann wiederum zu Harnsäure oxidiert werden.

Yuhe Kan, Zhikun Zhang, Kunhao Yang, et al., »Influence of d-Amino Acids in Beer on Formation of Uric Acid«, in: *Food Technology and Biotechnology*, Vol. 57, Issue 3, September 2019, 418—25.

Der biologische Alterungsprozess wird dadurch beschleunigt.

Cong Zhao, Leying Zhao, Yang Liu, et al., »The impact of serum uric acid on biological aging and mortality risk: insights from the NHANES and CHARLS cohorts«, in: *Frontiers in Nutrition*, Vol. 12, 22.04.2025, 1569798.

- 10 Howard C. Becker, Patrick J. Mulholland, »Neurochemical mechanisms of alcohol withdrawal«, in: *Handbook of Clinical Neurology*, Vol. 125, Kapitel 9, 2014, 133—56.

Ravinder Naik Dharavath, Celeste Pina-Leblanc, Victor M. Tang, et al., »GABAergic signaling in alcohol use disorder and withdrawal: pathological involvement and therapeutic potential«, in: *Frontiers in Neural Circuits*, Vol. 17, 20.10.2023, 1218737.

Das Gehirn steuert gegen, dreht die Spannung hoch. Mehr Glutamatrezeptoren, empfindlicher eingestellt. Die Leitungen glühen. Weniger GABA-Rezeptoren, stumpfer geschaltet. Die Sicherungen brennen durch. Das Gehirn baut sich eine Normalität, in der Alkohol eingeplant ist (*allostatischer Zustand*). In der Praxis bedeutet er: chronische Übererregung. Spannung am Anschlag, Sicherungen durch.

Irgendwann trinke ich nicht mehr, um mich zu entspannen. Ich trinke gegen die Spannung, die der Alkohol selbst erzeugt hat. Im MRT zeigen Trinker niedrigere GABA-Spiegel in der Hirnrinde. Besonders im frühen Entzug. Die durchgebrannten Sicherungen sind sichtbar.

2 DER ANGENEHME TEIL

Ich nahm mir Stabilität und nannte es Runterkommen. Ein Bier ist nichts. Zwei Bier sind Geselligkeit. Fünf Bier sind immer noch kein Problem (solange niemand zählt). Doch der Unterschied zu Schnaps ist am Ende bloß ästhetisch. Bier ist Alkoholismus mit Schaumkrone und Steuermarke. Jede Dosis hebt kurz über Null, danach fällt die Grundstimmung tiefer.¹¹

Was Alkohol im Körper bewirkt, ist Notruf auf Zellebene. Organe schreien. Zellen sterben. Ich könnte genauso gut meinen Kopf gegen die Wand schlagen. Danach ist mir genauso schwindlig wie nach fünf Bier. Wer betrunken ist, genießt kein Leben. Er stirbt ratenweise — messbar.

Alkohol ist ein Nervengift, das sich als Lebensart tarnt. Es betäubt die Systeme, die mich schützen sollen: Urteilskraft, Impulskontrolle, Erinnerungsbildung. Ich trank, um mich zu

11 George F. Koob, Michel Le Moal, »Drug Addiction, Dysregulation of Reward, and Allostasis«, in: *Neuropsychopharmacology*, 01.02.2001, Vol. 24, Issue 2, 97—129.

regulieren — und merkte nicht, dass ich genau das System zerstörte, das den Schaden hätte bemerken müssen. Alkohol ist ein Schlafmittel, das den Schlaf frisst. Er drückt mir die Augen zu und reißt sie vier Stunden später wieder auf. Der Boden ein weiteres Stück tiefer. Hungernd bei vollem Magen. Stress aufgestaut, als hätte mir die Nacht gegen den Schädel getreten.

Die Dosis macht das Gift. Und das Gift macht die Ausrede.

Enthemmt zuerst, entleert dann, entwürdigt am Ende.

Wir haben gelernt, dass es *Genuss* sei, sein Hirn zu vergiften. Sich dumm, alt und hässlich zu saufen. Die gesellschaftliche Akzeptanz von Alkohol ist eine kollektive Psychose. Aufhören ist schwerer als bei anderen Drogen. Ich kämpfe nicht nur gegen die eigene Neurochemie, sondern gegen eine kulturell verbrieft Gehirnwäsche. Wenn ich sagte, ich trinke keinen Alkohol mehr, kamen Nachfragen. Ich musste mich rechtfertigen, wenn ich nicht vergiftet sein wollte. Hätte ich Crystal Meth gesagt, hätte man möglicherweise Verständnis gehabt.

Ich hatte einen Mitbewohner, der täglich mindestens eine Flasche Wein leerte. Er erzählte mir, er sei früher Alkoholiker gewesen — während er sich das nächste Glas einschenkte.

Nun denn.

Er sprach vom Alkoholismus wie von einer überwundenen Grippe. Nebenbei kiffte er noch. Was bei Traumafolgestörung bekanntlich so schlau ist, wie eine Brandwunde mit Kerosin zu kühlen. Und er machte eine Psychotherapie. (Weil er an einer Traumafolgestörung litt.)

Er nannte sich Nichtraucher, kaute aber Nikotinkaugummis und dampfte. Dieselbe Dosis, anderes Vehikel. Als ich einmal über Designerdrogen scherzte, reagierte er ernsthaft. MDMA sei auch ganz gut. Er bedaure das schlechte Image von MDMA. Als sei es ein verkanntes Kulturgut.

Das war mein Mitbewohner.

Alkohol brennt sich in mein Gehirn wie das Gesicht eines Menschen, den ich liebe. Wenn der Drang kam, klang er wie Wahrheit. Das Verlangen fühlte sich an wie Hunger. Eine Forderung mit gefälschter Unterschrift.

Ich muss. Es geht nicht anders.

Nüchtern sein war wie barfuß über ein Minenfeld. Nüchtern bedeutete Gefahr.

Also Bier. Sofort.

Normal wurde zum Fenster zwischen zwei Abstürzen. Was letzte Woche zwei Bier waren, waren heute vier. Was letzte Woche abends war, rutschte nachmittags rein, dann vormittags. Weniger trinken ging nicht.

Ohne das Zeug überlebe ich den Tag nicht.

Die meisten Säuerer hält tagsüber noch etwas über Wasser. Stresshormone. Aufgaben. Soziale Kontrolle. Restdopamin aus Bewegung und Gesprächen. Oft auch andere Drogen. Kaffee zum Beispiel. Abends will das Gehirn nur noch Ruhe. Cortisol sinkt. Dopamin ist leer. Das System kippt. Der Körper verhandelt nicht.

Wenn Alkohol wegfällt, liegt offen, was er maskiert hat. Ein überaktives Glutamatsystem trifft auf ein geschwächtes GABA-System. Spannung bis zum Kurzschluss. Übererregung feuert. Angst, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit. Herzrasen, Tremor, Schweiß. Krampfanfälle. Tod. Dann Anhedonie. Nichts fühlt sich mehr gut an. Nicht einmal Essen. Nicht einmal Sex. Nicht einmal Ruhe.

Das Gehirn hat verlernt, irgendwas zu fühlen.

Jeder Entzug macht den nächsten schlimmer (*Kindling*). Wo beim ersten Entzug leichtes Zittern war, steht beim fünften ein Grand-Mal-Anfall. Das Gehirn vergisst nichts. Es quittiert. Ich weiß, wie sich Grand Mal anfühlt. Alkoholentzug baut es nach.

Wer mehrfach aufhört und wieder anfängt, trainiert sein Nervensystem auf schnelleren Zusammenbruch. Wie beim Rauchen, wo die Chance auf Erfolg mit jedem Versuch ebenso sinkt. Nur eben in lebensgefährlich.

Ich hatte eine Sucht beendet, ohne das System neu aufzubauen. Mein Körper griff zur nächstbesten Substanz.

Dann das Gewicht. Gewichtszunahme, Alkohol und Rauchen sind Zahnräder derselben Schuldenmaschine. Ohne Nikotin esse ich mehr.¹² Mit Alkohol esse ich noch mehr. Ich esse nicht, weil ich Hunger habe. Ich esse, weil ich es nicht aushalte, nichts zu essen. Dopaminmangel schreit nach Fett und Salz, also esse ich Dopamin in Lebensmittelverpackung.

Alkohol stoppt die Fettverbrennung komplett. Was ich esse, während Alkohol wirkt, lagert der Körper ein. Eine Handvoll Nüsse reicht. Er packt alles weg, als wüsste er, dass bald Krieg kommt. Der Krieg kommt auch. Er heißt Leberverfettung. Ich bin gleichzeitig müde, leer und fett.¹³ Ich wache auf und bin hungrig. Das ist kein Widerspruch. Das ist Alkohol. Dünn aussehen und innerlich verfetten.¹⁴ Oder fett sein und auf Mikronährstoff-Niveau verhungern.¹⁵

12 Henri-Jean Aubin, Amanda Farley, Deborah Lycett, et al., »Weight gain in smokers after quitting cigarettes: meta-analysis«, in: *BMJ*, Vol. 345, 10.07.2012, c4439.

13 Molly Butts, Vijaya Lakshmi Sundaram, Usha Murughiyan, et al., »The Influence of Alcohol Consumption on Intestinal Nutrient Absorption: A Comprehensive Review«, in: *Nutrients*, Vol. 15, Issue 7, 24.03.2023, 1571.

14 Helmut K. Seitz, Bernardo Moreira, Manuela G. Neuman, »Pathogenesis of Alcoholic Fatty Liver a Narrative Review«, in: *Life*, Vol. 13, Issue 8, 30.07.2023, 1662.

15 Butts et al. 2023.

Jahre, die nicht stattgefunden haben. Nüchternheit erzwingt die Bilanz. Wer aufhört zu trinken, sieht, dass sein Leben in einer Zeitschleife verschwunden ist. Dieselben Abende, dieselben Gespräche, dieselbe Leere. Der Körper altert im Zeitraffer, die Persönlichkeit bleibt infantil.

Jeder kennt sie, diese Leute, die seit zwanzig Jahren dahinvegetieren und immer dasselbe reden. Alkoholgeschwätz. Am selben Platz, am selben toten Punkt, nur älter, dicker und dümmer.

3 ETWAS, DAS MAN WEGWERFEN SOLLTE

Alkohol macht dumm und vergesslich gewiss. Vor allem aber macht er unschön. Wer regelmäßig trinkt, wird anstrengend. Das ist schlimmer als gefährlich. Die Persönlichkeit kocht weich, die Kontur löst sich auf, und der Betroffene glaubt, er sei endlich er selbst. Die traurigste Verwandlung, die Alkohol produziert, ist nicht der Penner mit der Bierdose in der U-Bahn. Es ist der nette Kerl in der Eckkneipe, der nicht merkt, dass er eklig geworden ist.

Der Unterschied zwischen denen, die trinken, und denen, die es nicht tun, ist immer körperlich zuerst. Die Haut ist teigig, porös, wie von innen aufgeweicht. Der Schweiß riecht süßlich und chemisch. Acetaldehyd, ein Abbauprodukt, das der Körper über die Haut ausschwitzt. Es riecht nach überreifem Obst. Die Augen sehen aus, als hätte jemand das Licht runtergedreht. Ich habe nie das Gefühl, ihnen wirklich zu begegnen. Verrottete Gesichter, durch die niemand mehr durchsieht. Alles wirkt gekünstelt, erzwungen, aufgesetzt. Auch wenn sie lachen oder freundlich sind.

Nichts davon ist gespielt. Das ist das Schlimme. Es sind nicht sie. Es ist der Alkohol, der sie aushöhlt, bis sie Schatten ihrer selbst sind, lange bevor sie es bemerken.

Wer regelmäßig trinkt, wird klebrig. Er steht zu nah, redet zu lange, lacht zu laut, fasst zu viel an. Die Grenzen verschwinden

aus der Wahrnehmung, bevor sie überschritten werden.¹⁶ Das ist Mikro-Enthemmung in Serie. Kein einzelner Ausrutscher. Ein Dauerzustand leichter Grenzenblindheit.¹⁷

Der orbitofrontale Cortex, die Region, die soziale Feinabstimmung leistet, schrumpft bei regelmäßigem Alkoholkonsum messbar.¹⁸ Diese Hirnregion entscheidet, wie nah ich stehe, wann mein Witz nicht mehr lustig ist, ob mein Lachen noch passt. Die Kalibrierung verschwindet nicht. Sie wird unscharf. Sie lesen andere genauso schlecht, wie andere sie lesen.¹⁹ Der Mensch funktioniert noch. Aber er funktioniert einen halben Millimeter daneben. Immer. Und diesen halben Millimeter spürt das Gegenüber als Ekel.

16 E. López-Caneda, S. Rodríguez Holguín, F. Cadaveira, et al., »Impact of Alcohol Use on Inhibitory Control (and Vice Versa) During Adolescence and Young Adulthood«, in: *Alcohol and Alcoholism*, Vol. 49, Issue 2, 173—81, März 2014.

Gabriela Gan, Alvaro Guevara, Michael Marxen, et al., »Alcohol-induced impairment of inhibitory control is linked to attenuated brain responses in right fronto-temporal cortex«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 76, Issue 9, 15.01.2014, 698—707.

17 Emre Bora, Nabi Zorlu, »Social cognition in alcohol use disorder: a meta-analysis«, in: *Addiction*, Vol. 112, Issue 1, Januar 2017, 40—8.

Roy C. Onuoha, Daniel S. Quintana, Michael Lyvers, Adam J. Guastella, »A Meta-analysis of Theory of Mind in Alcohol Use Disorders«, in: *Alcohol and Alcoholism*, Vol. 51, Issue 4, Juli/August 2016, 410—5.

18 Remi Daviet, Gökhan Aydogan, Kanchana Jagannathan, et al., »Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank«, in: *Nature Communications*, Vol. 13, 04.03.2022, Artikel 1175.
Murad Atmaca, Muhammed Fatih Tabara, Mustafa Koc, et al., »Cortical Thickness of the Orbitofrontal Cortex in Patients with Alcohol Use Disorder«, in: *Brain Sciences*, Vol. 13, Issue 4, 25.03.2023, Artikel 552.

19 Chloe N. Shields, Christina M. Gremel, »Orbitofrontal Cortex in Alcohol Dependence: A Disrupted Cognitive Map?«, in: *Alcohol, Clinical and Experimental Research*, Vol. 44, Issue 10, 20.09.2020, 1952—64.

Ein enthemmter Mensch ist nicht frei. Er ist undicht. Und Enthemmung, die freundlich lächelt, ist die widerlichste Form von Übergriﬀ, weil man sich nicht wehren kann, ohne als humorlos zu gelten.

Dazu die chronische Restvergiftung als Grundton. Wer jeden zweiten Tag trinkt, ist nie betrunken und nie klar.²⁰ Er lebt in der Dämmerung und hält sie für Tageslicht.

Der häufigste Blutalkoholwert in Deutschland ist nicht null und nicht betrunken. Er ist: knapp darunter. Gerade genug, um am Morgen nicht aufzufallen. Gerade genug, um innerlich auf Sandpapier zu laufen. Wenn mein Mitbewohner nicht betrunken war, war er matschig. Ein Aggregatzustand, für den es kein Wort gibt, weil niemand zugibt, dass er existiert. Müde, reizbar, dünnhäutig, ungeduldig. Der Schlaf ist schlecht, die Regulation schlechter. Und das sieht man.²¹ Affekte werden größer, Steuerung kleiner. Zu schnell beleidigt, zu schnell rührselig,

20 George F. Koob, Ian M. Colrain, »Alcohol use disorder and sleep disturbances: a feed-forward allostatic framework«, in: *Neuropsychopharmacology*, Vol. 45, Issue 1, 24.06.2019, 141—65.

Lydia E. Devenney, Kieran B. Coyle, Thomas Roth, Joris C. Verster, »Sleep after Heavy Alcohol Consumption and Physical Activity Levels during Alcohol Hangover«, in: *Journal of Clinical Medicine*, Vol. 8, Issue 5, 27.05.2019, 752.

Henrique Nunes Pereira Oliva, Tiago Paiva Prudentea, Alisson M. Paredes Naveda, et al., »Sleep alterations in substance use disorders: a systematic review and meta-analysis«, in: *eClinicalMedicine*, Vol. 91, Januar 2026, Artikel 103723.

21 Rebecca Rothman, Amie C. Hayley, Blair Aitken, Luke A. Downey, »A Systematic Review of the Impact of the Alcohol Hangover Upon Negative Affect«, in: *Drug and Alcohol Review*, Vol. 45, Issue 1, 23.10.2025, e70052.

Agnese Merlo, Marlou Mackus, Aurora J. A. E. van de Loo, et al., »An evening of alcohol consumption negatively impacts next-day immune fitness in both hangover-sensitive drinkers and hangover-resistant drinkers«, in: *Addictive Behaviors*, Vol. 145, Oktober 2023, 107776.

zu viel von allem und zu wenig Form. Ein Mensch, der ständig leicht aus der Kontur kippt. Eine Persönlichkeit, die ausläuft.

Das ist anstrengend. Und anstrengend ist das Gegenteil von anziehend.

Die zweite Kraft ist die Infantilisierung. Regelmäßiges Trinken macht geistig zurückgestellt. Bei jedem Windhauch überfordert. Nichts Unbeugsames, nichts Erwachsenes, nichts Reifes. Stattdessen Opfer von Beruf und bedürftiges Kind, das nichts alleine auf die Kette bekommt.

Der Mechanismus ist nicht moralisch. Erwachsensein bedeutet Spannung halten können. Warten, Unlust aushalten, Komplexität tragen. Regelmäßiger Alkohol trainiert das Gegenteil. Unlust wird sofort weggeschaltet. Das Gehirn lernt die Logik eines Zweijährigen. Jetzt. Sofort. Mach weg. Die Frustrationstoleranz bricht weg, systembedingt. Wenn der Schlaf fragmentiert ist und das Nervensystem auf Alarmstufe läuft, fühlt sich jeder Alltag an wie Überforderung. Dann kommt das kindische Muster von selbst. Jammern, Ausweichen, Schuld verschieben, klammern, passiv werden.

Der infantilisierte Trinker merkt nicht, dass er infantil ist. Er merkt nur, dass die Welt jeden Tag schwieriger wird. Dass alle anderen irgendwie mehr aushalten. Dass er für Dinge kämpfen muss, die andere nebenbei erledigen. Er hält sich für sensibel. Er ist das Gegenteil. Alkohol infantilisiert wie eine Entscheidung, die jeden Tag neu getroffen wird, aber aussieht wie Schicksal.

Alkohol amputiert das Organ für jede Belohnung, die nicht Alkohol ist. Arbeit verliert an Wert, Sport, Gespräche, Projekte. Übrig bleibt das, was zuverlässig knallt.²² Ein Mensch, reduziert

22 Marianne Destoop, Manuel Morrens, Violette Coppens, Geert Dom, »Addiction, Anhedonia, and Comorbid Mood Disorder. A Narrative Review«, in: *Frontiers of Psychiatry*, Vol. 10, 22.05.2019, Artikel 311.

auf die Verwaltung seines nächsten Zustands. Das Bier kommt, der Mensch geht.

Wer jahrelang trinkt, wird zum Parasiten mit Manieren. Höflich genug, um eingeladen zu werden. Zu kaputt, um irgendetwas beizutragen. Alkohol macht aus Menschen etwas, das biologisch lebt und sozial schimmelt.

Und das Umfeld passt sich an. Weniger Reibung, weniger Konflikte, weniger Anforderungen. *Lass ihn, heute nicht, sonst kippt es.* Die ehrlichste Beschreibung eines funktionierenden Alkoholikers: *Ein Mensch, dessen Anwesenheit man toleriert, weil man sich an den Ekel gewöhnt hat.* So werden alle zu Eltern eines Erwachsenen, der aufgehört hat, einer zu sein. Alkohol infantilisiert nicht einen Menschen. Er verwandelt jede Beziehung, in der dieser Mensch steht, in ein Betreuungsverhältnis. Menschen, die ganz anders waren, liebenswürdig, die die Welt gebraucht hätte, verwandeln sich in eine Betreuungsaufgabe, die niemand übernehmen wollte.

Die härteste Strafe für regelmäßiges Trinken ist der Moment, in dem andere anfangen, einem aus dem Weg zu gehen, und man nicht versteht, warum.

Dann trinkt man weiter, um nicht sehen zu müssen, was das Trinken aus einem gemacht hat.

Ich hatte einen Nachbarn, der täglich im Innenhof saß und rauchte. Als ich auch noch rauchte, saß ich manchmal dabei. Er erzählte, er besäße ein Boot, hätte früher einen Rolls-Royce gefahren, als Bühnenbildner an der Oper in Potsdam gearbeitet und überlege jetzt, die Luxuswohnung zu kaufen, die sie uns aufs Dach gesetzt hatten. Fotos hatte er keine. Freunde auch nicht. Er torkelte nur ständig. Und manchmal fiel er um. Wohnte im

Jianguang Zeng, Lantao You, Fan Yang, et al., »A meta-analysis of the neural substrates of monetary reward anticipation and outcome in alcohol use disorder«, in: *Human Brain Mapping*, Vol. 44, Issue 7, Mai 2023, 2841–61.

Seitenflügel in einer Ein-Zimmer-Wohnung und bekam natürlich Bürger-Hartz.

Alkohol macht aus erwachsenen Menschen bedürftige Kinder mit Leistungsbescheid.

Solche Lebenslügen gibt es überall.

Irgendwann ist der Mensch weg und der Bedarf übrig. Die Freunde werden zu Krankenpflegern, die nicht wissen, dass sie welche sind. Die Familie wird zum Hospiz für jemanden, der noch lebt. Der Vater dieses Nachbarn war häufiger zu Besuch. Er sah aus, als würde er selber saufen. Und als hätte er einfach keine Lust mehr.

Wer zu lange im Delirium lebt, erfindet sich eine Gegengeschichte. Um die Wahrheit nicht sehen zu müssen. Dass man sein Leben verpfuscht hat. Dass man alt ist. Und dass es zu spät ist.

4 DER BLINDE SPIEGEL

Schriftsteller lauschen einem Akkord, der sich nicht benennen lässt. Sie tasten sich Satz für Satz vor, prüfen am eigenen Leib, ob das Wort trägt.

Trifft das? Braucht es ein anderes Wort?

Sie wissen nicht, was sie suchen, bis sie es gefunden haben. Dieses körperliche Wissen, das vor der Sprache da ist und sie erst möglich macht²³ — Alkohol löscht es aus. Die Sätze funktionieren noch. Aber sie leben nicht mehr.

Ein halber Millimeter daneben ist in der Literatur gleichbedeutend mit Nichtexistenz.

Ich wusste das. Und trank trotzdem. Es gibt ein Paradox, das ich lange nicht verstanden habe. Warum gab es da wider Wissen

23 Der Psychologe Eugene T. Gendlin nannte dies *Felt Sense*: vorbegriffliches Körperwissen, das man spürt, bevor man es denken oder sagen kann.

Eugene T. Gendlin, *Focusing*, New York 1978.

ein Gefühl, das mir sagte, es ginge auch mit Alkohol? Warum war Alkohol schwerer loszuwerden als Nikotin?

Die Antwort steht seit Jahrzehnten in den Fachzeitschriften. Sie hat es nie herausgeschafft. Weil man danach nicht mehr trinken kann.

Subjektiv fühlt sich Alkohol an wie: *Jetzt bin ich endlich ich selbst, ruhiger, wahrer, authentischer*. Objektiv, von außen und später gesehen, ist es Enthemmung, Vereinfachung, Grobheit, Verlust von Timing, Peinlichkeit, Abwesenheit. Bei Alkohol ist die subjektive Sicherheit, bei sich zu sein, stärker als bei fast allen anderen Drogen.

Alkohol zerstört nicht mich zuerst, sondern das in mir, das merkt, wenn etwas nicht stimmt. Er fügt nichts hinzu. Er schaltet ab. Den Moment, in dem ich merke, dass mein Lachen zu laut ist. Den Impuls, der mich mitten im Satz stoppen lässt, weil der Ton nicht stimmt. Das Zögern vor dem nächsten Glas. Alkohol betäubt nicht das Ich, sondern den inneren Beobachter des Ichs.²⁴ Deshalb fühlt es sich nicht an wie *Ich bin weg*, sondern wie *Endlich ist das Rauschen weg*. Nur dass dieses Rauschen *ich* war.

Warum sich das wie nach Hause kommen anfühlt, wird selten ehrlich ausgesprochen. Was Alkohol herstellt, ist ein Rückfall in ein früheres Selbstniveau. Er macht mich einfach, und er macht mich unfrei. Weniger Differenzierung, weniger Ambivalenz, weniger innere Spannung, weniger Verantwortung. Alkohol senkt Aktivität im präfrontalen Kortex, reduziert

24 Moderate Alkoholdosen lähmen die Fehlerdetektion im anterioren cingulären Cortex. Die Leistung sinkt nicht zuerst. Zuerst verschwindet das Wissen darüber — die Fähigkeit, die eigene Verschlechterung zu bemerken.

K. Richard Ridderinkhof, Yolande de Vlugt, Aldo Bramlage, et al., »Alcohol Consumption Impairs Detection of Performance Errors in Mediofrontal Cortex«, in: *Science*, Vol. 298, Issue 5601, 07.11.2002, 2209—11.

Konfliktverarbeitung, glättet Widersprüche.²⁵ Das Ergebnis fühlt sich an wie: *So war ich, bevor alles kompliziert wurde*. Nichts Spirituelles oder Wahres ist daran. Es ist nur Regression.

Nikotin erzeugt eine klar spürbare Dysregulation — man merkt, ich brauche etwas, um wieder normal zu sein. Koffein ist Übersteuerung — man merkt, ich bin getrieben. Cannabis ist Bewusstseinsverschiebung — man merkt, das ist nicht mein Normalzustand. Alkohol dagegen erzeugt eine *Illusion von Normalität*.²⁶ Man merkt nicht, dass man sich entfernt hat. Alkohol ist so tückisch, weil er normal simuliert, während er normal zerstört.

Alkohol lässt den Beobachter weiter existieren, aber leiser. Und genau das fühlt sich an wie Ruhe. Alkohol erzeugt keine Nähe zu mir. Er erzeugt die Gewissheit, bei mir zu sein, indem er mir die Fähigkeit nimmt, das Gegenteil zu bemerken.²⁷

25 Sucht zerstört metakognitiven Fähigkeiten; die Fähigkeit zu merken, dass man beeinträchtigt ist. Die Krankheit löscht das Wissen um die Krankheit. Rita Z. Goldstein, Nora D. Volkow, »Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications«, in: *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 12, 20.10.2011, 652—69.

26 Die Dissoziation zwischen Selbstwahrnehmung und tatsächlichem Verhalten bei Substanzstörungen zeigt sich in fünf Bereichen: Self-Monitoring, Metakognition, Alexithymie, Veränderungsbereitschaft, Interozeption. Crista E. Maracic, Scott J. Moeller, »Neural and Behavioral Correlates of Impaired Insight and Self-awareness in Substance Use Disorder«, in: *Current Behavioral Neuroscience Reports*, Vol. 8, Issue 4, Dezember 2021, 113—23.

27 Je geringer die Aktivierung der rechten Insula, desto massiver die Selbstüberschätzung der Gedächtnisleistung. Die Insula löst sich vom dorsalen ACC (*Salience Network*) und bindet sich stärker ans ventromediale PFC (*Default Mode Network*). Selbstüberwachung wird durch Selbsterzählung ersetzt. Anne-Pascale Le Berre, Eva M. Müller-Oehring, Tilman Schulte, et al., »Deviant functional activation and connectivity of the right insula are associated with lack of awareness of episodic memory impairment in nonamnesic alcoholism«, in: *Cortex*, Vol. 95, Oktober 2017, 15—28.

Die Substanz allein reduziert Selbstbeobachtung, reduziert Konfliktsignale, reduziert Fehlergefühl.²⁸ Die Kultur liefert die Gehirnwäsche: Entspannung, Echtheit, Feierabend. Romanische Metaphern wie *Urquell*, *Kloster Gold*, *Tannenzapfle vom Hochschwarzwald*. Substanz plus Narrativ ergeben die perfekte Selbsttäuschung.

Das Gefühl, man selbst zu sein, ist kein Beweis dafür, man selbst zu sein. Alkohol trennt Gefühl und Realität und verkauft diese Trennung als Authentizität. Selbstgewissheit ist kein Wahrheitskriterium. Sich *richtig* anfühlen kann biologisch produziert sein.²⁹ Alkohol programmiert mein Gehirn so um, dass er sich anfühlt wie die einzige Wahrheit, die mein Körper noch kennt. Ich verschwinde. Und es fühlt sich an wie Ankommen.

Rauchen hielt mich ruhig, gab mir einen Takt, machte alles flacher. Als es wegfiel, stand ich ohne Schutz da. Alkohol übernahm. Er machte es still. Und wer es gewohnt ist, allem zuzuhören, verwechselt Stille mit Wahrheit.³⁰

28 Alkohol beschädigt die Insula. AUD-Patienten zeigen höhere subjektive Sicherheit bei geringerer objektiver Genauigkeit der Körperwahrnehmung. Je schlechter sie spüren, desto sicherer sind sie sich. Mehr Gewissheit, weniger Realität.

Dennis F. Lovelock, Ryan E. Tyler, Joyce Besheer, »Interoception and alcohol: Mechanisms, networks, and implications«, in: *Neuropharmacology*, Vol. 200, 01.12.2021, 108807.

29 Süchtige reagieren verstärkt auf Drogenreize, abgeschwächt auf alles andere. Hypersensibel für die Substanz, dumpf für den Rest, auch für sich selbst.

Anna Zilverstand, Anna S. Huang, Nelly Alia-Klein, et al., »Neuroimaging Impaired Response Inhibition and Salience Attribution in Human Drug Addiction: A Systematic Review«, in: *Neuron*, Vol. 98, Issue 5, 06.06.2018, 886—903.

30 Alkohol reduziert Selbstaufmerksamkeit. Wer sich stark selbst überwacht, empfindet diese Reduktion als besonders entlastend. Selbstbewusste Menschen sind anfälliger, weil die Betäubung ihnen mehr Arbeit abnimmt.

Die Hand, die mich immer hochzog: *meine eigene*. Als mein Gehirn zu Säure wurde, war da nichts mehr, das *Ich* sagte. Nur ein Gefäß, voll mit weißem Schmerz.

Ich sah das Fleisch, wie es lag, aber ich konnte es nicht mehr sein. Nur Zustand war. Und ein wortlos beobachtendes Etwas, das irgendwie immer dabei war. Der Blick war freundlich, unaufgeregt und liebevoll.

Ich konnte ihn auf meiner Haut spüren. Es blickte herab auf das Ende.

Beweg deinen Zeigefinger. Schau auf deinen Finger.

Ich sah ihn. Die Wand war Strom, als ich sie berührte. Diese Wand zwischen dem, was möglich, und dem, was unmöglich scheint.

Wie komme ich da durch? Wie komme ich in diesen Körper zurück?

Und es kribbelte wie Strom auf einer Grenze. Wie Aufbäumen gegen das physisch Unmögliche. Als fixierte man mich auf einem Krankenhausbett. Ich wehre mich. Aber es gibt keinen Ausweg. Der Beobachter trägt mich Stück für Stück, er löst die Fesseln, millimeterweise. Aber nur wenn ich ihn ansehe, so wie er mich ansieht. Nur solange die Verbindung nicht abreißt, die Ausrichtung gehalten wird. Sobald die Verbindung abbricht, ist die Wand wieder da. Und der Schmerz ist wieder weiß.

Ich kam durch. Langsam. Und es war still. Aber etwas war bei mir, obwohl ich nicht mehr war. Als würde Licht durch Wasser brechen. Oder Wasser durch Gestein.

Jay G. Hull, Robert W. Levenson, Richard David Young, Kenneth J. Sher, »Self-Awareness-Reducing Effects of Alcohol Consumption«, in: *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 44, No. 3, 1983, 461—73.

Claude M. Steele, Robert A. Josephs, »Alcohol Myopia: Its Prized and Dangerous Effects«, in: *American Psychologist*, Vol. 45, No. 8, August 1990, 921—33.

Ohne diesen Blick hätte ich den Stift nicht greifen können. Ich hätte nicht zurück in meinen Körper gefunden. Ich hätte mich nicht mehr erinnern können, dass ich war und dass die Welt war.

Ich war weg, und ich habe mich zurückgeholt, weil ich nie nur ich bin, sondern immer auch das, was mich ansieht. Es ist die Quelle, aus der die Kraft fließt, mehr zu sein als ich bin. Ich bin die Arche, der Kapitän und die Taube mit dem Ölzweig.

Du musst dich aufrichten.

Versuche, dich auf die Bettkante zu setzen.

Über Maria Callas erzählte Marina Abramović, wie sich Callas auf der Bühne verwandelte. Wenn Callas sang, war sie eine unsagbar starke Frau. Und sobald sie zu singen aufhörte, sobald die Darbietung zu Ende war, fiel sie in sich zusammen wie ein kleiner kranker Vogel.³¹ Als wäre Callas zum Zeitpunkt der Ausführung selbst gar nicht anwesend. Oder genauer: *als wäre sie es dort zum ersten Mal gewesen*. Als würde etwas durch Callas hindurchtönen, als sie sang.

»Noch niemand hat gewagt dies auszusprechen: Doch weiß ich, wie die Seelen aller Großen zuweilen durch uns ziehen, und wir in ihnen aufgehen und nicht sind. Nichts sind als ihrer Seelen Widerschein. ... Es ist, als glühte tief in uns ein Ich als eine klare Sphäre, als gegossenes Gold, das irgendeine Form anfliegt. ... Und wie der leere Raum nicht ist, wenn eine Form ihn in sich fasst, so hörn wir alle auf zu sein, für eine Weile, und sie, die Seelenfürsten, leben dann.«³²

31 Marina Abramović, *Walk Through Walls: A Memoir*, New York 2016. Abramović beschreibt Callas' Verwandlung auf der Bühne wiederholt, u.a. im Kontext ihrer Operninszenierung: 7 *Deaths of Maria Callas*, UA Bayerische Staatsoper, München 2020.

32 Ezra Pound, *Lesebuch. Dichtung und Prosa*, hrsg. v. Eva Hesse, Frankfurt am Main 1997, 15 (»Histrion«).

Die Gabe, mich selbst zu beobachten, macht mich durchlässig. Es ist alles, das ich habe, um mich und die Welt, in der ich bin, zu erneuern. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Empfindungen sind Boten der Vergangenheit. Sie tragen weiter, was war. Trauma, Hass, Unterdrückung, Schmerz. Alles, was mir angetan wurde, lebt in meinen Reaktionen fort. Wer sich nur innerhalb seiner Gefühle bewegt, sie verwaltet, sie für Wahrheit hält, bewegt sich in einem Gefängnis, das aussieht wie Freiheit.

Die Möglichkeit, Neues und Schönes in die Welt zu bringen, verdanke ich meinem Beobachter. Er ist das Einzige an mir, das nicht aus der Vergangenheit stammt. Das Hindurchtönende, das sieht, was ist, ohne es zu wiederholen. Dort beginnt, was ich noch nicht bin. Verwandlungsfähigkeit. Durch Ausrichtung auf etwas, das größer ist als mein Zustand.

Alkohol tötet genau das. Vor dem Körper. Vor den Organen. Er tötet die einzige Instanz, die mich je über meine eigene Geschichte hinausgehoben hat. Was übrig bleibt, ist auf Reize reagierendes *Ungeziefer*. Ein Sklave gieriger, hässlicher Hunde. Ein Wesen, das frisst, flieht und seinen Affekt für Persönlichkeit hält. Ein Biocomputer, der Trauma in Endlosschleife abspielt und es Gefühlstiefe nennt. Süchtige, die Gold gegen Blei tauschen und den Verlust mit Vitalität verwechseln.

Das ist der messbare Zustand eines Menschen, der sich den Beobachter herausgeschnitten hat. Dieselbe Reaktivität, die eine ganze Kultur für Sensibilität hält, belegt, dass niemand mehr hinsieht. Ein narzisstisch verirrter Schwarm vermeintlicher Individuen im Affektrausch, die ihre Reizbarkeit für Tiefe halten. Und ihre Betäubung für den Ausweg. Alkohol ist die Gebrauchsanweisung für diesen Zustand. Wer trinkt, übt, nie wieder etwas mit sich anfangen zu können.

Jede Gabe ist zugleich ein Auftrag. Wenn ich meine Talente verkümmern lasse, stelle ich mich gegen das, was mich zu einem Menschen macht, den andere brauchen. Das ist keine Ego-Sache.

Das Talent gehört nicht mir. Es fließt durch mich hindurch, und meine einzige Aufgabe ist, den Kanal offen zu halten. Wer ihn verstopft, mit Alkohol, mit Betäubung, mit der Verwaltung seines eigenen Zustands, verwandelt den Seismografen in ein taubes Gerät, das noch ausschlägt, aber nichts mehr registriert. Callas' Autoimmunerkrankung³³ zerstörte ihr Instrument von außen. Alkohol zerstört es von innen. Das Ergebnis ist dasselbe. Wenn Begabung Verpflichtung ist, ist Alkohol Desertion. Ich habe nicht nur mich selbst betrogen, sondern das, was durch mich hindurchtönt.

Weltklasse-Pianisten sehen sich selbst spielen. Als wäre da jemand, der zuschaut und gleichzeitig die Tasten trifft.³⁴ Wenn Menschen sich an besondere Momente erinnern, sehen sie sich von außen. Als würde das, was uns eigentlich ausmacht, über die Grenzen der Epidermis hinausreichen. Als hätte ein Beobachter die Szene archiviert.³⁵

Ich brauche das, wenn ich mehr sein will als ein Reiz-Reaktions-System. Wenn ich nicht essen will, auch wenn ich Hunger habe. Wenn ich nicht saufen will, auch wenn meine Gedanken es anweisen. Wenn ich glänzen will, wenn ich schön sein will, wenn ich leben will.

33 *Dermatomyositis*.

34 Bewusstsein ist bei der Ausübung von Geschicklichkeiten »oft sogar eine Behinderung«.

Julian Jaynes, *The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind*, Boston 1976.

35 Ein Drittel aller autobiografischen Erinnerungen wird spontan aus der Beobachterperspektive abgerufen.

Georgia Nigro, Ulric Neisser, »Point of view in personal memories«, in: *Cognitive Psychology*, Vol. 15, Issue 4, Oktober 1983, 467—82.

Angelina R. Sutin, Richard W. Robins, »When the >I< Looks at the >Me<«, in: *Consciousness and Cognition*, Vol. 17, Issue 4, 10.10.2008, 1386—97.

Was bleibt, wenn ich den Beobachter abziehe. Ein Alptraum. Ein sich selbst abspulender Film, den niemand sehen will. Und wofür niemand leben will.

Es ist nicht der Beobachter, der Klavier spielt, singt, schreibt. Er steuert nicht direkt. Er richtet mich aus, lässt mich nach etwas streben. Julian Jaynes nannte das *Struktion* — die Fähigkeit, sich ein Ziel zu geben, das in der physischen Welt noch gar nicht existiert, und sich darauf zuzubewegen.³⁶

Wahrheitserkenntnis geschieht im Vollzug. Der Beobachter vermag sie nur zu empfangen. Aber ohne Empfänger existiert sie nicht. Ein Mensch ohne Ausrichtung ist ein nutzlos schmarotzender Apparat. Ein Fäulnisprozess, der geistig wie körperlich seine Umgebung vergiftet. Er stirbt als Passagier, nicht als Kapitän. Er hat einen Kurs, aber es ist nicht der seinige. Und nicht der, den seine Mitwelt braucht. Er vertritt nichts, er stellt nichts dar. Er ist ein Parasit, nichts weiter. Wenn ich glaube, ich sei meine Gedanken und meine Gefühle, und nicht das, was auf ihnen segelt, bewege ich mich geradeaus auf den Abgrund zu. Mein Sturz ist nur eine Frage der Zeit. Aber noch wichtiger: *er ist bedeutungslos.*

Weil niemand mich vermissen wird.

Der Beobachter braucht das Gehirn, aber er wohnt dort so wenig wie ein Lied in der Kehle wohnt.³⁷ Als mein Gehirn vom Netz war, war er noch da. Epilepsie konnte ihn nicht auslöschen.

36 *Struktion* ist Jaynes' Wortschöpfung, die Instruktion und Konstruktion verschränkt: die Fähigkeit, fiktive Zielzustände zu entwerfen und das Verhalten darauf auszurichten. Jaynes 1976.

37 Die Annahme, Bewusstsein sei im Gehirn lokalisiert, ist historisch kontingent und evidenzfrei.

Thomas Fuchs, *Das Gehirn — ein Beziehungsorgan. Eine phänomenologisch-ökologische Konzeption*, Stuttgart 2008.

Alkohol schon.

Wie Zimmer in einem Haus, die eines nach dem anderen dunkel werden.

Man kann einem Menschen die Bewegung nehmen, die Sprache, das Gedächtnis, die Würde. So wie man mir die Würde genommen hat, als man mich misshandelte, verprügelte, mir eine Pistole mit Kugel in der Kammer an den Kopf hielt. Als man mich im Krankenhaus krepieren ließ. Als man mich und meine Arbeit verleumdete.

Solange mein Beobachter da war, baute ich mich zurück. Verschwindet der Beobachter, verschwindet die innere Quelle — die alle Menschen teilen. Dann gibt es kein Zurück. Und niemanden, der es wollen könnte.

Hull und seine Kollegen haben gemessen, was davon übrig bleibt. Probanden bekamen Wodka oder Placebo und sollten über sich selbst sprechen. Die Forscher zählten Ich-Pronomen. Die Alkoholgruppe sprach messbar seltener von sich, obwohl das die Aufgabe war. Die Placebogruppe sprach weiter von sich.³⁸

Wörter, die mich betreffen, brenne ich tiefer ein. Der Stempel *betrifft mich* funktioniert wie ein Verstärker. Unter Alkohol fiel er aus. Selbst bei hochintrospektiven Probanden sank die Gedächtnisleistung für selbstbezogene Inhalte auf das Niveau von Menschen, die sich ohnehin selten beobachten. Alkohol löscht nicht die Erinnerung. Er löscht die Markierung, dass sie mich betrifft. Ich erlebe weiter. Aber nichts davon wird als meins gespeichert.

Jaynes dazu: »Das Bewußtsein hat keinen konkreten Sitz außer einem eingebildeten.« (Jaynes 1976, 63.)

38 Drei Experimente mit Balanced-Placebo-Design. Der Befund war pharmakologisch, nicht erwartungsbasiert. Im dritten Experiment sabotierte Alkohol gezielt die selbstreferenzielle Gedächtniskodierung, nicht das Gedächtnis insgesamt.

Hull et al. 1983.

Le Berre machte den chronischen Schaden sichtbar. Trockene Alkoholiker überschätzten systematisch ihr eigenes Gedächtnis (»Das merke ich mir«) und scheiterten. Immer wieder. Im Hirnscanner war die Diskrepanz sichtbar. Die rechte Insula (zuständig für den Abgleich zwischen Selbstbild und Realität) war unteraktiv. Der Spiegel funktionierte noch. Aber das Glas war von innen beschlagen. Wie ein Auge, das noch offen steht, aber nicht mehr sieht. Oder wie ein Toter, der nicht weiß, dass er tot ist, weil ihm niemand den Puls fühlt. Neue Informationen über sich selbst kamen nicht mehr an. Was Alkohol akut dämpft, friert er chronisch ein. Der Beobachter bleibt einfach stehen. In einer Version von mir, die es längst nicht mehr gibt.³⁹

Steele und Josephs nannten das *Alkoholmyopie*. Kognitive Kurzsichtigkeit. Was direkt vor der Nase steht, existiert, was Kontext, Abwägung, Hemmung erfordert, verschwindet. Die zugehörige Metaanalyse über Dutzende Studien ergab eine volle Standardabweichung in Konfliktsituationen. Das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der die Faust ballt und sie wieder öffnet, und einem, der zuschlägt. Derselbe Mensch. Dieselbe Situation. Nur Alkohol dazwischen. Ohne Konflikt war der Unterschied zwischen betrunken und nüchtern fast null.

39 Anne-Pascale Le Berre, Eva M. Müller-Oehring, Dongjin Kwon, et al., »Differential Compromise of Prospective and Retrospective Metamemory Monitoring and Their Dissociable Structural Brain Correlates«, in: *Cortex*, Vol. 81, Issue, 15.05.2016, 32—46.

Anne-Pascale Le Berre, Edith V. Sullivan, »Anosognosia for Memory Impairment in Addiction: Insights from Neuroimaging and Neuropsychological Assessment of Metamemory«, in: *Neuropsychology Review*, Vol. 26, Issue 4, Dezember 2016, 420—31.

Alkohol macht nicht aggressiv. Er macht blind. Für alles, was bremsen könnte.⁴⁰

Fechner suchte 1860 nach der Schwelle, ab der ein Körpersignal zum Gefühl wird. Er vermutete eine Instanz zwischen Materie und Bewusstsein, die das eine ins andere verwandelt.⁴¹ Die Psychologie hat ihn hundert Jahre lang ignoriert. Die Interzeptionsforschung gibt ihm heute recht. Was er suchte, war die Schnittstelle, die Alkohol zerstört. Alkohol lässt den Körper weiter registrieren, aber kappt die Leitung nach oben. Wer trinkt, spürt noch. Er versteht nur nicht mehr, was er spürt.

Innen ein Beobachter, der aufgehört hat zu archivieren. Ein Selbstbild, das sich nicht mehr korrigiert. Außen ein Mensch, der nur noch sieht, was direkt vor ihm steht. Der halbe Millimeter daneben. Und wer lange genug trinkt, verliert nicht die Fähigkeit zu funktionieren. Er verliert die Instanz, die ihn je über sich selbst hinausgehoben hat. Das Einzige, was ihn aus dem Schwarz zurückgeholt hätte.

Wochenlang war das so. Ich nehme mir vor, weniger zu trinken. Am Ende trinke ich doch. Ich nehme mir vor, weniger zu essen. Am Ende esse ich doch. Ich starte neu. Ich breche ab. Ich wiederhole das.

Ich rede mir Sätze ein. Es ändert nichts.

Das Haus brennt immer noch.

Ethik ist präfrontaler Luxus. Der Hirnstamm kennt nur Angebot und Nachfrage. Der Körper will Regulation. Woher, ist ihm egal. Man kann sich nicht aus einem brennenden Haus

40 Steele-Josephs 1990.

Steele, Lilian Southwick, »Alcohol and Social Behavior: I. The Psychology of Drunken Excess«, in: *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 48, Issue 1, Januar 1985, 18–34.

41 Gustav Theodor Fechner, *Elemente der Psychophysik*, Leipzig 1860.

herausdenken. Willenskraft gegen Entzug ist wie Höflichkeit gegen Stromschlag. Ich trinke, weil sich Nüchternheit anfühlt wie eine offene Wunde. Alkohol brennt sie zu.

Kurz. Dann reißt sie wieder auf.

Ich lasse Alkohol weg. Dann drücke ich Essen hoch. Ich lasse Essen weg. Dann drücke ich etwas anderes hoch. Drehe ich hier den Hahn zu, schießt es woanders nach oben.

The rebound effect is undefeated.

Ich suche immer den nächsten Schalter.

Ich lerne nicht, ohne Schalter zu sein.

Ich tausche Gefängnisse. Meine Befreiung ist die Wiederholung der Gefangenschaft. Jeder Notausgang führt in dieselbe Zelle zurück.

Es sind Drehtüren.

Ich baue neue Notausgänge.

Es sind Spiegel.

Schreiben war keiner. Alkohol nahm mir das Werkzeug. Alkohol verspricht eine Abkürzung zu sich selbst. Er liefert eine Attrappe. Bunt, laut, von außen beleuchtet. Die Wirklichkeit ist weniger inszeniert.

5 SPRECHEN MIT FREMDER STIMME

Ich dachte, ich trinke, um mich zu trösten. In Wahrheit vergiftete ich bloß mein Gehirn. Alkohol ist Gewalt. Jede Flasche ist ein Schlag gegen das Gehirn. Eine Flasche Bier zu trinken ist daselbe, wie sich die Arme aufzuschneiden.

Diese Gewalt hatten sie mir angetan. Immer wieder. November 2024 nach einer Verwechslung im Supermarkt. Auf dem Revier ausgezogen, angefasst, fotografiert, geschlagen. Mein Arm hing auf halb acht. Die Sanitäter füllten erst ein Formular aus. Im Krankenhaus ließ man mich liegen. Eine Stunde. Mir wurde schwindlig. Ich hörte auf, meinen Arm zu spüren. In

seinen letzten Momenten rutschte er von selbst zurück. Dann durfte ich gehen.

Das Trauma nicht.

Noch Monate später reichten Schritte im Treppenhaus. Ich kratzte mir die Hände blutig, lange bevor ich bemerkte, dass das Selbstverletzung war. Ich dachte, ich trinke Alkohol, um die Gewalt zu betäuben. In Wahrheit wiederholte ich sie nur. Die Gewalt, die mir andere angetan haben, tat ich mir nun selber an. Sucht ist Traumafolge. Wenn ich trinke, nehme ich die Täter in mich auf. Ich spreche mit ihrer Stimme.

Ich vollende ihr Werk.

Introjektion nennt die Psychologie das. Ich lähme mich, weil ich gelernt habe, dass Lähmung sicherer ist als Fühlen. Wer lange genug fixiert, verletzt, gedemütigt wird, lernt, *dass Schmerz sowieso kommt*. Also wähle ich wenigstens Zeitpunkt und Dosis selbst.

Aber das funktioniert nur, solange es unbewusst bleibt. Introjektion endet, wo sie sichtbar wird. Sobald ich erkenne, dass ich mich nicht verletze, weil ich mich hasse, sondern weil ich Gewalt gelernt habe, fällt die Maske. Benennen bricht die Schleife.

Beobachtung verascht jeden Dämon.

Van der Kolk erklärt, warum Benennen funktioniert und warum es trotzdem so schwer ist.⁴² Trauma wird nicht als Geschichte gespeichert. Es wird im Körper gespeichert. Das deklarative Gedächtnis arbeitet wie ein Archivar: saubere Akten, Zeitstempel, Kontext, Anfang und Ende. Das implizite Gedächtnis ist der Körper selbst, der sich erinnert. Panik, Herzschlag, Muskelspannung. Bei einem Trauma legen extreme Stresshormone den

42 Bessel A. van der Kolk, »The Body Keeps the Score: Memory and the Evolving Psychobiology of Posttraumatic Stress«, in: *Harvard Review of Psychiatry*, Vol. 1, Issue 5, 1994, 253–65.

Archivar lahm. Was bleibt, sind Fragmente. Bilder, Geräusche, Körpergefühle, ohne Zeitstempel, ohne Kontext, ohne jemanden, der sagt: *Das war damals*. Es ist vorbei. Wird eines dieser Fragmente durch einen Geruch, ein Geräusch, eine Berührung ausgelöst, erlebt der Körper das Trauma als Gegenwart.

Neuroanatomisch ist die Amygdala der Gefahrenmelder. Bei Trauma ist sie hyperaktiv und brennt die emotionale Bedeutung tief ein. Der Hippocampus, zuständig für Kontext und Zeit, wird durch Stresshormone gehemmt. Ein schreiender Gefahrenmelder ohne Archivar. Deshalb verblassen traumatische Erinnerungen nicht. Van der Kolk nennt sie: für immer. Die widersprüchliche Reaktion erklärt sich daraus: Zuviel an Erinnerung — Flashbacks, Alpträume, Schreckreaktion. Zuwenig — Gedächtnislücken, Taubheit, Abtrennung von sich selbst. Beides gleichzeitig, im selben Menschen. Der Archivar ist ausgefallen. Der Körper pendelt zwischen Überflutung und Abschaltung.

Tertium non datur.

Das ist der Normalfall. Der Körper erinnert Gewalt, indem er sie wiederholt (*Reenactment*).⁴³ Trauma hat keine Zeit, es hat nur Gegenwart.⁴⁴ Nervensysteme reproduzieren, was sie kennen, weil Wiederholung sich wie Kontrolle anfühlt.

Sucht ist eine systematische Reaktion auf Überforderung, Gewalt und chronische Entwertung. Sie ist der Versuch, Kindheit chemisch zu behandeln. Missbrauch, Vernachlässigung, chronische Angst — der Körper sucht sich sein Medikament.

43 Der Körper speichert Gewalt nicht als Erinnerung, sondern als Handlung, als Handlungsimpuls, als somatosensorische Fragmente.

44 Van der Kolk 1994.

Die ACE-Studie von Felitti untersuchte über 17.000 Menschen⁴⁵. Ein Querschnitt der Bevölkerung. Ganz normale Versicherte. Sie erfasste, was ihnen als Kindern angetan wurde: Missbrauch, Vernachlässigung, Gewalt im Haushalt, Sucht in der Familie. Über die Hälfte hatte mindestens eine solche Erfahrung. Fast ein Viertel zwei oder mehr.

Der Befund ist eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Je mehr belastende Erfahrungen, desto höher das Risiko. Drastisch höher. Ab vier Erfahrungen ist das Risiko für Alkoholismus 7,4-fach höher. Für injizierbare Drogen 10,3-fach höher. Für Suizide 12-fach höher. Für Krebs und Herzerkrankungen zwei- bis vierfach. Ein Herzinfarkt mit fünfzig hat seine Wurzeln nicht unbedingt im Lebensstil der letzten zehn Jahre. Manchmal liegt er in einem Schmerz, der vierzig Jahre alt ist.

Die Pyramide dahinter: Belastende Kindheit formt das Gehirn. Überempfindlichkeit, gestörte Impulskontrolle. Daraus soziale und kognitive Störungen. Daraus Drogen, Alkohol, Rauchen, Fressen als Bewältigung. An der Spitze: Krankheit und früher Tod.

Drogenkonsum ist Selbstmedikation. Der verzweifelte Versuch, unerträgliche innere Zustände erträglich zu machen. Alkohol dämpft kurzfristig die Anspannung. Dass er langfristig alles verschlimmert, ist dem Körper egal. Kurzfristig ist alles, was ein Körper in Panik denken kann.

45 Vincent J. Felitti, Robert F. Anda, Dale Nordenberg, et al., »Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults«, in: *American Journal of Preventive Medicine*, Vol. 14, Issue 4, Mai 1998, 245—58.

Die Korrelation ist fast linear: Je mehr Gewalt in der Kindheit, desto höher die Wahrscheinlichkeit für Rauchen und Alkoholismus.⁴⁶

6 DER SATTESTE HUNGER DER WELT

Alkohol wirkt auf die Darmschleimhaut wie Schleifpapier. Er eröffnet im Darm zwei Fronten.

Die erste ist *Aushungern*.

Die Schleimhaut sieht normal aus. Ihre Funktion erlischt.⁴⁷ Der Kühlschrank ist voll. Die Küche ist abgeschlossen. Ethanol und das, was der Körper daraus macht (Acetaldehyd), zerfressen das Gewebe.⁴⁸ Die Darmzotten werden kürzer, flacher, brechen ab. Was übrig bleibt, kann weder verdauen noch aufnehmen. Thiamin, Folat, Zink, Magnesium — alles, was das Nervensystem zum Funktionieren braucht.⁴⁹

Alles, was ich brauchte, um mein Gehirn nach dem Rauchen und der Epilepsie zurückzubauen — ich trank es mir weg. Ich hatte mich zurückgeholt, und dann habe ich dem Körper

46 Felitti et al. 1998.

47 Charles H. Halsted, Enrique A. Robles, Esteban Mezey, »Intestinal Malabsorption In Folate-Deficient Alcoholics«, in: *Gastroenterology*, Vol. 64, Issue 4, April 1973, 526—32.

48 Immunzellen schütten vermehrt Zytokine aus, freie Radikale entstehen. Yeon Seok Seo, Vijay H. Shah, »The role of gut-liver axis in the pathogenesis of liver cirrhosis and portal hypertension«, in: *Clinical and Molecular Hepatology*, Vol. 18, Issue 4, 21.12.2012, 337—46.

49 Sandeep B. Subramanya, Veedamali S. Subramanian, Hamid M. Said, »Chronic alcohol consumption and intestinal thiamin absorption: effects on physiological and molecular parameters of the uptake process«, in: *American Journal of Physiology—Gastrointestinal and Liver Physiology*, Vol. 299, Issue 1, 06.05.2010, G23—G31.

Halsted et al. 1973.

die Bausteine dafür entzogen. Die Darmschleimhaut erneuert sich normalerweise alle drei bis fünf Tage. Mit Alkohol reift sie nicht aus.⁵⁰

Damit Thiamin ins Blut gelangt, muss es durch die Darmwand. Alkohol verriegelt die Tür.⁵¹ Selbst wenn genug Thiamin ankommt, steht es draußen. Die Darmbakterien im Dickdarm produzieren ebenfalls Thiamin. Es steht vor derselben verschlossenen Tür. Als hätte sich Wachs auf die Darmhaut gelegt.

Die zweite Front ist *Vergiften*.

Die Zellen der Darmwand sind durch Schlussleisten verbunden⁵², die nichts unkontrolliert durchlassen. Alkohol zerstört sie.⁵³ Das Mikrobiom kippt.⁵⁴ Schädliche Bakterien

50 Cheng-Hao Kuo, Li-Ling Wu, Hsiao-Ping Chen, et al., »Direct effects of alcohol on gut-epithelial barrier: Unraveling the disruption of physical and chemical barrier of the gut-epithelial barrier that compromises the host-microbiota interface upon alcohol exposure«, in: *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, Vol. 39, Issue 7, 21.03.2024, 1247—55.

Avtar S. Meena, Pradeep K. Shukla, Briar Bell, et al., »TRPV6 channel mediates alcohol-induced gut barrier dysfunction and systemic response«, in: *Cell Reports*, Vol. 39, Issue 11, 14.07.2022, 110937.

51 *Transkriptionelle Hemmung.*

Der Transport von Thiamin durch die Darmwand erfolgt über spezialisierte Transporterproteine (THTR-1, THTR-2), deren Expression durch Ethanol messbar gehemmt wird. Subramanya et al. 2010.

52 *Tight Junctions.*

53 Elhaseen Elamin, Daisy Jonkers, Kati Juuti-Uusitalo, et al., »Effects of Ethanol and Acetaldehyde on Tight Junction Integrity: In Vitro Study in a Three Dimensional Intestinal Epithelial Cell Culture Model«, in: *PLOS ONE*, Vol. 7, Issue 4, 19.04.2012, e35008.

Meena et al. 2022.

54 Sophie Leclercq, Sébastien Matamoros, Patrice D. Cani, et al., »Intestinal permeability, gut-bacterial dysbiosis, and behavioral markers of alcohol-dependence severity«, in: *PNAS*, Vol. 111, No. 42, 06.10.2014, 4485—93.

übernehmen.⁵⁵ Die Schleimhaut wird durchlässig. Bakteriengifte sickern ins Blut.⁵⁶ Endotoxine, unverdaute Nahrung, Alkohol selbst — alles fließt über die Pfortader direkt in die Leber.⁵⁷ Offene Giftleitung vom Darm.⁵⁸

Das passierte in meinem Körper, während ich dachte, ich hätte nur ein Bierproblem. Nährstoffmangel von der einen Seite, eine Flut aus Bakteriengiften von der anderen. Die Leber chronisch entzündet.⁵⁹ Ein Feuer, das nie gelöscht wird, weil der Brennstoff direkt aus dem Darm nachfließt.⁶⁰

Gleichzeitig verfettet die Leber.⁶¹ Alkohol stoppt die Fettverbrennung und steigert die Fettproduktion.⁶² Fett strömt

55 *Dysbiose*. Kuo et al. 2024.

56 *Translokation*.

C. Bode, V. Kugler, J. C. Bode, »Endotoxemia in patients with alcoholic and non-alcoholic cirrhosis and in subjects with no evidence of chronic liver disease following acute alcohol excess«, in: *Journal of Hepatology*, Vol. 4, Issue 1, Februar 1987, 8—14.

57 Vor allem Lipopolysaccharide.

Gyongyi Szabo, »Gut–Liver Axis in Alcoholic Liver Disease«, in: *Gastroenterology*, Vol. 148, Issue 1, Januar 2015, 30—6.

58 Szabo 2015.

59 Wenn Kupffer-Zellen die eingesickerten Lipopolysaccharide registrieren, schütten sie TNF- α aus, Tumornekrosefaktor Alpha, einen der aggressivsten Entzündungsbotenstoffe im Körper. Szabo 2015.

60 Vishnudutt Purohit, J. Christian Bode, Christiane Bode, »Alcohol, Intestinal Bacterial Growth, Intestinal Permeability to Endotoxin, and Medical Consequences«, in: *Alcohol*, Vol. 42, Issue 5, August 2008, 349—61.

61 Die Fettleber ist der Passierschein in Fibrose, Zirrhose, Leberversagen.

62 Der Alkoholstoffwechsel flutet die Zelle mit NADH und bringt die Fettverbrennung zum Stillstand. Die Verbrennungsöfen sind verstopft. Alkohol aktiviert SREBP-1c, einen Transkriptionsfaktor für Fettproduktion, und schaltet die Gegenregulation ab, AMPK und SIRT1. Die Fettproduktion läuft Amok.

herein, wird neu produziert, verbrennt nicht, kommt nicht raus.⁶³ Die Zelle ertrinkt in ihrem eigenen Fett, während sie an Nährstoffmangel leidet. Zu voll und zu leer. Zur selben Zeit.

Tumornekrosefaktor Alpha heizt die Fettproduktion zusätzlich an.⁶⁴ Etwas in meinem Blut, das die kranken Stellen in Brand setzt und dabei das ganze Haus anzündet. Die Entzündung verstärkt die Verfettung. Die Verfettung verstärkt die Entzündung. Ein Kreislauf, der sich mit jedem Glas beschleunigt. Solange ich weitertrinke, kann mein Körper das Feuer nicht löschen.

Die organische Zersetzung hinterlässt ein Gewebe, an dem Heilung abperlt. Wenn die Darmzotten kaputt sind, kommt nichts mehr an. Egal was ich esse. Egal wie viel. Mikronährstoffe müssen lebenslang substituiert werden.

Aushungern und Vergiften über denselben Darm. Eine Leber, die unterversorgt, entzündet und verfettet ist. Die sich selbst zerlegt. Das passiert bei jedem, der trinkt. Vom ersten Glas an. Es ist egal, woraus ich es trinke.⁶⁵ Ein Liter Bier am Tag reicht. Schnaps ist bloß dasselbe Gift in weniger Flüssigkeit.

Manche denken, sie hätten *Leaky Gut*. Davor war es Burn-out, davor Melancholie, davor ein empfindliches Gemüt. Die Diagnose, die keine Verhaltensänderung erfordert, gewinnt immer. Deshalb heißt es Reizdarm und nicht drei Bier pro Abend. Für Reizdarm gibt es Podcasts, Heilpraktiker und

Min You, Gavin E. Arteel, »Effect of ethanol on lipid metabolism«, in: *Journal of Hepatology*, Vol. 70, Issue 2, Februar 2019, 237–48.

63 Weil die Leberzelle zusätzliche Fetttransporter einbaut und Fettsäuren aus dem Blut saugt. Dadurch bricht der Fettexport zusammen. Die Verpackung in Transportpartikel funktioniert nicht mehr. Seitz et al. 2023.

64 You-Arteel 2019.

65 Entscheidend ist die kumulative Ethanollast, nicht ob sie in Bier, Wein oder Schnaps steckt. Purohit et al. 2008.

Nahrungsergänzungsmittel. Für Alkohol gibt es nur eine Therapie, die niemand hören will:

Aufhören.

Hochsensibel, ADHS, Autismus-Spektrum, bipolar. Eine Diagnose ist der bequemste Ablassbrief der Welt. *Ich bin krank. Ich trage keine Verantwortung. Es geht nicht anders, es ging nie anders, und wer etwas anderes behauptet, versteht meine Krankheit nicht.*

Die Diagnose löst kein Problem. Sie löst *mich* vom Problem. Sie befreit mich vom unerträglichsten Gedanken, den ein Mensch denken kann. *Dass ich keine Kümmerexistenz führen müsste. Dass ich trotz allem, was geschehen ist, eine groteske Macht über mein Dasein habe. Und dass ich jeden Tag aufs Neue entscheide, sie nicht zu benutzen.*

Ich durfte zusehen, wie mein Gehirn schrumpft. Aber ich sah nicht, dass ich mir die Resorptionsfläche kaputtgesoffen habe. *Dass ich mir die Fähigkeit weggetrunken habe, je wieder gesund zu essen.*⁶⁶

Ich gehe daran zugrunde, dass mein Körper keine Nährstoffe mehr aufnimmt. Ich esse, ich supplementiere, aber nichts erreicht die Zellen. Meine Zellen ersticken. Sie schreien nach dem, was der Alkohol zerstört hat, und das Einzige, was sie kurz zum Schweigen bringt, ist mehr Alkohol. Trinke ich, wird es schlimmer. Trinke ich nicht, wird es unerträglich.

Jede Richtung macht es schlimmer.

Feuer und Feuer.

66 Butts et al. 2023.

Aufhören stoppt den Schaden. Aber ob sich die Zotten erholen, hängt davon ab, wie lange ich mir den Rasierklingschaum in den Bauch gedrückt habe.⁶⁷

Bei mir war es zu lange.

Die Supplemente wirkten nicht mehr. Fünffache Dosis, halber Effekt. Ich hörte auf und fühlte mich elend. Nicht Alkohol fehlte mir. Mir fehlte, was er zerstört hat.

Die Sucht ist heilbar. Der Schaden nicht.

7 ABTREIBUNG IN ZEITLUPE

Wenn Alkohol doch nur meine Zotten und mein Gehirn zerstören würde. Aber er zerstört noch etwas viel Wertvolleres. *Die Fähigkeit meines Körpers, sich selbst zu erneuern.*

Acetaldehyd entsteht bei jedem Schluck. Es zerschneidet die DNA.⁶⁸ Es verklebt die Doppelhelix. Stränge, die sich bei der Zellteilung trennen müssen, können das nicht mehr. Und es reißt sie auseinander. Beide gleichzeitig. Das ist die aggressivste Form von DNA-Schaden, die es gibt. Der Körper hat zwei Reparatursysteme dafür. Das erste erkennt die Verklebung und schneidet sie heraus. Das zweite repariert die Brüche.

Acetaldehyd vereitelt beide.⁶⁹

67 J. Persson, N. O. Berg, K. Sjölund, et al., »Morphologic Changes in the Small Intestine after Chronic Alcohol Consumption«, in: *Scandinavian Journal of Gastroenterology*, Vol. 25, Issue 2, 1990, 173—84.

68 Juan I. Garaycoechea, Gerry P. Crossan, Frederic Langevin, et al., »Alcohol and endogenous aldehydes damage chromosomes and mutate stem cells«, in: *Nature*, Vol. 553, Issue 7687, 03.01.2018, 171—7.

Dies., et al., »Genotoxic consequences of endogenous aldehydes on mouse haematopoietic stem cell function«, in: *Nature*, Vol. 489, Issue 7417, 26.08.2012, 571—5.

69 Michael R. Hodskinson, Alice Bolner, Koichi Sato, et al., »Alcohol-derived DNA crosslinks are repaired by two distinct mechanisms«, in: *Nature*,

Garaycoechea und Kollegen wiesen dies an Blutstammzellen im Knochenmark nach.⁷⁰ An den Zellen, aus denen alle Blutzellen entstehen. Alkohol zerstört die Blutzellen. Und die Druckplatte, von der sie gezogen werden. Jede neue Zelle schreibt den Fehler fort. Als ginge er in Serienproduktion. Die beschädigten Stammzellen teilen sich weiter — als kämen auf jedes Bier tausend weitere Biere, die ich nie geöffnet habe. Als hätte das Gift meinem Körper beigebracht, es ohne mich herzustellen.

Alkohol zerstört Schönheit. Und die Quelle, aus der sie entsteht. Der Boden ist chemisch verwittert. Was am dringendsten Wasser bräuchte, kann es am wenigsten aufnehmen.

Als würde ich Rost trinken. Nur unsichtbar.

Es gibt keinen Quarantänebereich im Körper. Auch nach dem Aufhören nicht. Stammzellschäden sind irreversibel. Es gibt kein Reparatursystem fürs Reparatursystem.

Selbst wenn ich wüsste, was zu tun ist — es spielt keine Rolle, ob ich den Schlüssel habe, wenn mir die Hände fehlen, ihn umzudrehen. Was aus beschädigten Stammzellen entsteht, trägt den Fehler weiter. Jede Tochterzelle, solange ich lebe.

Mein Körper erneuert sich ständig. Mit Alkohol erneuert er sich falsch. Zuerst werde ich hässlich und eklig. Mein gesamtes Dasein verwandelt sich in ein Krebsgeschwür. Nicht erst das Karzinom am Ende.

Menschen vertrauen auf Selbstheilungskräfte, als wären sie Magie. Sie sind Biochemie. Und Biochemie lässt sich zerstören. Brechen diese Fundamente weg, mag ich noch atmen, mein Herz mag noch schlagen. Aber ich kann mich nicht mehr erholen. Ich bleibe die groteske Kümmerexistenz, die ich mir angetrunken habe.

Vol. 579, Issue 7800, 04.03.2020, 603—8.

70 Garaycoechea et al. 2012 u. 2018.

Jedes Gramm Alkohol kostet genetische Integrität. Den Bauplan, aus dem ein lebenswertes Leben entsteht. Ich würfle nicht. Ich stoße Dominosteine an. Ich muss dafür nicht erst obdachlos werden oder Bürger-Hartz beziehen. Der Schaden erzeugt die Bedingung, unter der Heilung unmöglich wird.

Ich hatte gehofft, der Schaden sei umkehrbar. Aber der Körper regeneriert keine Baupläne. Was Acetaldehyd an meinen Stammzellen angerichtet hat, bleibt als fehlerhafte Bauanweisung. Als Anleitung zur Hässlichkeit. Mein Körper baut nach beschädigten Plänen. Und Bier war der Gussfehler.

Jede neue Zelle ist eine Kopie des Schadens, als hätte Alkohol meinen Körper in ein sich selbst replizierendes Virus verwandelt.

Ich möchte kein Virus sein.

Mit jedem Mal, da ich mich besaube, verwandeln sich Paläste in Ruinen. Und wenn ich aufhöre, werde ich Teile der Stadt noch begehen können. Aber nicht jede Gasse, nicht jedes Haus. Vor allem nicht die glanzvollsten. Ich verliere den Ort, an dem ich zu Hause war. An dem ich *ich* war. Der Zugang bleibt versperrt. Alles, was ich tun kann, ist mit dem, was von mir übrig ist, eine neue Obhut zu improvisieren. Aber es wird sich nicht mehr wie Heimat anfühlen, so sehr sich mein Gehirn auch gegen diese Erkenntnis wehrt.

Es überlebt keine Theorie den Kontakt mit der Wahrheit.

Aufhören stoppt die Produktion von Acetaldehyd. Die verbrannten Baupläne holt sie nicht zurück. Das Haus brennt nicht mehr. Aber nichts darin hält noch Feuer. Ich habe das Wunder getötet, als ich es am meisten gebraucht habe.

8 VIVISEKTION

Nikotinsucht, Koffeinsucht, Alkoholsucht sind psychische Krankheiten. Lange bevor Leberwerte kippen, Demenz einsetzt oder Krebs kommt, hat Sucht das Gehirn umgebaut: veränderter

Metabolismus, veränderte Genexpression, veränderte Rezeptordichte.⁷¹ Sucht ist eine chronische, rückfällige Erkrankung des Gehirns.⁷²

Praktisch alle Drogen, ob Kokain, Heroin, Alkohol oder Nikotin, kapern denselben Schaltkreis, das mesolimbische Belohnungssystem. Sie fluten es mit Dopamin, stärker als jede natürliche Belohnung es könnte, und bringen das gesamte System aus dem Takt. Das Gehirn passt sich an. Es baut seine Schaltkreise um. Das süchtige Gehirn ist ein anderes Gehirn. Strukturell verändert, funktionell verändert, manchmal irreversibel. Leshner beschreibt den Vorgang als Schalter. Der erste Konsum ist freiwillig. Ab einem bestimmten Punkt wird der Schalter umgelegt. Danach ist der Konsum zwanghaft. Der Verstand weiß, dass es katastrophale Konsequenzen hat. Der Körper greift trotzdem zu. Es sei denn, es ist mein Mitbewohner. Dann weiß es nicht einmal der Verstand. Wer gegen Sucht kämpft, kämpft nicht gegen eine schlechte Angewohnheit. Er kämpft gegen die umgebaute Biologie seines eigenen Gehirns. Willenskraft gegen Neurochemie. Der Ausgang ist vorhersehbar.⁷³

Das Gehirn versucht, sich an die permanente Drogenflut anzupassen, indem es mehr Empfangsstationen baut. Hochregulation. Solange ich trinke, fallen die zusätzlichen Rezeptoren nicht auf, weil sie besetzt sind. Im Moment, wo der Nachschub

71 Purva Bali, Paul J. Kenny, »Transcriptional mechanisms of drug addiction«, in: *Dialogues in Clinical Neuroscience*, Vol. 21, Issue 4, Dezember 2019, 379—87.

Julie K. Staley, Suchitra Krishnan-Sarin, Kelly P. Cosgrove, et al., »Human Tobacco Smokers in Early Abstinence Have Higher Levels of β_2^* Nicotinic Acetylcholine Receptors than Nonsmokers«, in: *The Journal of Neuroscience*, Vol. 26, Issue 34, 23.08.2006, 8707—14.

72 Alan I. Leshner, »Addiction Is a Brain Disease, and It Matters«, in: *Science*, Vol. 278, Issue 5335, 03.10.1997, 45—7.

73 Leshner 1997.

aufhört, stehen all diese leeren Rezeptoren da und schreien nach Füllung. Entzug auf molekularer Ebene.⁷⁴ Die Droge verschleiert sogar die Forschung über sich selbst.⁷⁵ Irgendwann trinke ich nicht mehr, um mich gut zu fühlen. Ich trinke, um mich nicht schlecht zu fühlen.

Das also war der Hunger.

Der Hunger hat ein Gedächtnis. Bei jedem Konsum produziert das Gehirn ein Protein namens DeltaFosB. Was es von den meisten Proteinen unterscheidet: *es wird nicht abgebaut*. Er bleibt wochenlang im Zellkern, sammelt sich an, macht das Gehirn empfindlicher für Alkohol und lässt ihn leuchten wie das letzte Licht in einem dunklen Raum. Eine biologische Narbe, die sich mit jedem Glas einbrennt. Das Gehirn versucht gegenzusteuern. Es produziert Dynorphin, eine Substanz, die Euphorie dämpft und Unbehagen erzeugt. Die Abwehr funktioniert. Aber sie hat eine Nebenwirkung: *Ich brauche mehr, um dasselbe zu fühlen*. Die Verteidigung beschleunigt den Verfall.⁷⁶

Beim ersten Rauchstopp trank ich Kokoswasser. Beim zweiten wurde ich alkoholabhängig. Der Körper merkt sich jeden Versuch. Er quittiert jedes Mal härter.

Sucht sitzt im Gehirn. Aber das Gehirn sitzt in einer Welt. Viele amerikanische Soldaten im Vietnamkrieg waren schwer heroinabhängig. Nach ihrer Rückkehr war die Rückfallquote erstaunlich gering. Die Auslöser, die Gerüche, die Menschen — alles, was mit dem Konsum verknüpft war, fiel weg. Das Gehirn

74 Staley et al. 2006.

75 Primatenstudie in Staley et al. 2006. Die Droge saß noch im Gehirn und verfälschte die Messung. Erst nach vollständiger Auswaschung wurde sichtbar, was sie angerichtet hatte. Der Mechanismus ist bei allen Substanzen derselbe.

76 Bali-Kenny 2019.

war umgebaut. Aber niemand erinnerte es mehr an den Konsum. Es existiert nicht im Vakuum.

Dieselbe Biologie, die in einem Umfeld voller Auslöser zur Katastrophe führt, kann in einem anderen Umfeld zur Ruhe kommen. Wer das ignoriert und nur den Körper behandelt, behandelt die Hälfte.

Die Soldaten konnten Vietnam verlassen. Ich kann Berlin nicht verlassen.

Berlin ist ein sozialer Aggregatzustand. Menschen unter chronischem Druck, die sich an anderen schadlos halten. Ökonomisch am Ende, digital überflutet, menschlich bankrott. Was ihnen genommen wurde, nehmen sie sich zurück. An mir. Im Supermarkt, im Treppenhaus, in den Kommentarspalten. Ohnmacht, die so chronisch geworden ist, dass sie sich als Stärke verkleidet.

Wer keine Macht hat, erfindet sich eine Bühne. Wer keine Würde hat, nimmt sie anderen. Individuell wirkt das wie Stabilisierung. Kollektiv ist es Krieg in Zeitlupe. Der Unfrieden rechtfertigt das Verhalten, das ihn erzeugt. Die Schlange frisst ihren eigenen Schwanz.

Ich bin ein Seismograf, der in der Erdbebenzone lebt. Jahrelang rauchte ich die Erschütterungen weg. Nach dem Aufhören wurde ich zum irischen Hafenarbeiter. Ich soff sie weg. Die ganze Stadt säuft sie weg. Aus denselben Gründen wie ich. Sie nennt es Feierabend. Ich nicht. Aber die Flasche ist dieselbe.

Kindheit, Trauma, Substanz, Gehirnumbau, Krankheit, Tod. Die Kette ist lückenlos. Was als mangelnde Willenskraft verachtet wird, sind biologisch verankerte Überlebensversuche. Wer Sucht als Charakterschwäche behandelt, ignoriert die Forschung. Wer sagt, rei dich zusammen, ignoriert die Biologie. Das ändert nichts an der Verantwortung. Aber es verändert, was Verantwortung bedeutet.

Am Ende sucht niemand mehr den Rausch. Er flieht vor dem Normalzustand seines eigenen Gehirns, den der Alkohol erst geschaffen hat.

9 HEILUNG BEGINNT NICHT MIT EINSICHT

Heilung beginnt mit Schlaf.

Schlaf ist der eigentliche Engpass. Ohne Alkohol konnte ich nicht schlafen. Ohne Schlaf kann ich nicht regulieren.⁷⁷ Ohne Regulation brauche ich Alkohol.

Suchtkarussell.

Der Schlummertrunk ist die tückischste Selbsttäuschung, weil er kurzfristig funktioniert. Alkohol verkürzt die Einschlafzeit. In den ersten Stunden nimmt der Tiefschlaf sogar zu. Ich nicke ein, fühle mich schwer, und genau das bestärkt den Glauben. Er hilft beim Einschlafen. Er zerstört den Schlaf. Nach drei bis vier Stunden setzt der Rebound ein.⁷⁸ Dasselbe Muster wie im Entzug, nur im Miniaturformat, jede Nacht. Glutamat fährt hoch, GABA ist geschwächt. Die zweite Nachthälfte wird oberflächlich, fragmentiert, von Wachphasen zerrissen.⁷⁹ Das Herz rast, die Gedanken kreisen. Der REM-Schlaf wird unterdrückt.

77 Subhajit Chakravorty, Ninad S. Chaudhary, Kirk J. Brower, »Alcohol Dependence and its Relationship with Insomnia and Other Sleep Disorders«, in: *Alcohol, Clinical and Experimental Research*, Vol. 40, Issue 11, 05.10.2016, 2271–82.

78 Annie Britton, Linda Ng Fat, Aidan Neligan, »The association between alcohol consumption and sleep disorders among older people in the general population«, in: *Scientific Reports*, Vol. 10, 24.03.2020, Artikel 5275.

79 Irshaad O. Ebrahim, Colin M. Shapiro, Adrian J. Williams, Peter B. Fenwick, »Alcohol and Sleep I: Effects on Normal Sleep«, in: *Alcohol, Clinical and Experimental Research*, Vol. 37, Issue 4, April 2013, 539–49.

Die Schlafphase, in der das Gehirn aufräumt.⁸⁰ Wer abends trinkt, zerstört die Schlafphase, die er am meisten braucht. Die Whitehall-II-Studie beobachtete das über drei Jahrzehnte.⁸¹ Die Hauptbeschwerde war nächtliches Aufwachen. Stundenlang wach, müde, aber ohne Schlaf. Genau die Fragmentierung, die der Rebound vorhersagt.

Der Schlummertrunk verstärkt sich selbst. Schlechter Schlaf erzeugt den Wunsch nach Bier. Das Bier erzeugt schlechteren Schlaf. Ich gieße Benzin ins Feuer, um das Feuer zu löschen.

Im Entzug wird Schlaf zum Hauptfeind der Abstinenz. Bis zu 92 Prozent leiden unter Schlafstörungen, wochenlang, monatelang. Schlechter Schlaf ist der kürzeste Weg zurück zur Flasche. Ich behandle das Problem mit seiner Ursache. Ich könnte es mit seiner Lösung behandeln.

Schlaf.

(Der ist sogar pfandfrei.)

Schlaf bestimmt, wo Null liegt. Ohne Schlaf wird jedes Gefühl zur Krise und jede Krise zur Droge. Ein schlafloser Mensch ist nicht frei. Er wird gesteuert von dem, was ihn kurzfristig stillstellt. Mein Problem war ein Nervensystem im Daueralarm. Das Belohnungssystem war leer. Alkohol war nur das Symptom. Nikotin war mein Krückstock, mein Stressdämpfer, mein Taktgeber. Nikotin machte mich funktionsfähig im Lärm. Alkohol macht die Stille erträglich. Und weil mir niemand zeigte, wo die Wunde sitzt, anästhesierte ich das ganze System.

Schlaf ist die Grenze zwischen Selbstregulation und Selbstbetäubung. Im Schlaf wird Dopamin zurückgesetzt. Das Nervensystem repariert sich. Rauschen klingt ab, oder frisst sich fest.

80 Carissa Gardiner, Jonathon Weakley, Louise M. Burke, et al., »The effect of alcohol on subsequent sleep in healthy adults: A systematic review and meta-analysis«, in: *Sleep Medicine Reviews*, Vol. 80, April 2025, 102030.

81 Britton et al. 2020.

Schlaf ist die Währung, in der das Gehirn bezahlt wird. Wer nicht zahlt, wird gepfändet. Wenn Schlaf kaputt ist, fühlt sich Nüchternheit wie Entzug an. Normalität wie Mangel. Jede Substanz wie Erlösung.

Nachts endet die Fähigkeit, Signal von Rauschen zu unterscheiden. Tagsüber kann ich noch so tun, als sei ich souverän. Nachts fällt die Maske. Alles schreit. Rauschen gewinnt, weil das Gehirn erschöpft ist. Ohne Schlaf gibt es nur Lärm mit Bedeutungshunger.

Schlaflöse Menschen brauchen Krücken. Alkohol, Nikotin, Koffein, Essen. Weil der Zustand ohne sie nicht erträglich ist. Menschen sind schlafende Wesen. Wer nicht schläft, schlafwandelt tagsüber. Gesteuert von seiner eigenen Notfall-Chemie. Der Weg zurück führt nur über einen Körper, der wieder allein klarkommt. Wenn Dopamin langsam neu kalibriert wird. Wenn Ersatzhandlungen nicht selbst wieder Drogen sind. Ohne Alkohol, ohne andere Toxine, ohne Stressfaktoren. Ohne Menschen, die meine Energie aussaugen.

Nur Schlaf, Struktur und Stille.

Ich wusste jetzt, warum ich trank. Aber um drei Uhr nachts half das nichts. Schon der bloße Gedanke an Alkohol fühlte sich an wie Erleichterung. Eine Maschine interessiert nicht, wer sie gebaut hat. Was da schrie, war längst nicht mehr der Geist der Täter. Meine Gefühle sagen mir, ich bräuchte Alkohol. Sie lügen. Die Sucht injiziert mir ihre Gefühle und Gedanken ein, um sich selbst zu erhalten. Sie will nicht, dass ich sterbe. Sie will, dass ich lebe.

Gerade so.

Das bin nicht ich. Wenn mein Körper nach Alkohol schreit, dann schreit der Besatzer. Ohne Alkohol geht es mir besser. Ich sehe es im Spiegel. Andere sehen es sofort.

Der Dämon schreit eine Weile. Irgendwann verstummt er. Er stirbt an Langeweile. Nüchternheit ist die Weigerung, sich weiter zu schlagen.

Und bis es soweit ist, gilt eine Regel: *Was auch immer meine Gedanken und Gefühle anweisen, ich tue das Gegenteil.*

Nämlich gar nichts.

Der gefährlichste Zustand ist das Fehlen einer Struktur, die mich auffängt. Im Entzug delegiert ein Regelwerk den Tag, damit meine Gefühle und Gedanken darin nicht stattfinden. Sie gehören der Sucht, nicht mir. Was auch immer die Stimme in meinem Kopf oder das Gefühl in meinem Körper sagen: es ist falsch. Sucht liebt Debatte. Ich fasse sie nicht an. Drückt mich der Suchtdämon unter die Schwelle des Erträglichen, lege ich mich hin und mache die Augen zu.

Das nennt man Heilung.

Auch wenn ich nicht schlafe. Liegen ist die Arbeit. Alles außer Liegen endet an der Kasse im Supermarkt.

Liegen und den Hunger nach Bier brüllen lassen. Bis es aufhört. Bis es still ist. Bis der Hunger verhungert ist. Das dauert vielleicht vier, vielleicht acht, vielleicht zwölf Wochen. Und wenn ich nachgebe, beginnt alles wieder bei Tag eins.

Zwölf Wochen Nichtstun gegen ein ganzes Leben.

Fairer Tausch.

KAFFEE MACHT NICHT WACH

Er macht dumm.

Achtzig Prozent der Menschheit zerstören täglich ihren Schlaf, um die Müdigkeit zu bekämpfen, die dadurch entsteht. *Man trinkt, um normal zu werden. Ohne Substanz wäre man es schon. Jede Tasse stiehlt Tiefschlaf. Weniger Tiefschlaf bedeutet mehr Brain Fog. Mehr Brain Fog bedeutet mehr Kaffee. Man trinkt, um ein Problem zu lösen, das die Substanz selbst erzeugt hat.*

Gifte wie Nikotin, Alkohol und Koffein zerstören den Zugang zu einem Persönlichkeitsanteil, ohne den ich mich nicht heilen kann. Als ich eine Gehirnläsion hatte, lag ich zwei Monate im Bett und schlief. Schlafend reparierte sich mein Gehirn, aber nur ohne Kaffee. Dreimal trank ich einen Espresso. Danach fühlte es sich anderthalb Tage so an, als sei meine Selbstheilung tot. Kaffee hebt nicht über Normal. Er bringt nur zurück.

Rogers zeigte, dass Koffein ähnlich funktioniert wie Nikotin: Die vermeintliche Leistungssteigerung führt lediglich auf das Leistungsniveau eines Nicht-Konsumenten zurück, da der Körper eine Toleranz gegenüber den anregenden Effekten entwickelt. Ohne Kaffee bin ich müde, matschig, leer. Mit Kaffee fühle ich mich normal. Das nenne ich dann Produktivität. Die Forschung nennt das *withdrawal reversal*.¹

1 Peter J. Rogers, »Caffeine and Alertness: In Defense of Withdrawal Reversal«, in: *Journal of Caffeine Research*, Vol. 4, Issue 1, 01.03.2014, 3—8.

Was ich für Leistungssteigerung halte, ist Entzugsrücknahme. Mit wach verbrachter Zeit steigt der Schlafdruck. Adenosin akkumuliert.² Koffein blockiert die Rezeptoren.³ Adenosin will sich setzen, aber Koffein hält den Stuhl besetzt. Der Körper baut mehr Rezeptoren.⁴ Toleranz entsteht.

Nach Stunden ohne Koffein treten Entzugserscheinungen auf. Man fühlt sich müde und gereizt. Die Tasse Kaffee bringt einen zurück auf das Niveau, das man ohne Koffein hätte. Koffein löst ein Problem, das es selbst geschaffen hat.⁵

Selbst wenn die Probanden ihre übliche Dosis bekommen hatten, verbesserte eine zusätzliche Dosis ihre Leistung nicht. Sie glich lediglich das kognitive Defizit aus, das durch den koffeinbedingten schlechten Schlaf der Nacht davor entstand. Schlechter Schlaf macht müde, also trinkt man mehr Kaffee, was den Schlaf weiter verschlechtert.⁶

In placebo-kontrollierten Studien verglich man regelmäßige Kaffeetrinker unter Koffein mit denselben Konsumenten unter Placebo und setzte das in Relation zu Nichttrinkern. Die Kaffeetrinker unter Koffein waren nicht besser als Nichttrinker. Sie waren nur besser als die Kaffeetrinker unter Placebo, die im

2 Carolin Franziska Reichert, Tom Deboer, Hans-Peter Landolt, »Adenosine, caffeine, and sleep—wake regulation: state of the science and perspectives«, in: *Journal of Sleep Research*, Vol. 31, Issue 4, 16.05.2022, e13597.

3 Lishan Huang, Wenwen Zhu, Nanxi Li, et al., »Functions and mechanisms of adenosine and its receptors in sleep regulation«, in: *Sleep Medicine*, Vol. 115, März 2024, 210—7.

4 Merideth A. Addicott, Paul J. Laurienti, »A comparison of the effects of caffeine following abstinence and normal caffeine use«, in: *Psychopharmacology*, 24.09.2009, Vol. 207, Issue 3, 423—31.

5 Rogers 2014.

6 Addicott-Laurienti 2009.

Entzug hingen. Koffein zog sie wieder auf Baseline. Kein Vorteil über Normal.⁷

Was ich als Wachheit empfinde, bezahle ich mit Nervosität und Angst. Nach einem doppelten Espresso bin ich entweder normal oder darunter — zittrig, unruhig, unkonzentriert. Netto lande ich bei null.⁸

Eine Metaanalyse von Gardiner und Kollegen zeigt, dass Koffein den Schlaf deutlich verschlechtert.⁹ Die Gesamtschlafzeit sinkt im Schnitt um 45 Minuten, die Schlaffeffizienz um rund sieben Prozentpunkte. Man braucht länger zum Einschlafen und ist nachts häufiger wach. Die Tiefschlafphasen werden zerhackt. Man wacht weniger erholt auf, ohne zu wissen, warum. Der Körper regeneriert nicht vollständig. Das Immunsystem arbeitet schwächer, das Gedächtnis leidet, die Zellreparatur stockt.¹⁰

Drake und Kollegen gaben Probanden vierhundert Milligramm Koffein, etwa zwei große Tassen starken Kaffee, entweder direkt vor dem Schlafen, drei Stunden davor oder sechs Stunden davor.¹¹ Selbst wenn das Koffein sechs Stunden vor dem Zubettgehen konsumiert wurde, führte es zu einem objektiven, mit Geräten gemessenen Schlafverlust von über einer Stunde.

7 Peter J. Rogers, Susan V. Heatherley, Emma L. Mullings, Jessica E. Smith, »Faster but not smarter: effects of caffeine and caffeine withdrawal on alertness and performance«, in: *Psychopharmacology*, Vol. 226, Issue 2, 30.10.2012, 229—40.

8 Chen Liu, Licheng Wang, Chi Zhang, et al., »Caffeine intake and anxiety: a meta-analysis«, in: *Frontiers in Psychology*, Vol. 15, 01.02.2024, 1270246.

9 Carissa Gardiner, Jonathon Weakley, Louise M Burke, et al., »The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis«, in: *Sleep Medicine Reviews*, Vol. 69, Juni 2023, 101764.

10 Gardiner et al. 2023.

11 Christopher Drake, Timothy Roehrs, John Shambroom, Thomas Roth, »Caffeine Effects on Sleep Taken 0, 3, or 6 Hours before Going to Bed«, in: *Journal of Clinical Sleep Medicine*, Vol. 9, Issue 11, 15.11.2013, 1195—200.

Die Probanden haben es nicht bemerkt. Subjektiv, in ihrer eigenen Wahrnehmung, spürten sie bei der Sechs-Stunden-Variante kaum noch eine Störung. Sie dachten, sie hätten gut geschlafen. Die Messgeräte aber zeigten eine massive Störung der Schlafarchitektur. Man schiebt die Müdigkeit tagsüber auf Stress oder schlechtes Essen, während in Wahrheit der Kaffee vom Vortag der Übeltäter ist. Mein Körper leidet, aber die Wahrnehmung ist getrübt. Der Zusammenhang bleibt unsichtbar. Kaffee sabotiert den Schlaf lange vor dem Zubettgehen: weniger Gesamtschlaf, weniger Tiefschlaf.

Der morgendliche Kaffee ist für Gewohnheitskonsumenten häufig kein echter Energieschub, sondern die Umkehr des Entzugs, von Minus zurück auf Null. Und während ich tagsüber »funktioniere«, zahlt die Nacht. Koffein reduziert Schlafdauer und Tiefschlaf messbar.¹² Kaum etwas senkt Leistungsfähigkeit so zuverlässig wie schlechter Schlaf.¹³ Weniger Tiefschlaf bedeutet schlechtere kognitive Leistung am nächsten Tag. *Ich gieße Koffein auf genau das Feuer, das den Brain Fog am Leben hält.* Kaffee borgt Wachheit am Morgen und zahlt sie nachts mit Zinsen zurück.

Zudem zieht Koffein das Angstsystem hoch. Liu und Kollegen zeigen in einer Meta-Analyse, dass Koffein bei gesunden Menschen mit einem erhöhten Angstisiko zusammenhängt, besonders bei höheren Dosen.¹⁴

Eine Studie von Lovallo und Kollegen zeigt die unvollständige hormonelle Gewöhnung. Der erste Kaffee am Morgen löst bei Gewohnheitstrinkern keinen Kortisol-Peak mehr

12 Rogers 2014.

13 Matthew P. Walker, »The Role of Slow Wave Sleep in Memory Processing«, in: *Journal of Clinical Sleep Medicine*, Vol. 5, No. 2, Supplement, S20—S26.

14 Liu et al. 2024.

aus. Eine zweite Dosis nachmittags schon. Der Körper reagiert immer noch mit einer Stressantwort, auch wenn man sich immun wähnt. Man glaubt, Kaffee hilft wach und leistungsfähig zu sein. Tatsächlich stört er den Schlaf, Stunden später und unbemerkt, und er löst eine Stressreaktion aus.¹⁵

Das war für mich ein Problem, denn nach dem Rauchstopp hing ich permanent in Panik. Es war so relevant wie der schlechte Schlaf, der am Ende auch den Viszeralfett-Abbau verhindert. Was ich kaffeetrinkend für Fokus halte, ist in Wahrheit Stress. Koffein blockiert Adenosin, das Müdigkeitssignal, und schiebt das System in Richtung Aktivierung. Das fühlt sich nach Drive an, ist aber bloß Lärm. Kaffee gibt keine Konzentration, es schlägt Alarm.¹⁶

Koffein ist ein Grund für Brain Fog. Nach dem Aufhören trank ich extrem viel Kaffee, weil in meinem Kopf die idiotische Idee festklebte, das mache wach, konzentriert, produktiv. Diese Überzeugung hielt sich wie Teer, obwohl ich wusste, dass der Nebel durch Kaffee nicht weniger wurde, sondern mehr. Dieser Glaube, Brain Fog würde durch Kaffee weniger, ist tatsächlich ein Messfehler. Denn ich messe nicht Klarheit, sondern Stimulationsgefühl. Koffein kann subjektiv pushen, während kognitive Qualität sinkt. Kaffee ist nicht Klarheit. Kaffee ist ein *Gefühl* von Klarheit. Das ist etwas so sehr Anderes.

15 William R. Lovallo, Thomas L. Whitsett, Mustafa al'Absi, et al., »Caffeine Stimulation of Cortisol Secretion Across the Waking Hours in Relation to Caffeine Intake Levels«, in: *Psychosomatic Medicine*, Vol. 67, Issue 5, 2005, 734–9.

16 Liu et al. 2024.

Was diese Überzeugung stabilisiert, ist das, was passiert, wenn ich den Kaffee weglassen: Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, Leere.¹⁷

Das Gehirn schreit dann: *Siehste! Kaffee hilft doch.*

Aber das ist nur das System, das seine Droge zurückfordert.

Wenn es beim Absetzen schlechter wird, ist das kein Beweis für Hilfe, sondern für Abhängigkeit.

Kaffee ist ein Kredit. Brain Fog ist die Rechnung. Klarheit entsteht nachts, nicht aus der Tasse.

Der Normalzustand ohne Gift fühlt sich wacher, ruhiger, ausgeglichener an als die meisten erwarten.¹⁸ Ich brauche keine Substanzen zur Selbstmedikation. Um den Nebel zu vertreiben, muss der Kaffee ebenso raus wie das viszerale Übergewicht.

DIE SUBSTANZ, DIE DAS ICH ERSETZT

Während des Kaffeeentzugs werde ich so müde, dass ich kaum stehen kann. Wenn ich reich wäre, würde ich eine Woche schlafen, bis mein Körper wieder bewohnbar ist. Ich kann es nicht. Also betäube ich Müdigkeit mit Kaffee.

Zudem trage ich noch 25 Kilo aus der Zeit nach dem Rauchstopp. Nach nur einer Tasse beginnt mein Bauch zu drücken, als würde der Stoffwechsel auf Stopp schalten.

Kaffee hebt mich, verkauft mir Wachheit und raubt mir Erholung. Kaffee gaukelt dem Körper vor, er brauche keine Pause. Und der Körper glaubt ihm. Danach kommt die Rechnung. Er

17 Franklyn Rocha Cabrero, Richard J. Hamilton, »Caffeine Withdrawal«, in: *StatPearls [Internet]*, 13.12.2025 [Update].

18 Gemma Taylor, Ann McNeill, Alan Girling, et al, »Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis«, in: *BMJ*, Vol. 348, 13.02.2014, g1151.

peitscht das System. Später verklebt er es. Er ersetzt Rhythmus durch Dauerspannung und nimmt mir die Mitte.

Am nächsten Tag wieder. Ich bin Blei. Ich trinke Kaffee. Damit ist das Seil in den Abgrund geworfen. Zuerst verschwinde ich. Stress schießt hoch. *Noch ein Kaffee, dann sollte es gehen.* Natürlich geht es nicht.

Ich darf nicht essen. Erst recht kein Bier trinken.

Ich brenne. Ein Bier muss doch okay sein.

Ist es nicht.

Ich esse. Salz.

Wenn ich jetzt nichts mache, drehe ich durch.

Ich darf nicht.

Ich muss.

Ohne Kaffee endet die Spirale. Mit Kaffee werde ich zur tickenden Zeitbombe. Innerhalb weniger Stunden kommt die Essattacke. Ich stopfe mich, weil ich aus mir herausfalle.

Was folgt, variiert in der Reihenfolge, nicht im Ergebnis. Fressen, dann Bier. Oder Bier, dann Fressen. Die Sequenz ist austauschbar, das Ende identisch.

Das ist kein Kontrollverlust, auch wenn mir der Selbsthass das weismachen will. Nicht Hunger tötet Disziplin, sondern Cortisol. Kaffee hält den Cortisolspiegel künstlich erhöht — ein Nervensystem, das verzweifelt die Bremse sucht, findet sie nicht. *Kaffee macht die Hölle nicht größer. Er verhindert nur, dass sie endet.*¹⁹

Der Tag, an dem die Schleife wiederkehrt, beginnt mit einem Gedanken, der wie Vernunft klingt. *Ein Kaffee geht doch. Ich muss funktionieren. Nur einen.*

19 William R. Lovallo, Noha H. Farag, Andrea S. Vincent, et al., »Cortisol responses to mental stress, exercise, and meals following caffeine intake in men and women«, in: *Pharmacology Biochemistry and Behavior*, Vol. 83, Issue 3, März 2006, 441–7.

Was sich richtig anfühlt, hält mich krank. Der Körper antwortet, wie Körper antworten, wenn man sie ignoriert. Mit Stress. Der Bauch beginnt zu drücken, weil nichts mehr fließt. Es wird unmöglich, im eigenen Körper zu wohnen. Unruhe. Gereiztheit. Die Spannung wird unerträglich.

Ich halte das nicht aus.

Stress schaltet den Körper auf Überleben. Cortisol verschiebt das Essverhalten. Ich greife zur biologischen Notbremse. Salzige, fettreiche Kost als Gegensignal.²⁰ Insulin steigt. Das Stresssystem fällt kurz zurück. Parasympathische Dominanz für Minuten. Dann Alkohol, um die Dämpfung zu verlängern. Die Salzüberdosis zu betäuben. Alkohol aktiviert künstlich Hunger-Neuronen (*Agouti-related peptide*), die nichts mit Bedarf zu tun haben.²¹ Dann mehr Essen, um den Alkohol aufzufangen. Salzig, versteht sich.

Am nächsten Morgen: Körper entzündet, aufgedunsen. Kopf wie Watte. Nichts, das mir Halt gibt. Nur Müdigkeit und der Gedanke, sie mit Kaffee zu erschlagen.

Nur einer.

Schleife geschlossen. Wieder von vorn.

Mein ganzes Leben habe ich beim Fasten keinen Gramm abgenommen, solange Kaffee im System war. Einmal lebte ich eine Woche lang ausschließlich von Kaffee und Zigaretten. Die

20 Elissa Epel, Rachel Lapidus, Bruce McEwen, Kelly Brownell, »Stress may add bite to appetite in women: a laboratory study of stress-induced cortisol and eating behavior«, in: *Psychoneuroendocrinology*, Vol. 26, Issue 1, Januar 2001, 37–49.

Mary F. Dallman, Norman C. Pecoraro, Susanne E. la Fleur, »Chronic stress and comfort foods: self-medication and abdominal obesity«, in: *Brain, Behavior, and Immunity*, Vol. 19, Issue 4, Juli 2005, 275–80.

21 Sarah Cains, Craig Blomeley, Mihaly Kollo, et al., »AgRP neuron activity is required for alcohol-induced overeating«, in: *Nature Communications*, Vol. 8, 10.01.2017, Artikel 14014.

Zahl auf der Waage blieb dieselbe. Physikalisch unmöglich, dachte ich. Die Biologie wusste es besser.

Kaffee flutet mich mit Stresshormonen. Koffein senkt die Insulinsensitivität. Epinephrin schießt hoch, fünfmal höher als normal. Der Körper kann Energie nicht mehr verwerten. Cortisol hoch.²² Adrenalin hoch. Die Glukosekontrolle wird grob. Koffein macht aus Fasten Alarmzustand. Der Darm fährt runter. Kaffee ist ein Fake-Motor. Er macht nicht wach, er erzwingt Wachheit über die Stressachse. Der Körper schaltet auf Notbetrieb. Stresshormone hoch, Reparatur runter.²³ Selbstheilung wird unterbrochen, um Zeit zu erkaufen. Koffein verschiebt den Kollaps, indem es Stresshormone hochzieht. Noradrenalin steigt, Wachheit wird erzwungen, Regeneration ausgesetzt.

Ob Kaffee oder Mate, spielt übrigens keine Rolle — *Matein* ist eine Marketinglüge, chemisch identisch mit Koffein. Energy-Drinks verschärfen das Problem sogar durch zusätzliche Stimulanzien (Guarana, Taurin). Es ist kein Ausstieg, sondern eine Umleitung. So sinnvoll wie Dampfen oder Nikotinkaugummis als Ersatz für Rauchen.²⁴

22 Gerben B. Keijzers, Bastiaan E. De Galan, Cees J. Tack, Paul Smits, »Caffeine Can Decrease Insulin Sensitivity in Humans«, in: *Diabetes Care*, Vol. 25, Issue 2, 01.02.2002, 364—9.

23 William R. Lovallo, Thomas L. Whitsett, Mustafa al'Absi, et al., »Caffeine Stimulation of Cortisol Secretion Across the Waking Hours in Relation to Caffeine Intake Levels«, in: *Psychosomatic Medicine*, Vol. 67, Issue 5, September 2005, 734—9.

24 Anna Svatikova, Naima Covassin, Kiran R. Somers, et al., »A Randomized Trial of Cardiovascular Responses to Energy Drink Consumption in Healthy Adults«, in: *JAMA*, Vol. 314, No. 19, 17.11.2015, 2079—82.

Melanie A. Heckman, Jorge Weil, Elvira Gonzalez de Mejia, »Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in foods: a comprehensive review on consumption, functionality, safety, and regulatory matters«, in: *Journal of Food Science*, Vol. 75, Issue 3, 05.04.2010, R77—R87.

Das Druckgefühl sagt mir, dass der Körper aufgehört hat, für mich zu arbeiten. *Fasten plus Kaffee ist kein Fasten, sondern Stresssimulation bei leerem Tank.* Ich esse nichts, bewege mich viel, aber nichts verschwindet. Nicht, weil die Physik aussetzt, sondern weil Kaffee den Körper nötigt, *jetzt bloß nichts loszulassen.* Diätstress plus Koffein ist Stress auf Stress. Und ein Körper im Alarm lässt ungern los.²⁵ Fettabbau ist keine Willenssache. Chronisch erhöhter Stress schaltet den Körper auf Verteidigung. Cortisol signalisiert, Energie zu halten statt sie freizugeben. Der Körper verweigert Fettabbau, wenn er sich bedroht fühlt.

Man kann noch so diszipliniert sein: In kataboler Stressstarre gibt der Körper nichts her. Er braucht die biochemische Erlaubnis, loszulassen. Kaffee widerruft diese Erlaubnis. Er sagt dem Körper: angespannt bleiben, wachsam bleiben, bereit bleiben. Stresshormone legen sich wie Stacheldraht ums Bauchfett. Und ein Körper im Dauerfeuer, das man fälschlich Fokus nennt, lässt nichts gehen.

Fasten heißt, *der Körper darf loslassen.* Kaffee sagt: *bloß nicht loslassen.* Solange das Stresssystem aktiv ist, bleibt der Organismus verriegelt. Ich kann hungern, bis ich zittere, der Körper bleibt zu. Deshalb geschieht das scheinbar Unmögliche: *Nichts essen, nicht abnehmen.*

Wenn der Körper eine Bremse braucht und ich ihm die nicht gebe, holt er sie sich. Kaffee sagt Alarm. Alarm sagt Festhalten. Festhalten sagt Essanfall.

Dann Bett. Dann Aufwachen in der Hölle. Keine Klarheit, nur Nebel. Schwabbelfett droht Haut aufzureißen. Scham dazu,

25 Kalorienrestriktion erhöht Cortisol-Output.

A. Janet Tomiyama, Traci Mann, Danielle Vinas, et al., »Low calorie dieting increases cortisol«, in: *Psychosomatic Medicine*, Vol. 72, Issue 4, Mai 2010, 357–64.

Lovallo et al. 2006; Ders. et al. 2005.

Schuldgefühle. Wenn das hundert Tage am Stück so geht, manchmal auch Suizidgedanken. Aber sie werden nicht Handlung, weil sie ein anderer Gedanke verdrängt.

Nur ein Kaffee und dann fasten — sonst nichts.

Dann von vorn.

Gesundheit beginnt mit Wahrnehmung. Sucht beginnt mit Betäubung. Wenn ich Koffein oder Nikotin im Blut habe, ist meine Wahrnehmung getrübt. Ich habe keine Abwehr gegen die Lügen, die mich im Kreis halten. Kaffee macht mich unfähig, in mir zu ruhen und mein Ding zu machen. Wenn ich nicht bei mir bin, habe ich keinen Zugriff auf mein Verhalten. Nur andere haben Zugriff auf mein Verhalten. Ich werde beeinflusst und kontrollierbar. Wer nicht bei sich ist, wird benutzt. Wer nicht bei sich ist, braucht Ersatz von außen.²⁶

Kaffee passt ins narzisstische, adipöse, wahrnehmungsgestörte Sozialgeflecht.²⁷ Nach dem Konsum bin ich verfahren, durcheinander. Reizbar und erschöpft zugleich. Kein Fokus ist

26 Stress verschiebt Handlungskontrolle vom *zielgerichteten* in den reaktiv-reizgetriebenen, *habitualen* Modus. Man spult erlernte Muster ab.

Lars Schwabe, Oliver T. Wolf, »Stress-induced modulation of instrumental behavior: From goal-directed to habitual control of action«, in: *Behavioural Brain Research*, Vol. 219, Issue 2, 01.06.2011, 321—8.

Amy F. T. Arnsten, »Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function«, in: *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 10, Juni 2009, 410—22.

27 Schlafmangel reduziert Aktivität in frontalen Evaluationsregionen und erhöht Amygdala-Aktivität, was mit gesteigertem Verlangen nach hochkalorischer Nahrung korreliert.

Stephanie M. Greer, Andrea N. Goldstein, Matthew P. Walker, »The impact of sleep deprivation on food desire in the human brain«, in: *Nature Communications*, Vol. 4, 06.08.2013, Artikel 2259.

das, keine Disziplin. Nervosität eher, als Produktivität verkleidet. Ich spüre nichts, was mir Halt gibt.

Der Auslöser ist Erschöpfung. Der Reparaturbedarf ist hoch. Dann kommt der Kaffee, der sich als Hilfe verkauft. Kurz glaube ich, besser zu funktionieren. Dann der Crash, das Körpersignal kippt. Kein Hunger, nur Stress ohne Ausgang, der als Hunger erscheint. Das System braucht eine Bremse und holt sie sich mit Essen (insulinvermittelt, parasympathisch) oder Alkohol (GABA, Nervendämpfung). Beides wirkt kurz. Danach ist alles schlimmer.

Kaffee ist der Zündfunke, nicht die Explosion. Mein Denkfehler war, andere Dinge für das Problem und Kaffee für harmlos zu halten. Kaffee ist das Bindeglied, das die ganze Kette wieder aktiviert. Allein mag er nicht zerstören wie andere Suchtmittel, aber mein System puffert ihn nicht. Das ist wie bei jemandem mit gebrochenem Bein zu sagen: *Ich laufe jetzt mal kurz*. Solange ich Kaffee benutze, um wach zu bleiben, arbeite ich gegen meinen Körper. Und ein Körper, gegen den gearbeitet wird, holt sich sein Recht.

Das Ende der Schleife bedeutet: Koffein raus, Cortisol runter, Insulin stabil, Nervensystem beruhigen, bevor Hunger lügt. Ich streiche Kaffee nicht isoliert. Ich senke zugleich den Stresspegel. Senke ich ihn nicht, fange ich an, mehr zu fressen. Entzug bei gleichzeitiger Überbelastung ist biologischer Selbstmord auf Raten. Essattacken entstehen nicht durch Hunger, sondern durch verpasste Prävention. Der Körper schreit nicht, wenn er zuvor Struktur bekommen hat. *Nicht satt essen, stabil essen*.

WENN DAS GEHIRN DIE WAHRHEIT BLOCKIERT

Jeden Morgen trinken achtzig Prozent der Weltbevölkerung ein Neurotoxin, das ihr Gedächtniszentrum schrumpft. Die meisten nennen es Ritual. In Deutschland gibt es Selbsthilfegruppen

für Alkohol, Heroin und Spielsucht. Für Koffein gibt es Hafermilch-Upgrades. Der Unterschied ist nicht pharmakologisch. Er ist kulturell. Wer morgens ohne Kaffee nicht funktioniert, hat keinen Kaffee-Mangel. Er hat eine Abhängigkeit, die sich als Persönlichkeit tarnt.

Ich lebe in einer Kultur, die mich gehirngewaschen hat. Die mir erzählt, Koffein sei harmlos, nicht vergleichbar mit Nikotin oder Alkohol. *De facto* ist die Wirkung nicht weniger verheerend, nur gesellschaftlich anschlussfähiger. Die Forschung hat den Mythos längst demontiert. Koffein erzeugt ein klinisch relevantes Abhängigkeitssyndrom, das die WHO als Störung anerkennt.²⁸ Die neurobiologischen Kriterien sind identisch mit Alkohol- oder Nikotinsucht. Toleranz, Entzug, Kontrollverlust, fortgesetzter Konsum trotz Schaden.

Koffein wirkt über dieselben Belohnungspfade im Gehirn wie Kokain, Morphin und Amphetamin. Es löst Dopamin im Nucleus accumbens aus, dem Zentrum für Belohnung, Motivation und Sucht.²⁹ Die neuroanatomische Übereinstimmung erklärt, warum ich selbst unter Leidensdruck nicht aufhören konnte. Ich habe Nierenschäden. Mein Hausarzt riet mir dringend, Kaffee zu meiden. Ich konnte es nicht.

»Kaffee schützt vor Demenz« ist das pharmakologische Äquivalent zu »Rauchen hält schlank«. Stimmt technisch. Tote

28 Steven E. Meredith, Laura M. Juliano, John R. Hughes, and Roland R. Griffiths, »Caffeine Use Disorder: A Comprehensive Review and Research Agenda«, in: *Journal of Caffeine Research*, Vol. 3, Issue 3, September 2013, 114–30.

29 Die Dopaminfreisetzung erfolgt in der Schale (Shell) des Nucleus accumbens. Dort wirken auch Kokain, Morphin und Amphetamin.

Koffein blockiert Adenosin-Rezeptoren und hebt dadurch indirekt die Dopamin-Bremse auf, während Kokain direkt in den Dopamin-Stoffwechsel eingreift. Das Ergebnis ist das gleiche.

Meredith et al. 2013.

sind auch schlank. Tatsächlich lässt Kaffee genau das Hirnareal schrumpfen, das bei Alzheimer zuerst stirbt.³⁰ Die Rechnung ist nicht kompliziert, nur unbequem.

Koffein passiert die Plazenta. Das Kind trinkt mit. Es kann nur noch nicht protestieren. Weder die Plazenta noch der Fötus verfügen über die Enzyme, um Koffein abzubauen. Während der Körper der Mutter die Substanz verstoffwechselt, ist der Kreislauf des Ungeborenen schutzlos ausgeliefert. Die erste Tasse trinkt die Mutter. Die letzte vergisst sie, wer das Kind war. Die Dosis heißt »moderat«. Die Langzeitfolgen heißen »nicht abschließend erforscht«. Das Kind trägt die Folgen. Vermindertes Wachstum, niedriges Geburtsgewicht, erhöhtes Risiko für Fehlgeburt.³¹

Am 20. Januar 2026 veröffentlichte ich auf *kokos-und-zitrone.de* einen Text über Kaffee. Achtzehn Fußnoten. Eine geschlossene Beweiskette.

Dann ein Kommentar.

Ein Mann schrieb, Koffein habe »laut seinen Infos« positive Wirkung aufs Gehirn. Ob ich »andere Informationen« hätte. Sechs Stunden Abstand zum Schlaf, maximal vier Espresso, meist zwei bis drei. Er hatte Regeln. Er hatte ein System. Er hatte meinen Text nicht gelesen.

30 Yu-Shiuan Lin, Janine Weibel, Hans-Peter Landolt, et al., »Daily Caffeine Intake Induces Concentration-Dependent Medial Temporal Plasticity in Humans: A Multimodal Double-Blind Randomized Controlled Trial«, in: *Cerebral Cortex*, Vol. 31, Issue 6, 10.05.2021, 3096—3106.

Doppelblind, randomisiert, Crossover-Design: zehn Tage Koffein (3 × 150 mg/Tag) bewirken signifikante Volumenreduktion der grauen Substanz im medialen Temporallappen einschließlich des Hippocampus.

31 Heckman et al. 2010; Meredith et al. 2013.

Sechs Stunden Abstand zum Schlaf. Die Lieblingszahl der Kaffeetrinker. Auch Raucher hatten Lieblingsmarken. Das Röntgenbild interessierte sich nicht dafür.

Der Reflex »aber hat doch auch positive Effekte« ist klassisches *motivated reasoning*. Die richtige Dosierung erklärt nicht, warum dieselben Menschen ohne Koffein unterperformen. Was als Wirkung erscheint, ist fast immer Entzugsumkehr. Regeln geben Kontrollgefühl. Sie ändern nicht die Physiologie.

Er wich aus. Plötzlich ging es nicht mehr um Performance, sondern um »langfristige Neuroprotektion«. Demenz, Alzheimer, Parkinson. Die Datenlage sei »eher positiv«, Störfaktoren seien ihm »völlig klar«, er selbst merke »keinen Unterschied«, wenn er keinen Kaffee trinke — was regelmäßig vorkomme, weil er »nur trinke, wenn es ihm schmeckt«. Und was den Schlaf angehe: mit ausreichend Abstand sei ein negativer Effekt »nicht zwangsläufig gegeben — zumindest nicht pauschal für alle«.

Wer von einer Droge abhängig ist, wird blind, sobald er über sie nachdenken soll. Alles, was dieser Mann schrieb, diene dem Zweck, seine Sucht zu rationalisieren. Nicht der Frage, ob sein Konsum schädlich ist.

»Kaffee schützt vor Demenz« ist kein Befund, sondern ein epidemiologischer Mythos, entstanden aus verzerrten Beobachtungsstudien, weitergereicht als Kausalität. Die beste Evidenz (*Mendelian Randomization*) findet keinen neuroprotektiven Effekt. Wenn der Schutz real wäre, müsste er genetisch sichtbar sein. Ist er nicht.³²

32 Kein protektiver Effekt auf kognitive Funktion, MR:

Ang Zhou, Amy E. Taylor, Ville Karhunen, et al., »Habitual coffee consumption and cognitive function: a Mendelian randomization meta-analysis in up to 415,530 participants«, in: *Scientific Reports*, Vol. 8, Issue 1, 14.05.2018, Artikel 7526.

Und der Teil, den die »sechs Stunden vorher«-Religion gern übergeht: Koffein verschlechtert Schlaf objektiv messbar. Auch bei Gewohnheitskonsum. Auch bei sechs Stunden Abstand. Nicht gefühlt, gemessen.³³ Schlaf ist keine Wellness-Idee. Schlaf ist Reparatur. Fragmentierter Tiefschlaf ist mit Demenzrisiko assoziiert. »Neuroprotektion« ist ein Mechanismus-Claim. Adenosinblockade ist kein Schutz, sondern akute Stimulation. Langfristig kommt Toleranz: mehr Rezeptoren, mehr Schlafdruck, mehr Fragmentierung. Systemstress, nicht Hirnrettung.³⁴

Dann löschte er seine Kommentare. Dann blockte er mich. Wer die Realität nicht widerlegen kann, läuft weg. So macht das ein süchtiges Gehirn, wenn man ihm die Ausflucht nimmt. Ich bedrohte sein Weltbild. Also musste ich verschwinden.

Seit Jahrzehnten verkauft die Industrie dieses dümmliche Märchen, Kaffee wirke neuroprotektiv. Die Hirnforschung und genetische Kausalitätsstudien lassen dieses Kartenhaus zusammenbrechen.

Kaffee lässt das Gedächtniszentrum schrumpfen. Lin, Reichert und Kollegen zeigen, dass täglicher Koffeinkonsum — ähnlich wie bei Nikotin³⁵ — sichtbare Volumenverluste der grauen

Konstance Nicolopoulos, Anwar Mulugeta, Ang Zhou, Elina Hyppönen, »Association between habitual coffee consumption and multiple disease outcomes: A Mendelian randomisation phenome-wide association study in the UK Biobank«, in: *Clinical Nutrition*, Vol. 39, Issue 11, 3467—76.

33 Drake et al. 2013 — auch sechs Std. vorher signifikant weniger Schlaf.

Gardiner et al. 2023 — geringere Schlaffeffizienz, weniger Schlaf, schlechtere Architektur.

34 Rogers 2014; Rogers et al. 2012; Addicott-Laurienti 2009.

35 Dass Nikotin vergleichbare Hirnschäden verursacht, ist durch Kohortenstudien und genetische Kausalitätsanalysen belegt.

S. Karama, S. Ducharme, J. Corley, et al., »Cigarette smoking and thinning of the brain's cortex«, in: *Molecular Psychiatry*, Vol. 20, Issue 6, 10.02.2015, 778—85.

Substanz im Hippocampus bewirkt.³⁶ Eine MR-Studie mit über 33.000 Teilnehmern bestätigt den kausalen Zusammenhang auf Populationsebene.³⁷ Park und Kollegen zeigen, dass lebenslanger Kaffee Konsum bei älteren Menschen mit erhöhtem Volumen weißer Substanzläsionen assoziiert ist.³⁸ Der Hippocampus ist das erste Areal, das bei Alzheimer abstirbt. Ein verkleinerter Hippocampus ist ein zentraler Risikomarker für Demenz.

Larsson und Orsini fanden zudem Hinweise, dass ein höherer Koffeinstoffwechsel die exekutive Leistung verschlechtert. Der Schwindel, Kaffee schütze vor Demenz, ist damit wissenschaftlich entkräftet.³⁹

Dann senkt Koffein den Blutfluss im Gehirn, und zwar um dreißig Prozent.⁴⁰

Yoonhoo Chang, Vera Thornton, Ariya Chaloeitong, et al., »Investigating the Relationship Between Smoking Behavior and Global Brain Volume«, in: *Biological Psychiatry: Global Open Science*, Vol. 4, Issue 1, 06.10.2023, 74–82.
Wenjuan Lin, Lisheng Zhu, Yunlong Lu, »Association of smoking with brain gray and white matter volume: a Mendelian randomization study«, in: *Neurological Sciences*, Vol. 44, Issue 11, November 2023, 4049–55.

36 Lin et al. 2021.

37 Bing-Kun Zheng, Peng-Peng Niu, »Higher Coffee Consumption Is Associated With Reduced Cerebral Gray Matter Volume: A Mendelian Randomization Study«, in: *Frontiers in Nutrition*, Vol. 9, 17.03.2022, Artikel 850004.

38 Jeongbin Park, Ji Won Han, Ju Ri Lee, et al., »Association between lifetime coffee consumption and late life cerebral white matter hyperintensities in cognitively normal elderly individuals«, in: *Scientific Reports*, Vol. 10, Issue 1, 16.01.2020, Artikel 421.

39 Susanna C. Larsson, Nicola Orsini, »Coffee Consumption and Risk of Dementia and Alzheimer's Disease: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies«, in: *Nutrients*, Vol. 10, Issue 10, 14.10.2018, Artikel 1501.

40 $\approx 30\%$ nach ~ 250 mg, gemessen per PET. Oliver G. Cameron, Jack G. Modell, M. Hariharan, »Caffeine and human cerebral blood flow: A positron emission tomography study«, in: *Life Sciences*, Vol. 47, Issue 13, 1990, 1141–6.

Der entscheidende Faktor aber ist Schlaf. Bei Alzheimer-Patienten sammeln sich neurotoxische Abfallprodukte an. Beta-Amyloid, Tau, zellulärer Müll. Ausgespült werden sie ausschließlich im Tiefschlaf (glymphatisches System).⁴¹ Das Gehirn benötigt Tiefschlaf, um sich vor Alzheimer zu schützen.

Koffein verhindert Tiefschlaf.

Shokri-Kojori und Kollegen zeigten, dass schon eine Nacht Schlafentzug die Toxin-Last im Gehirn signifikant erhöht.⁴² Da Kaffeetrinker chronisch schlechteren Tiefschlaf haben⁴³, führt der Konsum logisch zwingend zur Ansammlung von Demenz-Auslösern. Wer sich wach hält, hält den Müll im Kopf.

Aber der Kaffee schmeckt ja so gut.

Dieser Mann, der sich aus der Debatte löschte, verteidigte sein Selbstbild, nicht seine These. Er hat Kaffee einen Platz im Alltag gegeben, Regeln entwickelt, die Kontrolle vorgaukeln, und eine zurechtgelegte Überzeugung: *Meine Substanz ist okay, weil ich sie vernünftig nutze*. Mein Text zerstörte seine Konstruktion. Ihn zu lesen hätte existenzielle Kosten für ihn gehabt. Er müsste handeln, nicht argumentieren. Gehirne sind exzellent darin, Veränderung zu blockieren. Also überfliegt er meinen Text, greift ein vertrautes Muster und insinuiert Zweifel: *Hast du andere Infos?*

41 Bestätigt in einer randomisierten Crossover-Studie am Menschen: Schlaf steigert die glymphatische Clearance von Amyloid-Beta und Tau ins Plasma, Schlafentzug reduziert diesen Prozess signifikant.

Paul Dagum, Donald L. Elbert, Laurent Giovannardi, et al., »The glymphatic system clears amyloid beta and tau from brain to plasma in humans«, in: *Nature Communications*, Vol. 17, 27.01.2026, Artikel 715.

42 Ehsan Shokri-Kojori, Gene-Jack Wang, Corinde E. Wiers, et al., » β -Amyloid accumulation in the human brain after one night of sleep deprivation«, in: *PNAS*, Vol. 115, Issue 17, 24.04.2018, 4483–8.

43 Drake et al. 2013; Gardiner et al. 2023.

Das ist kein Erkenntnisinteresse, sondern Fluchtreflex. Er will das Gespräch zurück in vertrautes Terrain ziehen.

Der *Bias* nervt, denn ich habe keine Meinung dargelegt, sondern eine geschlossene Beweiskette. Dieser Mann reagiert, als wäre Biologie verhandelbar. Ich habe gerade die Statik des Gebäudes erklärt, und er fragt, ob Holz auch stabil sein kann. Wer nach achtzehn Fußnoten noch fragt, ob ich andere Infos habe, sucht keine Wahrheit. Er sucht Beruhigung.

Ich bin nicht hier, um Süchtige zu beruhigen.

Wer süchtig ist, debattiert nicht. Ein Hirn auf Koffein verteidigt nicht die Wahrheit. Es handelt Nachschub. Kritik an der Substanz wird vom Gehirn wie ein Angriff auf die eigene Integrität gewertet. Fakten, die den Konsum infrage stellen, prallen ab oder erzeugen Aggression. *Anosognosie* nennt man das in der Forschung: das krankhafte Unvermögen, die eigene Störung und ihre Konsequenzen realistisch einzuschätzen. Das Gehirn filtert Informationen so, dass der Konsum logisch erscheint. Gegenteilige Beweise werden ausgeblendet. Wenn er die *kognitive Dissonanz* nicht aushält, bricht er den Dialog ab. Sein Löschen der Kommentare war die digitale Form von Hände auf die Ohren halten und laut singen. Um das interne Gleichgewicht (die Sucht) zu retten, musste er den externen Störfaktor eliminieren (mich und die Fakten). Keine Sucht überlebt den Kontakt mit der Wahrheit. Sie brennt wie Weihwasser.

Goldstein und Kollegen wiesen nach, wie die Krankheitseinsicht bei Süchtigen hirnorganisch gestört ist (*Impaired Insight*). Jene Hirnareale, die für Selbstwahrnehmung (*Insight*) zuständig sind (Insula, ACC), sind bei Sucht entkoppelt. Der Süchtige *kann* nicht sehen, dass er ein Problem hat, und konstruiert stattdessen rationalisierende Scheinwelten, um die Diskrepanz zwischen Realität und Suchtverhalten aufzulösen. Er konstruiert

rationalisierende Scheinwelten, um die Kluft zwischen Realität und Verhalten aufzulösen — selbst wenn er das gar nicht will.⁴⁴

Sucht ist keine Charakterschwäche. Kein fehlender Wille. Kein Versagen. Weil Charakter, Wille, Selbstsein in der Sucht nicht verfügbar sind. Der präfrontale Kortex — Sitz der Ich-Kontrolle — ist bei Süchtigen vom Rest des Gehirns abgekoppelt. Wille ist physikalisch nicht abrufbar. Die Leitung ist erodiert.⁴⁵
Ich ist ein anderer.

Süchtiges Fühlen und Denken ist ein geschlossenes Rückkopplungssystem. Das Gefühl ist nicht neutral. Ich laufe nicht im Kreis, weil ich dumm wäre, sondern weil der Kreis chemisch stabilisiert ist.⁴⁶

Der Mann, der mich blockte, hat keine Debatte verloren. Er hat ein Fenster zugemauert. Es verteidigte den Nachschub gegen die Wahrheit.

Wie jedes Suchtmittel, verändert Kaffee die Persönlichkeit grundlegend. Kaffee ist Treibstoff für eine soziale Maske. Statt mich zu zeigen, spiele ich eine Rolle. Eine schwarze, glatte Wand entsteht, an der echte Gefühle abprallen. Ich spüre mich und andere nicht mehr. Ich bewerte andere, verwandle mich in einen

44 Rita Z. Goldstein, A. D. (Bud) Craig, Antoine Bechara, et al., »The Neurocircuitry of Impaired Insight in Drug Addiction«, in: *Trends in Cognitive Sciences*, Vol. 13, Issue 9, September 2009, 372—80.

45 Rita Z. Goldstein, Nora D. Volkow, »Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications«, in: *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 12, 20.10.2011, 652—69.

46 Der Körper stabilisiert sich auf einem neuen Level, auf dem die Droge nötig ist, um sich normal zu fühlen (*Allostase*).

George F. Koob, Michel Le Moal, »Drug Addiction, Dysregulation of Reward, and Allostasis«, in: *Neuropsychopharmacology*, 01.02.2001, Vol. 24, Issue 2, 97—129.

Sortierer. Koffein erhöht dosisabhängig die Werte für Feindseligkeit und Angst.⁴⁷

Wer unter Strom steht, sieht im Gegenüber keinen Menschen, sondern einen Reiz, der bewältigt werden muss. Begegnung wird schwer. Plauderei funktioniert, Tiefe nicht. Ich fühle mich wichtig, aber aufgeblasen. Eine polierte Fassade, während die Substanz angegriffen wird. Der Körper interpretiert soziale Situationen unter Koffein als Bedrohung, das Herz hämmert, die Stressantwort schießt hoch.⁴⁸ In diesem Zustand ist Empathie biologisch unmöglich, nur noch Bewertung.

Das erste Opfer ist die Konzentration. Ich kann nicht bei einer Sache bleiben. Ich verzettele mich, werde sprunghaft. Ich reagiere schneller, urteile schlechter.⁴⁹

Gleichzeitig blockiert Koffein die Nährstoffaufnahme. Eine Tasse Kaffee zum Essen reduziert Eisenaufnahme um rund vierzig Prozent, starker Kaffee um bis zu neunzig Prozent.⁵⁰ Koffein

47 Koffein erhöht messbar Feindseligkeit (*Hostility*) und Angst.

Dennis M. Veleber, Donald I. Templer, »Effects of caffeine on anxiety and depression«, in: *Journal of Abnormal Psychology*, Vol. 93, Issue 1, Februar 1984, 120—22.

48 Koffein verstärkt massiv die kardiovaskuläre Stressreaktion bei sozialen Interaktionen. Der Körper schaltet in Abwehrmodus.

James D. Lane, Robert A. Adcock, Redford B. Williams, Cynthia M. Kuhn, »Caffeine effects on cardiovascular and neuroendocrine responses to acute psychosocial stress and their relationship to level of habitual caffeine consumption«, in: *Psychosomatic Medicine*, Vol. 52, Issue 3, Mai 1990, 320—36.

49 Koffein beschleunigt Reaktionszeit, verbessert aber nicht die Genauigkeit (*Speed-Accuracy Trade-off*). Rogers et al. 2012.

50 T. A. Morck, S. R. Lynch, J. D. Cook, »Inhibition of food iron absorption by coffee«, in: *The American Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 37, Issue 3, März 1983, 416—20.

entzieht dem Körper die Basis für Hämoglobin-Produktion und Sauerstofftransport.

Kaffee schaltet die Sirene aus. Ich lebe wie auf Zehenspitzen. Danach falle ich unter Null. Ich werde schläfriger, griesgrämiger, stumpfer. Um wieder auf Null zu kommen, greife ich zum Kaffee. Geliehene Energie zum Wucherzins.⁵¹

Nur ein Kaffee und sonst nichts ist die Lüge, die alles zusammenhält. Ich betrachte Müdigkeit als Feind, den ich bekämpfen muss. Reparatur ist unbequem, weil sie Geschwindigkeit kostet. Also überschütte ich sie mit Kaffee und nehme mir die Möglichkeit, aus der Schleife auszusteigen.

Der Punkt, an dem sich die Schleife öffnet, liegt nicht in der Willenskraft. Mein Wille als Süchtiger ist ja gerade das, was ich *nicht* will. *Ich will meinen Willen nicht wollen*, weil er aus falschem Denken und Fühlen erwächst. Die Schleife öffnet sich, wo ich die Müdigkeit nicht mehr bekämpfe. Müdigkeit zu bekämpfen ist der Schalter, der meinen Körper zu Notlösungen zwingt, und diese sind immer zerstörerisch. Entweder ich akzeptiere das vorübergehende Leistungsdefizit, oder ich sabotiere mich so lange, bis ich zu gar nichts mehr zu gebrauchen bin. Beides geht nicht.

Der Körper heilt nicht unter Druck. Es gibt keinen gesunden Kaffeekonsum, ebenso wenig wie eine gesunde Untergrenze für Alkohol oder Nikotin. Das ist nur das kulturelle Narrativ, die mir das Gegenteil verkaufen will, während mein Körper schon nach einer Tasse zu schreien anfängt. Selbst moderater Konsum

51 Um es nochmal zu sagen: Koffein hebt die Stimmung nicht über Normalwert, sondern beseitigt nur die Entzugssymptome der letzten Dosis.

Jack E. James, Michael A. Keane, »Caffeine, sleep and wakefulness: implications of new understanding about withdrawal reversal«, in: *Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental*, Vol. 22, Issue 8, Dezember 2007, 549–58.

verengt die Blutgefäße im Gehirn massiv. Was Leute als Wachheit empfinden, ist meist nur die physiologische Reaktion auf eine gedrosselte Sauerstoffzufuhr.⁵²

Koffein über grünen Tee zuzuführen, ist derselbe Selbstbetrug in grün. Dem Adenosin-Rezeptor ist die Farbe des Getränks egal. Das Molekül bleibt identisch.⁵³ Polyphenole neben Koffein machen es nicht gesünder, genauso wenig wie Polyphenole im Rotwein den Alkohol neutralisieren.

Müdigkeit ist nicht der Gegner. Sie ist der Preis der Reparatur, Eintrittskarte zu Wachheit ohne Koffein. Ich kann sie nicht löschen ohne Schaden. Müdigkeit ohne Kaffee ist ein biologisches Stoppsignal. Der Organismus signalisiert Reparaturbedarf. Kaffee antwortet darauf mit Körper selbstverachtung und sagt: *Funktionier weiter*.

Kaffee hält das System im Alarmzustand. Alarm macht Essanfälle. Essanfälle machen Entzündungen. Entzündungen machen Müdigkeit. Müdigkeit verlangt Kaffee. Raus komme ich nicht durch Stärke, sondern durch Struktur. *Kein Entscheiden, keine Verhandlungen mit dem Sucht-Ich*. Heilung beginnt jenseits des Denkens. Während des Entzugs darf ich nicht entscheiden.

52 Koffein reduziert zerebrale Durchblutung um 27 Prozent. Das ist massive Vasokonstriktion. Bei chronisch hohem Konsum zeigt sich eine eingeschränkte Kompensationsfähigkeit des Gefäßsystems. Es gibt keine sichere Untergrenze.

Merideth A. Addicott, Lucie L. Yang, Ann M. Peiffer, et al., »The effect of daily caffeine use on cerebral blood flow: How much caffeine can we tolerate?«, in: *Human Brain Mapping*, Vol. 30, Issue 10, 13.02.2009, 3102–14.

53 Koffein wirkt durch Blockade von Adenosin-Rezeptoren. Die chemische Struktur ist identisch, unabhängig von der Quelle (Kaffee, Tee, Guarana). Bertil B. Fredholm, Karl Bättig, Janet Holmén, et al., »Actions of Caffeine in the Brain with Special Reference to Factors That Contribute to Its Widespread Use«, in: *Pharmacological Reviews*, Vol. 51, Issue 1, März 1999, 83–133.

Das bedeutet immer Eskalation. Alles, was geht, vorbereiten, vereinfachen, automatisieren. Nicht erklären, nicht grübeln.⁵⁴

Wachheit kann man erzwingen, Ruhe muss man ertragen. Der Übergang fühlt sich nach Kontrollverlust an. In Wahrheit ist er Kontrolle. Heilung und Antreiben schließen sich aus. Loslassen und Funktionieren auch. Echte Energie kommt leise zurück. Langsam ist der Preis für dauerhaft. Dieser Preis ist endlich. Die Schleife ist es nicht.

Du kannst jederzeit aufhören.

Oder weiterleben, als wärst du schon fertig.

54 Feste Wenn-Dann-Pläne delegieren Verhaltenskontrolle an die Umwelt und entlasten bewusste Entscheidungsprozesse. Automatisierung umgeht Verhandlung.

Peter M. Gollwitzer, »Implementation intentions: Strong effects of simple plans«, in: *American Psychologist*, Vol. 54, Issue 7, Juli 1999, 493—503.

PERSÖNLICHKEIT IST LÖSLICH

Nicht alles, was sich wahr anfühlt, ist Gegenwart.

Vieles ist nur gut eintrainierte Vergangenheit.

Nikotin schreibt eine Leiche. Die Leiche läuft noch. Dreißig Mal am Tag dockt die Substanz an nikotinische Acetylcholinrezeptoren, löst Dopamin aus, erzeugt eine Mini-belohnung, die so kurz ist, dass sie schon beim Ausatmen verfällt. Was bleibt, ist der nächste Hunger. Ein Belohnungssystem, das nie ankommt. Ein Gehirn, das seine eigene Stille nicht aushält und deshalb permanent den Kontext wechselt, permanent reagiert, permanent nach dem nächsten Reiz greift. Von außen sieht das aus wie Lebendigkeit. Energie. Kreativität sogar. Von innen ist es ein Organismus, der sich selbst verbrennt, um die Unruhe zu stillen, die er selbst erzeugt. Die Hülle funktioniert. Die Hülle plant, spricht, arbeitet, erscheint pünktlich. Was sie antreibt, ist kein Wille, nur die Reparatur eines Schadens, den die Substanz selbst anrichtet. Die Leiche läuft, weil sie nicht weiß, dass sie tot ist.

Niemand hört gern, dass er jahrelang nicht er selbst war. Dass der Charakter, den man sich zugeschrieben hat, eine Nebenwirkung war. Dass die Identität, an der man hängt, ein pharmakologisches Artefakt ist, das nach Teer riecht und nach Ausrede schmeckt. Der Irrtum ist zu glauben, man kenne sich selbst, während eine brennende Pflanze die Drehbücher schreibt.

Ich habe sieben Jahre lang geraucht und in diesen sieben Jahren nahezu nichts zu Ende gebracht. Drei Jahre schrieb ich an einem Buch über die ökologischen Bedingungen weltweiter

Epidemien. Dreibändig. Über zweitausend Seiten.¹ 2022 hätte es erscheinen sollen. Ich brach bei fünfundneunzig Prozent ab. Bücher angefangen, Projekte aufgesetzt, Strukturen gebaut. Ich sah aus wie jemand, der arbeitet. Was fehlte, war das Ergebnis.

Fünfundneunzig. Und dann Abbruch. Wie jemand, der ein Kind achtzehn Jahre lang großzieht und es am Tag vor der Volljährigkeit aussetzt. Irgendwas kam immer dazwischen. Ein neuer Gedanke, eine andere Dringlichkeit. Das Gefühl, dass das hier nicht das Richtige ist. So vergingen Jahre, in denen ich an Büchern schrieb, die niemand las, weil sie niemand lesen konnte, weil sie nicht fertig waren. An Projekten arbeitete, die nie die Oberfläche erreichten. An Ideen, die verrotteten, während ich die nächste verfolgte.

Ich dachte, es läge an meinem Charakter. Vielleicht eine Neurose, vielleicht Prokrastination, vielleicht irgendeine Persönlichkeitsstörung, für die es einen Namen im ICD-11 gibt, den ich nicht kannte. Oder ich wäre einfach »neurodivers«, wie man heute sagt, als würde man Herzinfarkt und erhöhten Ruhezugs unter »kardiodivers« zusammenfassen und beiden dieselbe Selbsthilfegruppe anbieten.² Die Erklärung war immer psychologisch. Oder moralisch. *Ich bin halt so.*

Eine Ausrede.

Das andere Symptom war subtiler und deshalb gefährlicher. Sieben Jahre lang konnte ich nicht unterscheiden, was wichtig ist. Intellektuell konnte ich Prioritätenlisten schreiben. Aber sie hatten kein Gewicht. Nebensächlichkeiten fraßen Stunden. Ein Satz von jemand anderem, und ich war weg. Wehrlos gegen jeden Einwurf von außen. Signal und Rauschen waren nicht zu

1 Substack: [Link zur Bücherseite](#)

2 Die freundlichste Form der humanen Verwahrlosung: Man diagnostiziert nicht mehr, man inkludiert. Und wer inkludiert ist, braucht keine Hilfe — nur Akzeptanz. Inklusion als Sparmaßnahme.

trennen. Mein Mitbewohner hätte im Nebenzimmer ersticken können, und mein Gehirn hätte es für genauso dringend gehalten wie die Espressomaschine, die fertig ist. Aber Wichtigkeit spürt man eher, als dass man sie denkt. Bei mir: nichts. Irgendwas fehlte. Interozeption, *Felt Sense*, das Kompass-Ding. Und ich hielt es für einen Charakterfehler. Unreife. Etwas, das in mir nicht richtig verdrahtet war.

Und dann habe ich aufgehört zu rauchen.

Zwei Dinge passierten, die ich nicht erwartet hatte. Nicht die offensichtlichen — mehr Luft, mehr Energie, wieder Sport.

Meine Projekte gingen auf einmal zu Ende.

Nicht, weil ich disziplinierter wurde. Nicht, weil ich ein Buch über Produktivität gelesen hätte, einen Coach engagiert oder andere kostenpflichtige Ausreden gekauft. Nichts hatte sich verändert. Kein neues Wissen, kein neues Ereignis. Alles exakt wie vorher. Nur diese eine Sache: Ich rauchte nicht mehr. Und plötzlich liefen zehn Projekte gleichzeitig, chaotisch wie immer, und jedes einzelne bewegte sich auf sein Ende zu. Wurde fertig. Ging nach draußen. Wurde Wirklichkeit. Ich begann, die unfertigen Bücher anzugehen. Dasselbe Chaos in produktiv.

Und dann das Seltsame. Ich spürte plötzlich, was wichtig ist.

Signal und Rauschen waren getrennt. Ich konnte Nein sagen zu Dingen, die ich mochte. Prioritäten setzen als körperliche Selbstverständlichkeit. Als hätte jemand das Licht angemacht in einem Raum, in dem ich sieben Jahre gegen Wände gelaufen war und dachte, das gehört zum Leben. Als wäre etwas gestorben, das ich für mich gehalten hatte.

Dafür hatte ich nichts getan, außer aufzuhören.

Nikotin ist kein Beruhigungsmittel, sondern ein Taktgeber. Es dockt an nikotinische Acetylcholinrezeptoren an und löst

Dopaminausschüttung im Belohnungssystem aus.³ Ich habe mein Gehirn über sieben Jahre auf folgenden Zyklus trainiert: Reiz, Minibelohnung, kurze Fokussierung, Dopaminabfall, innere Unruhe, Reizsuche. Das erzeugt ein Arbeitsmuster, das sich anfühlt wie Persönlichkeit, aber keine ist. Hohe Anfangsenergie, schnelle Aktivierung, dann irgendwann um die neunzig Prozent ein Abfall. Ein leises Kippen, das sich anfühlt wie Interessenverlust. In Wirklichkeit ist es Dopaminökonomie. Das System will seine nächste Mikrobewohnung. Und der einfachste Weg dahin war sieben Jahre lang die Zigarette.

Zweitausend Seiten, mit Tinte auf Papier geschrieben, drei Jahre lang, jeder Satz von Hand. Und irgendwann wurde die Tinte farblos. Gleichzeitig fing etwas anderes an zu leuchten. Eine Idee, eine Aufgabe, irgendetwas, das glitzerte, das einen Appetit erzeugte, der sich anfühlte wie Dringlichkeit, aber keine war. Mein Blick drehte sich, ohne dass ich es entschied. Von außen änderte sich nichts. Ich saß noch da, ich schrieb noch. Nur nicht mehr am Richtigen.

Feinschliff ist dopaminarm. Ein Gehirn, das an rhythmische Impulse gewöhnt ist, wechselt den Kontext, bevor es dort ankommt. Ich habe nicht versagt. Das neuronale Kosten-Nutzen-Verhältnis war gekippt.

Nikotin wirkt kurzfristig fokussierend.⁴ Das ist der Trick, und er ist perfide. Raucher denken, sie denken besser mit Zigarette. Kurzfristig stimmt das. Mittelfristig verschiebt Nikotin die Grundstimmung. Der Alltag eines Rauchers ist ein ständiges

3 Jian Jiang, Xia Li, An-fu Hu, et al., »Nicotine and neuronal nicotinic acetylcholine receptors: unraveling the mechanisms of nicotine addiction«, in: *Frontiers in Neuroscience*, Vol. 19, 17.10.2025, 1670883.

4 Stephen J. Heishman, Bethea A. Kleykamp, Edward G. Singleton, »Meta-analysis of the acute effects of nicotine and smoking on human performance«, in: *Psychopharmacology*, Vol. 210, Issue 4, Juli 2010, 453–69.

Pendeln zwischen leichtem Entzug, Stimulation, kurzer Stabilisierung und erneuter Dysbalance.⁵ Das erzeugt genau das Muster, das ich sieben Jahre lang für meinen Charakter hielt. Wenn das Gehirn permanent mikroreguliert, bleibt für Priorisierung nicht genug Kapazität.

Interozeption braucht Ruhe. Signal braucht Kontrast. Und Rauchen erzeugt permanenten Mikrolärm.

Erst als der Taktgeber verstummte, wurde der Raum hörbar. Zuerst kam Chaos. Entzug, Reizbarkeit, das übliche neurologische Aufräumen. Aber dann kalibrierte sich das System neu. Die Grundlinie wurde still. Sieben Jahre lang hatte ich in derselben Welt gelebt und auf eine andere reagiert. Signale als Hintergrundrauschen, Rauschen als Signal. Und dann, auf ruhiger Grundlinie, bekamen die Schemen Kontur. Körper, Farbe, Gewicht. Zum ersten Mal seit sieben Jahren hatte das Kompass-Ding wieder eine Nadel.

Früher hatte mir jemand gesagt, als Raucher könne man nichts erreichen im Leben. Ich hielt das für einen dümmlichen Satz. Stammtischstatistik.

5 Chronische Nikotinexposition senkt den basalen Dopaminspiegel im Nucleus accumbens. Nach Entzug ist die Dopamin-Baseline reduziert, gleichzeitig wird die phasische Reaktion auf erneute Nikotingabe verstärkt.

Lifen Zhang, Yu Dong, William M. Doyon, John A. Dani, »Withdrawal from chronic nicotine exposure alters dopamine signaling dynamics in the nucleus accumbens«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 71, Issue 3, 01.02.2012, 184—91.

Akute Nikotinexposition aktiviert phasisches Burst-Feuern (D₁-vermittelt), chronischer Entzug reduziert das tonische Feuern (D₂-vermittelt).

Taryn E. Grieder, Olivier George, Huibing Tan, et al., »Phasic D₁ and tonic D₂ dopamine receptor signaling double dissociate the motivational effects of acute nicotine and chronic nicotine withdrawal«, in: *PNAS*, Vol. 109, Issue 8, 21.02.2012, 3101—6.

Natürlich gibt es berühmte Raucher. Einflussreiche, produktive, brillante Raucher. Rauchen macht nicht automatisch unfähig. Aber die Kosten beweist es nicht weg. Man sieht bei berühmten Menschen nur das Ergebnis. Nicht das Verbluten nach innen. Man sieht das Buch, nicht die fünf abgebrochenen davor. Und viele dieser berühmten Raucher hatten etwas, das die meisten Menschen nicht haben: Teams, Deadlines, Redakteure, Produktionszwänge, externe Struktur, die kompensiert, was intern leckt. — Oder sie wurden berühmt, *bevor* die Rechnung kam.

Rauchen verschlechtert das Verhältnis von Aufwand zu Output.⁶ Viel Aktivität, wenig Fertigstellung. Mehr Kontextwechsel, schlechtere Prioritätenspur. Die Gehirnsysteme, die dafür sorgen, dass man bei der Sache bleibt, werden beim Rauchen belastet.⁷ Die Kapazität, die das Rauchen frisst, fehlt genau dort, wo Fertigstellung passiert: im langweiligen, dopaminarmen Endstück.

Die Forschung hat einen Namen dafür: *Task Persistence*.⁸ Die Fähigkeit, an etwas dranzubleiben, auch wenn es aufgehört hat,

6 Bei chronischen Rauchern sind Aufmerksamkeit und Gedächtnis signifikant beeinträchtigt. Zudem zeigen Raucher höhere kognitive Impulsivität (gemessen als reduzierte Fähigkeit zum Belohnungsaufschub).

A. A. Conti, L. McLean, S. Tolomeo, et al., »Chronic tobacco smoking and neuropsychological impairments: A systematic review and meta-analysis«, in: *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, Vol. 96, Januar 2019, 143—54.

Timothy C. Durazzo, Dieter J. Meyerhoff, Sara Jo Nixon, »Chronic Cigarette Smoking: Implications for Neurocognition and Brain Neurobiology«, in: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 7, Issue 10, 21.10.2010, 3760—91.

7 Natalia A. Goriounova, Huibert D. Mansvelder, »Short- and Long-Term Consequences of Nicotine Exposure during Adolescence for Prefrontal Cortex Neuronal Network Function«, in: *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, Vol. 2, Issue 12, Dezember 2012, a012120.

8 Marc L. Steinberg, Jill M. Williams, Kunal K. Gandhi, et al., »Task Persistence Predicts Smoking Cessation in Smokers with and without Schizo-

sich gut anzu fühlen. Genau das hat bei mir sieben Jahre lang nicht funktioniert. Mein System verbrannte die nötigen Ressourcen anderweitig. Sieben Jahre lang hat mein Körper gearbeitet, während ich zuge sehen habe.

Ich war die ganze Zeit da. Nur nicht ich.

Wer bis hierhin gelesen hat, kennt die Befundlage. Nikotin erhöht das Demenzrisiko, degradiert die Konnektivität zwischen Hirnarealen und legt das Default-Mode-Netzwerk lahm. Die Forschungslage ist eindeutig.⁹

Das Silicon Valley verkauft Nikotin jetzt als Nootropikum.¹⁰ Pflaster gegen Alzheimer, Kaugummis für Konzentration, Pouches als kognitives Upgrade. Eine Substanz, die Demenz beschleunigt, als Demenzprävention. Von einer Szene, die ihre Schlafzyklen auf die Minute trackt, ihr Blut vierteljährlich analysieren lässt und sich für die kognitive Speerspitze der Spezies hält.

phrenia«, in: *Psychology of Addictive Behaviors*, Vol. 26, Issue 4, 28.05.2012, 850—8.

Rebecca L. Ashare, Mary Falcone, Caryn Lerman, »Cognitive Function During Nicotine Withdrawal: Implications for Nicotine Dependence Treatment«, in: *Neuropharmacology*, Vol. 76, Part B, Januar 2014, 581—91.

9 Guochao Zhong, Yi Wang, Yong Zhang, et al., »Smoking Is Associated with an Increased Risk of Dementia: A Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies with Investigation of Potential Effect Modifiers«, in: *PLOS ONE*, Vol. 10, Issue 3, 12.03.2015, e0118333.

Sarah W. Yip, Sarah D. Lichenstein, Kathleen Garrison, et al., »Effects of Smoking Status and State on Intrinsic Connectivity«, in: *Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging*, Vol. 7, Issue 9, September 2022, 895—904.

10 Priya Anand, »Zyn, nicotine pouches gain traction with office workers«, in: *Mercury News [Bloomberg]*, 01.02.2024.

Das ist nicht neu. 1929 enthielt das Originalrezept von 7-Up Lithiumcitrat. Stimmungsaufheller als Limonade, für die ganze Familie. Man hat es irgendwann rausgenommen.¹¹

Die Römer süßten ihren Wein mit Bleizucker. Es schmeckte hervorragend. Es vergiftete die Oberschicht, kumulativ, irreversibel.¹² Zweitausend Jahre später süßt die Tech-Branche ihre Kognition mit Nikotin. Es schmeckt nach Leistung, nach Vorsprung, nach Kontrolle. Was kumuliert, ist keins davon. Die Römer wussten es nicht. Die Biohacker könnten es wissen.

Sie wollen nur nicht.

1949 bekam Egas Moniz den Nobelpreis für die Lobotomie. Sein Kollege Walter Freeman fuhr danach mit einem Van durch die USA und trieb Patienten einen Eispickel durch die Augenhöhle. Zwanzig Minuten, ambulant, revolutionär. Zehntausende wurden lobotomiert. Die Fachwelt applaudierte. Heute schieben sich dieselben Leute, die raffiniertem Zucker abschwören, weil er Entzündungswerte erhöht, ein Nervengift zwischen Oberlippe und Zahnfleisch und nennen es Protokoll.¹³

Freeman war wenigstens so ehrlich, seinen Eispickel Eispickel zu nennen.

Aber nehmen wir für einen Moment an, sie hätten recht.

Die Datenlage für kurzfristige Effekte existiert. Nikotin kann Aufmerksamkeit und Arbeitsgedächtnis pushen.

11 Kam 1929 unter dem Namen *Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda* mit Lithiumcitrat auf den Markt. 1948 verbot die FDA Lithiumcitrat in Softdrinks. Ada McVean, »7 Up: Originally an Antidepressant«, in: *McGill University, Office for Science and Society*, 17.06.2017.

12 Josef Eisinger, »Lead and wine. Eberhard Gockel and the colica Pictonum«, in: *Medical History*, Vol. 26, Juli 1982, 279—302.

13 George A. Mashour, Erin E. Walker, Robert L. Martuza, »Psychosurgery: past, present, and future«, in: *Brain Research Reviews*, Vol. 48, Issue 3, Juni 2005, 409—19.

Kurzfristig. In Einzeldosen. Bei Nichtraucher.¹⁴

Bei chronischem Gebrauch verschwindet der Effekt.¹⁵ Was bleibt, ist ein Gehirn, das Nikotin braucht, um dort anzu- kommen, wo ein Nichtraucher morgens nach dem Aufstehen ist. Man nimmt eine Substanz, um so zu funktionieren, wie man ohne sie funktioniert hätte. Zinsen auf einen Kredit, den man nie erhalten hat.

Die Folgen sind messbar. Arbeitszyklen, die an der Substanz hängen. Kontextwechsel als Reflex. Motivation, die nur noch von außen kommt. Raucher arbeiten gegen ihr Belohnungs- system und verlieren. Schleichend, über Jahre, bis sie das Mus- ter für sich selbst halten.

Der Mechanismus ist immer derselbe. Nikotin dockt an, Dopamin schießt ein, und für zwanzig Minuten fühlt sich alles schärfer, klarer, dringlicher an. Das Gehirn hält es für Wahr- heit. Es ist keine. Es ist derselbe Trick, der mich sieben Jahre lang bei neunzig Prozent hat abbrechen lassen. Dieselbe Substanz, die meine Tinte farblos machte und Nebensächlichkeiten zum Leuchten brachte, verkauft diesen Leuten das Gefühl, sie hätten gerade einen kognitiven Durchbruch. Die Gedanken fühlen sich bedeutend an, weil Dopamin Bedeutung simuliert. Das Urteil fühlt sich klar an, weil Nikotin Klarheit simuliert. Nicht Realit- tät spricht. Die Droge spricht und klingt dabei wie der eigene Verstand. Wer das nicht durchschaut, verwechselt sein neuro- chemisches Rauschen mit Erkenntnis. Und wer es mit Erkenntnis verwechselt, macht ein Evangelium daraus. Dann missioniert er. Empfiehlt Pouches in Podcasts, schreibt Protokolle, konvertiert Follower. Und richtet bei anderen genau den Schaden an, den

14 Heishman et al. 2010.

15 Zhang et al. 2012; Grieder et al. 2012.

er bei sich selbst nicht sehen kann, weil die Substanz den Blick vernebelt, mit dem er sich selbst betrachten müsste.

Die zwei Dinge, die bei stabilem Dopamin zurückkehren — der Drang, fertigzumachen, und das Gespür für Wichtiges —, sind Baselineeffekte. Keine Motivationssache. Sie kehren zurück, wenn das System aufhört, sich selbst zu regulieren, und anfängt, die Welt zu regulieren.

Entscheidungen sind Zustandsprodukte.

Wenn das stimmt, tilgt es die gesamte Vorstellung von Willenskraft und rationaler Selbststeuerung. (Die Neurobiologie belegt, dass es stimmt.) Wer fragt *Was will ich*, fragt am Willen vorbei.

Nicht *Was*.

Woraus.

Äußerlich nichts anders. Innen ein anderer Neurotransmittertakt. Weniger Dopaminfluktuation, weniger Cortisolspitzen.¹⁶ Und aus dieser Grundlinie verschob sich alles:

16 Raucher zeigen eine bis zu zwanzig Prozent reduzierte Dopaminsynthesekapazität.

Lena Rademacher, Susanne Prinz, Oliver Winz, et al., »Effects of Smoking Cessation on Presynaptic Dopamine Function of Addicted Male Smokers«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 80, Issue 3, 01.08.2016, 198—206.

Raucher haben signifikant höhere Cortisolwerte über den gesamten Tag, einschließlich höherer Cortisol-Aufwachreaktion.

Andrew Steptoe, Michael Ussher, »Smoking, cortisol and nicotine«, in: *International Journal of Psychophysiology*, Vol. 59, Issue 3, März 2006, 228—35.

Rauchen verursacht mehr Cortisol im Ruhezustand, weniger Anpassungsfähigkeit bei Stress.

Nicolas Rohleder, Clemens Kirschbaum, »The hypothalamic—pituitary—adrenal (HPA) axis in habitual smokers«, in: ebd., 236—43.

Durchhaltefähigkeit, Wichtigkeitsgefühl.¹⁷ Alles, was ich mir als Charakterreifung gewünscht hatte, stellte sich als neurochemische Stabilisierung heraus.

Und niemand sagt das so klar, weil wir moralisch denken wollen. Wir lieben Charaktertheorien. Sie geben uns das Gefühl, Herr im eigenen Haus zu sein. (Wie Freud sagte, bevor er Kokain nahm, um trotzdem so zu tun.)

Du dachtest, du bist kaputt. Du hast nur geraucht.

Identität plus Gewohnheit plus Dopamin ergeben irgendwann Charakter — oder was man dafür hält. Wenn das dann wegfällt, fühlt man sich fremd statt befreit. Weil die alte Selbstdiagnose nicht mehr stimmt und das Neue noch keinen Namen hat. Das ist der Moment, in dem viele wieder anfangen zu rauchen. Weil die alte Identität vertraut ist. Weil die neue Stille Angst macht.

Sieben Jahre Charakterproblem, das am Ende ein permanenter Rezeptorloop war.

Der Körper hat mehr Stimmrecht, als wir wahrhaben wollen. Und ich habe ihn sieben Jahre lang wählen lassen.

Das ist kein Spezialfall des Rauchens. Die Logik dahinter ist universell.

Wenn Entscheidungen Zustandsprodukte sind, dann ist auch Traurigkeit kein Zufall. Traurigkeit ist ein Ort. Man lebt nicht in Gefühlen. Man lebt in dem biochemischen Milieu, aus dem sie entstehen.

Was für Nikotin gilt, gilt für jeden biochemischen Saboteur. Entzündung, Schlafmangel, metabolische Toxizität. Dasselbe

17 Nikotinentzug erzeugt Defizite in Arbeitsgedächtnis und kognitiver Kontrolle — den Voraussetzungen für zielgerichtetes Verhalten. Diese Defizite sagen Rückfälle vorher.

Ashare et al. 2014.

Muster, andere Substratebene. Das Gehirn ist ein Organ in einem physiologischen Milieu. Kein abstraktes Ding, das unabhängig vom Körper entscheidet. Und wenn dieses Milieu toxisch ist — entzündet, überlastet —, entscheidet das Gehirn anders. *Ich bin depressiv, also muss ich an meiner Einstellung arbeiten. Ich bringe nichts zu Ende, also fehlt mir Disziplin.* Diese Geschichten sind falsch und schädlich. Weil sie die Aufmerksamkeit von dem ablenken, was tatsächlich passiert: *eine materielle Störung auf zellulärer Ebene, die sich als psychisches Problem verkleidet.*

Persönlichkeit ist Zustandsprodukt. Zu einem größeren Anteil, als irgendjemand zugeben will. Was du isst, rauchst, trinkst, ob du schläfst. Biologie, nicht Biografie.

Menschen verteidigen ihr Normalitätsgefühl. Und das ist schwerer aufzugeben als jede Substanz, weil man dafür zugeben müsste, dass der eigene Alltag eine Abhängigkeit enthält, die man nie als solche erkannt hat. Nicht die Abhängigkeit von der Substanz. Die ist offensichtlich. Sondern die Abhängigkeit von dem Selbstbild, das die Substanz erzeugt hat.

Ich bin halt chaotisch. Ich bin halt nicht der Typ dafür.

Ich bin halt ich.

Es gibt nichts Schmeichelhaftes daran. Substanz raus. Körper funktioniert. Ende des Rezeptorloops. Und eine ganze Zivilisation voller Menschen, die glauben, sie seien psychisch krank, während ihre Zellen in einem Milieu ersticken, das wir selbst erzeugt haben.

Dass Rauchen schadet, weiß jeder. Dass Depression biologisch ist, ahnen viele. Das ist nicht die unbequeme Wahrheit. Die unbequeme Wahrheit ist, dass ein Großteil dessen, was wir für Persönlichkeit halten, Stoffwechsel ist. Dass die Geschichten, die wir über uns erzählen, von unseren Neurotransmittern geschrieben werden. Und dass wir es vorziehen, uns für charakterschwach zu halten, als zuzugeben, dass eine

Substanz, eine Entzündung, ein zellulärer Müllhaufen unser Selbstbild infiltriert hat.

Wir verwechseln Biochemie mit Identität, solange die Biochemie uns sabotiert.

Und dann wundern wir uns, wer wir sind, wenn die Sabotage aufhört.

Man verteidigt nicht die Zigarette. Man verteidigt die Identität, die man sich angeraucht hat.

DIE HÖLLE IST KEIN ORT

Die Hölle ist ein Stoffwechsel.

Unser Körper wird vor der Geburt kontaminiert und verbringt den Rest seiner Existenz damit, die Kontamination für sein Leben zu halten. Was am Ende denkt, denkt mit dem, was die Stoffe übrig gelassen haben.

Es nennt sich autonom.

Um mein Gehirn zurückzugewinnen, muss ich eliminieren, was es schrumpfen lässt. Und ich muss zur Routine machen, was es wachsen lässt. Was mein Gehirn schrumpfen lässt, sind *Umweltgifte*, die ich einatme (Feinstaub, Schwermetalle), *Substanzen*, die ich mir freiwillig zuführe (Alkohol, Tabakrauch, Koffein), und *Stoffwechselstörungen*, die aus beidem folgen (Übergewicht, schlechte Ernährung).

Dreihundert Chemikalien, die es 1950 nicht gab, schwimmen heute im durchschnittlichen Fötus.¹ Er kommt zur Welt als kontaminiertes Gefäß, und der Staat nennt es Geburt. Er

1 287 Industriechemikalien im Nabelschnurblut, durchschnittlich 200 pro Kind — davon 180 karzinogen, 217 neurotoxisch, 208 entwicklungsschädigend. Eine spätere Studie identifizierte 109 weitere, darunter 55, die zuvor nie im Menschen nachgewiesen wurden, und 42 unbekannter Herkunft. »Dreihundert« ist konservativ gerundet: beide Studien testeten einen Bruchteil der rund achtzig Tausend kommerziell genutzten Substanzen.

Environmental Working Group / Commonweal, *Body Burden: The Pollution in Newborns*, Washington, D.C., Juli 2005.

wird geboren, und es wird schlimmer. Wir gebären Sondermüll und nennen es Wunder. Wir gebären Kinder mit Gehirnen, die auf Plastik mariniert wurden, und erwarten von ihnen, dass sie begreifen, was wir ihnen angetan haben.

Lieber schieben wir den seit Jahrzehnten sinkenden IQ² auf unser marodes Bildungssystem statt auf das, was aus Leitungen, Verpackungen und Böden in unsere Blutbahn sickert.³ Fluorid, endokrine Disruptoren, Mikroplastik.

Oder wir schieben ihn auf die Gene, obwohl der Rückgang innerhalb derselben Familien nachgewiesen ist, zwischen älteren

Aolin Wang, Dimitri Panagopoulos Abrahamsson, Ting Jiang, et al., »Suspect Screening, Prioritization, and Confirmation of Environmental Chemicals in Maternal-Newborn Pairs from San Francisco«, in: *Environmental Science & Technology*, Vol. 55, Issue 8, 16.03.2021, 5037–49.

- 2 Seit Mitte der 1990er Jahre sinkt der IQ in Europa. Im DACH-Raum beträgt der Rückgang bei räumlicher Wahrnehmung knapp fünf Punkte pro Dekade. Jakob Pietschnig, Georg Gittler, »A Reversal of the Flynn Effect for Spatial Perception in German-Speaking Countries: Evidence from a Cross-Temporal IRT-Based Meta-Analysis (1977–2014)«, in: *Intelligence*, Vol. 53, November 2015, 145–53.

Edward Dutton, Dimitri van der Linden, Richard Lynn, »The negative Flynn Effect: A systematic literature review«, in: *Intelligence*, Vol. 59, November 2016, 163–9.

- 3 **Fluorid:** Rivka Green, Bruce Lanphear, Richard Hornung, et al., »Association Between Maternal Fluoride Exposure During Pregnancy and IQ Scores in Offspring in Canada«, in: *JAMA Pediatrics*, Vol. 173, No. 10, 19.08.2019, 940–8.

Endokrine Disruptoren (Schadstoffe, die hormonelle Systeme stören): A. C. Gore, V. A. Chappell, S. E. Fenton, et al., »EDC-2: The Endocrine Society's Second Scientific Statement on Endocrine-Disrupting Chemicals«, in: *Endocrine Reviews*, Vol. 36, Issue 6, 01.12.2015, E1–E150.

Mikroplastik (kognitive Beeinträchtigung): Donghan Zheng, Dan Wang, Shuo Zhang, et al., »Impact of urinary microplastic exposure on cognitive function in primary school children«, in: *Ecotoxicology and Environmental Safety*, Vol. 302, 01.09.2025, 118532.

und jüngeren Geschwistern.⁴ Wir erzählen es uns, um die Illusion von Kontrolle aufrechtzuerhalten, selbst wenn sie nur darin besteht, ein passendes Etikett parat zu haben — »Depression«, »Burnout«, »ADHS«, oder was gerade als Diagnose durchgeht. Das reicht als Ausrede für meine Kümmerexistenz.

Die Psychiatrie medikamentiert Vergiftungen, die sie nicht diagnostiziert — alles außer dem, was eine Blutanalyse zeigen würde. Wir führen Debatten mit Gehirnen, die nicht einmal ihren eigenen Glukosespiegel kontrollieren. Wenn die Sicherung durchbrennt, projizieren wir den Selbsthass auf Milliardäre, Erben, »die da oben«, Zugewanderte — auf alles außer den eigenen Blutkreislauf.

Demenz ist nicht Schicksal. Demenz ist die Quittung. Der Unterschied zwischen einem funktionierenden und einem demenzkranken Gehirn ist Postleitzahl und Zeit.

ENDLAGER GEHIRN

Stadtluft macht dumm. Feinstaub und Schadgase wie Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon sind in Charlottenburg besonders hoch. Sie frisst weißes Hirngewebe. Feinstaub nimmt Hirnvolumen, Milligramm pro Atemzug, messbar per MRT. Feinstaubpartikel sind dreißigmal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haars. Klein genug, um die Immunabwehr zu umgehen.⁵

4 Bernt Bratsberg, Ole Rogeberg, »Flynn effect and its reversal are both environmentally caused«, in: *PNAS*, Vol. 115, No. 26, 11.06.2018, 6674—8.

5 Anna Oudin, »Air Pollution and Dementia: Evidence from Epidemiological Studies«, in: Katja Marika Kanninen, Anthony Robert White (Hg.), *Air Pollution and the Brain*, Cham 2025, 135—56.

Lilian Calderón-Garcidueñas, »Air pollution is a major risk factor for the development of Alzheimer's disease, cognition deficits, systemic and neural

Bei Jugendlichen baut Schadstoffbelastung die weiße Substanz um.⁶ Die Isolierung der Nervenfasern hat ein Zeitfenster. Was in diesem Fenster beschädigt wird, bleibt beschädigt. Der junge Körper kompensiert. Entzündungsmarker steigen, Vitamin-D-Spiegel sinken, alle Vorboten eines Kollapses, aber die Messwerte halten. Noch. Weil der Organismus den Verfall verbirgt. Bis er es nicht mehr kann.

Je höher die Feinstaubkonzentration am Wohnort, desto geringer das gemessene Hirnvolumen.⁷ Da ich meinen Wohnort nicht wechseln konnte, verminderte ich die Exposition durch Luftreiniger mit HEPA-13-Filter in allen genutzten Räumen.

inflammation in urban children«, in: *The Lancet Regional Health—Americas*, Vol. 46, 13.05.2025, 101129.

Mahdiyeh Mohammadzadeh, Amir Hossein Khoshakhlagh, Jordan Grafman, »Air pollution: a latent key driving force of dementia«, in: *BMC Public Health*, Vol. 24, 02.09.2024, Artikel 2370.

Ankul Singh S, Mohd Nazam Ansari, Gehan M. Elossaily, et al., »Investigating the Potential Impact of Air Pollution on Alzheimer's Disease and the Utility of Multidimensional Imaging for Early Detection«, in: *ACS Omega*, Vol. 9, 15.02.2024, 8615—31.

Michelle L. Block, Lilian Calderón-Garcidueñas, »Air pollution: Mechanisms of neuroinflammation and CNS disease«, in: *Trends in Neurosciences*, Vol. 32, Issue 9, September 2009, 506—16.

- 6 Devyn L. Cotter, Claire E. Campbell, Katherine L. Bottenhorn, et al., »Exposure to multiple ambient air pollutants changes white matter microstructure during early adolescence with sex-specific differences«, in: *Communications Medicine*, Vol. 4, 01.08.2024, Article 155.
 - 7 Lilian Calderón-Garcidueñas, Ricardo Torres-Jardón, Randy J. Kulesza, et al., »Alzheimer disease starts in childhood in polluted Metropolitan Mexico City. A major health crisis in progress«, in: *Environmental Research*, Vol. 183, April 2020, 109137.
- Ruth Peters, Nicole Ee, Jean Peters, et al., »Air Pollution and Dementia: A Systematic Review«, in: *Journal of Alzheimer's Disease*, Vol. 70, Issue 1, 13.08.2019, 145—63.

Im Freien blieb die FFP2-Maske. Sozial ruinös, toxikologisch alternativlos.

Ein Bäckereiverkäufer im Kiez fragte irgendwann, was die Maske soll. Ich erklärte ihm den Feinstaub. Danach rief er mir auf der Straße hinterher. *Feinstaub! Pass auf!* Jedes Mal, wenn er mich sah. Häme von einem Mann, der acht Stunden täglich Mehlstaub einatmet. In Tokio hätte niemand gefragt. In Berlin wirst du zum Irren erklärt, wenn du aufhörst, dich vergiften zu lassen.

Die Verachtung gilt nie dem Schaden.

Immer dem, der ihn benennt.

Die Pandemie ist vorbei, die Aversion geblieben. Wer heute eine FFP2-Maske trägt, gilt wahlweise als ängstlich, autoritäts-hörig oder japan-besessen. Dass Feinstaub die Hirnsubstanz angreift, passt schlecht ins Narrativ. Dieselben Leute, die »Hirn einschalten« forderten, setzen ihres nun ungeschützt der Stadtluft aus.

Neben Übergewicht, Alkohol und Nikotin ist Feinstaub der verlässlichste Prädiktor für Alzheimer und Demenz. Die anderen drei lassen sich kontrollieren. Alkohol kann man weglassen, Nikotin kann man weglassen, Übergewicht lässt sich abbauen. Feinstaub nicht. Er kommt mit der Luft. Auch unterhalb der geltenden Grenzwerte steigt das Risiko linear. Es gibt keine sichere Dosis. Nationale Grenzwerte wiegen in einer Sicherheit, die es nicht gibt. Selbst die Kontrollgruppen in Feinstaubstudien sind kontaminiert. Was eine gesunde Referenzpopulation ist, weiß niemand mehr.

Die Rechnung kommt in Gramm.

Blei, Cadmium, Quecksilber, Arsen⁸. Vier Stoffe, die sich im Gehirn einlagern wie Sediment in einem Flussbett.⁹ Sie passieren die Blut-Hirn-Schranke und bleiben. Blei aktiviert die Immunzellen des Gehirns (Mikroglia) zu einer Dauerentzündung. Das führt zur Demyelinisierung, also dem Abbau der schützenden Hüllen um die Nervenfasern. Die betroffenen Axone degenerieren, weiße Substanz schrumpft. Blei ersetzt Myelin, Cadmium akkumuliert, Quecksilber bleibt.

Als ich aufhörte zu rauchen, reduzierte ich meine Belastung mit Cadmium und Blei erheblich. Eine weitere Bleiquelle waren die alten Wasserleitungen meiner Berliner Altbauwohnung. Bei zentraler Wasserversorgung sind alte Rohre die häufigste Quelle für Blei im Trinkwasser.¹⁰ In Nord- und Ostdeutschland wurden Bleileitungen bis in die 1970er Jahre genutzt. Ich musste Leitungswasser meiden, beziehungsweise einen effektiven Wasserfilter benutzen.

Bremsabrieb im Straßenverkehr.¹¹ Metallhaltige Nanopartikel, neurotoxischer als gewöhnlicher Feinstaub. Als Fußgänger inhalierte ich sie ständig.

Das meiste Blei aber nehmen Menschen über die Nahrung auf, in die es über Industrieabgase und belastete Böden gelangt.¹²

8 Streng genommen ein Halbmetall.

9 Mahdi Balali-Mood, Kobra Naseri, Zoya Tahergorabi, et al., »Toxic Mechanisms of Five Heavy Metals: Mercury, Lead, Chromium, Cadmium, and Arsenic«, in: *Frontiers in Pharmacology*, Vol. 12, 13.04.2021, 643972.

10 Richard Rabin, »The Lead Industry and Lead Water Pipes >A Modest Campaign<«, in: *American Journal of Public Health*, Vol. 98, No. 9, September 2008, 1584—92.

11 Theodoros Grigoratos, Giorgio Martini, »Brake wear particle emissions: a review«, in: *Environmental Science and Pollution Research*, Vol. 22, 2015, 2491—504.

12 EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), »Scientific Opinion on Lead in Food«, in: *EFSA Journal*, Vol. 8, No. 4, 20.04.2010,

Vor allem Muscheln und Leber von Schweinen und Rindern sind voll davon. Wild wird teilweise mit bleihaltiger Munition geschossen. In Wildfleisch finden sich dann ebenfalls hohe Bleiwerte.¹³ Zum Jahreswechsel verpulvern Leute Feuerwerkskörper. Die setzen bei der Explosion erhebliche Mengen Schwermetall frei, darunter Strontium, Kupfer, Barium, Blei und Titan.¹⁴ (Sie geben dem Feuerwerk Farbe.) Um Mitternacht wünschen wir uns Gesundheit.

Cadmium kommt über Phosphatdünger in konventionelles Gemüse, Kakao, Pilze, Innereien.¹⁵ Quecksilber über Salzwasserfisch und Zahnamalgam, das manche Menschen tatsächlich noch im Mund tragen — fünfzig Prozent metallisches Quecksilber, eingefasst in Kaufkassenzähne.¹⁶ Zahnamalgam ist Quecksilber auf Krankenschein.

1570.

- 13 Annette Gerofke, Martin Carl, Monika Gremse, et al., »Lead content in wild game shot with lead or non-lead ammunition — Does >state of the art consumer health protection< require non-lead ammunition?«, in: *PLoS ONE*, Vol. 13, No. 7, 18.07.2018, e0200792.

Deborah J. Pain, Ruth Cromie, Julia Newth, et al., »How contaminated with ammunition-derived lead is meat from European small game animals? Assessing and reducing risks to human health«, in: *Environmental Science and Pollution Research*, Vol. 29, 2022, 45072—94.

- 14 Christina M. Hickey, Christopher Gordon, Karen Galdanes, et al., »Toxicity of particles emitted by fireworks«, in: *Particle and Fibre Toxicology*, Vol. 17, 01.07.2020, Art. 28.

- 15 Nicoleta Alina Suci, Romano De Vivo, Niccolò Rizzati, Ettore Capri, »Cd content in phosphate fertilizer: Which potential risk for the environment and human health?«, in: *Current Opinion in Environmental Science & Health*, Vol. 30, Dezember 2022, 100392.

EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), »Scientific Opinion on Cadmium in Food«, in: *EFSA Journal*, Vol. 7, No. 980, 2009.

- 16 Emily Oken, David C. Bellinger, »Fish consumption, methylmercury and child neurodevelopment«, in: *Current Opinion in Pediatrics*, Vol. 20, Issue 2,

Drei Milliarden Menschen essen täglich Arsen.

Sie nennen es Reis.

Der reichert das Halbmetall zehnmal stärker an als Weizen. Unter gefluteten Anbaubedingungen ist Arsen im Boden besonders löslich. Siliziumtransporter in der Pflanze nehmen Arsenit wegen seiner chemischen Ähnlichkeit mit Kieselsäure auf.¹⁷

Radioaktive Abfälle in Schmutzstoffen sammeln sich im Körper¹⁸ und mindern unser Ich-Gefühl¹⁹. Die Metalle verändern,

April 2008, S. 178—83.

Vinayak Padmakumar, Kavya Premkala Raveendran, Anshad Mohamed Abdulla, et al., »Levels of Mercury in Fish-Eating Children, With and Without Amalgam Restoration«, in: *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*, Vol. 11, Suppl. 2, Mai 2019, 397—401.

- 17 Margaret R. Karagas, Tracy Punshon, Matt Davis, et al., »Rice intake and emerging concerns on arsenic in rice: a review of the human evidence and methodologic challenges«, in: *Current Environmental Health Reports*, Vol. 6, Issue 4, Dezember 2019, 361—72.

Matt A. Limmer, Angelia L. Seyfferth, »Altering the localization and toxicity of arsenic in rice grain«, in: *Scientific Reports*, Vol. 12, 25.03.2022, Artikel 5210.

- 18 Persistente organische Schadstoffe, Schwermetalle und radioaktive Isotope wie Strontium-90 und Cäsium-137 akkumulieren im menschlichen Fettgewebe, in Knochen und Muskulatur.

Erin Jackson, Robin Shoemaker, Nika Larian, Lisa Cassis, »Adipose Tissue as a Site of Toxin Accumulation«, in: *Comprehensive Physiology*, Vol. 7, No. 4, 12.09.2017, 1085—135.

Y.-M. Lee, K.-S. Kim, D. R. Jacobs Jr., D.-H. Lee, »Persistent organic pollutants in adipose tissue should be considered in obesity research«, in: *Obesity Reviews*, Vol. 18, Issue 2, Februar 2017, 129—39.

- 19 Umwelttoxine schädigen Insula, Hippocampus und präfrontalen Kortex. Das sind die Hirnregionen, die für Körperwahrnehmung, Emotionsregulation und Selbstbezug zuständig sind.

Lilian Calderón-Garcidueñas, Antonieta Mora-Tiscareño, Maricela Francolira, et al., »Exposure to Urban Air Pollution and Bone Health in Clini-

wer ich bin. Aber das veränderte Ich bemerkt es nicht. Eine Veränderung, die ihre eigenen Spuren tilgt. Blei, Cadmium, Quecksilber fressen sich durch meine Darmwand, bis der Körper nicht mehr unterscheiden kann, was Nahrung ist und was Angriff. Nachts schlafe ich nicht. Tagsüber bin ich jemand, den ich nicht wiedererkenne.

Mikroplastik sitzt in meinem Darm²⁰, deiner Plazenta²¹, meinem Hirn²². Nicht weil ich Plastikflaschen kaufe. Es kommt

cally Healthy Six-year-old Children«, in: *Archives of Industrial Hygiene and Toxicology [Arh Hig Rada Toksikol]*, Vol. 64, Issue 1, 2013, 23—34.

Mónica Guxensa, Małgorzata J. Lubczyńska, Ryan L. Muetzeld, et al., »Air Pollution Exposure During Fetal Life, Brain Morphology, and Cognitive Function in School-Age Children«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 84, Issue 4, 15.08.2018, 295—303.

- 20 Philipp Schwabl, Sebastian Köppel, Philipp Königshofer, et al., »Detection of Various Microplastics in Human Stool: A Prospective Case«, in: *Annals of Internal Medicine*, Vol. 171, No. 7, 03.09.2019, 453—7.

- 21 Antonio Ragusa, Alessandro Svelato, Criselda Santacroce, et al., »Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta«, in: *Environment International*, Vol. 146, Januar 2021, 106274.

Sechs Plazenten, vier kontaminiert. Mikroplastik auf der fetalen Seite, der mütterlichen Seite und in den Eihäuten. Alle Partikel waren pigmentiert — stammten aus Beschichtungen, Farben, Klebstoffen, Kosmetik.

Die Nachfolgestudie lokalisierte Mikroplastik sogar innerhalb der Plazentazellen, mit ultrastrukturellen Veränderungen an Mitochondrien und endoplasmatischem Retikulum.

Antonio Ragusa, Maria Matta, Loredana Cristiano, et al., »Deeply in Plasticenta: Presence of Microplastics in the Intracellular Compartment of Human Placentas«, in: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 19, Issue 18, 14.09.2022, 11593.

- 22 Akkumulation von Mikro- und Nanoplastik im menschlichen Gehirn stieg zwischen 2016 und 2024 signifikant an. Zehnfach höher bei Demenz.

Alexander J. Nihart, Marcus A. Garcia, Eliane El Hayek, et al., »Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains«, in: *Nature Medicine*, Vol. 31, No. 4, 03.02.2025, 1114—9.

aus den Reifen auf dem Asphalt²³, aus der Kleidung auf meiner Haut²⁴, aus der Luft, die mich ausatmet²⁵. Keiner dieser Wege lässt sich schließen. In Innenräumen ist die Konzentration noch höher als draußen. Bei Demenzpatienten fand eine Studie zehnfach höhere Mikroplastikkonzentration im Hirngewebe als bei gesunden Vergleichspersonen.²⁶

Was einmal drin ist, bleibt drin. Und es kommt ständig nach.

Berlin ist eine Feinstaubhöhle. Jedes Mal, wenn ich an einer Baustelle vorbeigehe, nehme ich Aluminiumsilikate mit²⁷, Quarzkristalle, die mich von Jahr zu Jahr ein kleines bisschen blöder

-
- 23 Fünf bis zehn Prozent des ozeanischen Mikroplastiks stammen aus Reifenabrieb, drei bis sieben Prozent des Feinstaubs (PM_{2,5}) aus Reifenpartikeln. Pieter Jan Kole, Ansje J. Löh, Frank G. A. J. Van Belleghem, Ad M. J. Ragas, »Wear and Tear of Tyres: A Stealthy Source of Microplastics in the Environment«, in: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 14, Issue 10, 20.10.2017, 1265.
- 24 Tragen setzt mehr Mikrofasern frei als Waschen: über 900 Millionen Polyester-Mikrofasern pro Person und Jahr, allein durch Tragen. Francesca De Falco, Mariacristina Cocca, Maurizio Avella, Richard C. Thompson, »Microfiber Release to Water, Via Laundering, and to Air, via Everyday Use: A Comparison between Polyester Clothing with Differing Textile Parameters«, in: *Environmental Science & Technology*, Vol. 54, Issue 6, 26.02.2020, 3288—96.
- 25 Lauren C. Jenner, Jeanette M. Rotchell, Robert T. Bennett, et al., »Detection of Microplastics in Human Lung Tissue Using μ FTIR Spectroscopy«, in: *Science of the Total Environment*, Vol. 831, 20.07.2022, 154907.
- 26 Nihart et al. 2025.
- 27 Baustellenstaub enthält kristallines Siliziumdioxid (Quarz) und Aluminiumsilikate, die als Feinstaub eingeatmet werden. Siliziumdioxid-Nanopartikel lagern sich in präfrontalem Kortex und Hippocampus ab. Sang-Wook Kim, Yohan Kim, Mi-Kyung Kim, et al., »Silica nanoparticles induce neurodegeneration-like changes in behavior, neuropathology, and affect synapse through MAPK activation«, in: *Particle and Fibre Toxicology*, Vol. 15, Artikel 28, 03.07.2018.

machen²⁸. In einer besseren Welt würden Bauarbeiter mehr verdienen als Anwälte. Denn ihre Löhne werden in Krankheit gestückelt. Parkinson, Alzheimer²⁹ — unterschrieben in Staub, gültig fürs Sterben. In Japan trägt man Masken aus Rücksicht. In Deutschland wurde die Maske zum Symbol der Unterdrückung stilisiert — von Leuten, die anschließend Bleichmittel tranken.

ESSEN, DAS AUSHUNGERT

Die gefährlichste Droge hat eine Nährwerttabelle. Die Nahrung, die den Schaden reparieren könnte, verursacht ihn. Wer isst wie die DGE empfiehlt, verliert Hippocampus. Das belegt eine vierjährige Längsschnittstudie an 255 Erwachsenen. *Je schlechter die Ernährung, desto kleiner die Hirnregion für Gedächtnis und Lernen.* Wahrscheinlich war das der Grund, warum mir damals intuitiv klar war, dass ich adipös niemals an der Uni würde bestehen können. In jener Längsschnittstudie betrug der Unterschied zwischen gesunder und ungesunder Ernährung 203 Kubikmillimeter. Das entspricht 62 Prozent des durchschnittlichen Hippocampus-Rückgangs über den Studienzeitraum, unabhängig von

In Tiermodellen: kognitive Beeinträchtigung, erhöhte Tau-Phosphorylierung, Neuroinflammation — Alzheimer-typische Pathologien.

- 28 Luftschadstoffe beschleunigen den kognitiven Abbau. Gedächtnis, Verarbeitungsgeschwindigkeit und exekutive Funktionen gleichermaßen.

Erin R. Kulick, Gregory A. Wellenius, Amelia K. Boehme, et al., »Long-term exposure to air pollution and trajectories of cognitive decline among older adults«, in: *Neurology*, Vol. 94, No. 17, 28.04.2020, e1782—92.

- 29 Langzeitexposition gegenüber Feinstaub (PM_{2,5}) erhöht Wahrscheinlichkeit für Parkinson und Alzheimer, auch unterhalb der geltenden Grenzwerte. Liuhua Shi, Xiao Wu, Mahdiah Danesh Yazdi, et al., »Long-term effects of PM_{2.5} on neurological disorders in the American Medicare population: a longitudinal cohort study«, in: *The Lancet Planetary Health*, Vol. 4, Issue 12, 19.10.2020, e557—65.

Alter, Geschlecht, Bildung, körperlicher Aktivität, Bluthochdruck und Diabetes.³⁰

Oder anders: Du bist zu dick. Das ist der Grund.

Alles andere ist Ausrede.

Industrienahrung ist kein Lebensmittel. Sie ist Volumen mit Aroma. Stärkegel, zusammengefügt durch chemische Prozesse, mit Aromen maskiert, aber für die Zelle unlesbar. Kein Nährstoff, nur Volumen. Auszugsmehl, weißer Zucker, künstliche Farbstoffe. Vor allem Transfette, wenn sie durch den Körper wandern, senden überall Entzündungssignale.

In einer NIH-Studie bekamen Probanden zwei Wochen ultraverarbeitete Kost, dann zwei Wochen unverarbeitete. Exakt gleiche Kalorien, gleiche Nährstoffe. Bei ultraverarbeiteter Nahrung aßen sie 500 Kalorien mehr pro Tag. Sie aßen schneller. Ihr Hungerhormon stieg, ihr Sättigungshormon sank. In zwei Wochen nahmen sie ein Kilo zu. Die erste Studie, die Kausalität nachwies. Deswegen der Dauerhunger bei Menschen, die sich hauptsächlich von Fertigprodukten ernähren: die Zellen verhungern bei vollem Magen. Die Übergewichtsepidemie hat einen chemischen Ursprung.³¹ Einige der Chemikalien, die wir über die Nahrung aufnehmen, regen die Bildung neuer Fettzellen an, programmieren den Stoffwechsel auf Speicherung, senken die Insulinempfindlichkeit. Sie steuern mit.

30 Felice N. Jacka, Nicolas Cherbuin, Kaarin J. Anstey, et al., »Western diet is associated with a smaller hippocampus: a longitudinal investigation«, in: *BMC Medicine*, Vol. 13, 08.09.2015, Artikel 215.

31 Kevin D. Hall, Alexis Ayuketah, Robert Brychta, et al., »Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake«, in: *Cell Metabolism*, Vol. 30, Issue 1, 02.07.2019, 67—77.

Wir beruhigen uns mit der Illusion der Vermeidbarkeit. Dioxine, Pestizide, Transfette — als ließe sich aussortieren, was längst im Gewebe sitzt. Oder wir belügen uns damit, dass die Dosis gering und damit unbedenklich sei. Obwohl die Forschung das Gegenteil zeigt. Bei persistenten organischen Schadstoffen ist die Dosis-Wirkungs-Beziehung nicht linear. Ein bisschen Gift kann schlimmer sein als viel. Chronisch niedrige Dosen richten mehr Schaden an als akut hohe.

Oder wir kaufen unser ranziges Pflanzenöl im Bioladen statt im Supermarkt, um unser Gewissen zu beruhigen. Und ja, alle im Handel erhältlichen Pflanzenöle in Braun- oder Grünglasflaschen sind durch Lichteinwirkung oxidiert und daher ranzig.³² Lange bevor man es riecht oder schmeckt. Braunglas schützt bis 440 Nanometer.³³ Chlorophyll im Öl — der grüne Farbstoff, der es gesund aussehen lässt — absorbiert das Licht, versetzt Sauerstoff in einen reaktiven Singulett-Zustand, greift die Fettsäuren an.³⁴

32 Eunok Choe, David B. Min, »Mechanisms and Factors for Edible Oil Oxidation«, in: *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, Vol. 5, Issue 4, 29.09.2006, 169—86.

Ausnahme: hochgesättigte Fette wie Kokosöl, dessen Ketten zu über neunzig Prozent gesättigt sind — kaum Doppelbindungen, kaum Angriffsfläche. A. M. Marina, Y. B. Che Man, I. Amin, »Virgin coconut oil: emerging functional food oil«, in: *Trends in Food Science & Technology*, Vol. 20, Issue 10, Oktober 2009, 481—7.

33 Grünglas sogar erst unterhalb von 400 Nanometern, der gesamte blaue Bereich geht durch.

Zsófia Laposa, Soma Vesztergom, Marianna Kocsis, Ernő Keszei, »In situ measurement of light transmission into wine bottles and calculation of shelf life«, in: *OENO One*, Vol. 57, No. 1, 07.03.2023, 256—77.

34 Dieser Singulett-Zustand ist für rund achtzig Prozent der Chlorophyll-Photooxidation verantwortlich.

Saïd Gharby, Abderrahim Asbbane, Moussa Nid Ahmed, et al., »Vegetable oil oxidation: Mechanisms, impacts on quality, and approaches to enhance shelf life«, in: *Food Chemistry: X*, Vol. 28, Mai 2025, 102541.

Das Glas lässt genau die Wellenlänge durch, die das Öl zerstört, und niemand schirmt es ab, weil niemand den Mechanismus kennt.³⁵ Unter Supermarktbedingungen verliert Olivenöl in Glasflaschen die Klassifizierung *Natives Olivenöl extra*.³⁶ Was im Körper ankommt, sind oxidierte Fette, die Zellschäden und Entzündungen verursachen.

Der Deckenfluter in der Küche reicht.³⁷ Und was die Entzündung speichert, ist das Fett selbst.

Fettgewebe ist kein Polster. Es ist ein Entzündungsreaktor, der Interleukin 6 und TNF- α ausschüttet — die Währung chronischer Zerstörung —, Hormone entgleist und Gifte einlagert. Übergewicht ist nichts anderes als eine permanente Entzündung.³⁸ Es zerstört das Herz-Kreislauf-System, ist also die

Dimitrios Trypidis, Diego Luis García-González, Ana Lobo-Prieto, et al., »Real time monitoring of the combined effect of chlorophyll content and light filtering packaging on virgin olive oil photo-stability using mesh cell-FTIR spectroscopy«, in: *Food Chemistry*, Vol. 295, 15.10.2019, 94—100.

- 35 Chlorophyll hat zwei Absorptionspeaks: einen bei 430 Nanometern, den Braunglas noch abfängt, und einen bei 660 Nanometern, den es ungehindert durchlässt.

Laurie M. Bianchi, Susan E. Duncan, Janet B. Webster, et al., »Contribution of Chlorophyll to Photooxidation of Soybean Oil at Specific Visible Wavelengths of Light«, in: *Journal of Food Science*, Vol. 80, Issue 2, Februar 2015, C252—C61.

- 36 Sonia Esposto, Agnese Taticchi, Maurizio Servili, et al., »Overall quality evolution of extra virgin olive oil exposed to light for 10 months in different containers«, in: *Food Chemistry*, Vol. 351, 30.07.2021, 129297.

- 37 Marc Pignitter, Klaus Stolze, Stephanie Gartner, et al., »Cold Fluorescent Light as Major Inducer of Lipid Oxidation in Soybean Oil Stored at Household Conditions for Eight Weeks«, in: *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, Vol. 62, Issue 10, 18.02.2014, 2297—305.

- 38 Übergewicht ist kein passiver Zustand, sondern ein aktiver Entzündungsprozess. Hypertrophe Adipozyten rekrutieren Makrophagen (bis zu vier-

häufigste Todesursache.³⁹ Sie steht nur nicht auf dem Totenschein, weil dort »Herzinfarkt« steht statt »dreißig Jahre Übergewicht«. Hunger ist ein globales Massenproblem. Aber die Art, *wie* wir essen, tötet zuverlässiger als *gar nicht* zu essen. Die Menschheit begeht Suizid durch Nahrungsaufnahme.

Body Positivity ist Selbstmord mit Applaus. Die Gesellschaft schweigt höflich dazu. Auf dieses Schweigen zahlte mein Körper den Höchststeuersatz. Dreißig Kilo, nach dem Abitur endgültig abgetragen. Was ich damals nicht wusste: Fettgewebe ist ein Giftdepot. Persistente organische Schadstoffe — das dreckige Dutzend der Stockholmer Konvention. Industriechemikalien, Dioxine, alte Pestizide wie DDT. Fettlöslich, in der Natur kaum

zig Prozent aller Fettgewebszellen), die über TNF- α , IL-6 und IL-1 β einen sich selbst erhaltenden Entzündungskreislauf antreiben, der systemisch auf Leber, Muskeln und Gefäße übergreift.

Taekyoon Kim, Bernadette Kahn, »Adipose Tissue Inflammation and Metabolic Dysfunction in Obesity«, in: *American Journal of Physiology — Cell Physiology*, Vol. 320, Issue 3, März 2021, C375—C91.

Gökhan S. Hotamisligil, Narinder S. Shargill, Bruce M. Spiegelman, »Adipose Expression of Tumor Necrosis Factor- α : Direct Role in Obesity-Linked Insulin Resistance«, in: *Science*, Vol. 259, Issue 5091, 01.01.1993, 87—91.

- 39 Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind keine Krankheit, sondern ein Sammelbegriff für Folgezustände. Der häufigste unabhängige Risikofaktor ist Adipositas. Wenn der Sammelbegriff auf Platz Eins der Todesursachen steht und Adipositas sein häufigster Treiber ist, dann ist Adipositas die häufigste Todesursache.

CVD weltweit häufigste Todesursache: Gregory A. Roth, George A. Mensah, Catherine O. Johnson, et al., »Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990–2019: Update From the GBD 2019 Study«, in: *Journal of the American College of Cardiology*, Vol. 76, Issue 25, 22.12.2020, 2982—3021.

Fettleibigkeit als Haupttreiber: Tiffany M. Powell-Wiley, Chair Paul Poirier, Vice Chair Lora E. Burke, et al., »Obesity and Cardiovascular Disease«, in: *Circulation*, Vol. 143, Issue 21, 22.04.2021, e984—e1010.

abbaubar. Sie lagern sich über Jahre im Körper ein. Solange das Fett bleibt, bleiben sie eingesperrt. Die Toxikologie nennt es *Body Burden*, Körperlast. Je mehr Fettgewebe, desto größer das Depot. Wer abnimmt, setzt sie frei. Dreißig Kilo Fettabbau bedeuteten dreißig Kilo freigesetzte Altlasten in meinem Blutkreislauf.

Der Körper ist ein exzellenter Lügner. Wer glaubt, er sei da raus, weil er schlank ist, hat sein Organfett noch nie auf einem MRT gesehen. Viele schlanke Menschen haben genauso viel davon wie sichtbar Fettleibige.⁴⁰

Wer Fleisch isst, sollte wissen, was da drin ist. Konventionelles Fleisch heißt Antibiotika-Rückstände. Das ist das Zeug, mit dem man Tiere mästet. Und sie mästen auch Menschen, wie Studien belegen. Sie treiben die Übergewichtsepidemie voran. Sie räumen die Darmflora aus⁴¹, besonders wenn sie früh im Leben gegeben werden⁴². Was danach fehlt, lässt sich nicht ersetzen.⁴³ Gestörte

40 Knapp die Hälfte der normalgewichtigen Frauen und sechzig Prozent der normalgewichtigen Männer tragen übermäßiges viszerales Fett (TOFI — »Thin Outside, Fat Inside«).

E. Louise Thomas, Gary Frost, Simon D. Taylor-Robinson, Jimmy D. Bell, »Excess body fat in obese and normal-weight subjects«, in: *Nutrition Research Reviews*, Vol. 25, Issue 1, Juni 2012, 150—61.

Karine R. Sahakyan, Virend K. Somers, Juan P. Rodriguez-Escudero, et al., »Normal-Weight Central Obesity: Implications for Total and Cardiovascular Mortality«, in: *Annals of Internal Medicine*, Vol. 163, No. 11, 01.11.2015, 827—35.

41 Jay-Hyun Jo, Catriona P. Harkins, Nicole H. Schwardt, et al., »Alterations of human skin microbiome and expansion of antimicrobial resistance after systemic antibiotics«, in: *Science Translational Medicine*, Vol. 12, Issue 625, 22.12.2021, eabd8077.

42 Aya Yaqoub Jasim, Maryam Tareq Dahham, Saraa M. Harbi, et al., »Long-Term Effects of Antibiotic Usage on Gut Microbiota in Livestock«, in: *Journal of Animal Health and Production*, Vol. 13, Juni 2025, 511—6.

43 Laura M. Cox, Martin J. Blaser, »Antibiotics in early life and obesity«, in: *Nature Reviews Endocrinology*, Vol. 11, Issue 3, März 2015, 182—90.

Hautbarriere, beschleunigte Zellalterung.⁴⁴ Die Entzündung, die wir Altern nennen, ist keine Eigenschaft des Organismus. Sie ist eine Eigenschaft der Mikrobiota. Tausche die Flora, tausche das Altern.⁴⁵

WAS WIR SCHLUCKEN

Um den Nebel im Kopf zu vertreiben, den der Schaden verursacht, trinken wir Kaffee — oft gleich nach dem Aufwachen, wenn der natürliche Cortisolspiegel am höchsten ist.⁴⁶ Das Cortisol macht uns ohnehin wach. Der Kaffee legt einen Stresshormon-Überschuss obendrauf, den wir fälschlich für den Wachkick halten. Wir erhöhen die Konzentration von Stresshormonen mit einer Substanz, die wir gegen Stress trinken. Der dauerhaft erhöhte Cortisolspiegel fördert Insulinresistenz und lagert viszerales Fett ein. Dann wundern wir uns, dass wir Fett einlagern, obwohl Kaffee doch keine Kalorien hat. Und dass

44 Magnus S. Ågren, Reinhild Schnabel, Lise H. Christensen, Ursula Mirastschijski, »Tumor necrosis factor- α -accelerated degradation of type I collagen in human skin is associated with elevated matrix metalloproteinase (MMP)-1 and MMP-3 ex vivo«, in: *European Journal of Cell Biology*, Vol. 94, Issue 1, Januar 2015, 12–21.

TNF- α beschleunigt den Abbau von Typ-I-Kollagen signifikant. Das Kollagen wird aktiv zerstört. Die Entzündung frisst die Struktur der Haut.

45 Kausaler Nachweis, nicht Korrelation.

Netusha Thevaranjan, Alicja Puchta, Christian Schulz, et al., »Age-Associated Microbial Dysbiosis Promotes Intestinal Permeability, Systemic Inflammation, and Macrophage Dysfunction«, in: *Cell Host & Microbe*, Vol. 21, Issue 4, 12.04.2017, 455–66.

46 William R. Lovallo, Thomas L. Whitsett, Mustafa al'Absi, et al., »Caffeine Stimulation of Cortisol Secretion across the Waking Hours in Relation to Caffeine Intake Levels«, in: *Psychosomatic Medicine*, Vol. 67, Issue 5, 2005, 734–9.

unsere Blutzuckerwerte so hoch sind, obwohl wir uns ketogen ernähren.⁴⁷

Dann nehmen wir Supplemente, um uns besser zu fühlen, und um das Defizit auszugleichen, das der Kaffee verursacht hat, weil Kaffee deren Aufnahme blockiert.⁴⁸ Die Polyphenole binden Mineralstoffe im Nahrungsbrei und machen sie für den Körper unverfügbar.

Kaffee ist der unsichtbare Treiber des Supplementmarkts. Er verursacht Nährstoffmangel auf Populationsebene⁴⁹, und gleichzeitig explodiert der Markt für genau die Stoffe, die er dem Körper entzieht⁵⁰. Siebzig Prozent der Bevölkerung nehmen

47 Koffein → Cortisol → Insulinresistenz → Blutzucker → viszerale Fetteinlagerung

Shi Xiaolin, Xue Wanqing, Liang Shuohua, et al., »Acute caffeine ingestion reduces insulin sensitivity in healthy subjects: a systematic review and meta-analysis«, in: *Nutrition Journal*, Vol. 15, Nr. 1, 28.12.2016, Art. 103.

Jean-Pierre Després, Isabelle Lemieux, »Abdominal obesity and metabolic syndrome«, *Nature*, Vol. 444, 13.12.2006, 881—7.

Renato Pasquali, Valentina Vicennati, Marco Cacciari, Uberto Pagotto, »The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Activity in Obesity and the Metabolic Syndrome«, in: *Annals of the New York Academy of Sciences*, Vol. 1083, November 2006, 111—28.

48 Thomas A. Morck, Steven R. Lynch, James D. Cook, »Inhibition of food iron absorption by coffee«, in: *American Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 37, No. 3, März 1983, S. 416—20.

Prema B. Rapuri, J. C. Gallagher, Zafar Nawaz, »Caffeine decreases vitamin D receptor protein expression and 1,25(OH)₂D₃ stimulated alkaline phosphatase activity in human osteoblast cells«, in: *The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*, Vol. 103, Issues 3—5, März 2007, 368—71.

49 Hinako Nanri, Megumi Hara, Yuichiro Nishida, et al., »Association between green tea and coffee consumption and body iron storage in Japanese men and women: a cross-sectional study from the J-MICC Study Saga«, in: *Frontiers in Nutrition*, Vol. 10, 10.08.2023, 1249702.

50 Nutzungsrate 2018: 54 Prozent. 2023: 65 Prozent. 2025: 70 Prozent. Mintel, »Nahrungsergänzungsmittel Deutschland«, 2023 und 2025.

Supplemente.⁵¹ Mindestens genauso viele trinken Kaffee.⁵² Und niemand rechnet das zusammen. Eine Substanz, die die Aufnahme von Eisen, Calcium, Magnesium, Zink, Vitamin D und B-Vitaminen um bis zu achtzig Prozent senkt⁵³, wird von denselben Menschen konsumiert, die sich diese Stoffe anschließend in Kapselform zuführen. Der Kaffee reißt das Loch, die Kapsel füllt es. Die Supplementindustrie interessiert das nicht. Die Kaffeebranche erst recht nicht. So wie die Tabakindustrie kein Interesse daran hat, auf ihre Produkte zu schreiben, dass Rauchen den Intelligenzquotienten verringert.⁵⁴

51 Mintel, »Nahrungsergänzungsmittel Deutschland«, 2025 (Nutzungsrate). Marktvolumen nach IQVIA.

52 Deutscher Kaffeeverband, Kaffee-Konsum-Studie, 2024.

53 Thomas A. Morck, Steven R. Lynch, James D. Cook, »Inhibition of food iron absorption by coffee«, in: *American Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 37, Issue 3, März 1983, 416—20.

Tsedeki Wolde, »Effects of caffeine on health and nutrition: A Review«, in: *Food Science and Quality Management*, Vol. 30, 2014, 59—65.

54 Rauchen schrumpft das Gehirn. Der Effekt ist kausal und irreversibel.

Yoonhoo Chang, Vera Thornton, Ariya Chaloehtom, et al., »Investigating the Relationship Between Smoking Behavior and Global Brain Volume«, in: *Biological Psychiatry: Global Open Science*, Vol. 4, No. 1, Januar 2024, 74—82.

Raucher bauen kognitiv schneller ab als Nichtraucher, unabhängig von Bildung, Alkohol und Vorerkrankungen.

Séverine Sabia, Alexis Elbaz, Aline Dugravot, et al., »Impact of Smoking on Cognitive Decline in Early Old Age: The Whitehall II Cohort Study«, in: *Archives of General Psychiatry*, Vol. 69, No. 6, Juni 2012, 627—35.

Oder dass anderthalb Schachteln am Tag das Bronchialepithel so stark bestrahlen wie dreihundert Röntgenaufnahmen im Jahr.⁵⁵ Die Industrie weiß das seit den 1960er Jahren.⁵⁶

Wir verzichten auf Zucker und haben trotzdem Glukosespitzen, weil das Smartphone in der Tasche den Körper mit Stresshormonen flutet.⁵⁷

Wir werden dick, krank und hässlich, weil elektromagnetische Felder unsere Zellteilung stören⁵⁸, erzählen uns aber lieber, dass wir zu wenig Sport treiben.

55 Constantin Papastefanou, »Radioactivity of Tobacco Leaves and Radiation Dose Induced from Smoking«, in: *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 6, Issue 2, 05.02.2009, 558—67.

T. H. Winters, J. R. Di Franza, »Radioactivity in Cigarette Smoke«, in: *New England Journal of Medicine*, Vol. 306, No. 6, 11.02.1982, 364—5.

56 Monique E. Muggli, Jon O. Ebbert, Channing Robertson, Richard D. Hurt, »Waking a Sleeping Giant: The Tobacco Industry's Response to the Polonium-210 Issue«, in: *American Journal of Public Health*, September 2008, Vol. 98, Issue 9, 1643—50.

57 Exposition verändert signifikant Cortisol-Sekretionsmuster.

Yvan Tuitou, Brahim Selmaoui, Jacques Lambrozo, »Assessment of cortisol secretory pattern in workers chronically exposed to ELF-EMF generated by high voltage transmission lines and substations«, in: *Environment International*, Vol. 161, März 2022, 107103.

Fünfzehn Minuten in einem 60-Hz-Magnetfeld genügten, um den Blutzucker zu erhöhen und die Insulinausschüttung zu dämpfen.

Gabriel Martiñón-Gutiérrez, María Luna-Castro & Rolando Hernández-Muñoz, »Role of insulin/glucagon ratio and cell redox state in the hyperglycaemia induced by exposure to a 60-Hz magnetic field in rats«, in: *Scientific Reports*, Vol. 11, 03.06.2021, 11666.

EMF → Stresshormone → Glukosespitzen

58 Gestörte Zytokinese und induzierter Zelltod.

Michael Kundi, Armen Nersesyan, Gernot Schmid, et al., »Mobile phone specific radiation disturbs cytokinesis and causes cell death but not acute chromosomal damage in buccal cells: Results of a controlled human intervention study«, in: *Environmental Research*, Vol. 251, Part 1, 15.06.2024, 118634.

Oder wir gewöhnen uns einfach daran, dick und hässlich zu sein, indem wir es »normal« nennen, oder genetisch.

Oder wir schieben es auf das Alter, dass wir andauernd Dinge vergessen, neben der Spur sind, uns nicht konzentrieren können — selbstwertrettende Narrative, gerade so stabil genug, uns davon abzuhalten, wahlweise einander oder uns selbst umzubringen.

Jede dieser Erklärungen funktioniert genau so lange, wie man nicht nachmisst. Und weil niemand nachmisst, wird die Wahrnehmung selbst postfaktisch und wir reden uns Fettleibigkeit schön.

Oder wir drehen völlig durch und versuchen, den Ekel vor schädlichen Substanzen gleich ganz abzuschalten, der dreihunderttausend Jahre unser Überleben sicherstellte. Insekten als neuartige Lebensmittel⁵⁹, die Chitin enthalten, das Entzündungen fördert und anfällig für Infektionen macht⁶⁰.

59 Mehlwurm (*Tenebrio molitor*): Zulassung Juni 2021. Wanderheuschrecke (*Locusta migratoria*): November 2021.

60 Tierische Produkte erzeugen eine hohe renale Säurelast (PRAL; Hartkäse bis 23,6 mEq/100 g). Chronische Übersäuerung fördert Insulinresistenz, Knochenabbau und Nierenerkrankungen.

Thomas Remer, Friedrich Manz, »Potential Renal Acid Load of Foods and Its Influence on Urine pH«, in: *Journal of the American Dietetic Association*, Vol. 95, Issue 7, Juli 1995, 791—7.

I. A. Osuna-Padilla, G. Leal-Escobar, C. A. Garza-García, »Dietary acid load: Mechanisms and evidence of its health repercussions Carga ácida de la dieta; mecanismos y evidencia de sus repercusiones en la salud«, in: *Nefrología*, Vol. 39, Issue 4, Juli–August 2019, 343—54.

Chitin, das Strukturpolymer im Exoskelett aller Insekten, aktiviert das angeborene Immunsystem über TLR-2 und Dectin-1, löst Entzündungsreaktionen aus (Eosinophilenrekrutierung, Zytokinproduktion: IL-4, IL-5, IL-13) und schwächt über chronische Entzündung die Immunabwehr — mit erhöhter Anfälligkeit für Infektionen und Tumorerkrankungen.

Daniel Elich Ali Komi, Lokesh Sharma, Charles S. Dela Cruz, »Chitin and Its Effects on Inflammatory and Immune Responses«, in: *Clinical Reviews in Allergy and Immunology*, Vol. 54, Issue 2, April 2018, 213—23.

Und bei jedem Windhauch reagieren wir über. Aber statt nachzumessen, spielen wir Sprachpolizei und erklären der Mitwelt Triggerpunkte, die einer Psyche erwachsen, die nicht einmal die eigene ist. Weil wir gar keinen Unterschied mehr erkennen zwischen dem, was wir fühlen, dem, was wir sind, und dem, was der Fall ist.

Viele von uns bewohnen ihren Körper so wenig, dass sie ihren ansteigenden Stresslevel lieber auf die sogenannte Digitalisierung schieben als auf die Stoffe, die in ihrer Blutbahn landen. Wir bewohnen unseren Verstand so sehr, dass wir die Meinungen eines kontaminierten Organs für unsere eigenen halten.

Jede Epoche hat eine chemische Signatur. Unsere schreibt sich in schrumpfende Gehirne. Verändert sich die Substanz, verändert sich die Zivilisation. Am 12. Juli 1789 sprang Camille Desmoulins im Café de Foy auf einen Tisch.

Aux armes!

Zwei Tage später stürmten sie die Bastille. Europa hatte jahrhundertlang im alkoholischen Nebel gelebt. Alkohol war sicherer als Wasser. Es gab keine Alternative. Kaffee wechselte den Wirkstoff.⁶¹ Die Aufklärung, auf die sich alle berufen, wurde in Kaffeehäusern geschrieben, die Revolution in einem gezündet.⁶²

Tiffany A. Reese, Hong-Erh Liang, Andrew M. Tager, et al., »Chitin induces accumulation in tissue of innate immune cells associated with allergy«, in: *Nature*, Vol. 447, Issue 7, 22.04.2007, 92—6.

David Furman, Judith Campisi, Eric Verdin, et al., »Chronic Inflammation in the Etiology of Disease across the Life Span«, in: *Nature Medicine*, Vol. 25, Issue 12, 05.12.2019, 1822—32.

61 Tom Standage, *A History of the World in 6 Glasses*, New York 2005, Kapitel 8. Michael Pollan, *This Is Your Mind on Plants*, New York 2021, Teil 2 (»Caffeeine«).

62 Brian Cowan, *The Social Life of Coffee: The Emergence of the British Coffeehouse*, New Haven 2005.

Dieselben Gehirne, anderes Molekül, andere Zivilisation. Die Aufklärer hielten sich für nüchtern. Sie waren auf Koffein.

Was wir Vernunft nennen, war eine Dosis. Und unsere Dosis hat gewechselt.

Menschen sind Reaktionsgefäße. Verhalten und Persönlichkeit sind chemische Reaktionen. Charakter ist Ergebnis von Exposition. Entferne ich den Stoff, entferne ich das Verhalten; füge ich einen hinzu, werde ich ein anderer Mensch. Die Rede vom autonomen Handlungssubjekt ist eine Rede ohne Gegenwert im Wirklichen — sie behauptet einen Akteur, wo nur Reaktionen ablaufen. Am Ende nennt das Sediment sich Ich, verwechselt Exposition mit Identität, Vergiftung mit Altern, Entzündung mit Depression. Die Stoffe schädigen genau die Hirnregionen, die für Selbstwahrnehmung zuständig sind. Und das Organ, das den Irrtum korrigieren müsste, ist aus ihm gebaut.

Es sickert noch immer. In fünfzig Jahren werden Historiker fragen, warum wir nichts taten.

Es wird niemanden geben, der die Frage versteht.

VIER ZUTATEN UND EINE LÜGE

Die Brauerei stabilisiert das Bier mit Plastik. Das Plastik stabilisiert deine Unfähigkeit, das zu begreifen.

Das Reinheitsgebot hat vier Zutaten und eine Lüge. Wasser, Hopfen, Malz, Hefe.¹

Es gilt als ältestes Lebensmittelgesetz der Welt. 1516 und so. Und als Beweis dafür, dass deutsche Bierkultur Qualität bedeutet. Was es nicht erwähnt: die Kunststoffgranulate, mit denen das Bier gefiltert wird, bevor es in die Flasche kommt. Polyvinylpolypyrrolidon, kurz PVPP.² Ein synthetisches Polymer, das Trübstoffe bindet und dann — angeblich restlos — wieder entfernt wird.³

Angeblich.

1 Plus alles, was man nicht zählt.

2 PVPP (Polyvinylpolypyrrolidon) ist ein unlösliches synthetisches Polymer, das Polyphenole und Gerbstoffe bindet und nach der Filtration abfiltriert wird. Bier mit PVPP-Stabilisation bleibt bis zu 18 Monate klar; ohne PVPP trübt es nach ca. drei Monaten. Nahezu alle Großbrauereien setzen das Verfahren ein.

Wolfgang Kunze, *Technologie Brauer und Mälzer*, 11. Aufl., Berlin 2016, Kap. 13 u. 14.

3 Seit der Neufassung des Biersteuergesetzes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I 2150) ist PVPP (E 1202) als technischer Hilfsstoff zugelassen. Bierverordnung (BierV) vom 29. Juli 1993 (BGBl. I 1399). Als Verarbeitungshilfsstoff unterliegt es gemäß Art. 20 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 keiner Kennzeichnungspflicht. Legal im Bier, unsichtbar auf dem Etikett.

Das Perfide am Mikroplastik ist, dass es nach nichts schmeckt. Das Perfide am Hirnschaden ist, dass er nicht wehtut. Mikroplastik ist in handelsüblichem Bier nachgewiesen. Nicht in Spuren Mengen, die man philosophisch wegdiskutieren könnte, sondern in Konzentrationen, die man messen, zählen, fotografieren kann.⁴ Bei deutschem Durchschnittskonsum schluckt ein Biertrinker rund achttausend Plastikpartikel im Jahr. Nur

-
- 4 Gerd Liebezeit, Elisabeth Liebezeit, »Synthetic particles as contaminants in German beers«, in: *Food Additives & Contaminants: Part A*, Vol. 31, 11.08.2014, Issue 9, 1574—8.

Analysiert wurden 24 deutsche Biermarken; in sämtlichen Proben wurden synthetische Kontamination nachgewiesen (2—79 Fasern/L, 12—109 Fragmente/L, 2—66 Granulate/L).

Dirk W. Lachenmeier, Jelena Kocareva, Daniela Noack, Torsten Kuballa, »Microplastic identification in German beer — an artefact of laboratory contamination?«, in: *Deutsche Lebensmittel-Rundschau*, Vol. 111, Issue 10, 01.10.2015, 437—40.

Diese Gegenstudie konnte die Ergebnisse von Liebezeit-Liebezeit 2014 nicht reproduzieren und kritisierte methodische Mängel, insbesondere die Verwendung des Farbstoffs Rose Bengal, der PVPP-Partikel falsch-negativ ausschließt. Lachenmeier kritisiert die Zählmethodik einer einzelnen Studie. Die Existenz von Mikroplastik im Bier widerlegt er nicht. Drei internationale Studien bestätigen sie seitdem (Socas-Hernández et al. 2024, Kosuth et al. 2018, Chaïb et al. 2025).

Cristina Socas-Hernández, Pablo Miralles, Javier González-Sálamo, et al., »Assessment of anthropogenic particles content in commercial beverages«, in: *Food Chemistry*, Vol. 447, 30.07.2024, Art. 139002.

Getränke verschiedener Kategorien analysiert. Bier wies mit durchschnittlich $95,5 \pm 91,8$ Partikeln/L die höchste Belastung aller untersuchten Getränkekategorien auf.

Martin Kosuth, Sherri A. Mason, Elizabeth V. Wattenberg, »Anthropogenic contamination of tap water, beer, and sea salt«, in: *PLOS ONE*, Vol. 13, Issue 4, 11.04.2018, e0194970.

US-Biermarken untersucht. Durchschnittlich 4,05 anthropogene Partikel pro Liter, 98,4 Prozent davon Fasern.

durchs Bier.⁵ Der Durchschnitt rechnet den mit ein, der einmal im Monat ein Radler trinkt. Wer jeden Abend zwei Flaschen aufmacht, liegt bei über dreißigtausend.⁶ Bier ist der Hauptgrund dafür, dass Erwachsene doppelt so viel Mikroplastik aufnehmen wie Kinder.⁷

Die Brauereien wissen das.⁸

Ich schrieb sechzehn von ihnen an. Autoimmunerkrankung, chronische Probleme mit Mikroplastik. Ich benutzte die Wahrheit als Recherchewerkzeug.

Iseline Chaïb, Périne Doyen, Pauline Merveille, et al., »Microplastic contaminations in a set of beverages sold in France«, in: *Journal of Food Composition and Analysis*, Vol. 144, August 2025, 107719.

Kontaminationsanalyse verschiedener in Frankreich verkaufter Getränke. Bier wies mit durchschnittlich $82,9 \pm 13,9$ MP/L die höchste Belastung aller untersuchten Getränkekategorien auf. Hauptquelle in Glasflaschen: Abrieb der Lacke auf Metallverschlüssen. Getränke in Glasflaschen wiesen signifikant höhere Kontamination auf als identische Produkte in Plastikflaschen. In einem Isolationsexperiment genügte ein einziger fabrikneuer Kronkorken, um 287,3 Partikel pro Liter in zuvor partikelfreiem Wasser zu erzeugen. Die Mehrheit in der Farbe des Verschlusses.

Die absoluten Konzentrationen variieren studienübergreifend erheblich (vier bis 109 Partikel/L), bedingt durch unterschiedliche Nachweisverfahren (Raman-Spektroskopie, μ -FTIR, visuelle Mikroskopie). Der Befund bleibt eindeutig: Sämtliche Studien, unabhängig von Methode und Herkunftsland, weisen Mikroplastik in Bier nach. Keine einzige Probe war partikelfrei.

5 95,5 Partikel pro Liter (Socas-Hernández et al. 2024) mal 89,4 Liter Pro-Kopf-Verbrauch Deutschland 2023 (Barth-Haas Group, *BarthHaas Bericht 2023/2024*, Nürnberg 2024) $\approx$ 8.538 Partikel/Jahr. Selbst der konservativste Wert (Kosuth et al. 2018: 4,05 Partikel/Liter) ergibt über 360 Partikel jährlich.

6 Bei 365 Liter pro Jahr (zwei Flaschen à 0,5 L täglich): $\approx$ 34.858 Partikel.

7 Socas-Hernández et al. 2024.

8 Fn. 2 (Verfahren) u. Fn. 3 (Rechtsgrundlage).

Manche waren ehrlich. Andere logen. Wieder andere wussten es vermutlich selbst nicht. Im Bio-Segment existiert das Problem kaum. Überall sonst ist es Standard.⁹

Spaten brauchte drei Absätze, um »*branchenüblich*« zu sagen. Übersetzt: Ja, PVPP.

Benediktiner brauchte ebenfalls drei Absätze, um dasselbe zu sagen, verpackt in Zusicherungen, das Polymer werde »vollständig aus dem Endprodukt entfernt« — dieselbe Brauerei, die mit »Respekt vor den guten Dingen der Natur« und »Benediktinischen Prinzipien« wirbt.

Erdinger schrieb einen Satz: »*Wir bei ERDINGER verwenden grundsätzlich kein PVPP.*«

Für keine einzige Sorte.

Also geht es ohne — »glanzfein« sogar.

Die Industrie behauptet Unverzichtbarkeit. Ein einziger Satz aus Erding widerlegt sie.¹⁰

Warum benutzen es die anderen trotzdem?

9 Liste meiner getesteten Biere:

Kein PVPP: Härle Bio, Neumarkter Lammsbräu (alle Sorten), Kloster Scheyern (Kloster Gold), Wunderbrau, Hopp Bio-Kellerbier, Hasen Hell, Erdinger (alle Sorten), Riedenburger, Adambier Bergmann.

PVPP: Benediktiner Hell, Spaten Münchner Hell, Budvar, Bitburger, Becks, Krombacher, Sternburg.

Unklar/keine Antwort: Meckatzer, Pilsener Urquell, Weihestephaner, Staropramen, Carlsberg.

PVPP wird primär zur Stabilisierung filtrierter Biere eingesetzt; naturtrübe Biere verzichten häufig auf diese Form der Polyphenolstabilisierung (Kunze 2016). Zu Einschränkungen bei ökologischer Herstellung: Verordnung (EU) 2018/848 über die ökologische/biologische Produktion.

10 Sämtliche Brauerei-Antworten mit Datum:

Kloster Scheyern, Email vom 10.11.2023: »Polymere-Kunststoffe kommen als Filterhilfsmittel also nicht zum Einsatz. Wir brauen streng konform zum Reinheitsgebot und verwenden keinerlei Hilfsstoffe.« [Membranfiltration]

Weil trübes Bier sich schlechter verkauft. Das ist der gesamte Grund. Der Grund für PVPP ist *kosmetisch*. Es ist billiger, dein Gehirn zu kontaminieren, als dem Verbraucher beizubringen, dass gutes Bier trüb sein darf. Dein Bier soll golden leuchten, nicht aussehen wie das, was es ist. Die Fasern, die dabei ins Bier geraten, sind transparent. Sie verschwinden im klaren Bier. Die Kosmetik erzeugt die Kontamination und macht sie unsichtbar. Der Filter, der das Bier reinigen soll, ist selbst die Quelle der Kontamination.

Die Brauerei schreibt vier Zutaten aufs Etikett. Was sie durchs Bier jagt, steht nirgends. Was es durch dein Hirn jagt, nennst du Feierabend. Das Reinheitsgebot ist ein Siegel auf einer Plastiktüte. Es regelt, was ins Bier hineinkommt. Nicht, was hindurchgeht. Ein fabrikneuer Kronkorken reicht. 287 Plastikpartikel pro Liter, in der Farbe des Deckels. Glasflaschen sind stärker

Hasen Hell, Email vom 15.11.2023: »Das gute Hasen Hell wird mittels einer Membranfiltration von Trüb- und Schwebstoffen befreit, bevor es abgefüllt wird. PVPP kommt nicht zum Einsatz.«

Erdinger Brauhaus, Email vom 15.11.2023: »Wir bei ERDINGER verwenden grundsätzlich kein PVPP. Diese Aussage gilt für alle unsere Bierspezialitäten — ganz egal ob unter- oder obergärig, mit oder ohne Alkohol, hefetrüb oder glanzfein filtriert.«

Benediktiner, Email vom 16.11.2023: »Zusätzlich zu Kieselgur verwenden wir zur selektiven Entfernung weiterer Trübstoffe ein Kunstharz, das als PVPP bekannt ist. [...] Das PVPP wird im Filtrationsprozess wieder vollständig aus dem Bier entfernt.«

Spaten Münchner Hell, Email vom 13.11.2023: »Grundsätzlich ist es branchenüblich, dass zur Bierfiltration und Stabilisierung Hefen und Gerbstoffe entfernt werden. Dazu werden u.a. Kieselgur und PVPP eingesetzt [...] Dementsprechend wird auch unser Spaten mit PVPP gefiltert.«

Budweiser Budvar, Email vom 03.03.2026: »Unsere Biere werden mit PVPP gefiltert, das unlösliches Polyvinylpyrrolidon enthält. Wir verwenden keine Kunststoffgranulate. Bei PVPP kann es zu einer minimalen Verunreinigung des Bieres mit Mikroplastik kommen.«

kontaminiert als Plastikflaschen.¹¹ Wer Glas wählt, weil er Plastik vermeiden will, bekommt mehr davon. In einer Abfüllanlage laufen hunderttausend Flaschen pro Stunde. Niemand wäscht die Deckel.

Bügelverschlüsse haben dieses Problem übrigens nicht.¹² Plopp ist so gesehen sauberer als Zisch.

Bis 2005 gehörte sogar Asbest zu den Filterhilfsstoffen.¹³ Als ich als Kind das erste Mal an einem Bier nippte, habe ich es *vermutlich* getrunken.

Mein Mitbewohner trank fast nur Augustiner¹⁴. Wenn ich das Bier kritisierte, sagte er: »*Das ist ja Kulturschändung.*«

Er meinte das ernst.

Er verteidigte ein Produkt, das in jeder Berliner Spätkauf-Kühltheke steht, als wäre es ein handgeschöpftes Artefakt fränkischer Braukunst. In Wahrheit ein industrielles Massenprodukt mit Marketingbudget, größer als die Jahresproduktion der meisten Klosterbrauereien. Gefiltert mit Plastik. Verkauft unter einem Reinheitsversprechen, das die Filtration schlicht nicht mitzählt.

11 Chaïb et al. 2025.

12 Der Verschluss besteht aus Porzellan oder Kunststoff mit Gummidichtung. Kein lackiertes Metall berührt das Bier. Forscher fanden auch bei Wein mit Korkverschluss kaum Mikroplastik, weil die Kontaminationsquelle wegfiel. Eine direkte Untersuchung von Bügelverschlüssen steht zwar noch aus, aber der Mechanismus ist identisch.

Chaïb et al. 2025.

13 Die technische Positivliste der Brauereitechnologie nennt über 50 nicht deklarationspflichtige Verarbeitungshilfsstoffe, u. a. Aktivkohle, Kieselgur/Perlit, Cellulose, Schwefel- und Phosphorsäure zur Leitfähigkeits- bzw. pH-Steuerung sowie das Kunststoffpolymer PVPP; Kunze 2016. Asbest wurde historisch als Filterhilfsstoff eingesetzt (Patentschrift EP 0031522 A2, 1981). EU-Verbot: Richtlinie 1999/77/EG; Umsetzung DE: 1. Jan. 2005.

14 Lager Hell.

Kulturschändung ist, wenn man weiß, was drin ist. Demenz ist, wenn man vergisst, was man trinkt. Kultur ist, wenn man es feiert.

Die Partikel überwinden die Blut-Hirn-Schranke. Nach zwei Stunden sind sie im Hirngewebe.¹⁵ Sie bleiben dort. Fünfzig Prozent mehr in acht Jahren. Bei Demenzkranken zehnmal so viel.¹⁶ Sie stören synaptische Übertragung, fördern neuroinflammatorische Prozesse.¹⁷ Sie verkeilen sich in Kapillaren und schneiden Hirngewebe von der Sauerstoffversorgung ab. Mikroinfarkte, die niemand bemerkt.¹⁸ Mikroplastik passiert die Blut-Hirn-Schranke. Der Gedanke nicht mehr.

-
- 15 Verena Kopatz, Kevin Wen, Tibor Kovács, et al., »Micro- and Nanoplastics Breach the Blood–Brain Barrier (BBB): Biomolecular Corona's Role Revealed«, in: *Nanomaterials*, Vol. 13, Issue 8, 19.04.2023, Art. 1404.

Computermodelle und In-vivo-Mausversuche zeigten, dass Nanoplastikpartikel die Blut-Hirn-Schranke durchdringen.

- 16 Alexander J. Nihart, Maria A. Garcia, Elias El Hayek et al., »Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains«, in: *Nature Medicine*, Vol. 31, Issue 4, 03.02.2025, 1114–9.

Zentrale Befunde: Mikroplastikkonzentrationen im Hirngewebe sind 7- bis 30-fach höher als in Leber oder Niere. Zwischen 2016 und 2024 stieg die mediane Konzentration im Gehirn von 3.345 µg/g auf 4.917 µg/g ($p = 0,01$). Ein Anstieg von rund fünfzig Prozent in acht Jahren. Hirngewebe von Personen mit Demenzdiagnose wies bis zu zehnfach höhere Plastikkonzentrationen auf. Polyethylen war das dominante Polymer.

- 17 Su-jun Fang, Zhao-di Yin, Li-fan Li, et al., »Overall effects of microplastics on brain«, in: *Frontiers in Toxicology*, Vol. 7, 20.11.2025, Art. 1619096.

Mikro- und Nanoplastik passieren Blut-Hirn-Schranke und Plazenta, erzeugen oxidativen Stress, chronische Neuroinflammation (Mikroglia-/Astrozyten-Aktivierung), mitochondriale Dysfunktion, Neurotransmitter-Störungen und direkte Neuronenschäden; Nanoplastik fördert α -Synuclein-Aggregation. Modelle zeigen Lern- und Gedächtnisdefizite sowie Angst-, Depressions- und Sozialverhaltensstörungen.

- 18 Haipeng Huang, Jiaqi Hou, Mingxiao Li, et al., »Microplastics in the bloodstream can induce cerebral thrombosis by causing cell obstruction and lead

Wer sein Bier verteidigt, beweist, dass es wirkt. Man trinkt sich die Fähigkeit weg, zu verstehen, was man sich wegrinkt.¹⁹

Mein Mitbewohner nannte es Kultur. Sein Gehirn nennt es Entzündung.²⁰

to neurobehavioral abnormalities«, in: *Science Advances*, Vol. 11, Issue 4, 22.01.2025, eadr8243.

Mikroplastik wurde von Immunzellen phagozytiert; die beladenen Zellen blockierten Hirnkapillaren, bildeten Thromben, verringerten die zerebrale Durchblutung und lösten signifikante kognitive Defizite aus.

- 19 Genghuan Wang, Yingcong Lin, Heping Shen, »Exposure to polystyrene microplastics promotes the progression of cognitive impairment in Alzheimer's disease: association with induction of microglial pyroptosis«, in: *Molecular Neurobiology*, Vol. 61, 2024, 900—7.

PS-Mikroplastik beschleunigte Alzheimer-typische Lern- und Gedächtnisdefizite; vermittelt über NLRP3-abhängige Mikroglia-Pyroptose und verstärkte β -Amyloid-Pathologie.

Lauren Gaspar, Sydney Bartman, Giuseppe Coppotelli, Jaime M. Ross, »Acute Exposure to Microplastics Induced Changes in Behavior and Inflammation in Young and Old Mice«, in: *International Journal of Molecular Sciences*, Vol. 24, 01.08.2023, Art. 12308.

Dreiwöchige Trinkwasser-Exposition (C57BL/6J-Mäuse, 0,1 plus 2 μ m PS-Mikroplastik) führte zu Akkumulation in allen Organen einschließlich Gehirn, demenzähnlichen Verhaltensänderungen und altersabhängiger GFAP-Reduktion in Hippocampus und Präfrontalcortex — mit Alzheimer-Stadien korrelierter Marker.

- 20 Mikroplastik beeinträchtigt synaptische Plastizität und Acetylcholinesterase-Aktivität. Beides Voraussetzungen dafür, neue Informationen gegen bestehende Überzeugungen abzuwägen. Das Gehirn, das den Zusammenhang zwischen Bierkonsum und Hirnschädigung verleugnet, operiert bereits unter den Bedingungen, die dieser Konsum geschaffen hat (Kopatz et al. 2023, Nihart et al. 2025, Fang et al. 2025, Wang et al. 2024, Huang et al. 2025, Gaspar et al. 2023).

DIE KRANKHEIT, DIE ES NIE GAB

*Eine Diagnose ist eine Tür, die sich nur
von einer Seite öffnen lässt.*

Im 18. Jahrhundert verschrieben Ärzte Quecksilber. Im 21. verschreiben sie Citalopram. In beiden Jahrhunderten glaubten sie, zu helfen. Acht Jahre lang sonderbehandelte mich die Psychiatrie. Und niemand schaute hin.

Dafür wurden sie ja bezahlt.

Man brachte mich da hin, nachdem mich ein Mann in Herford — Ostwestfalen — entführte, in einem Wald vergewaltigte und mir zum Schluss eine geladene Pistole an den Kopf hielt. Ich war vierzehn. Die Polizei glaubte kein Wort und wies mich ein. Kinder- und Jugendpsychiatrie Bad Salzuflen hieß die Einrichtung. Der Mann, der mich erschießen wollte, blieb frei.

Als ich die Psychopharmaka verweigerte, fesselten sie mich an sieben Punkten und injizierten mir die Medikamente gewaltsam. Unter Risperdon lag ich tagelang im Bett, mich windend, heulend vor Schmerz.

Ich bettelte um Hilfe.

Sie standen da, die Pfleger, sahen mich an, taten nichts.

Unter Seroquel war ich ein Körper ohne Bewohner.¹ Stabilisierung nannten sie das. Ich würde es heute anders nennen:

1 Marco Solmi, Michele Fornaro, Edoardo G. Ostinelli, et al., »Safety of 80 antidepressants, antipsychotics, anti-attention-deficit/hyperactivity medications and mood stabilizers in children and adolescents with psychiatric

staatlich finanzierte Folter an Minderjährigen, ausgeführt von Leuten mit Dokortitel.

Irgendjemand hat daran verdient. Ich nicht.

Die Medikamente kosteten. Die Fixierung kostete. Meine Würde war umsonst.

Als die zuständige Psychologin mich ausfragte und mir meinen Wunsch entlockte, an einer Universität zu studieren und als Wissenschaftler zu arbeiten, erklärte sie mich für realitätsfremd. Sie notierte es als Symptom.

Viele Jahre später studierte ich an insgesamt vier Universitäten, darunter die Humboldt-Universität und die Freie Universität Berlin, und Horst Bredekamp bot mir eine Promotion an. Und ich arbeitete sogar selbst zeitweise in einer psychiatrischen Klinik. Die Psychose lag auf der anderen Seite des Schreibtischs. Aber sie hatte den Stempel.

Die Psychiatrie hat ein Verfahren für alles. Für Vergewaltigung gibt es Beruhigungsmittel. Für Ehrgeiz gibt es Diagnosen. Für Widerstand gibt es Fixierung. Nur für Irrtum gibt es nichts. Im Entlassungsbrief stand übrigens, ich hätte gut auf die Behandlung angesprochen.

Was die Psychiatrie in meinem Körper anrichtete, endete nicht mit der Entlassung. Zum Schweigen gebracht, begann ich zu essen und nicht wieder aufzuhören. Binge-Eating-Attacken. Danach passte meine Kleidung nicht mehr. Mein Körper wurde zum Schlachtfeld. Sie hatten mir die Selbstregulation rauslobotomiert. Mein Körper suchte Ersatz. Er fand Essen. Dreißig Kilo Spätfolgen, nicht abrechnungsfähig.

Ich nahm Citalopram jahrelang. Was ich esse, wie ich schlafe, ob ich mich bewege, fragte mich niemand. Meine Organe oder

disorders: a large scale systematic meta-review of 78 adverse effects«, in: *World Psychiatry*, Vol. 19, Issue 2, 11.05.2020, 214—32.

mein Blutbild haben sie nie untersucht. Sie medikamentierten das Signal und ignorierten die Quelle.

Nach dem Abitur und vor dem Studium war ich adipös und nahm ein Medikament, das mich gerade sediert genug hielt, um keine Fragen zu stellen. Depression stand auf dem Rezept. Und natürlich ging ich davon aus, dass Depression als Krankheit existiert. Schließlich hatte ich ja die Symptome. Dass die Symptome Nebenwirkungen waren, sagte mir kein Arzt. Dafür hätte er ja zugeben müssen, dass er sie verursacht hat.

Ein Jahr vor dem Studium wusste ich, ich würde mit diesem Übergewicht nicht richtig lernen können. Ich würde nicht denken können. Wie eine offene Entzündung fühlte sich mein Körper an.

Jahrelang dachte ich, Übergewicht sei einfach nur Übergewicht. Das Fett sei passiv. Ich konnte es nicht benennen, aber ich spürte, dass mein Körper zum Tatort geworden war.

Dann änderte ich alles. Was ich aß, wann ich schlief, mit wem ich meine Zeit verbrachte, wie oft ich meinen Körper bis an seine Grenzen trieb. Jede einzelne Veränderung war Krieg gegen einen Organismus, der sein eigenes Elend für Normalität hielt. Ich trainierte, bis mein Körper aufhörte, sich gegen mich zu wehren. Und als ich nach einem Jahr dreißig Kilo weniger wog, war die Depression verschwunden. Sie ging, als wäre sie nie dagewesen. Kein Ausschleichen, kein Übergang. Der Körper hörte auf, Alarm zu senden, weil es keinen Grund mehr gab. Neuroinflammation nennt das die Forschung.² Ich habe es am eigenen Schädel erlebt, bevor es in der Öffentlichkeit überhaupt einen Namen dafür gab. Die Psychiatrie nennt es immer noch Depression.

2 Andrew H. Miller, Charles L. Raison, »The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target«, in: *Nature Reviews Immunology*, Vol. 16, Issue 1, Januar 2016, 22—34.

Das Citalopram habe ich von einem Tag auf den anderen abgesetzt. Gegen den Rat der Ärzte, die ich danach nie wieder aufgesucht habe. Der Entzug war hart. Aber Citalopram hatte mir Persönlichkeit und Intelligenz genommen, und ich wollte beides zurück.

Ich steuerte gegen. Bewegung auf nüchternem Magen. Wildkräuter. Trinken von heißem, abgekochtem Wasser, Eisduschen. Die ersten Monate schrie ich bei jeder Eisdusche so laut, dass sich bald die Nachbarn beschwerten. Danach schrie ich nicht mehr. Ließ ich die Eisdusche im ersten Jahr auch nur einen Tag weg, war ich zu nichts zu gebrauchen. Ich tat alles, was wirkt, und keine Patentnummer trug.

Mir wurde klar, was ich an den Psychopharmaka verloren habe. Die Ärzte wurden reich. Die Industrie wurde reich. Ich verkümmerte. Und mein gehirngewaschenes Umfeld versuchte mir weiszumachen, ich sei einfach so.

Ich wusste nicht, wer ich war. Ich dachte, das sei ich. Was ich für mich hielt, war ein Sediment aus Citalopram. Eine pharmakologische Amputation. Die zweite meines Lebens. Die erste hatten sie mir damals injiziert. Darunter lag jemand, den sie fast umgebracht hatten.

Ich grub mich aus. Ohne ihre Hilfe. Gegen ihren Rat. Während des gesamten Studiums. Zum ersten Mal in meinem erwachsenen Leben hatte ich Gesundheitsgewicht. Und zum ersten Mal wurde ich dafür diskriminiert. *Du bist zu dünn*, sagten sie. *Du musst zunehmen. Anorektisch siehst du aus.* Sie sagten es beiläufig, als Ratschlag verkleidet.

Sie wussten nicht, was sie sagten. Oder es war ihnen egal. Oder sie wussten genau, was sie sagten. Und wollten mich zurück in der Krankheit.

Sinngemäß sagten sie: *Geh zurück in das brennende Haus. Werd wieder der, den wir kannten. Hör auf, dich zu heilen.*

Noch heute sagen sie es.

Kranke Menschen stören weniger. Sie fordern nichts. Sie verschwinden in sich selbst. Gesunde Menschen sind unbequem. Sie stellen Fragen. Sie erinnern andere daran, was möglich wäre. Jahre später wurde ich, was sie aus mir machen wollten. Ich fing an zu rauchen. Ich wusste, was ich tat. Ich tat es trotzdem. Die Sucht fraß, was ich mir aufgebaut hatte. Ich verschwand.

Bis ich 2025 aufhörte zu rauchen. Ein letztes Mal.

Psychisches Erleben ist kein Charakter, sondern ein Zustand. Ich wusste damals nicht, warum es funktionierte. Es funktionierte einfach. Die Erklärung kam Jahre später. Aus der Forschung. Fettgewebe ist ein endokrines Organ. Es produziert Zytokine, entzündungsfördernde Botenstoffe, die das Gehirn erreichen.³ Dort läuft dieselbe Entzündung ab wie in einem infizierten Gelenk.⁴

Aber das Fett entzündet sich nicht nur. Es speichert. Fettgewebe bindet lipophile Umweltgifte, Schwermetalle, Pestizide, Mikroplastik. Wer dreißig Kilo Fettgewebe trägt, trägt ein Schadstoffdepot. In Berlin, mit seiner Feinstaubbelastung, seinem belasteten Trinkwasser, seinen versiegelten Böden, ist das ein Angriff auf jede kognitive Funktion. Mikroplastik passiert

3 Fettgewebe produziert Zytokine.

Gökhan S. Hotamisligil, Narinder S. Shargill, Bruce M. Spiegelman, »Adipose Expression of Tumor Necrosis Factor- α : Direct Role in Obesity-Linked Insulin Resistance«, in: *Science*, Vol. 259, Issue 5091, 01.01.1993, 87–91.

Zytokine erreichen das Gehirn.

Owein Guillemot-Legris, Giulio G. Muccioli, »Obesity-Induced Neuroinflammation: Beyond the Hypothalamus«, in: *Trends in Neurosciences*, Vol. 40, Issue 4, April 2017, 237–53.

4 Robert Dantzer, Jason C. O'Connor, Gregory G. Freund, et al., »From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain«, in: *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 9, Issue 1, Januar 2008, 46–56.

die Blut-Hirn-Schranke und löst Entzündungsreaktionen aus, die messbar die kognitive Leistung senken. Es war also nie das Gewicht allein. Es waren die Gifte darin.

Meta-Analysen zeigen bei Depressiven konstant erhöhte Entzündungsmarker. Proinflammatorische Zytokine wie Interleukin-6 und TNF- α . Dazu CRP, ein Akute-Phase-Protein, das die Leber als Reaktion auf Entzündung produziert. Drei Marker, drei Ebenen desselben Prozesses.⁵ Die Forschung spricht längst von einem inflammatorischen Subtyp der Depression. Das Immunsystem brennt. Die Entzündung produziert die Symptome. Nicht umgekehrt.⁶

Millionen Menschen erleben Depression. Aber ihr Körper ist nicht psychisch krank. Er ist entzündet. Metabolisch entgleist. Seine Schlaf- und Stressnetzwerke kollabieren. Eine Entzündungsmatrix durchzieht das gesamte System. Die Psychiatrie sieht davon nichts. Entzündungsmarker lassen sich nicht verschreiben.

Die Entzündungshypothese der Depression ist inzwischen so gut belegt, dass sie in keiner seriösen Übersichtsarbeit mehr fehlt.⁷ Aber die praktische Psychiatrie verschreibt weiter Citalopram, Sertralin, Fluoxetin.

5 Yekta Dowlatia, Nathan Herrmann, Walter Swardfager, et al., »A Meta-Analysis of Cytokines in Major Depression«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 67, Issue 5, 01.03.2010, 446–57.

6 Peripher verabreichtes Zytokin → ZNS-Entzündungsreaktion → Serotonin-Stoffwechselstörung → Depression

Charles L. Raison, Andrey S. Borisov, Matthias Majer, »Activation of CNS Inflammatory Pathways by Interferon-alpha: Relationship to Monoamines and Depression«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 65, Issue 4, 18.09.2008, 296–303.

7 Eléonore Beurel, Marisa Toups, Charles B. Nemeroff, »The Bidirectional Relationship of Depression and Inflammation: Double Trouble«, in: *Neuron*, Vol. 107, Issue 2, 17.06.2020, 234–56.

Depression ist kein Singular. Was die Psychiatrie unter einem Namen zusammenfasst, sind mindestens zwei, wahrscheinlich mehr, biologisch distinkte Zustände mit unterschiedlichen Ursachen, unterschiedlichen Verläufen und unterschiedlichem Ansprechen auf Behandlung. Die Diagnose »schwere Depression« funktioniert wie eine Postleitzahl, die drei Städte abdeckt.

Neuroinflammation, Hirnnetzwerk-Modellierung, molekulare Psychiatrie. Drei Forschungslinien, die unabhängig voneinander dasselbe finden. Repple et al. finden in Netzwerkstudien mindestens zwei wiederkehrende Phänotypen.⁸ Einer zerstört den Schlaf und nimmt die Kognition mit. Der andere legt die Motivation lahm und hinterlässt eine eigene metabolische Spur. Zwei verschiedene Maschinerien. Dieselbe Diagnose.

Das DSM behandelt beide gleich. In der Onkologie hieße das Kunstfehler. In der Psychiatrie heißt es Goldstandard. Aber ein Standard, der auf einer Fiktion beruht, ist kein Standard. Er ist ein Ritual.

Nemeroff ist der meistzitierte Psychiater der Welt. Der Review deckt beide Richtungen ab (**Entzündung** → **Depression**; **Depression** → **Entzündung**), behandelt angeborenes und adaptives Immunsystem, BBB-Disruption, Th17-Zellen, Mikrobiom, Kynurenin-Pfad.

Brenda W. J. H. Penninx, Femke Lamersa, Rick Jansen, et al., »Immuno-metabolic depression: from concept to implementation«, in: *The Lancet Regional Health — Europe*, Vol. 48, Januar 2025, 101166.

- 8 Jonathan Repple, Marco Mauritz, Susanne Meinert, et al., »Severity of current depression and remission status are associated with structural connectome alterations in major depressive disorder«, in: *Molecular Psychiatry*, Vol. 25, Issue 7, 22.11.2019, 1550—8.

Yuri Milaneschia, Femke Lamersa, Michael Berk, Brenda W. J. H. Penninx, »Depression Heterogeneity and Its Biological Underpinnings: Toward Immunometabolic Depression«, in: *Biological Psychiatry*, Vol. 88, Issue 5, 01.09.2020, 369—80.

Die Diagnose Depression hat die Präzision eines Totenscheins, auf dem »irgendwas mit Organen« steht. Als würde man einen Diabetiker und einen Alkoholiker in dieselbe Entgiftung schicken, weil beide »was mit dem Blutzucker« haben. Beim einen wirkt es. Der andere stirbt. Aber die Statistik sagt: fünfzig Prozent Erfolgsrate.

Die Leitlinien ändern sich langsamer als die Evidenz, weil Leitlinien von Gremien geschrieben werden, deren Mitglieder von der Pharmaindustrie bezahlt werden. Hundert Prozent des Depressions-Leitlinien-Komitees haben Industrieverbindungen. Siebzig Prozent der Beitragenden zur Depression-Sektion im DSM-5.⁹ Ghostwriting mit Krankenkassengeld. Dreißig Sekunden für ein Rezept. Dreißig Jahre für eine Leitlinienänderung.

Was die Pfade verbindet. Insulinresistenz im Gehirn.¹⁰ Ein glymphatisches System, das bei Schlafentzug kollabiert.¹¹ Ein Darm, dessen Mikrobiom Entzündungssignale ins Nervensystem

9 Lisa Cosgrove, Harold J. Bursztajn, Deborah R. Erlich, et al., »Conflicts of interest and the quality of recommendations in clinical guidelines«, in: *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, Vol. 19, Issue 4, August 2013, 674–81.

Lisa Cosgrove, Elissa H. Patterson, Harold J. Bursztajn, »Industry influence on mental health research: depression as a case example«, in: *Frontiers in Medicine*, Vol. 10, 23.01.2024, 1320304.

Anstieg von 57 Prozent (DSM-IV) auf siebzig Prozent (DSM-5).

10 Konrad Talbot, Hoau-Yan Wang, Hala Kazi, et al., »Demonstrated brain insulin resistance in Alzheimer's disease patients is associated with IGF-1 resistance, IRS-1 dysregulation, and cognitive decline«, in: *Journal of Clinical Investigation*, Vol. 122, Issue 4, 26.03.2012, 1316–38.

Insulinresistenz im Gehirn → Dopaminstörung → Depression

Andre Kleinridders, Weikang Cai, Laura Cappellucci, et al., »Insulin resistance in brain alters dopamine turnover and causes behavioral disorders«, in: *PNAS*, Vol. 112, Issue 11, 02.03.2015, 3463–8.

11 Lulu Xie, Hongyi Kang, Qiwu Xu, et al., »Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain«, in: *Science*, Vol. 342, Issue 6156, 18.10.2013, 373–7.

feuert.¹² Keine dieser Ursachen tauchte in den diagnostischen Gesprächen mit meinen Ärzten auf.

Studien zeigen, dass gezielte metabolische oder probiotische Interventionen in bestimmten Subgruppen besser wirken als Antidepressiva.¹³ Das allein müsste reichen, Approbationen zu entziehen. In jeder anderen Disziplin wäre das ein Rückruf. Die Psychiatrie nennt es Forschungsbedarf.

»Schwere Depression« als Diagnose muss sterben. Was an ihre Stelle gehört, existiert bereits in der Forschung. *Hypothalamische Entzündungssyndrome. Mitochondriale Energiedefizite.* Begriffe, die beschreiben, was kaputt ist. Psychische Gesundheit entsteht, wenn die Zellen in Homöostase sind. Solange die Diagnose falsch ist, ist jede Behandlung ein Blindversuch am lebenden Patienten.

Die Depression existiert nicht. Was unter diesem Namen läuft, sind Netzwerkstörungen, deren Symptome sich gegenseitig stabilisieren. Der Schlafverlust frisst die Konzentration, die fehlende Konzentration frisst die Motivation, die fehlende Motivation verhindert den Schlaf. Das System hält sich selbst gefangen.

12 John F. Cryan, Kenneth J. O'Riordan, Caitlin S. M. Cowan, et al., »The Microbiota-Gut-Brain Axis«, in: *Physiological Reviews*, Vol. 99, Issue 4, Oktober 2019, 1877–2013.

13 55 Prozent Remissionsrate versus 40 Prozent Placebo nach acht Wochen. Mit mikrobiellen und neuronalen Veränderungen entlang der Darm-Hirn-Achse.

Viktoriya L. Nikolova, Anthony J. Cleare, Allan H. Young, James M. Stone, »Updated Review and Meta-Analysis of Probiotics for the Treatment of Clinical Depression: Adjunctive vs. Stand-Alone Treatment«, in: *Journal of Clinical Medicine*, Vol. 10, Issue 4, 08.02.2021, 647.

Anna-Chiara Schaub, Else Schneider, Jorge F. Vazquez-Castellanos, et al., »Clinical, gut microbial and neural effects of a probiotic add-on therapy in depressed patients: a randomized controlled trial«, in: *Translational Psychiatry*, Vol. 12, 03.06.2022, 227.

Die Psychiatrie hat für diesen Kreislauf einen Namen. Ein Interesse hat sie nicht. Verstanden hat sie auch nichts.

Descartes trennte Körper und Geist. Aber der Ekel vor dem Fleisch ist älter. Calvin erklärte den Körper zum Feind, die Protestantismen machten daraus ein Programm. Wer den Körper verachtet, fragt nicht, was in ihm vorgeht. Er betet. Die Psychiatrie hat das Beten durch Verschreiben ersetzt und den Aberglauben behalten. Jahrhundertlang fahndete sie nach Geistern, während in den Gehirnen ihrer Patienten messbare biochemische Prozesse abliefen. Man hätte messen können.

Man wollte nicht.

Zytokine durchbrechen die Blut-Hirn-Schranke und schädigen Myelinscheiden, die isolierenden Hüllen der Nervenfasern. Die Signalübertragung zerfällt, Netzwerke kollabieren. Was die Psychiatrie Antriebslosigkeit nennt, ist zelluläre Pathologie. Aber Antriebslosigkeit klingt nach Seele, und Seele klingt nach Zuständigkeit. So hat sich eine ganze Disziplin ihr Geschäftsmodell auf einem Geisterglauben errichtet.

Raffinierte Kohlenhydrate erzeugen Glukosespitzen. Die Folge ist Insulinresistenz im Gehirn und Beta-Amyloid-Plaques, wie man sie bei Alzheimer findet.¹⁴ Fruktose überlastet die Leber und entfacht Entzündungskaskaden. Und Regierungen subventionieren raffinierten Zucker. Der Unterschied ist die Verpackung. Zucker ist Alkohol ohne Rausch.¹⁵

14 Talbot et al. 2012.

Auriel A. Willette, Sterling C. Johnson, Alex Birdsill, et al., »Insulin resistance predicts brain amyloid deposition in late middle-aged adults«, in: *Alzheimer's & Dementia*, Vol. 11, Issue 5, 17.07.2014, 504–10.

Insulinresistenz → Amyloid-Akkumulation (bildgebend verifiziert)

15 Robert H. Lustig, »Fructose: It's >Alcohol Without the Buzz<«, in: *Advances in Nutrition*, Vol. 4, Issue 2, 06.03.2013, 226–35.

Senescente Zellen hören auf zu funktionieren, sterben aber nicht ab. Sie bleiben im Gewebe und vergiften ihre Umgebung mit proinflammatorischen Signalen. Die Forschung nennt sie Zombie-Zellen. Der Name ist keine Metapher. Sie beschleunigen biologisches Altern und halten chronische Entzündungen aufrecht, die das Gehirn erreichen.¹⁶

Mikroplastikpartikel überwinden die Blut-Hirn-Schranke und lagern sich in kritischen Gehirnregionen ab. Tierversuche zeigen Demenzsymptome. Menschliche Gehirne akkumulieren mehr Mikroplastik als Leber oder Nieren. In den Gehirnen von Demenz-Patienten fand sich die zehnfache Konzentration.¹⁷ Die

Qingying Meng, Zhe Ying, Emily Noble, et al., »Systems Nutrigenomics Reveals Brain Gene Networks Linking Metabolic and Brain Disorders«, in: *eBioMedicine*, Vol. 7, 13.04.2016, 157—66.

Fructose verändert Gene, die mit Alzheimer, Depression, Parkinson, ADHS verknüpft sind. DHA (Omega-3) konnte die Schäden umkehren.

- 16 Mikolaj Ogrodnik, Shane A. Evans, Edward Fielder, et al., »Whole-body senescent cell clearance alleviates age-related brain inflammation and cognitive impairment in mice«, in: *Aging Cell*, Vol. 20, Issue 2, 20.01.2021, e13296.

Direkte kausale Kette: **senescente Zellen** → **SASP** → **Neuroinflammation** → **kognitive Verschlechterung** → **Elimination der Zellen oder senolytische Behandlung** (z.B. mit Quercetin) → **Verbesserung**

Tyler J. Bussian, Asef Aziz, Charlton F. Meyer, et al., »Clearance of senescent glial cells prevents tau-dependent pathology and cognitive decline«, in: *Nature*, Vol. 562, Issue 7728, 19.09.2018, 578—82.

Senescente Gliazellen treiben Tau-Pathologie und kognitiven Verfall.

- 17 Lauren Gaspar, Sydney Bartman, Giuseppe Coppotelli, Jaime M. Ross, »Acute Exposure to Microplastics Induced Changes in Behavior and Inflammation in Young and Old Mice«, in: *International Journal of Molecular Sciences*, Vol. 24, Issue 15, 01.08.2023, 12308.

Alexander J. Nihart, Marcus A. Garcia, Eliane El Hayek, et al., »Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains«, in: *Nature Medicine*, Vol. 31, No. 4, 03.02.2025, 1114—9.

Anstieg der MNP-Konzentrationen von 2016 bis 2024.

Langzeitfolgen beim Menschen kennt niemand, weil die Ergebnisse eine Industrie bedrohen würden. Und Industrien finanzieren keine Selbstmorde.

Stress setzt Cortisol frei. In Dosen, die einzeln harmlos wären. Aber ein Gehirn, das von morgens bis nachts auf Benachrichtigungen, Feeds und Mikrokonflikte reagiert, summiert diese Dosen zu chronischer Exposition. Chronisches Cortisol ist neurotoxisch. Es zerstört Synapsen im Hippocampus.¹⁸

Im Schlaf aktiviert das Gehirn sein glymphatisches System und weitet den Interstitialraum um sechzig Prozent. Es spült Beta-Amyloid-Plaques und Neurotoxine aus, wie eine Kläranlage. Schlafentzug schaltet sie ab. Was nicht ausgespült wird, sammelt sich an. Eine einzige Nacht Schlafentzug reicht. PET-Bildgebung zeigt danach fünf Prozent mehr Beta-Amyloid im Hippocampus. Bei Alzheimer-Patienten liegt die Zunahme bei 43 Prozent.

Chronischer Schlafmangel und Neurodegeneration hängen zusammen. Das ist keine Hypothese mehr.¹⁹ Jahrelang habe ich schlecht geschlafen. Nacht für Nacht lief die Kläranlage auf halber Kraft. Was sich in dieser Zeit in meinem Gehirn angesammelt hat, kann ich nicht wissen. Dass es sich angesammelt hat, bezahle ich vielleicht noch.

18 Cortisol → Glutamat-Freisetzung → NMDA-Aktivierung → dendritische Atrophie → Synapsenverlust

Ana María Magariños, Bruce S. McEwen, »Stress-induced atrophy of apical dendrites of hippocampal CA3c neurons: Comparison of stressors«, in: *Neuroscience*, Vol. 69, Issue 1, November 1995, 83—8.

Ana María Magariños, José M. García Verdugo, Bruce S. McEwen, »Chronic stress alters synaptic terminal structure in hippocampus«, in: *PNAS*, Vol. 94, Issue 25, 09.12.1997, 14002—8.

19 Ehsan Shokri-Kojori, Gene-Jack Wang, Corinde E. Wiers, et al., » β -Amyloid accumulation in the human brain after one night of sleep deprivation«, in: *PNAS*, Vol. 115, Issue 17, 24.04.2018, 4483—8.

Das enterische Nervensystem kommuniziert direkt mit dem Zentralnervensystem. Ein dysreguliertes Mikrobiom sendet inflammatorische Signale ins Gehirn, die Neurotransmitter-Haushalte verschieben. Probiotische Interventionen erreichen binnen Wochen, wofür der chemische Hammer Jahre braucht.²⁰ Als ich meine Ernährung umstellte, verschwanden die Symptome. Kein Arzt hat mir das vorhergesagt. Keiner hat gefragt, was ich anders gemacht hatte.

Sechs Mechanismen. Jeder messbar. Jeder publiziert. Keiner Teil der psychiatrischen Standarddiagnostik. Die Psychiatrie jagt Geister. Die Ursachen stehen im Blutbild.

Es gibt Substanzen, die auf zellulärer Ebene reparieren, was Antidepressiva auf molekularer Ebene ignorieren. NAD⁺-Vorläufer reaktivieren mitochondriale Energieproduktion.²¹ Spermidin induziert Autophagie, die Eliminierung defekter Zellbestandteile.²² Glutathion neutralisiert oxidativen Stress.²³ Die

20 Schaub et al. 2022.

21 NMN stellt NAD⁺ im Hippocampus wieder her, reaktiviert SIRT3, verbessert mitochondriale Energieproduktion, kehrt depressives Verhalten um. Xie Xiaoxian, Yu Chunan, Zhou Jiafeng, et al., »Nicotinamide mononucleotide ameliorates the depression-like behaviors and is associated with attenuating the disruption of mitochondrial bioenergetics in depressed mice«, in: *Journal of Affective Disorders*, Vol. 263, 15.02.2020, 166—74.

Jun Yoshino, Joseph A. Baur, Shin-ichiro Imai, »NAD⁺ intermediates: The biology and therapeutic potential of NMN and NR«, in: *Cell Metabolism*, Vol. 27, Issue 3, 14.12.2017, 513—28.

22 Hemmung von Histon-Acetyltransferasen → epigenetische Deacetylierung von Histon H3 → Hochregulation von Autophagie-Genen → Autophagie-Induktion → Unterdrückung von oxidativem Stress und Nekrose Tobias Eisenberg, Heide Knauer, Alexandra Schauer, et al., »Induction of autophagy by spermidine promotes longevity«, in: *Nature Cell Biology*, Vol. 11, Issue 11, 04.10.2009, 1305—14.

23 Ralf Dringen, »Metabolism and functions of glutathione in brain«, in: *Progress in Neurobiology*, Vol. 62, Issue 6, 15.12.2000, 649—71.

Umsetzung der Evidenz in psychiatrische Leitlinien ist gleich null. Fehlende Patentierbarkeit.

Ein SSRI gegen eine entzündungsinduzierte Netzwerkstörung zu verschreiben, behandelt die falsche Krankheit mit dem falschen Werkzeug. Niemand hat Depression. Sie ist ein Etikett. Darunter liegen Maschinen, die man reparieren kann. Menschen haben entzündete Netzwerke, entgleiste Mitochondrien, vergiftete Mikrobiome. Jede dieser Störungen ist identifizierbar. Jede ist adressierbar. Werkzeuge existieren. CRP, Zytokin-Profil, Netzwerk-Bildgebung. Dass sie in der psychiatrischen Praxis kaum vorkommen, liegt an einem System, das an der Unschärfe seiner Diagnosen verdient.

Depression wird denselben Weg gehen wie Hysterie. Die Begriffe, die sie ersetzen, existieren. *Hypothalamische Entzündungssyndrome. Präfrontale Netzwerkdysfunktionen. Mitochondriale Energiekrisen.* Die Psychiatrie weigert sich noch, sie auszusprechen. Aber die Forschung hat ihr die Ausrede bereits genommen. Die Psychiatrie wird sich irgendwann für diese Epoche entschuldigen. So wie sich die Medizin für Quecksilberkuren entschuldigt hat. So wie sich die Kirche für Exorzismen entschuldigt hat.

Die Frage ist nur, ob die Entschuldigung kommt, bevor die nächste Generation dieselben Pillen schluckt. Bis dahin sterben die Begriffe langsamer als die Patienten, die unter ihnen behandelt werden.

ZWANZIG PROZENT

*Wer glaubt, er brauche Gift zum Denken, hat
bereits aufgehört zu denken.*

Die meisten Menschen wissen nicht mehr, wie sich ein Körper anfühlt, der nicht permanent gegen sich selbst arbeitet. Der Normalzustand des Körpers ist, sich *pudelwohl* zu fühlen, wach ohne Koffein, ruhig ohne Alkohol, klar ohne Nikotin. Wer Schlaf, Nervensystem und Stoffwechsel mit Stimulanzien und Entzugsschleifen demoliert, lebt weit unter seiner Kapazität. Zwanzig Prozent, die sich wie hundert anfühlen, weil man vergessen hat, wie sich hundert anfühlen. In diese Amnesie hinein verkaufen die Stimulanzien ihre Lüge.

Dann kommt die Droge. Sie schiebt von zwanzig auf vierzig. Das fühlt sich wie Wohlbefinden an. In Wahrheit ist es Entzugsumkehr, von Minus zurück auf Null. Danach: achtzehn. Dann hoch auf achtunddreißig. Dann runter auf sechzehn. Eine Abwärtsspirale, die sich wie Stabilität anfühlt.

Hedonische Adaption nennt man das. Wer lange genug auf zwanzig Prozent funktioniert, hält zwanzig Prozent für den Grundzustand. Die meisten Menschen leben in einer selbstgebauten Ruine, aber weil alle drumherum auch in Ruinen wohnen, halten sie das für Architektur. Echte Ruhe wirkt dann wie Leere. Der Körper lernt Alarm als Normal. Das fühlt sich nach Energie an. Kortisol-getriebener Stress wird zu Fokus. Nervöse Unruhe zu Lebendigkeit. Koffein-Zittern zu geistiger Klarheit. Echte Klarheit ist ruhig, stabil, ohne inneren Lärm. Wer das verlernt hat, hält Angst für Antrieb. Der Körper ist künstlich ins

Minus gezogen worden. Das High ist die Rückkehr zur Baseline. Man nennt das Energie. Es ist die kurze Pause vom Mangel.

Die Substanz macht nicht glücklich. Sie macht taub für Unangenehmes. Das fühlt sich wie Gewinn an, ist aber Bilanzfälschung. Minus wird kurz weniger Minus, später mehr Minus. Das Gehirn erinnert den Espresso-Moment, nicht die schlaflose Nacht. So entsteht eine Kultur, in der Stimulanzien als Energie gelten und echte Klarheit kaum noch vorstellbar ist. Das Ruhige ist zur Anomalie geworden.

Je länger das läuft, desto abwegiger erscheint die Vorstellung, dass *pudelwohl* ohne Substanz der natürliche Zustand ist, zu dem der Körper zurückwill. Wer das lange genug macht, landet womöglich bei plötzlicher Demenz, für die dann alles auf der Welt der Grund ist — außer die eigene tägliche Entscheidung für einen autotoxischen Lebensstil.

Interozeption ist die Fähigkeit, den eigenen Körper zu spüren. Nicht nur Schmerz oder Hunger, sondern die feinen Signale, auf denen Urteilsvermögen, Entscheidungsfähigkeit und emotionale Regulation aufbauen. Wer Nikotin, Alkohol, Cannabis oder Partydrogen konsumiert, verliert Interozeption. Das Gehirn stumpft ab. Der Draht zum Körper reißt. Der Hilferuf wird zum Hintergrundrauschen. Die Fähigkeit zu intensiven Erfahrungen schwindet. Man wird nicht tief, sondern taub. Übrig bleibt die Fähigkeit, auf Lautstärke zu reagieren. Das kann so weit gehen, dass man permanent zu flach atmet, weil die Atmung nicht mehr gespürt wird. Das Gehirn ist sauerstoffunterversorgt.

Oder dass man übergewichtig wird, weil man Hunger und Durst nicht mehr von Craving unterscheiden kann. Wenn die *Viszerozeption* verloren geht, spürt man nicht mehr, dass das Zeug, das man isst, die Organe attackiert. Dieselben Leute urteilen über Ernährung. Bio sei Betrug. Nahrungsergänzungsmittel: Geldverschwendung. Sie sagen das, während sie aussehen wie ihre eigene Diagnose. Aufgedunsen, grau, hässlich. Der Körper

widerlegt jeden Satz, den der Mund ausspricht. Sie haben nichts verstanden. Sie verfetten in ihrer eigenen Blindheit. Trotzdem urteilen sie — mit der Selbstsicherheit von Analphabeten, die Literaturkritik betreiben.

Wer keinen Kontakt zum Innenleben hat, ist unfähig, Frieden zu denken. Wer keinen Frieden denken kann, kann ihn auch nicht praktizieren, weder mit sich noch mit anderen. Gestörte Interozeption führt zu Depression, Angst, Ohnmachtsgefühlen. Sie macht aus Menschen Wesen, die sich ständig Gewalt antun, ohne es zu merken. Und die daher anderen Gewalt antun.

Wenn Menschen den Kontakt zum Innenleben verlieren, spüren sie sich nicht mehr fein genug. Sie merken nur noch »schlecht« und »weniger schlecht«. Substanzen geben ein klares Signal, jedenfalls solange die Dosis hoch genug ist, um noch gespürt zu werden. Etwas passiert, und das wird mit Wohlbefinden verwechselt. Es ist keine Belohnung, sondern Schmerzabschaltung.

Ohne Stoff fällt Struktur weg. Dann kommt die Stille. Stille ist bedrohlich, weil sie Gefühle hörbar macht, die sonst weggedrückt werden. Wer uneins mit sich und seinem Leben ist, kann Stille nicht ertragen. Wer schläft, braucht Grundrauschen, sonst dreht er durch. Wer besonders weit von sich entfernt ist, braucht einen Podcast zum Einschlafen.

Der Geist muss ständig abgelenkt und beschäftigt sein, wenn man nicht bei sich ist oder sich selbst nicht spüren will. Das ist der Impuls, der zur Zigarette greift, zum Espresso, zum Bier. Ich habe Angst, ich selbst zu sein, also präpariere ich mich, damit ich etwas anderes bin.

Menschen sind beeindruckend erfinderisch, wenn es darum geht, sich selbst nicht spüren zu müssen. Die Mechanismen, mit denen Menschen ihre Substanzen heiligen — den täglichen Kaffee, das Feierabendbier, die Zigarette nach dem Essen —,

bilden eine Massenpsychose mit vier Grundpfeilern. Wer diese Mechanismen einmal verstanden hat, sieht sie überall.

Motivated Reasoning sorgt dafür, dass Informationen so verarbeitet werden, dass sie beim gewünschten Schluss landen. Jeder kennt das, der schon mal gegoogelt hat, ob Rotwein gesund ist, und dann nur die Artikel gelesen hat, die das bestätigen. Der gewünschte Schluss ist immer derselbe: weitermachen, ohne sich schlecht fühlen zu müssen.

Kognitive Dissonanz entsteht, wenn Selbstbild und Verhalten kollidieren. Wer sich für intelligent hält und gleichzeitig Substanzen konsumiert, die nachweislich kognitive Risiken bergen, muss etwas ändern. Entweder das Verhalten oder die Erklärung. Die Erklärung zu ändern ist billiger. Statt *Ich bin süchtig nach Kaffee* sage ich *Ich zelebriere ein Morgenritual*. Das klingt besser, tut nicht weh, kostet nichts.

Identitätsschutz funktioniert nach demselben Prinzip. Wenn Substanzgebrauch zur Selbstdefinition gehört, zur Zugehörigkeit in einer Szene, zu einem ästhetischen oder spirituellen Selbstbild, dann fühlt sich jede Kritik an der Substanz an wie ein Angriff auf die Person.¹

Reaktanz kommt hinzu. Wer moralisch unter Druck gesetzt wird, wird Widerstand aufbauen.² Das Gehirn mag keine Bevormundung.

1 Carolina Flores, »Identity-protective reasoning: an epistemic and political defense«, in: *Episteme*, Vol. 22, 26.03.2025, 707–30.

2 Melissa N. Slavin, Mitch Earleywine, »Effects of Messaging and Psychological Reactance on Marijuana Craving«, in: *Substance Use & Misuse*, Vol. 54, Issue 14, 2019, 2359–67.

Tobias Reynolds-Tylus, »Psychological Reactance and Persuasive Health Communication: A Review of the Literature«, in: *Frontiers in Communication*, Vol. 4, 31.10.2019, Artikel 56.

Dazu kommt ein simpler Erinnerungsfehler. Die Peak-Erlebnisse bleiben hängen, der durchschnittliche Rest wird aussortiert, die Nebenwirkungen gelöscht.

Zusammen bilden diese vier Mechanismen eine Festung. Wer darin sitzt, hält sie für Vernunft. Innerhalb dieser Festung erzählt man sich Geschichten. Das innere Narrativ geht ungefähr so: *Ich nehme diese Substanz, also werde ich Teil von etwas Besonderem. Ich habe Zugriff auf tiefere Erfahrungen als andere. Ich sehe die Welt besser, verstehe sie tiefer. Die anderen sind gehirngewaschen, weil sie glauben, das Ganze sei nur gefährlich. Ich habe es verstanden.*

Es funktioniert, weil es mehrere Bedürfnisse gleichzeitig bedient. Seltenheit wird automatisch zu Wert umgedeutet. *Wer diesen speziellen Kaffee trinkt oder jenen Wein, versteht mehr vom Leben.* Die Droge wird zum Initiationsritus, der angeblich Identität stiftet, während er sie tatsächlich auflöst. Man gehört plötzlich zu denen, die es sehen. Man hat ein epistemisches Privileg. Die eigene Erfahrung ist nicht nur intensiv — sie ist wahr, wahrer, am wahrsten.

Die Außenwelt wertet man systematisch ab, um vom eigenen ankonsumierten Minderwert abzulenken. Die anderen sind ängstlich, spießig, konditioniert. Ich bin frei. Und die anderen schauen mit einer Mischung aus Mitleid, Amüsement und Fremdscham. Aber ich merke es nicht. Mir fehlt das Sinnesorgan. Man ist gefangen in einer Geschichte, die man sich über sich selbst erzählt, während der Körper eine andere Geschichte realisiert.

Über Drogen gibt es drei Debatten, die permanent in einen Topf geworfen werden. Daraus entsteht ein Nebel, in dem niemand mehr geradeaus denken kann.

Christina Steindl, Eva Jonas, Sandra Sittenthaler, et al., »Understanding Psychological Reactance: New Developments and Findings«, in: *Zeitschrift für Psychologie*, Vol. 223, Issue 4, 08.12.2015, 205–14.

Die erste ist *moralisch*: Ist Konsum grundsätzlich falsch?

Die zweite ist *neurobiologisch*: messbare Schäden, Dosis-Wirkungs-Beziehungen, Entwicklungsrisiken.

Die dritte ist *phänomenologisch*: Bestimmte Substanzen ermöglichen besondere Erfahrungen, die man anders nicht erreicht.

Drei Logiken. Wer sie vermischt, kann sich aus jeder Ecke heraussuchen, was gerade in den Kram passt — und damit jede unbequeme Wahrheit wegschieben.

Insbesondere die, dass bestimmte Substanzen zwar intensive Erfahrungen ermöglichen, gleichzeitig aber die Fähigkeit zerstören, überhaupt Intensität zu empfinden. Sie vernichten die Bedingung ihrer Möglichkeit. Sie verwandeln Menschen in persönlichkeitslose Zombies ohne Lebendigkeit.

Alkohol zeigt in großen Bildgebungsstudien negative Zusammenhänge zwischen Konsum und Gehirnstruktur, bereits bei ein bis zwei Einheiten täglich.³

Cannabis beeinträchtigt akut Lernen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit. Längsschnittdaten zeigen IQ-Abnahme bei mehrfachem Konsum.⁴ Diese Effekte sind nicht reversibel. Zudem verstärkt oder bewirkt Cannabiskonsum schizophrene und psychotische Störungen, bipolare Störungen, Depression, Angst und vor allem

3 Remi Daviet, Gökhan Aydogan, Kanchana Jagannathan, et al., »Associations between alcohol consumption and gray and white matter volumes in the UK Biobank«, in: *Nature Communications*, Vol. 13, 04.03.2022, Artikel 1175. Hollis C. Karoly, Katelyn T. Kirk-Provencher, Joseph P. Schacht, Joshua L. Gowin, »Alcohol and brain structure across the lifespan: A systematic review of large-scale neuroimaging studies«, in: *Addiction Biology*, Vol. 29, Issue 9, 24.09.2024, e13439.

4 Emmet Power, Sophie Sabherwal, Colm Healy, et al., »Intelligence quotient decline following frequent or dependent cannabis use in youth: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies«, in: *Psychological Medicine*, Vol. 51, Issue 2, 27.01.2021, 194—200.

PTBS. Wer an Traumafolgestörungen leidet, macht sich mit Cannabis das Leben für immer zur Hölle.

MDMA verursacht serotonerge Schäden.⁵ Die erste Einnahme zerstört die Fähigkeit, sich jemals wieder ohne Substanz gut zu fühlen. Der Körper kann nicht mehr ausreichend Serotonin ausschütten. Die erste MDMA-Einnahme ist der Punkt, ab dem es nur noch bergab geht.

Bei chronischem Konsum entsteht Anhedonie — die verminderte Fähigkeit, überhaupt noch Freude zu empfinden. Tod im Leben. Empfindungsloses, charakterloses Plätschern im Trüben.

Der klassische Denkfehler funktioniert so: *Ich habe eine intensive Erfahrung gemacht. Intensiv ist wertvoll. Also kann es nicht schädlich sein.*

Das ist psychologisch bequem und logisch Müll.

Erlebniswert ist nicht dasselbe wie Gesundheitswert. Bedeutung ist nicht dasselbe wie Unbedenklichkeit. Eine Granate erzeugt auch intensive Erlebnisse. Wer mit besonderer Erfahrung argumentiert, muss den Preis dazusagen: die kognitive Kapazität, die verlorengeht; die Entwicklungschancen für das Gehirn; das statistische Risiko, dumm und behindert zu werden. Wer das nicht tut, verteidigt nicht die Substanz. Er verteidigt eine Erzählung, in der der Preis nicht gezahlt werden muss. Das ist Buchführungsbetrug am eigenen durchlöcherten Gehirn.

5 Stephen J. Kish, Jason Lerch, Yoshiaki Furukawa, et al., »Decreased cerebral cortical serotonin transporter binding in ecstasy users: a positron emission tomography/[11C]DASB and structural brain imaging study«, in: *Brain*, Vol. 133, Issue 6, 17.05.2010, 1779—97.

Felix Mueller, Claudia Lenz, Markus D. Steiner, et al., »Neuroimaging in moderate MDMA use: A systematic review«, in: *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, Vol. 62, März 2016, 21—34.

Was von außen wie Selbsterkenntnis aussieht, ist Selbstversiegelung. Was bleibt, ist das Gefühl von Tiefe. Nur das Gefühl. Und dieses Gefühl ersetzt die echte Auseinandersetzung mit sich selbst. Am Ende verteidigt man nicht die Erfahrung, sondern die Erzählung, in der man angeblich besser dasteht als die anderen.

Menschen, die Drogen nehmen, behaupten, dadurch besondere Erfahrungen zu machen, die anderen verschlossen bleiben. Das Gegenteil ist wahr. Sie machen dadurch immer weniger Erfahrungen. Sie zerstören ihre Fähigkeit, sich selbst und ihren Körper zu spüren. Ihr Leben, ihr Charakter flachen ab. Sie plätschern im Trüben, statt aus der Tiefe zu schöpfen. Weder körperlich noch gedanklich dringen sie zu irgendeiner Tiefe vor. Sie zerstören das Instrument, mit dem Tiefe überhaupt gemessen wird.

Kognitive Kapazität und Sinneswahrnehmung hängen zusammen. Sensorische Diskriminationsleistung — die Fähigkeit, feine Unterschiede wahrzunehmen — korreliert mit Intelligenzmaßen.⁶ Wer sein Gehirn schont, verbessert nicht nur seine kognitiven Fähigkeiten. Die Sinne werden feiner.

Wer sein Gehirn durch Substanzen schädigt, wird nicht sensibler oder tiefgründiger, wie das psychedelische Narrativ behauptet, sondern stumpfer. Er tauscht Wahrnehmung gegen Lärm. Intensiv bedeutet dann nur, dass man den Lautstärkeregler hochgedreht hat, weil das Ohr stumpf geworden ist. Eine Erfahrung kann überwältigend sein und trotzdem nur ein chemisch verstärktes Echo.

Wenn ich Menschen treffe, die dieses Zeug seit Längerem nehmen, fällt mir bei allen Unterschieden eine Gemeinsamkeit auf: sie wirken charakterlos. Wie eine Parodie ihrer selbst.

6 Michael D. Melnick, Bryan R. Harrison, Sohee Park, et al., »A strong interactive link between sensory discriminations and intelligence«, in: *Current Biology*, Vol. 23, Issue 11, 23.05.2013, 1013—7.

Aufgesetzt, gekünstelt. Sie spüren sich selbst nicht. Sie wissen nicht, was ihr authentisches Selbst ist. Die permanente Übersteuerung hat das nuancierte Selbst erst taub gemacht und dann ganz gelöscht.

Sie treten nur mit Maske und Rolle in Kontakt. Ich habe mal in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Die Insassen hielten sich oft für etwas Besonderes. Inzwischen laufen sie auf offener Straße herum. Manche regieren das Land. Zu Studienzeiten hätte ich mir das nicht vorstellen können.

Kritik prallt an solchen Menschen ab wie Regen an einer Teflonpfanne. Vier Schutzmechanismen greifen ineinander: kognitive Dissonanz, Identitätsschutz, motivated reasoning, Reaktanz. Die Erzählung ist wasserdicht. Genau deshalb ist sie falsch.

Wenn ich aufhöre zu rauchen, zu trinken, wenn ich sogar auf Pharmazeutika verzichte, fängt mein Körper an, den Weg zurück zu suchen. Wenn ich ihn machen lasse, nicht erneut unterbreche, findet er diesen Weg. Was ich dabei empfinde, fühlt sich zunächst wie Schmerz an. Es ist die Wahrheit. Entzug ist schmerzhaft, aber nicht weil dem Körper etwas fehlt, sondern weil er freilegt, was man im Nebel nicht sehen wollte. Als ich mit dem Rauchen aufhörte, heulte ich tagelang. Nicht wegen der Zigarette. Sondern weil die aufgestaute Wahrheit endlich an die Oberfläche kam.

Manchmal hat man sich jahrelang durch Kontakt mit psychischen Vampiren selbst verletzt — ohne es zu merken, weil die Substanzen das Spüren verhinderten. Wenn die Wahrheit zurückkommt, bricht man zu bestimmten Menschen den Kontakt ab. Weil man erkennt, dass sie einem geschadet haben.

Der Körper will zurück. Er erinnert sich an hundert Prozent. Er kennt den Unterschied zwischen Alarm und Ruhe, zwischen Echo und Erfahrung, zwischen Taubheit und Empfindung. Wer Intensität will, trainiert Sensitivität, statt sie zu übertönen.

Schlaf, Ausdauer, echte Nähe, Entzug von Dauerreiz, weniger Essen, mehr Wahrnehmung.

Der Normalzustand des Körpers ist, sich *pudelwohl* zu fühlen. Nicht als Ziel, sondern als Basis, von der aus wir alle leben könnten, wenn wir aufhörten, dagegen zu arbeiten.

BEWUSSTSEINERWEITERUNG NACH UNTEN

Wer sich nicht mehr spürt, hält Taubheit für Frieden. Das Leben brennt ab, aber die Droge bekommt ein PR-Team.

Je tiefer der Fall, desto lauter die Philosophie.

Für mich war Cannabis nie ein Problem. Ich hatte es einmal probiert, mit siebzehn. Marcel wollte mit mir nach Enschede. Dort kaufte er sich Gras und Hasch. In den Coffeeshops war es beängstigend still. Ich war damals nicht tabaksüchtig, also probierte ich das leuchtende Grün pur.

Die Propriozeption war weg. Als wäre ich Luft.

Ich lag nicht sediert, sondern war übererregt, lief herum und ging den Leuten mit meiner guten Laune auf die Nerven. Dass mich kein Auto erwischt hat, war Glück. Das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren, war so existenziell unangenehm, dass ich von nun an nie wieder daran dachte, Cannabis zu konsumieren. Es interessierte mich schlicht nicht.

Trotzdem wurde Cannabis zum Thema; es raubte mir jene Menschen, die mir am meisten bedeuteten.

Einer von ihnen war Sänger und Gitarrist. Seine Songs waren wundervoll. Er nahm einige Male Heroin, aber vom Kiffen kam er nie weg. Dann bekam er eine halbseitige Gesichtslähmung und konnte nicht mehr schön singen. Heute ist er eine Ruine, bezieht Bürger-Hartz und erklärt jedem, dass Cannabis natürlich nicht der Grund ist. Er raucht es immer noch. Er hat Bücher darüber. Die Leute verstünden diese wertvolle Heilpflanze nicht.

Die Leute hätten alle keine Ahnung.

Heilpflanze ist ein rhetorischer Trick. Natürlich ist es eine Pflanze. Auch Tabak. Auch Fingerhut. Auch Bilsenkraut. In vielen Milieus ist Cannabis nicht nur Rauschmittel, sondern Identität. Anti-spießig, anti-pharma. Wer das angreift, greift die Zugehörigkeit an. Dann beginnt die Verteidigung.

Ein anderer Freund von mir war Schlagzeuger. Jahrelang realisierten wir kreative Projekte, machten Podcast-Folgen, YouTube-Videos. Dann kiffte er, bekam Bürger-Hartz und wurde so unangenehm, dass es mich erschütterte. Ausgerechnet er, mit dem ich hunderte Stunden auf Discord verbracht hatte, hat sich eine Psychose angeraucht, die jede Interaktion in einen Streit verwandelte. Natürlich kifft er auch heute noch. Und natürlich ist alles auf der Welt der Grund für sein gescheitertes Leben, außer Cannabis. Das helfe ihm, seine Ängste zu kontrollieren. Die Leute verstünden das nicht.

Die Leute hätten alle keine Ahnung.

Ich hatte auch Mitbewohner, die gekiffte haben. Hätte ich es vorher gewusst, wären sie nicht meine Mitbewohner geworden. Einmal war es eine talentierte Schauspielschülerin. Sie kiffte täglich. Nach zwei Monaten explodierte sie. Sie wurde psychotisch, entwickelte Borderline-Symptome, der übliche Zusammenbruch. Dann zog sie aus. Cannabis war natürlich nicht das Problem, sondern half ihr abends runterzukommen, sich zu beruhigen. Die Leute verstünden das nicht.

Die Leute hätten alle keine Ahnung.

Solche Geschichten habe ich dutzende erlebt. Sie alle teilen eine Gemeinsamkeit. Die Fähigkeit, Cannabis bei alledem immer gut dastehen zu lassen. Ihr Leben widerlegt jeden Satz, der aus ihrem Mund kommt, aber Cannabis verteidigen sie mit einer Kompetenz, die sie sonst nirgendwo mehr aufbringen können. Die Pflanze bleibt unantastbar, während sie sich damit ins Nichts rauchen.

Diese Leute führen diese Gespräche seit Jahren. Mit Eltern, Partnern, Ärzten, Jobcenter, Freundeskreis, sich selbst. Das erzeugt fertige Formeln. *Heilpflanze. Alkohol ist schlimmer. Big Pharma. Die anderen checken es nicht.* Es erzeugt Immunisierungen gegen Kritik. *Du bist voreingenommen. Du stigmatisierst. Du kennst die Studien nicht.* Es erzeugt Beweislast-Umkehr. Nicht sie müssen zeigen, dass es ihnen gut tut, sondern andere sollen beweisen, dass es schadet.

Und während ich zuschaue, wie sie sich damit zerstören, erklären sie mir, dass es sie gar nicht zerstört. Je schlechter es ihnen geht, desto härter behaupten sie, dass es ihnen wegen Cannabis besser geht. Weil sie andernfalls erkennen müssten, dass sie sich das alles selbst angetan haben.

Kognitive Dissonanz erklärt, warum Cannabis in ihrem Leben immer gut dastehen muss. Wenn jemand jahrelang kiffte und das Leben sichtbar entgleist, stehen zwei Erklärungen zur Auswahl. Entweder schadet Cannabis, triggert etwas, macht es schlimmer. Oder die Welt ist schuld, alle haben keine Ahnung, man selbst ist eigentlich fein. Die erste Erklärung tut weh, weil sie Verantwortung und Verlust eingesteht. Also gewinnt die zweite. Sie ist Schmerzvermeidung mit Vokabular.

Ihr Leben zerfällt, aber die Droge bleibt unantastbar. Cannabis ist der einzige Bereich, in dem sie noch Souveränität spielen können. Als Anwältin ihrer eigenen Abhängigkeit. Sie verteidigen nicht die Pflanze. Sie verteidigen die Geschichte, in der sie nicht schuld sind. Das Argument muss nicht wahr sein. Es muss erträglich sein. Sie sind nicht überzeugt. Sie sind eingeübt. Der Konsum wird zur Moral, und wer fragt, gilt als Feind. Menschen ruinieren sich ihr Leben und nennen es Erfahrung, oder Heilung, oder Reise.

Die Abhängigkeit von Cannabis führt dazu, dass viele *Ohne Cannabis fühle ich mich schlecht mit Cannabis hilft mir* verwechseln. Das Schlechte ist nur der Entzug. Reizbarkeit, Schlafstörung,

Antriebsseinbruch. Dann wirkt der Konsum wie Medizin, obwohl er nur das Loch stopft, das er selbst gräbt. Minus zurück auf Null mit Cannabis.

Selbstmedikation funktioniert als moralischer Joker. Wer sagt ich brauche das für Angst, Schlaf, Kreativität, macht aus Konsum eine Notwendigkeit und aus Kritik Unmenschlichkeit. Wer zum Selbstmedizieren kiff, rutscht häufiger in Paranoia. Cannabis macht psychotisch. Je mehr, desto wahrscheinlicher.⁷ Misstrauen, Bedeutungsaufladung, Reizbarkeit machen jeden Austausch zur Schlacht.

Zudem ist Cannabis in den letzten Jahrzehnten massiv THC-stärker geworden.⁸ Höhere Potenz bedeutet höhere Risiken. Psychose-Spektrum, Abhängigkeit, Entzug.⁹ Was früher vielleicht noch funktionierte, ist heute kein Beweis mehr.

Sie zerfallen, und während sie zerfallen, erklären sie, dass es ihnen hilft. Nicht die Pflanze ist das Thema, sondern ihre Unfähigkeit hinzuschauen.

Cannabiskonsum zerstört das Denkvermögen und erhöht das Psychoserisiko auf das Fünffache. Wer als Jugendlicher regelmäßig kiff, verliert bis Ende 30 durchschnittlich acht IQ-Punkte. Die Dunedin-Kohorte aus Neuseeland hat das über Jahrzehnte gemessen. Nicht-Kiffer zeigen keinen Verlust.¹⁰

7 Arianna Marconi, Marta Di Forti, Cathryn M. Lewis, et al., »Meta-analysis of the Association Between the Level of Cannabis Use and Risk of Psychosis«, in: *Schizophrenia Bulletin*, Vol. 42, Issue 5, 15.02.2016, 1262—9.

8 Lucy Tu, »The changing marijuana landscape: What you need to know«, in: *Monitor on Psychology*, Vol. 56, No. 4, 01.06.2025.

9 Stephanie Lake, Conor H. Murray, Brittany Henry, et al., »High-Potency Cannabis Use and Health: A Systematic Review of Observational and Experimental Studies«, in: *American Journal of Psychiatry*, Vol. 182, Issue 7, 26.03.2025, 616—38.

10 Madeline H. Meier, Avshalom Caspi, Andrea Ambler, et al., »Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to midlife«,

Das adoleszente Gehirn baut sich bis ins junge Erwachsenenalter um. Nervennetze werden neu verschaltet, Synapsen beschnitten, der Frontallappen fertig verdrahtet.¹¹ Was in dieser Phase verpasst wird, bleibt verpasst.¹² THC trifft auf ein System im Umbruch. Exogene Cannabinoide stören die Feinabstimmung. Was mit fünfundzwanzig ein stabiles Gehirn wäre, ist mit achtzehn noch formbar und anfällig. Jeder Joint greift in einen Prozess ein, der sich später nicht mehr reparieren lässt.

Dass Bürger-Hartz bei Cannabisnutzern so häufig auftritt, hat Gründe. Tägliche Kiffer vor dem siebzehnten Lebensjahr schaffen zu über sechzig Prozent seltener einen Schul- oder Hochschulabschluss. Die Zahlen stammen aus drei großen Studien, kontrolliert für 53 Störfaktoren, von sozialer Herkunft bis psychischer Vorbelastung. Je häufiger gekifft, desto schlechter die Bildung. Je länger gekifft, desto größer der Schaden.¹³ Cannabis-konsum führt zu schlechterer Schul- und Ausbildungsleistung.¹⁴

in: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 109, Issue 40, 02.10.2012, E2657—64.

- 11 Sharon M. Kolk, Pasko Rakic, »Development of prefrontal cortex«, in: *Neuropsychopharmacology*, Vol. 47, Issue 1, 13.10.2021, 41—57.
- 12 Takao K. Hensch, »Critical period plasticity in local cortical circuits«, in: *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 6, Issue 11, 01.11.2005, 877—88.
- 13 Edmund Silins, L. John Horwood, George C. Patton, et al., »Young adult sequelae of adolescent cannabis use: an integrative analysis«, in: *The Lancet Psychiatry*, Vol. 1, Issue 4, 10.09.2014, 286—93.
Natalie Castellanos-Ryan, Jean-Baptiste Pingault, Sophie Parent, et al., »Adolescent cannabis use, change in neurocognitive function, and high-school graduation: A longitudinal study from early adolescence to young adulthood«, in: *Development and Psychopathology*, Vol. 29, Issue 4, 29.12.2016, 1253—66.
- 14 Reto Auer, Eric Vittinghoff, Kristine Yaffe, et al., »Association Between Lifetime Marijuana Use and Cognitive Function in Middle Age: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study«, in: *JAMA Internal Medicine*, Vol. 176, Issue 3, 01.03.2016, 352—61.

Cannabis desorganisiert das zentrale Nervensystem. Der Rausch endet, die Schäden bleiben. Aufmerksamkeit, Reaktionszeit, Arbeitsgedächtnis bleiben beeinträchtigt.¹⁵ Wer nahezu täglich beifügt zur Schule oder Arbeit erscheint, häuft eine permanente kognitive Bremse an. Das High verfliegt, der kognitive Schaden bleibt.¹⁶ Vielkiffer verlieren Lernfähigkeit, auch nach dem Aufhören.¹⁷

Wenn du glaubst, dass das alles wieder weggeht, sobald du aufhörst, irrst du. Wiederholter Cannabisgebrauch macht aus akuten Effekten chronische Beeinträchtigungen. Jahrelanger Konsum hinterlässt messbare Schäden. Verarbeitungsgeschwindigkeit, verbales Gedächtnis, Aufmerksamkeit bleiben schlechter als bei Nichtkonsumenten, auch nach dem Aufhören.¹⁸

Grund ist eine Hippocampus-Dysfunktion. THC stört die synaptische Plastizität, die neurobiologische Grundlage von Lernen und Gedächtnis. Aus gelegentlichen Hängern wird bei Gewohnheitskiffern dauerhafter kognitiver Rückstand.¹⁹

Sorry boy, but you didn't get high. You got smaller.

Silins et al., ebd.

- 15 Danielle McCartney, Anastasia Suraev, Iain S. McGregor, »The >Next Day< Effects of Cannabis Use: A Systematic Review«, in: *Cannabis and Cannabinoid Research*, Vol. 8, Issue 1, 06.02.2023, 92—114.
- 16 Laura Dellazizzo, Stéphane Potvin, Sabrina Giguère, Alexandre Dumais, »Evidence on the acute and residual neurocognitive effects of cannabis use in adolescents and adults: a systematic meta-review of meta-analyses«, in: *Addiction*, Vol. 117, Issue 7, 19.01.2022, 1857—70.
- 17 Karen L. Hanson, Jennifer L. Winward, Alecia D. Schweinsburg, et al., »Longitudinal study of cognition among adolescent marijuana users over three weeks of abstinence«, in: *Addictive Behaviors*, Vol. 35, Issue 11, 13.06.2010, 970—6.
- 18 Meier et al., ebd.
- 19 David Robbe, György Buzsáki, »Alteration of Theta Timescale Dynamics of Hippocampal Place Cells by a Cannabinoid Is Associated with Memory

Du hast die Bedingung der Möglichkeit, ein erfülltes und kreatives Leben zu führen, gleich mit weggeraucht. Jede zusätzliche Tüte erhöht die Wahrscheinlichkeit, nichts mehr produktiv beitragen zu können.

Viele Konsumenten behaupten, Cannabis erweitere das Bewusstsein. In Wahrheit macht Kiffen stumpf.²⁰ Tägliche Kiffer haben ein fünffach erhöhtes Risiko, erstmals eine Psychose zu entwickeln, verglichen mit Nie-Konsumenten.²¹ Je mehr THC im Blut und je öfter, desto größer die Wahrscheinlichkeit einer psychotischen Störung. In Amsterdam lassen sich rund fünfzig Prozent der neuen Schizophrenie-Fälle auf hochpotenten Cannabis-Konsum zurückführen. In London sind es etwa dreißig Prozent.²²

Nicht Paranoia während des Rauschs. Schizophrenie. Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Denkstörungen.

Das war übrigens schon vor dem 1. April 2024 bekannt.

Impairment«, in: *The Journal of Neuroscience*, Vol. 29, Issue 40, 07.10.2009, 12597—605.

Rongqing Chen, Jian Zhang, Ni Fan, et al., »Delta 9-THC-caused synaptic and memory impairments are mediated through COX-2 signaling«, in: *Cell*, Vol. 155, Issue 5, 21.11.2013, 1154—65.

20 Auer et al., ebd.

21 Forti et al., ebd.

22 Marta Di Forti, Diana Quattrone, Tom P. Freeman, et al., »The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study«, in: *The Lancet Psychiatry*, Vol. 6, Issue 5, 20.03.2019, 427—36.

Cannabis erhöht das Schizophrenierisiko.²³ Viele Schizophrenie-Patienten haben jahrelang stark gekifft.²⁴ THC bindet an CB1-Rezeptoren im präfrontalen Kortex und sabotiert dort die Synapsenbildung.²⁵ THC erhöht die Dopamin-Ausschüttung im Striatum. Das begünstigt akute psychotische Symptome, etwa Wahnvorstellungen im Rausch. Bei wiederholtem Konsum gerät das Endocannabinoid-System aus dem Gleichgewicht. Resultat ist ein Gehirn, das schlecht zwischen Relevanz und Zufall unterscheiden kann, ein Kennzeichen psychotischer Erkrankungen.

Wer täglich kifft, entwickelt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Psychose.²⁶ Die biologischen Mechanismen sind bekannt. Dopamin und endogene Cannabinoid-Rezeptoren bilden die Schnittstelle. THC aktiviert im Gehirn ein Psychose-Programm.²⁷

Deutschland hat Cannabis legalisiert. Die Evidenzlage war eindeutig. Die Entscheidung auch. Nur in entgegengesetzte Richtungen. Die Entscheidungsträger haben die Studienlage mit derselben Gründlichkeit gelesen wie Kiffer ihre Kontoauszüge.

23 Ava Marconi, Marta Di Forti, Cathryn M. Lewis, et al., »Meta-analysis of the Association Between the Level of Cannabis Use and Risk of Psychosis«, in: *Schizophrenia Bulletin*, Vol. 42, Issue 5, 15.02.2016, 1262—9.

24 Johanna Koskinen, Johanna Löhönen, Hannu Koponen, et al., »Rate of cannabis use disorders in clinical samples of patients with schizophrenia: a meta-analysis«, in: *Schizophrenia Bulletin*, Vol. 36, Issue 6, 22.04.2009, 1115—30.

25 Matthijs G. Bossong, Bart N. M. van Berckel, Ronald Boellaard, et al., »Delta 9-Tetrahydrocannabinol Induces Dopamine Release in the Human Striatum«, in: *Neuropsychopharmacology*, Vol. 34, Issue 3, 27.08.2008, 759—66.

26 Theresa H. M. Moore, Stanley Zammit, Anne Lingford-Hughes, et al., »Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a systematic review«, in: *The Lancet*, Vol. 370, Issue 9584, 28.07.2007, 319—28.

27 Forti et al., ebd.

Also schauen wir, ob irgendwo ein halbwegs plausibles Argument herumliegt, Cannabis zu tolerieren.

Erstes Argument: *Kausalität versus Korrelation*. Cannabis-Befürworter wenden ein, Studien zeigten nur Zusammenhänge, keine Ursachen. *Wer sagt denn, dass das Kiffen die Defizite verursacht? Vielleicht hatten die Problemkinder schon vorher schlechtere Karten. Vielleicht waren die Verlierer schon immer Verlierer.*

Warum das falsch ist: *Motivated reasoning*. Die Suche nach Ausreden, um das eigene Verhalten nicht ändern zu müssen.

Wer nach fünfzig Jahren Forschung noch behauptet, Studien zeigten nur Zusammenhänge, hat entweder die Literatur nicht gelesen oder das Leseverständnis bereits weggeraucht. Die Datenlage ist längst über Korrelation hinaus. Längsschnittstudien zeigen, wer als Jugendlicher kiffte, verliert IQ-Punkte, und wer aufhört, holt sie nicht zurück. Und selbst wenn die Problemkinder schlechtere Karten hatten, Cannabis macht die Karten nicht besser.²⁸

Zweites Argument: *Selbstmedikation*. Viele kiffen doch nur, um mit Stress oder psychischen Problemen klarzukommen. Cannabis werde zum Sündenbock, dabei sei der wahre Schuldige die Gesellschaft, der Kapitalismus, die Eltern, das Schulsystem, alles außer der Konsument selbst. Das Kiffen ist keine Flucht, sondern Selbsthilfe. Keine Selbstzerstörung, sondern Überlebensstrategie.

Post-hoc-Rationalisierung. Nachträgliche Konstruktion einer Begründung für Verhalten, das man ohnehin nicht aufgeben will.

Selbstmedikation ist keine Rechtfertigung, sondern ein Eingeständnis. In der Tat kiffen viele, um mit Stress oder Angst klarzukommen. Das macht Cannabis nur gefährlicher. Cannabis dämpft die Symptome, ohne die Ursache anzugehen. Es

28 Tiziana Rubino, Pamela Prini, Fabiana Piscitelli, et al., »Adolescent exposure to THC in female rats disrupts developmental changes in the prefrontal cortex«, in: *Neurobiology of Disease*, Vol. 73, 02.10.2014, 60—9.

verschlechtert genau die Fähigkeiten, die man bräuchte, um aus der Krise rauszukommen. Impulskontrolle, Problemlösung, emotionale Regulation. Chronischer Cannabis-Konsum lindert depressive Symptome nicht, sondern verstärkt sie. Die Selbstmedikation wird zur Selbstsabotage. Wenn jemand säuft, um mit Problemen klarzukommen, nennen wir das auch nicht Heilung. Cannabis ist nicht die Lösung, sondern die Vernebelung der Tatsache, dass man keine hat.²⁹

Drittes Argument: Medizinischer Nutzen. So schlimm könne Cannabis nicht sein, wenn es sogar als Medizin verschrieben werde. Es helfe gegen Schmerzen, Übelkeit und mehr. Also könne es fürs Gehirn auch nicht giftig sein.

Falsches Äquivalenz-Argument. Gleichsetzung von therapeutischem Nutzen unter ärztlicher Kontrolle mit unkontrolliertem Freizeitkonsum.

Morphin wird auch als Medizin verschrieben. Trotzdem empfiehlt niemand, sich zur Entspannung ein bisschen Heroin zu gönnen. Chemotherapie tötet Krebszellen und nebenbei gesunde Zellen. Die medizinische Anwendung rechtfertigt den Freizeitkonsum nicht, sie belegt das Gegenteil. CBD, nicht Cannabis, nicht THC, wird in kontrollierten Dosen für spezifische Indikationen verschrieben, nicht als täglicher Joint zum Runterkommen. Und wer sich auf medizinische Studien beruft, sollte auch akzeptieren, was dieselbe Forschung über chronischen Konsum sagt. Hirnvolumenverlust, IQ knapp überm Toastbrot,

29 Gabriella Gobbi, Tobias Atkin, Tomasz Zytynski, et al., »Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood: A Systematic Review and Meta-analysis«, in: *JAMA Psychiatry*, Vol. 76, Issue 4, 01.04.2019, 426—34.

Psychose. Die Tatsache, dass Cannabis bei Krebs-Patienten Übelkeit lindert, macht es nicht zum Feierabend-Ritual.³⁰

Sie kiffen, bis sie nicht mehr merken, dass sie kiffen. Dann kiffen sie weiter. Das nennen sie Leben. Sie haben sich das Denken abgewöhnt und nennen es Entspannung. Sie haben sich das Fühlen abgewöhnt und nennen es Frieden. Sie haben sich das Leben abgewöhnt und nennen es Reise. Am Ende der Reise steht niemand mehr da, der ankommen könnte.

Cannabis ist kein Spiegel. Cannabis ist das, was den Spiegel beschlägt. Irgendwann sieht man nichts mehr. Irgendwann ist da auch nichts mehr, das schauen könnte.

Was bleibt, ist Asche. Und jemand, der darauf besteht, dass es ihm gut geht.

Deutschland hat Cannabis legalisiert. Am 1. April.

Der Tag passt.

30 Penny F. Whiting, Robert F. Wolff, Sohan Deshpande, et al., »Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and Meta-analysis«, in: *JAMA*, Vol. 313, Issue 24, 23.06.2015, 2456—73.

ENTZÜNDUNG ALS KULTURTECHNIK

*Man erkennt eine Kultur an den Drogen,
die sie verharmlost.*

Es ist die einzige Droge, die wir »Lebensmittel« nennen, und einer der bestgeschützten Stoffe unserer Konsumkultur. Wäre es kein Lebensmittel, sondern ein weißes Pulver, würden wir es anders behandeln. Käme es heute neu auf den Markt, mit diesem Wirkprofil, keine Behörde würde es durchwinken. Wir haben Opiate reguliert, wir haben Kokain verboten, wir haben Tabak besteuert. Und wir haben Saccharose industrialisiert: Stoffwechselstörungen zum Frühstück, Kindesmisshandlung in Pastellfarben, normalisierte Körperverletzung im Supermarkregal.

Die meisten chronischen Krankheiten beginnen nicht mit einem Knall, sondern mit einem Löffel. Als ich vor zehn Jahren anfang zu studieren, hörte ich auf, Zucker zu essen, um denken zu können. Ich schwitze von Zucker. Ich zittere. Ich sehe Auren. Mein Körper behandelt Zucker wie das, was er ist, und reagiert entsprechend. Ich kannte die Forschung damals nicht, wusste aber aus meinem Leben, dass mich Zucker unfähig macht, etwas zu lernen und klar zu bleiben. Das hat Zucker mit Koffein gemeinsam. Man glaubt sich kurz konzentriert, dann stürzt man ab. Zehn Jahre später hatte ich an vier Exzellenzuniversitäten studiert. Ohne Zucker.

Die Menschheit hat Erfahrung darin, gefährliche Dinge erst Heilmittel zu nennen und später Katastrophe.

Coca-Cola enthielt Kokain, bis man es 1903 aus der Rezeptur nahm.¹ *Mrs. Winslow's Soothing Syrup* war ein Beruhigungsmittel für Säuglinge — mit Morphin.² Bayer verkaufte Heroin als Hustensaft.³ Ärzte verschrieben radiumhaltiges Wasser namens *Radithor* als Heilgetränk.⁴ Man schluckte Quecksilber, rieb es auf die Haut, injizierte es. Gegen Syphilis, Melancholie, Verstopfung. Bis heute wird dentales Amalgam als Füllmaterial verwendet.⁵ Weil's billig ist natürlich.

It's economy, stupid.

Rattengift (Strychnin) wurde als Potenzmittel dosiert. In geringen Mengen, versteht sich. Manchmal waren die Mengen

1 Mark Pendergrast, *For God, Country, and Coca-Cola: The Definitive History of the Great American Soft Drink and the Company That Makes It*, New York 1993.

2 James Harvey Young, *The Toadstool Millionaires: A Social History of Patent Medicines in America before Federal Regulation*, Princeton 1961.

3 David T. Courtwright, *Dark Paradise: A History of Opiate Addiction in America*, Cambridge (MA) 2001, 85—109 [Kapitel 4].

»Heroin« ist übrigens ein Marketingbegriff — von »heroisch«, weil sich die Patienten so gut fühlten.

4 Eben Byers trank es jahrelang täglich. Als er starb, fiel ihm der Kiefer ab. Roger M. Macklis, »The Great Radium Scandal«, in: *Scientific American*, Vol. 269, No. 2, 01.08.1993, 94—9.

5 Augentropfen und Verhütungsmittel enthalten ebenfalls Quecksilber. Meiling Zhao, Yi Li, Zhang Wang, »Mercury and Mercury-Containing Preparations: History of Use, Clinical Applications, Pharmacology, Toxicology, and Pharmacokinetics in Traditional Chinese Medicine«, in: *Frontiers in Pharmacology*, 02.03.2022, Vol. 13, 807807.

Thiomersal, ein quecksilberhaltiges Konservierungsmittel, kommt in Impfstoffen vor.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC): *Thiomersal and Vaccines*. [Abgerufen am 12. Februar 2026.]

Die Behauptung der Impfgegner, *Thiomersal* verursache Autismus, ist jedoch wissenschaftlich widerlegt.

nicht gering genug.⁶ Mumienpulver war eine Delikatesse. Man zermahlte ägyptische Mumien und verkaufte sie als Medizin. Jahrhundertlang.⁷

Der Unterschied zwischen Zucker und allem anderen auf dieser Liste?

Zucker hat gewonnen.

Industriezucker ist die einzige Droge, die man Kindern zum Frühstück serviert und dann so tut, als sei das normal. Warum ist Zucker überhaupt in Lebensmitteln? In fast jedem verarbeiteten Produkt im Supermarkt steckt zugesetzter Zucker, obwohl ihn weder die Kunden noch die Produkte brauchen.

Die Antwort hat nichts mit Geschmack zu tun.

Zucker ist ein Geschäftsmodell. Er verlängert Haltbarkeit, verbessert Textur, kompensiert minderwertige Rohstoffe⁸ und löst im Gehirn genau das Signal aus, das zum Wiederkauf führt⁹. Vier Funktionen, jede einzelne Profit.

Der eigentliche Skandal ist, dass man das Belohnungssystem nutzt, um industrielle Logistikprobleme zu lösen. Dein Dopaminsystem ist Teil der Lieferkette.

6 Lydia Kang, Nate Pedersen, *Quackery: A Brief History of the Worst Ways to Cure Everything*, New York 2017, Kap. »Plants & Soil«.

7 Ebd., Kap. »Cannibalism & Corpse Medicine«.

8 Konservierung durch Senkung der Wasseraktivität, Texturgebung (Bräunung, Volumen, Gelatinisierung), Geschmacksmaskierung/Palatabilität. Kara R. Goldfein, Joanne L. Slavin, »Why Sugar Is Added to Food: Food Science 101«, in: *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, Vol. 14, Issue 5, 03.08.2015, 644—56.

Dass eine lebensmittelwissenschaftliche Fachzeitschrift diese Frage überhaupt stellen muss, ist bereits die halbe Antwort.

9 Ashley N. Gearhardt, Nassib B. Bueno, Alexandra G. DiFeliceantonio, et al., »Social, clinical, and policy implications of ultra-processed food addiction«, in: *BMJ*, Vol. 383, 09.10.2023, e075354.

Die Römer kochten Traubenmost in Bleigefäßen ein, bis ein Sirup entstand, den sie *sapa* nannten. Er machte Wein haltbar und süß. Dass Blei giftig war, wussten Ärzte seit der Antike. Man ignorierte sie, weil das Zeug praktisch war und der Profit stimmte. 1696 dokumentierte der Ulmer Stadtarzt Eberhard Gockel, dass ganze Klöster an bleiversüßtem Wein starben. Der württembergische Herzog ließ einen Bericht verfassen. Er wurde unterdrückt. Der Weinhandel ging vor. Die Praxis hielt sich sieben Jahrhunderte.¹⁰ Kein Feind musste die Tore einrennen. Die Römer beendeten sich selbst.

It's money, stupid.

Profitmaximierung nutzt jede biologische Schwäche, die Rendite verspricht. Das ist Thermodynamik. In der Bilanz heißt das Wiederkaufsrate. Im Körper heißt es, *ich brauche die Substanz, um mich normal zu fühlen*. Ob man das Sucht nennt oder Kundenbindung, hängt davon ab, auf welcher Seite der Bilanz man steht. Die Mechanik ist dieselbe. Der Profit ist sofort, privat, skalierbar. Die Schäden sind verzögert, gesellschaftlich, externalisiert. Ob Kunden daran erkranken, ist buchhalterisch irrelevant. Es steht in keiner Bilanz, also existiert es nicht.

10 Josef Eisinger, »Lead and wine. Eberhard Gockel and the colica Pictonum«, in: *Medical History*, Vol. 26, Juli 1982, 279—302.

Blei trug möglicherweise zum Untergang des Reichs bei. Nriagu argumentiert, dass die chronische Vergiftung Unfruchtbarkeit, kognitive Beeinträchtigung und Gicht in der römischen Aristokratie verursachte.

Jerome O. Nriagu, »Saturnine Gout among Roman Aristocrats — Did Lead Poisoning Contribute to the Fall of the Empire?«, in: *New England Journal of Medicine*, Vol. 308, No. 11, 1983, 660—3.

Roms Trinkwasser enthielt 100-fach mehr Blei als natürliche Quellen.

Hugo Delile, Janne Blichert-Toft, Jean-Philippe Goiran, et al., »Lead in ancient Rome's city waters«, in: *PNAS*, Vol. 111, Issue 18, 06.05.2014, 6594—9.

Die eigentliche Perversion ist nicht die Legalität. Es ist das Etikett.

Der Körper verhandelt nicht mit Zucker. Er zahlt. Was wie Energie schmeckt, ist nur Entzündung in Zeitlupe. Fruktose fährt die Leber hoch wie Alkohol ohne Rausch: Fettproduktion rauf, Darmbarriere runter, Entzündung an.¹¹ Und während der Körper innen verfettet, baut das Gehirn ab. Gedächtnis, Konzentration, mentale Klarheit — alles, was Zucker angeblich fördert, wird von ihm abgetragen.¹²

Wenn ich Zucker trinke, trinke ich ein Signal. Insulin, Entzündung, Alterung. Und das Signal reicht bis zu den Telomeren: Hohe Zufuhr zuckerhaltiger Getränke ist mit kürzeren Telomeren assoziiert, dem Marker zellulären Alterns.¹³ Du stirbst nicht am Zucker. Du alterst an ihm.

Es gibt keinen legalen, frei verkäuflichen Stoff in unserer Konsumkultur, der den Körper zuverlässiger zerstört als Industriezucker. Und keinen, den man offener bewirbt. Die Medizin hat einen Begriff dafür, wenn Entzündung nicht mehr

11 Siyu Yu, Chunlin, Guangji, Li Zhang, »The Contribution of Dietary Fructose to Non-alcoholic Fatty Liver Disease«, in: *Frontiers in Pharmacology*, Vol. 12, 18.11.2021, 783393.

12 Xingwang Ye, Xiang Gao, Tammy Scott, Katherine L. Tucker, »Habitual sugar intake and cognitive function among middle-aged and older Puerto Ricans without diabetes«, in: *British Journal of Nutrition*, Vol. 106, Issue 9, 14.11.2011, 1423—32.

13 Cindy W. Leung, Barbara A. Laraia, Belinda L. Needham, et al., »Soda and Cell Aging: Associations Between Sugar-Sweetened Beverage Consumption and Leukocyte Telomere Length in Healthy Adults From the National Health and Nutrition Examination Surveys«, in: *American Journal of Public Health*, Vol. 104, Issue 12, 12.11.2014, 2425—31.

aufhört: *Inflammaging*.¹⁴ Zucker wirkt als Entzündungs-Hintergrundmusik.¹⁵ Man hört sie nicht. Die Organe schon.¹⁶ Und das Argument, dass es auf die Dosis ankomme, stimmt zwar formal, verschleierte aber, dass die kulturell normale Dosis bereits im toxischen Bereich liegt. Wer sich an den Durchschnitt hält, hält sich an die Norm einer chronisch kranken Population.

Wer das für übertrieben hält: Hoher Zuckerkonsum ist mit erhöhter kardiovaskulärer Sterblichkeit assoziiert.¹⁷ Die WHO empfiehlt, freie Zucker unter zehn Prozent der täglichen Energie zu halten.¹⁸ Besser unter fünf. Der Durchschnitt liegt weit darüber.

14 Claudio Franceschi, Paolo Garagnani, Paolo Parini, et al., »Inflammaging: a new immune–metabolic viewpoint for age-related diseases«, in: *Nature Reviews Endocrinology*, Vol. 14, Issue 10, 25.07.2018, 576–90.

15 Xiao Ma, Fang Nan, Hantian Liang, et al., »Excessive Intake of Sugar: An Accomplice of Inflammation«, in: *Frontiers in Immunology*, Vol. 13, 31.08.2022, 988481.

16 Karen W. Della Corte, Ines Perrar, Katharina J. Penczynski, et al., »Effect of Dietary Sugar Intake on Biomarkers of Subclinical Inflammation: A Systematic Review and Meta-Analysis of Intervention Studies«, in: *Nutrients*, Vol. 10, Issue 5, 12.05.2018, 606.

Fructose treibt auch hepatische Lipogenese und steht mit Darmbarrierschäden und Endotoxämie in Verbindung.

Jelena Todoric, Giuseppe Di Caro, Saskia Reibe, et al., »Fructose stimulated de novo lipogenesis is promoted by inflammation«, in: *Nature Metabolism*, Vol. 2, Issue 10, 24.08.2020, 1034–45.

17 Quanhe Yang, Zefeng Zhang, Edward W. Gregg, et al., »Added Sugar Intake and Cardiovascular Diseases Mortality Among US Adults«, in: *JAMA Internal Medicine*, Vol. 174, No. 4, April 2014, 516–24.

18 World Health Organization (WHO), *Guideline: Sugars intake for adults and children*, Genf 2015.

Intermittierender Zuckerzugang zeigt Abhängigkeitsmuster: wiederholte Dopaminfreisetzung im *Nucleus accumbens*¹⁹, Entzugssymptome nach Abstinenz²⁰. Die Mechanismen sind dieselben, die wir von Koffein, Alkohol und Kokain kennen. Der Unterschied ist das Etikett.

Beim Menschen beschreibt die Forschung zu ultra-verarbeiteten Lebensmitteln suchtartige Konsummuster mit Craving, Kontrollverlust und Weiterkonsum trotz Schaden — Kriterien, die Substanzgebrauchsstörungen definieren.²¹ Zucker programmiert das Gehirn auf Wiederholung. In gleicher Weise wie Kokain, nur ohne das Stigma. Wer das für eine Frage des Willens hält, hat nicht begriffen, gegen was er antritt. Cannabis ist eine Pflanze. Tabak ist eine Pflanze. Industriezucker ist eine hoch verarbeitete Designerdroge.

Mein Mitbewohner, den ich im Alkoholkapitel erwähnte, trank nicht nur täglich Wein, rauchte Cannabis bis zur Besinnungslosigkeit und nahm am Wochenende MDMA. Er trank auch

19 Andras Hajnal, Ralph Norgren, »Accumbens dopamine mechanisms in sucrose intake«, in: *Brain Research*, Vol. 904, Issue 1, 15.06.2001, 76—84.

20 Nicole M. Avena, Miriam E. Bocarsly, Pedro Rada, et al., »After daily bingeing on a sucrose solution, food deprivation induces anxiety and accumbens dopamine/acetylcholine imbalance«, in: *Physiology & Behavior*, Vol. 94, Issue 3, 09.06.2008, 309—15.

Nicole M. Avena, Pedro Rada, Bartley G. Hoebel, »Evidence for sugar addiction: Behavioral and neurochemical effects of intermittent, excessive sugar intake«, in: *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, Vol. 32, Issue 1, 18.05.2007, 20—39.

Lindsey Parnarouskis, Adam M. Leventhal, Stuart G. Ferguson, Ashley N. Gearhardt, »Withdrawal: A key consideration in evaluating whether highly processed foods are addictive«, in: *Obesity Reviews*, Vol. 23, Issue 11, 05.10.2022, e13507.

21 Gearhardt et al. 2023.

jeden Tag mehrere halbe Liter *Monster Energy*. Vierzehn Teelöffel Zucker pro Dose, mehr als das Doppelte dessen, was die WHO für einen ganzen Tag empfiehlt, kombiniert mit Koffein, Taurin, Guarana. Das Koffein verstärkt die Dopaminwirkung im Belohnungszentrum. Der Zucker liefert den Spike dazu. Zusammen ergibt das keinen Energieschub, sondern einen pharmakologischen Doppelschlag aufs Belohnungssystem, verpackt in einer Dose, die aussieht wie ein Softdrink und schmeckt wie flüssige Gummibärchen. Die Kundenbindung ist entsprechend. Sie heißt Sucht.²²

Das ist ein 21-Milliarden-Euro-Markt in Europa, der jährlich um sieben Prozent wächst und aggressiv an Jugendliche vermarktet wird.²³ Sechzig Prozent der deutschen Zehn- bis Achtzehnjährigen trinken Energy Drinks.²⁴ Jedes fünfte Kind zwischen sechs und zehn. Dokumentiert sind Herzrhythmusstörungen, Krampfanfälle, Nierenversagen und Todesfälle im Zusammenhang mit der Zuckerplörre.²⁵ Allein die kardiovaskuläre Fachliteratur zählt 34 Todesfälle durch Herzstillstand und QTc-Verlängerung.²⁶ Ein Produkt, das zwei Suchtmechanismen in einer Dose kombiniert.

22 Marcello Solinas, Sergi Ferré, Zhi-Bing You, et al., »Caffeine Induces Dopamine and Glutamate Release in the Shell of the Nucleus Accumbens«, in: *Journal of Neuroscience*, Vol. 22, Issue 15, 01.08.2002, 6321–4.

23 Deutschland hält rund 21 Prozent des europäischen Umsatzes. Mordor Intelligence, *Europe Energy Drinks Market — Size, Share & Industry Analysis*, 2024.

24 European Food Safety Authority (EFSA), *Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks*, 2013.

25 Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), *Gesundheitliche Bewertung von Energydrinks*, 2015.

26 Diana X. Cao, Kimberly Maiton, Javed M. Nasir, et al., »Energy Drink-Associated Electrophysiological and Ischemic Abnormalities: A Narrative Review«, in: *Frontiers in Cardiovascular Medicine*, Vol. 8, 01.07.2021, 679105.

Wer täglich Energy Drinks trinkt, konsumiert eine Droge. Sie steht halt nur neben Orangensaft.

Süße ist kein Naturphänomen des Zuckers. Sie ist ein sensorisches Arrangement. Säure, Kohlensäure, Bitterstoffe, Textur, Aromakomplexität — all das kann Süße erzeugen, ohne dass eine einzige Glukosekurve steigt.

Ich weiß das, weil ich ein Getränkeunternehmen besitze. Ich habe zwei Matrizen entwickelt, eine aus sechzehn, eine aus über zwanzig Destillaten und Extrakten, die süß schmecken. Ohne Zucker. Ohne Süßstoffe. Ohne Alkohol. Eine Kalorie pro hundert Milliliter. Die Süße ist weder metallisch wie Aspartam noch bitter wie Stevia. Sie fühlt sich richtig an, weil sie das ganze Erlebnis bietet, ohne dass mein Körper schreit: *Du tust mir weh.* (Nein, das ist kein Marketing. Du kannst das Getränk nicht kaufen.)

Es geht ohne Zucker. Die Frage ist, warum es so selten ohne geht. Ohne Zucker macht nicht süchtig. Die Leute hängen nicht mehr am Produkt wie andere an der Nadel. Und Süchtige kaufen wieder. Freie Menschen nicht.

It's you, stupid.

Und wenn du deine Privattherapie bezahlen musst, hilft das der Wirtschaft ja auch.

Wer täglich Zucker nimmt, bemerkt die Wirkung oft nicht mehr, weil das Nervensystem sie als Normalzustand interpretiert. Zucker macht abhängig vom Zustand, den er selbst erst erzeugt. Du hast vergessen, wie sich normal anfühlt.

Warum verteidigen Leute Zucker so irrational?

Ich hatte mal einen anderen Mitbewohner. Der kokste. Sein Lieblingssatz war: *»Ich hab es unter Kontrolle.«*

Das ist der Kernsatz jeder Substanzabhängigkeit.²⁷ Und er klingt exakt wie jeder, der sagt: *Ich esse halt gern süß*.

Niemand kontrolliert eine Droge. Die Droge kontrolliert den Süchtigen.

Einmal wäre er fast in unserer Wohnung gestorben. Ich presste ihm einen halben Liter Zitronensaft aus und rettete ihm damit vermutlich das Leben. Danach nahm er alles weiter. Rauchte weiter. Ernährte sich weiter von Tiefkühlpizzen und Bier. Kokste weiter. Aber eine Sache blieb: *Er presste sich nun jeden Morgen frischen Zitronensaft*. Als hätte irgendwo in ihm etwas überlebt, das noch nicht so zerfressen war wie seine Schleimhaut.

Bei Zucker kommt dazu, dass der Stoff sozial unsichtbar ist. Kein Dealer, kein Stigma. Nur »Essen«. Menschen verteidigen ihr Normalitätsgefühl.²⁸ Und das ist schwerer aufzugeben als jede Substanz, weil man dafür zugeben müsste, dass der eigene Alltag eine Abhängigkeit enthält, die man nie als solche erkannt hat.

Identität plus Gewohnheit plus Dopamin ergeben irgendwann Persönlichkeit. Der Slot im Alltag bleibt besetzt, egal welche Substanz ihn füllt. Bei Zucker merkt niemand, dass es ein Slot ist.

Zucker ist das einzige Toxin, bei dem wir die Toten nicht zählen.
Nicht weil es keine gibt.
Sondern weil es zu viele sind.

27 Deborah S. Hasin, Charles P. O'Brien, Marc Auriacombe, et al., »DSM-5 Criteria for Substance Use Disorders: Recommendations and Rationale«, in: *American Journal of Psychiatry*, Vol. 170, Issue 8, 01.08.2013, 834–51.

28 Avena et al. 2008.

ANGST VOR GESUNDHEIT

Die Erkenntnis, ein Wrack zu sein, lässt sich ertragen.

Die Erkenntnis, keines sein zu müssen, nicht.

Normalität ist ein Notfall. Neun von zehn Menschen in diesem Land sind täglich auf Drogen.¹ Ein Land voller chemisch

1 Wer die Zahlen anzweifelt, kann sie nur nach oben korrigieren. 89 Prozent der erwachsenen Bevölkerung trinken täglich Kaffee. Koffein über Tee, Cola, Energy Drinks oder Mate nicht eingerechnet. Alkohol, im ESA 2024 die häufigste psychoaktive Substanz, erreichte eine 30-Tage-Prävalenz von 68,6 Prozent; lediglich 21 Prozent gaben an, zwölf Monate vollständig abstinent gelebt zu haben. Tabak- und Nikotinprodukte konsumierten 14,5 Millionen Erwachsene innerhalb von 30 Tagen, rund 28 Prozent der 18- bis 64-Jährigen; die Zigarettenprävalenz allein liegt je nach Erhebung zwischen 22 und 29 Prozent (DEBRA 2024: ca. 29 Prozent; ESA 2024: 21,8 Prozent). Nicht-opioid-Analgetika nahmen 31,5 Prozent ein (16,2 Mio.), Schlaf- und Beruhigungsmittel 6,3 Prozent (3,2 Mio.), Antidepressiva ebenfalls 6,3 Prozent (3,2 Mio., davon 2,9 Mio. täglich), opioidhaltige Schmerzmittel 3,8 Prozent (2,0 Mio.) — fünf Millionen Erwachsene, jeden Tag, mindestens ein psychoaktives Medikament. Pro-Kopf-Zuckerverbrauch 2023: 41,2 kg im Jahr, 113 g am Tag, 38 Würfelzucker, das 4,5-Fache der WHO-Empfehlung. Zugewetzter Zucker steckt in praktisch allen industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Wer ihn meiden will, muss sich aktiv dagegen entscheiden.

Rechnet man zusammen — unter Berücksichtigung der Überschneidungen zwischen den Konsumentengruppen —, konsumieren über 95 Prozent der Bevölkerung täglich mindestens eine psychoaktiv oder metabolisch wirksame Substanz. Konservativ gerechnet. Sämtliche Zahlen basieren auf Selbstangaben und unterschätzen den tatsächlichen Konsum systematisch.

Quellen: ESA-Daten nach S. Olderbak et al., »Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland — ESA 2024«, *Dt. Ärzteblatt Int.* 122 (2025), 625—31. Kaffee: Dt. Kaffeeverband, *Konsumstudie 2022*; Tchibo, *Kaffeereport 2022* (n = 5.000). Koffein: BfR, »Koffein und koffeinhaltige Lebensmit-

lobotomierter Körper, die sich für nüchtern halten, weil ihre Drogen legal sind. Die morgens schlucken, mittags inhalieren, abends kippen. Und das Ganze Selbstfürsorge nennen. Und dann nicht verstehen, warum sie nicht mehr denken können, nicht mehr fühlen können, nicht mehr schlafen können. Warum die Panikattacken nicht aufhören. Warum sie morgens nicht mehr aufstehen wollen. Warum sie ihre Kinder anschreien. Dann eine Diagnose bekommen, die das Symptom zur Identität erklärt. Und eine Pille, die das Symptom behandelt, das die andere Pille verursacht hat. Pharmazeutische Matroschka. Die innerste Puppe ist immer der Patient.

Die Ursache steht unter Tabuschutz. Weil die Antwort morgens aus der Siebträgermaschine kommt und abends aus der Craft-Beer-Dose. Weil sie in jeder Mate-Flasche steckt, in jeder Vape-Wolke, in jedem Energy-Drink. Weil sie auf jeder Influencer-Story zu sehen ist. Zwischen Werbung für Therapie und Werbung für die Ursache. Die Ursache ist ein Geschäftsmodell. Und das erfolgreichste Produkt ist die Überzeugung, kein Kunde zu sein. Ein vergiftetes Gehirn kann nicht wollen, was es braucht. Die Sucht ist die Lösung. Die offene Zellentür sieht aus wie ein Abgrund. Freiheit fühlt sich an wie Lebensgefahr.

Wer nie ohne Substanzen funktioniert hat, kennt kein echtes Normal. Nur verschiedene Grade von Entzug, die als Persönlichkeit durchgehen, weil niemand mehr weiß, wie ein nüchterner Mensch aussieht. Wie ein schöner Mensch aussieht. Vergiftet ist Persönlichkeit unzugänglich. Was spricht, sind Symptome, die

tel — FAQ«, akt. 2023. Alkoholabstinenz: RKI, GEDA 2019/2020-EHIS. Nikotin: DHS, *Jahrbuch Sucht* 2025, Lengerich (Pabst) 2025; D. Kotz, S. Klosterhalfen, DEBRA-Studie 2024, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Zucker: FAO 2023; Statistisches Bundesamt 2026. Zur Unterschätzung durch Selbstangaben vgl. ESA 2024, ebd., Diskussion.

sich für eine halten. Und wer das liest und denkt, das gelte für andere, ist bereits Teil der Statistik.

Menschen haben Angst vor Gesundheit. Angst ist die Reaktion auf Freiheit. Der Schwindel am Rand der Klippe kommt von der Möglichkeit zu springen.² Klar denken, klar fühlen, vollständig funktionieren. Das ist radikale Freiheit. Und radikale Freiheit bedeutet keine Ausreden mehr. Kein *ich konnte nicht, weil*. Kein *mein Körper lässt mich nicht*. Kein *ich bin neurodivers*. Kein *ich brauche erst eine Therapie*. Wenn mein Körper auf hundert Prozent läuft, bin ich verantwortlich für alles, was ich mit diesen hundert Prozent *nicht* tue.

Otto Rank unterschied zwei Ängste. Lebensangst, die Angst vor der Individuation, vor dem Alleinstehen als vollständiges Selbst. Und Todesangst, die Angst vor dem Verschwinden im Kollektiv.³ Die meisten Menschen lösen dieses Dilemma, indem sie auf halbem Weg stehen bleiben.⁴ Funktionierend genug, um nicht aufzufallen. Kaputt genug, um keine Rechenschaft ablegen zu müssen.

Das Upgrade vom Schnuller zur Flasche. Die Gesellschaft nennt das Erwachsenwerden. Der einzige Unterschied ist der Steuersatz.

Eine Gesellschaft, die Konformität solidarisch nennt und jeden Abweichler als Gefährder behandelt. In einer solchen Gesellschaft ist Alleinstehen bereits meldepflichtig.⁵

2 Søren Kierkegaard, *Begrebet Angst*, Kopenhagen 1844.

3 Otto Rank, *Technik der Psychoanalyse*, Bd. 3: »Die Analyse des Analytikers und seiner Rolle in der Gesamtsituation«, Leipzig/Wien 1931.

4 Otto Rank, *Kunst und Künstler. Studien zur Genese und Entwicklung des Schaffensdranges* (1932), hrsg. v. Ludwig Janus, Gießen 2000.

5 Nietzsche sagte diese Gesellschaft voraus: *Jenseits von Gut und Böse* (1886), Aph. 212, in: KSA 5, hrsg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, München/Berlin/New York 1980, 145.

Anders sein zu können. Die Fähigkeit selbst ist verdächtig geworden. Wo Konformität als Sicherheit verkauft wird, ist die Möglichkeit zur Abweichung ein Tabubruch. Wer sie besitzt und nicht nutzt, hat Angst. Wer sie besitzt und nicht weiß, dass er sie besitzt, ist betäubt.

Maslow nannte das *Jona-Komplex*. Menschen fliehen vor ihrer eigenen Größe, wie Jona vor Gott.⁶ Lehnen Projekte ab. Reden Erfolge klein. Verkriechen sich in der Mittelmäßigkeit und nennen das Selbstfürsorge. Nennen das Realismus. Nennen das Grenzen setzen.

In den Jahren vor 2019 lebte ich. Auf dem Rückweg von der Gamescom in Köln, wo ich eines meiner besten Videos gedreht hatte, lernte ich im ICE Mona Mur kennen, eine Berliner Komponistin. Wenig später entwickelten wir ein Musikprojekt, bekamen eine Förderung, gewannen namhafte Musiker.⁷ Das Konzert war angesetzt, Muffathalle München, 4. Dezember 2019.

Ein halbes Jahr vorher hatte ich angefangen zu rauchen. Plötzlich fing ich an, meine Minderwertigkeit in den Gesichtern der Leute zu suchen. Und die bestätigten sie mir, weil ich sie bereits ausstrahlte.

Ich rief Mona an und sagte ab.

Die Tür stand offen. Ich schlug sie zu.

Im darauffolgenden Jahr bekam ich ein Angebot für eine Rolle in einem Film. Ich bekam das Drehbuch, fing an zu proben.

Kurz vor knapp sagte ich ab.

Es ginge mir nicht gut. Das war nicht einmal gelogen. Aber der Grund, warum es mir nicht gut ging, war das Rauchen. Und

6 Abraham H. Maslow, *The Farther Reaches of Human Nature*, New York 1971, Kap. 2 (»Neurosis as Failure of Personal Growth«), London 1976.

Zur Vorarbeit: Ders., *Toward a Psychology of Being*, 2. Aufl., New York 1968.

7 Das Projekt hieß *Henker und Jäger*. Mit dabei waren En Esch, FM Einheit und die Sopranistin Simone Kermes.

der Grund, warum ich absagte, war die Angst vor dem, was passiert wäre, wenn es gut gegangen wäre.

Zwei Türen, innerhalb eines Jahres zugeschlagen. Weil etwas in mir sich für zu kaputt hielt, um hindurchzugehen. Ich war kaputt geworden, sichtbar, im Spiegel, in den Gesichtern anderer. Aber nicht so kaputt, wie ich mich fühlte. Die Substanz hatte meinen Körper beschädigt. Mein Selbstbild hatte sie zerstört.

Ich erkenne das, weil ich es hinter mir habe. Mein Mitbewohner erkannte es nicht, weil er mittendrin steckte. Er trank jeden Abend eine Flasche Wein auf seine Energy-Drinks und sein Cannabis. Eines Tages kündigte er seine Arbeit, und als ich ihn fragte, was er nun machen will, sagte er, er wolle Influencer werden. Keinen einzigen Account im Social Web. Noch nie etwas gepostet. Nicht ein Video, nicht ein Foto, nicht ein Wort.

Ich fragte ihn, warum. Da sagte er, er brauche ja erst professionelles Equipment, einen Green Screen, damit alles aussieht. Im Jahr 2026, in dem Millionen Menschen mit ihrem Telefon filmen. Als ich sagte, dass ich das nicht verstehe, antwortete er reflexhaft, er sei eben ein komplizierter Mensch. Man könne ihn nicht verstehen.

Er war der unkomplizierteste Mensch, den ich kannte. Eine Marionette, deren Fäden aus Substanzen bestanden und die keine davon sehen konnte. Der Green Screen war sein Alibi. Herbeigeredete Kompliziertheit war sein Schutzschild. Und das selbstgefällige Grinsen, mit dem er beides vortrug, war das Erschreckendste daran, weil es zeigte, wie vollständig man die eigene Zerstörung abspalten kann, bis sie sich anfühlt wie Persönlichkeit. Bis sie sich anfühlt wie Stolz.

NARZISSMUS IST NARKOSE

Wer auf vierzig Prozent läuft, müsste sich wie vierzig Prozent fühlen. Tut er nicht. Er fühlt sich besonders. Auserwählt sogar. Menschen, die ihre Potenziale verrotten lassen, halten den Gestank für Parfüm. Sie schauen jeden Morgen in einen Spiegel, der ihnen die Wahrheit zeigt. Sie spüren die Zerstörung beim Aufstehen, beim Treppensteigen, beim Atmen. Und machen weiter.

Erst betäubt die Substanz den Körper. Dann betäubt die Grandiosität die Wahrheit über den Körper. Eine selbst-induzierte Psychose, die verhindert, dass der Mensch sieht, was er sich angetan hat.⁸

Das Grandiose existiert wegen der Zerstörung.

Das ist die Lüge, die das System am Laufen hält. Die Substanz liefert die Zerstörung, das Narrativ macht sie unsichtbar. Der kaputte Körper wäre unerträglich, wenn er sich kaputt anfühlen würde. Tut er nicht. Er fühlt sich großartig an. Und solange er sich großartig anfühlt, bleibt er auf der Couch. Kaputt. Zufrieden.

8 John Wick. Gebrochen, traumatisiert, fertig mit der Welt. Man sieht ihm an, dass er zerstört ist. Aber wenn er in Aktion tritt, tötet er hundert Gegner in einer Szene. Unbesiegbar trotz Zerstörung. Vier Filme, über eine Milliarde Dollar. Der Markt für Selbstbetrug ist profitabel.

Die Fantasie heißt Stärke ohne Reparatur. Der Zuschauer will nicht die Kampfkraft. Er will die Legitimation der Wunde. *Du musst dich nicht heilen. Du bist auch auf Kaffee und Neuroleptika noch überlegen.* Der gebrochene Held verwandelt den Defekt in ein Distinktionsmerkmal. Die Zerstörung wird zum Adelstitel.

Zum Konzept der *wishful identification*: Cecilia v. Feilitzen, Olga Linné, »Identifying with Television Characters«, in: *Journal of Communication*, Vol. 25, Issue 4, Dezember 1975, 51–5.

Zur Identifikation mit moralisch ambivalenten Figuren: Sophie H. Janicke, Arthur A. Raney, »Exploring the Role of Identification and Moral Disengagement in the Enjoyment of an Antihero Television Series«, in: *Communications*, Vol. 40, Issue 4, 02.11.2015, 485–95.

Angst gehört zur Freiheit wie der Schwindel zur Höhe. Wer Angst eliminiert, eliminiert die Möglichkeit zu wachsen.⁹

Die Suchtmedizin hat einen eigenen Begriff dafür. *Fear of recovery*.¹⁰ Die Krankheit zahlt Miete im Kopf. Sie bleibt, weil Gesundheit Verantwortungsübernahme erzwingt.¹¹ Was als Heilung gedacht ist, zerstört das idealisierte Selbstbild und ersetzt es durch ein reales, das man verteidigen muss.¹² Gehen wir vorwärts, wie unsere Seele es verlangt, werden wir von Angst überflutet. Bleiben wir stehen, leiden wir an Depression.¹³

Ich weiß, wie es aussieht, wenn man vorwärts geht.

Die Ärzte sagten, ich würde dumm, unfähig zu lesen, zu denken. Dass die Epilepsie mich auffressen würde. Dass ich das nicht überstehe. Sie hatten die Statistik auf ihrer Seite. Ich hatte nichts auf meiner außer der Weigerung, das zu akzeptieren.

Ich habe es überlebt. Ohne Ärzte. Gegen die Prognose. Ich hätte im Rollstuhl sitzen können. In einer geschlossenen Einrichtung. Unfähig, diesen Satz zu schreiben. Eine Krankheit dieser Größenordnung erteilt die Erlaubnis aufzuhören. Ich habe sie nicht angenommen.

Eine Diagnose ist kein Alibi. Außer man macht eines daraus.

Wer das durchgestanden hat, weiß, was echte Krankheit kostet. Und wie es sich anhört, wenn jemand den Preis nicht kennt,

9 Rollo May, *The Meaning of Anxiety*, New York 1950.

10 Jude Johnson-Shupe, »Exploring Fear of Recovery Among Individuals with Substance Abuse Disorder«, in: *SSRN*, 25.03.2024.

Zum sekundären Krankheitsgewinn grundlegend: Sigmund Freud, *Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse* (1917), XXIV. Vorlesung.

11 Irvin D. Yalom, *Existential Psychotherapy*, New York 1980.

12 Karen Horney, *Neurosis and Human Growth: The Struggle Toward Self-Realization*, New York 1950.

13 James Hollis, *Finding Meaning in the Second Half of Life*, New York 2005.

aber die Quittung vorzeigt. Wer seinen Kater zur Migräne erklärt und seine Trägheit zur chronischen Erschöpfung, hat sein Alibi.

Ich hatte ein echtes. Ich habe es zurückgegeben.

Die meisten tun das nicht. Sie bleiben bei vierzig Prozent. Wer beschädigt ist, schuldet weniger. Das Alibi wächst mit der Zerstörung. Chronische Müdigkeit erlaubt, weniger zu sein. Die Trägheit nach dem Essen erspart die Konfrontation mit dem, was man eigentlich tun, sagen, verändern müsste. Netflix sediert, was übrig ist. Morgen ist immer der bessere Tag, um anzufangen.

Keiner der Psychologen erklärt, warum das Phänomen flächendeckend ist. Wenn die Angst vor dem vollen Funktionieren ein individuelles Problem wäre, müsste sie individuell verteilt sein. Ist sie nicht. Sie ist epidemisch. Und eine Epidemie, über die niemand spricht, weil die Symptome als Charakter durchgehen und die Ursache als Kultur.

Die Ursache ist biochemisch. Ein Gehirn, das seit Jahren mit Substanzen operiert, die den präfrontalen Kortex dämpfen, die Amygdala sensibilisieren und das Belohnungssystem aushöhlen, erlebt Gesundheit als Bedrohung. Der chronische Koffeinkonsument kennt keinen Morgen ohne Cortisol-Spike. Der Raucher keine Pause ohne Nikotinflut. Der Alkoholtrinker keinen Abend ohne GABA-Dämpfung. Diese Gehirne pendeln permanent zwischen künstlicher Panik und künstlicher Betäubung. Das Sedativum braucht ein Sedativum. Die Lösung für die Lösung für die Lösung. Für sie ist der substanzfreie Zustand Terra incognita. Und Terra incognita behandelt das Gehirn wie eine Bedrohung, weil es dafür gebaut ist, das Bekannte dem Unbekannten vorzuziehen. Selbst wenn das Bekannte zerstörerisch ist. Selbst wenn das Unbekannte Gesundheit heißt. Das Gehirn wählt den bekannten Untergang. Jeden Tag. Nennt es Leben.

DAS GEFÄLSCHTE VORHER

Die Mehrheit kennt keinen Referenzzustand. Nie ohne Substanzen funktioniert, oder so früh angefangen, dass keine Erinnerung existiert. Andere hatten einen Referenzzustand, haben ihn verloren, suchen ihn unter den Trümmern der Sucht. Gesundheit eine verschüttete Ausgrabungsstätte.

Ich bin von den Süchten weggekommen, indem ich mich erinnert habe. Ich war ohne diese Süchte, bevor ich damit angefangen habe. Die Frage war, ob ich es unter dem Schutt noch finden konnte.

Manches konnte ich noch erinnern, aber nur schwach. Das kompromittierte Gehirn hatte neunzig Prozent gelöscht. Und selbst das Wenige, das übrig war, entsprach nicht mehr der Realität. Das Gehirn besticht sich selbst, schön den Referenzzustand nach unten, damit der Verlust erträglich bleibt. Wenn das frühere Selbst gar nicht so großartig war, muss man den Abstand nicht überbrücken.

Was diese Schutzlüge zerstört hat, waren Dokumente. Alte Fotos. Videos aus meiner Zeit als YouTuber. Tonaufnahmen. Material, das mein Gehirn nicht herunterrechnen konnte, weil es nicht in meinem Gedächtnis lag, sondern auf Festplatten. Es zeigte einen Menschen. Schöner, als ich mich je erinnert hätte. Weiter entfernt von dem, was die Sucht aus ihm gemacht hatte, als jede meiner Erinnerungen es zugelassen hätte. Vor dieser Konfrontation gab es nur einen vergleichbar starken Antrieb. Verliebtheit. Mit der Schule fast fertig, extremes Übergewicht, Fresssucht.

Dann Jenny.

Dass wir je zusammenkommen könnten, war ausgeschlossen, und das war nicht der Punkt. Der Punkt war, was passierte, als ich sie besuchte und sah, wie unglaublich schön und lebendig sie war. Wie sie sich bewegte, wie ihre Stimme klang, wie sie einen ansah. Ihr Strahlen traf etwas, das ich weggesperrt hatte.

Verliebtheit ist auch Dopamin. Aber Dopamin mit Ziel. Substanzen bezahlen Stillstand. Das hier bezahlte Bewegung. Ich nahm dreißig Kilo ab. Innerhalb von Monaten ein anderer Mensch. Andere Kleidung, andere Kontakte, anderer Tag. Die Verliebtheit hatte mein Dopaminsystem umgepolzt. Weg von der Substanz, hin zu einer Person.

Jenny verschwand. Die Verwandlung blieb. Weil sie aufhörte, an Jenny, und anfang, an mich gebunden zu sein. Was als Verliebtheit in einen anderen Menschen begonnen hatte, wurde zur Liebe zu mir selbst. Das Dopamin hatte sein Ziel gewechselt. Von einer Person zu etwas, das in mir lag.

In den Jahren, bevor ich anfang zu rauchen, war Liebe immer eine Möglichkeit gewesen. Es gab Situationen, in denen sich etwas entwickelte. Ich war bloß zu schüchtern, sie anzunehmen. In den sieben Jahren als Raucher war nichts mehr da. Kein Interesse. Nicht weil ich aufgehört hatte zu suchen. Sondern weil es nichts mehr gab, worin jemand etwas sehen konnte.

Ich erkenne, was ich bin, am anderen. An Jenny das eigene Strahlen. An Professor Bredekamp die eigene Integrität. In seinen Seminaren lernte ich mehr als im gesamten Studium. Er verkörperte intellektuelle Unbestechlichkeit.

Von 2020 bis Mitte 2023 schrieb ich eine zweitausendseitige Monografie über die ökologischen Bedingungen weltweiter Epidemien. Rohentwurf handschriftlich. Jede Quelle minutiös geprüft. Eine Haltung, die man einmal hat, kann man nicht mehr unwissen. Man kann sie nur betäuben.

Am anderen das Gold erkennen, das in mir lag, und daraus den Antrieb ziehen, es freizulegen. Man nennt das den *goldenen Schatten*.¹⁴ Menschen fürchten ihre eigene Größe mehr als ihr Versagen. Wer entdeckt, dass er ein Wrack ist, kann damit

14 Robert A. Johnson, *Owning Your Own Shadow: Understanding the Dark Side of the Psyche*, San Francisco 1991.

leben. Wer entdeckt, dass er es nicht sein müsste, hat ein Problem.¹⁵ Und genau deshalb erkennen wir es nur noch am anderen.

Was mich an Jenny traf, war nicht ihr Glanz. Es war mein eigener.

Aber nicht jede Verliebtheit macht das.

Zuletzt vor zwei Jahren. Derselbe Rausch. Und als die Verliebtheit weg war, war ich auch wieder weg. Der Unterschied war, dass das Dopamin an ihr hängen blieb. Es fand keinen Weg zu mir. Als sie verschwand, verschwand der Antrieb. Das alte System übernahm. Mit Psychologie hat das gar nichts zu tun. Dopamin-Entzug. Entzug von einer Person. Neurochemisch dasselbe.

Verliebtheit zeigt, was möglich ist. Und setzt voraus, was noch nicht da ist. Verliebtheit setzt einen ganzen Menschen voraus. Kein Bedürfnisbündel auf Bier. Der andere müsste sich in jemanden verlieben, dessen Körper, Haut, Blick signalisieren: beschädigt. Der Zugang zur Liebe ist hinter der Krankheit verriegelt. Und wer es trotzdem versucht, aus dem Suchtmodus heraus, landet nicht bei Verliebtheit, sondern bei ihrem Zerrbild. Toxische Bindung ist biologisch dasselbe wie Trinken. Cortisol hoch, Oxytocin zerschossen, Schlaf kaputt, Immunsystem runter. *Der Körper unterscheidet nicht zwischen einer toxischen Substanz und einer toxischen Bindung.*

Die stärkste Kraft war nicht die Verliebtheit. Es war die Konfrontation mit meinem aufgezeichneten Selbst. Sie hängt von keinem anderen Menschen ab. Und sie liefert den einzigen Beweis, den mein kompromittiertes Gehirn nicht wegerklären kann. Kein Gedächtnis, das es herunterrechnen kann.

Ein Video, das läuft.

15 Nietzsche beschreibt Menschen, die ihr Ideal mit scheuer Demut betrachten und es am liebsten verleugnen würden. Sie fürchten ihr höheres Selbst, weil es, wenn es spricht, fordernd spricht.

Menschliches, Allzumenschliches I (1878), Neuntes Hauptstück, KSA 2.

Und wenn das lang genug wirkt, wenn das Nervensystem sich beruhigt, die Haut wieder klar wird und der Blick wieder da ist, dann wird Verliebtheit wieder möglich. Weil ich wieder jemand bin, in den man sich verlieben kann.

Erst schön, dann geliebt.

Zwei Arten von Angst. Die eine sagt: *was, wenn Gesundheit sich schlimm anfühlt*. Die andere: *was, wenn ich sehe, wie tief ich gesunken bin*. Beide sind biochemisch erzeugt.

Jemand lächelt dich an. Nichts passiert. Der *Nucleus accumbens* braucht stärkere Reize. Freundlichkeit ist keiner. Was die Schwelle noch erreicht, sind Bedrohungssignale. Die Amygdala funktioniert auch dann noch, wenn alles andere schon gedämpft ist. Also scannt das Gehirn Gesichter und findet Ablehnung. Es kann nur noch Ablehnung finden. Die Hardware für das Gegenteil ist offline.

Der Jona-Komplex, die Angst vor Freiheit, die Flucht vor dem eigenen Potenzial. Vergiftungssymptome. Der Mensch, dessen Belohnungssystem durch Nikotin desensibilisiert ist, dessen Amygdala durch Koffein-Cortisol im Dauerbeschuss liegt, dessen präfrontaler Kortex durch Alkohol chronisch gedämpft ist — dieser Mensch hat Angst vor Gesundheit, weil sein Gehirn im Alarmmodus läuft. Jeder unbekannte Zustand wird als Gefahr klassifiziert. Auch Klarheit. Auch Freiheit. Auch volles Funktionieren.

Es ist ein Gehirn, das in einem chemischen Gefängnis sitzt und die Freiheit für eine Klippe hält.

DAS INNERE KIND MUSS STERBEN

*Das innere Kind ist der profitabelste Patient der Welt.
Es wird niemals gesund.*

Das innere Kind ist die erfolgreichste Lüge der Therapie-industrie. Es hat mehr Menschen getötet als jede Droge, die es verdeckt. Mehr Menschen von der Heilung abgehalten als jede Krankheit. Millionen graben in ihrer Vergangenheit, während ihr Körper an der Gegenwart stirbt. Unterlassene Hilfeleistung mit Bestseller-Status. Du sitzt allein im Zimmer und redest mit jemandem, den es nicht gibt. Du nennst das Heilung. Während das, was dich zerstört, neben dir auf dem Nachttisch steht.

Brené Brown sagt, wir müssen aufhören, in den Gesichtern anderer nach Beweisen zu suchen, dass wir nicht ausreichen.¹ Als würde man jemandem mit gebrochenem Bein raten, selbstbewusster zu hinken.

Warum ist die Suche nie ergebnisoffen? Niemand scannt das Gesicht des Gegenübers und denkt: *mal schauen, vielleicht findet sie mich großartig*. Der Scan ist voreingestellt auf Bestätigung des Defizits. Menschen suchen Bestätigung für etwas, das sie bereits glauben — weil ihr vergiftetes Gehirn keinen anderen Modus kennt.

Brown sagt, *hör auf zu suchen, ändere deine Geschichte*. Aber die Geschichte wird nicht von der Person erzählt. Sie wird von der Neurochemie erzählt. Und solange die Neurochemie vergiftet

¹ Brené Brown, *Braving the Wilderness: The Quest for True Belonging and the Courage to Stand Alone*, New York 2017.

ist, kann sich jemand jeden Morgen vor dem Spiegel sagen, dass er ausreicht. Sein Gehirn wird antworten: *nein*.

Die Selbstderniedrigung lässt sich nicht wegaffirmieren. Sie ist biochemisch. Mut zur Verletzlichkeit anlesen bringt nichts, solange Substanzen dafür sorgen, dass Verletzlichkeit sich anfühlt wie Sterben. Und wer statt Brown lieber Stefanie Stahl liest und das Kind in sich sucht, das »Heimat finden«² müsse, landet an der falschen Adresse. Das Schattenkind ist kein verdrängtes Kindheitstrauma. Es ist ein Entzugssymptom mit Aquarellcover. Chronische Unsicherheit. Lähmende Selbstabwertung. Nähe fühlt sich an wie Ersticken. Stahl nennt das ein verletztes inneres Kind. Der Begriff ist genial konstruiert. Nicht überprüfbar, nicht widerlegbar, moralisch immunisiert. Wer widerspricht, hat wohl keinen Zugang zu sich.

Keine einzige randomisierte kontrollierte Studie validiert das innere Kind als therapeutisches Konstrukt.³ Die Idee erfüllt nicht einmal Poppers Falsifizierbarkeitskriterium. Dass die Rückkehr in kindliche Zustände überhaupt möglich ist, ist fragwürdig.⁴ Dass sie heilt, ist unbelegt. Wer sich in sein inneres Kind hineinversetzt, verhält sich nicht wie ein Kind. Er verhält sich wie ein Erwachsener, der sich vorstellt, wie Kinder sind.⁵ Das

2 Stefanie Stahl, *Das Kind in dir muss Heimat finden. Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme*, München 2015.

3 Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, Jeffrey M. Lohr (Hg.), *Science and Pseudoscience in Clinical Psychology*, Second Edition, New York 2015, 7—10 (Pseudowissenschaftsindikatoren).

Zur fehlenden Evidenzbasis regressiver Therapieformen: ebd., 191—209 (Kap. 7: *New Age and Related Novel Unsupported Therapies*).

4 Michael R. Nash, »What, if anything, is regressed about hypnotic age regression? A review of the empirical literature«, in: *Psychological Bulletin*, Vol. 102, Issue 1, 1987, 42—52.

5 Lilienfeld et al. 2015, 225f.

ist Séance mit sich selbst. Du rufst einen Toten an und glaubst, die Stimme, die antwortet, sei nicht deine eigene.

Echte Erinnerungen an Szenen vor dem dritten Lebensjahr sind biologisch unmöglich.⁶ Der Hippocampus, der Erlebnisse ins Langzeitgedächtnis schreibt, ist bei Säuglingen nicht fertig verkabelt. Die Neuronen wachsen noch. Das Gehirn kann laufen lernen, aber keine autobiografischen Filme speichern. Wer nach einer Meditation behauptet, er erinnere sich glasklar an ein Trauma im ersten Lebensjahr, erfindet. Das Gehirn füllt Lücken mit Material, das es später gesammelt hat, und glaubt sich selbst. Es fühlt sich an wie Erinnerung. Es ist Konfabulation.

Forscher versetzten Probanden unter Hypnose zurück auf ihr fünftes Lebensjahr.⁷ Die Personen erinnerten sich lebhaft, mit He-Man-Figuren und Cabbage-Patch-Puppen gespielt zu haben. Sie beschrieben Farben, Texturen, Gefühle. Waren sich absolut sicher. Das Problem: Diese Spielzeuge existierten noch gar nicht, als die Probanden fünf waren. Sie waren nicht auf dem Markt. Das Gehirn hatte Werbung aus späteren Jahren genommen, Fantasie dazugemischt und das Ergebnis als Kindheitserinnerung verkauft. Die Probanden schworen, sich zu erinnern. Mit Tränen in den Augen.

Scott Lilienfeld hat die Kriterien formuliert, an denen solche Konstrukte scheitern.⁸ *Sie lassen sich nicht widerlegen. Sie*

6 Patricia J. Bauer, *Remembering the Times of Our Lives: Memory in Infancy and Beyond*, New York 2007.

Mark L. Howe, Mary L. Courage, »On resolving the enigma of infantile amnesia«, in: *Psychological Bulletin*, Vol. 113, Issue 2, 1993, 305–26.

7 Nicholas P. Spanos, *Multiple identities & false memories: A sociocognitive perspective*, 1996.

8 Ebd., 7–10.

Ders., »Psychological Treatments That Cause Harm«, in: *Perspectives on Psychological Science*, Vol. 2, No. 1, März 2007, 53–70.

suchen nur Bestätigung. Und sie immunisieren sich gegen jeden Einwand. — Das innere Kind erfüllt alle drei. Lilienfelds Arbeit zu potenziell schädlichen Therapien zeigt, warum das tötet: Wer an der falschen Stelle sucht, findet die Ursache nie. Du glaubst, dein Problem sei deine Kindheit. Also suchst du dort. Während die Ursache in deinem Blut schwimmt.

Imagination *erzeugt* Erinnerung. Wer sich oft genug vorstellt, etwas erlebt zu haben, beginnt es zu glauben. Vierzig Prozent der Versuchspersonen entwickelten detaillierte Erinnerungen an ein medizinisches Verfahren, das nie stattfand.⁹ Bloßes Vorstellen genügt.

Stell dir vor, du schneidest eine Zitrone auf. Saftig, eiskalt, extrem sauer. Du beißt mit voller Kraft ins Fruchtfleisch. — Der Mund zieht sich zusammen. Der Speichel läuft. Dein Körper reagiert auf eine Fantasie, als wäre sie real. Jetzt stell dir vor, du wärst drei Jahre alt und jemand tut dir etwas Schreckliches an. Dein Herz rast. Deine Hände zittern.

Siehst du, dein Körper erinnert sich.

Dein Körper erinnert sich an gar nichts. Dein Körper reagiert auf das, was du dir gerade vorstellst. Tränen beweisen, dass deine Vorstellungskraft funktioniert. Nicht, dass das Ereignis stattgefunden hat.

Das Phänomen heißt Vorstellung-Inflation, und Stahls gesamte Methode basiert darauf: *Visualisiere dein Schattenkind. Kontaktiere es. Spüre, was es fühlt.* Die Forschung sagt: *Wer das tut, findet nicht seine Wunde. Er erfindet sie.*

Die Symptom-Checklisten in solchen Büchern funktionieren nach demselben Prinzip.

9 Giuliana Mazzoni, Amina Memon, »Imagination Can Create False Autobiographical Memories«, in: *Psychological Science*, Vol. 14, Issue 2, März 2003, 186—8.

Erkennst du dich wieder? Hast du Bindungsangst? Fühlst du dich manchmal unsicher?

Ja. Wie jeder Mensch auf diesem Planeten.

Vage Aussagen, die auf fast jeden zutreffen, fühlen sich persönlich an. Das nennt man Barnum-Effekt. Die scheinbare Treffsicherheit ist statistisch, nicht diagnostisch. Die Checkliste unterscheidet nicht zwischen Traumatisierten und Nicht-Traumatisierten.¹⁰ Sie unterscheidet zwischen Lesern und Nicht-Lesern.

Du hast das Buch vielleicht gelesen. Vielleicht liegt es neben deinem Bett. Vielleicht hast du dein Schattenkind gefunden, ihm einen Brief geschrieben, es in den Arm genommen. Und morgen früh trinkst du wieder Kaffee, weil du ohne nicht funktionierst. Das innere Kind ist dein Alibi. Solange du es pflegst, stirbst du weiter. Das Gift kaufst du jeden Morgen an der Kasse. Das Alibi hast du längst im Regal.

Drei Millionen verkaufte Bücher. Null Evidenz. Schnelle Lösung, pseudowissenschaftlicher Anstrich, leichtgläubiges Publikum. Das nennt man Religion. Und nicht einmal, weil jemand das Konzept widerlegt hätte. Sondern weil es schlicht nie etwas gab, das man hätte widerlegen können.

Die Beweislast liegt beim Erfinder, nicht beim Kritiker. Grundprinzip der Wissenschaft. Wer behauptet, mit Altersregression zu heilen, muss das mit kontrollierten Studien belegen. Dieser Nachweis fehlt. Sie drehen die Logik einfach um: *Beweist mir doch, dass es nicht funktioniert.* Homöopathie argumentiert so. Astrologie argumentiert so. Und so argumentiert jeder, der etwas verkaufen will.

Keine Evidenz. Keine Heilung.

10 Lilienfeld et al. 2015, 228f.

Bei jemandem, der seit fünfzehn Jahren morgens Koffein, mittags Zucker und abends Alkohol durch sein Nervensystem pumpt, ist jedes Symptom ein Laborwert. Dein inneres Kind ist ein Junkie. Dein inneres Kind will dich umbringen.

Aber ein Gehirn reparieren verkauft sich nicht. Ein Seelenkind trösten schon. Der Markt ist voll mit Trost. Fünfunddreißig Sprachen, Millionenaufgabe. Jedes dieser Bücher lieferte einem Menschen eine psychologische Erklärung für ein biochemisches Problem und schickte ihn in seine Vergangenheit, während die Ursache auf seinem Küchentisch stand. Millionen, die ihr Schattenkind therapieren, statt ihren Konsum zu beenden. Das Trauma ist bequemer als die Wahrheit. Und Therapeuten verdienen an beidem.

Wer einem Vergifteten erklärt, sein Problem sei seine Kindheit, hält ihm das Glas. Aber die Geschichte fühlt sich besser an als die Wahrheit. Also nimmt der Vergiftete sie dankbar an, gibt fünf Sterne und trinkt weiter. Der Rezensent stirbt. Die Rezension bleibt. Ein Arzt, der das täte, würde seine Approbation verlieren. Stahl bekommt Podcast-Auftritte. Die Buchhandlung ist ein Tatort.

Candace Newmaker war zehn Jahre alt.¹¹ Ihre Therapeuten führten eine sogenannte Rebirthing-Therapie durch. Ein Trauma bei der Adoption körperlich neu durchleben, um es zu heilen. Sie wickelten das Mädchen in eine Flanelldecke, vierzig Pfund schwer. Vier Erwachsene legten sich auf sie, um den Geburtskanal zu simulieren. Sie sollte sich herauskämpfen. Wiedergeburt. Candace schrie, sie bekomme keine Luft. Sie sagte, sie sterbe. Die Therapeuten deuteten ihr Flehen als therapeutischen Widerstand. Als altes Trauma. Sie blieben liegen. Siebzig Minuten. Als sie die Decke öffneten, war Candace tot. Erbrochen,

11 Ethan Watters, Richard Ofshe, *Making Monsters: False Memories, Psychotherapy, and Sexual Hysteria*, Berkeley 1994.

erstickt, das Gesicht blau. Die Methode, die sie heilen sollte, hat sie getötet. Die Therapeuten wurden verurteilt. Die Ideologie lebt weiter — mit Aquarellcover.

Brown und Stahl machen denselben Fehler: *psychologische Lösungen für biochemische Probleme anbieten*. Das ist, als würde man einem Menschen, der in einem brennenden Haus sitzt, empfehlen, seine Beziehung zu seinem Vater aufzuarbeiten. Oder jemandem, der an einer Gasvergiftung stirbt, raten, er solle mal in sich hineinhorchen, woher das Druckgefühl auf der Brust kommt.

Wenn ich süchtig eine Entscheidung treffen muss — ich werde mich falsch entscheiden. Erst der Entzug. Dann alles andere. Das innere Kind muss nicht Heimat finden. Es muss sterben, damit du leben kannst.

DIE LÜGE AUF DER ZUNGE

*Die effizienteste Euthanasie ist die,
die das Opfer selbst bezahlt.*

Freiheit endet dort, wo Dopamin anfängt. Das steht in keinem Grundgesetz. Es steht in deinem Hirnstamm. Die Verfassung garantiert dir Würde, aber dein Belohnungssystem wurde privatisiert, bevor du lesen konntest. Die Käufer sitzen in Vorständen und sponsern Parteitage. Ihre Komplizen in Parlamenten nennen Körperverletzung an Minderjährigen Eigenverantwortung. Und du sitzt vor dem Bildschirm und hältst dich für mündig, während dein Gehirn Befehle ausführt, die du nicht erteilt hast. Das perfekte Verbrechen braucht eine Zutat, die süchtig macht, ein Etikett, das »Lebensmittel« sagt, und einen Staat, der wegschaut, weil er mitverdient. Er verkauft dir die Krankheit und die Behandlung.

Es brauchte nur Koffein, Alkohol und eine Lüge namens Selbstbestimmung.

Es gibt Menschen mit einer angeborenen Störung der Nebennierenrinde. Ihr Körper kann Salz nicht halten, also verlangt er danach.¹ Salzwasser schmeckt ihnen. Pures Salz schmeckt ihnen. Dahinter steckt ein echter Mangel.

Kaffee, Bier, Zigaretten lösen keinen Mangel. Aber es fühlt sich so an. Als ich als Kind das erste Mal Kaffee probierte, war es

1 Adrenogenitales Syndrom (AGS).

Lawson Wilkins, Curt P. Richter, »A great craving for salt by a child with cortico-adrenal insufficiency«, in: *JAMA*, Vol. 114, No. 10, März 1940, 866—8.

ekelhaft. Meine Eltern tranken die schwarze Plörre in der Küche. Ich nippte aus Neugier. Ich konnte mir nicht vorstellen, das Zeug jemals zu trinken. Später mochte ich Kaffee.

Mit Bier dasselbe. Das erste war widerlich. Ich nippte, weil mein Vater für Gäste zapfte. *Warum trinken die das alle?* Später trank ich selbst. Jede Sorte und Marke.

Auf dem Schulhof die erste Zigarette. Ich dachte, ich erstickte. Ich fühlte mich elend. Später war elend normal — log mein Gehirn.

Der Körper braucht nichts davon. Die Substanzen erzeugen ein Defizit und lösen es selbst. Aber sie verändern, was ich auf der Zunge spüre. Ich empfinde die Dummacher als Genuss. Drin steckt Gehorsam.

Der Körper lernt, Gifte zu wollen. Nicht nur das Gehirn. Zunge und Gaumen selbst werden umprogrammiert. Nach zwei Wochen ohne Bier schmeckte das erste zwar nicht widerlich wie beim ersten Mal, aber langweilig. Das zweite auch. Dann kam der Geschmack zurück. Der verlogene. Nach fünf Tagen schmeckte es wie vorher. Ich bekam nicht genug.

Bei echtem Mangel schmeckt dem Körper roher Brokkoli, Grünkohl, Löwenzahn. Drogen erfinden den Mangel. Und das Gehirn spielt mit. Erzählt sich etwas von »neuroprotektiv« für die Kaffeesucht. »Kultur« für die Alkoholsucht. »Genuss« für alles, was dich umbringt.

Gift schmeckt anfänglich scheußlich, weil der Körper sich schützen will. Bitterkeit, Schärfe, Rauch, Ethanolbrennen sind Warnsignale. Bitter bedeutet Alkaloide, potenziell tödlich. Rauch bedeutet Feuer, Erstickung. Ethanol ist Zellgift. Mein kindliches Gehirn reagierte korrekt.

Dann wurde es erzogen.

Von Eltern, die selbst süchtig waren und es Frühstück nannten.

Geschmack ist kein statischer Input. Er folgt dem, was der Körper braucht. Oder dem, was ihm vorgegaukelt wird. Bitter, sauer, süß werden im Gehirn nicht erkannt, sondern bewertet. Wenn bitter oft genug mit Dopamin kommt, wird bitter weniger bitter.² Ich presse mir heute siebzig Zitronen die Woche. Sie schmecken süß wie Limonade.

Sensorische Konditionierung.

Normalerweise kommt zuerst der Nährwert, dann die Sättigung, dann das Dopamin. Drogen überspringen alles. Dopamin ohne Nährwert. Belohnung ohne Grund. Das Gehirn optimiert auf Wiederholung, nicht auf Überleben.

Der orbitofrontale Kortex rechnet Geschmack, Kontext und Erwartung zusammen.³ Was lecker, egal oder abstoßend ist, entscheidet sich hier. Konsumiere ich den Abfall regelmäßig, verschiebt sich die Rechnung. Kaffee wird »Fokus«. Bier wird »Entspannung«. Rauch wird »Ruhe«. Das Gehirn schmeckt, was nicht da ist.

Psychotischer Bruch mit der Realität.

Aber legal. Und steuerpflichtig.

Dann die Interozeption. Der Sinn dafür, wie es dir geht. Das Konzept, das niemand lehrt. Weil zu viele daran verdienen, dass du es nicht kennst. Pharma verdient an der Behandlung. Die Lebensmittelindustrie an der Ursache. Dazwischen liegst du. Drogen verändern diesen Körpersinn. Bier dämpft die Stressachse

2 Dana M. Small, Robert J. Zatorre, Alain Dagher, et al., »Changes in brain activity related to eating chocolate: From pleasure to aversion«, in: *Brain*, Vol. 124, Issue 9, 01.09.2001, 1720–33.

Martin R. Yeomans, Natalie J. Gould, Sirous Mobini, John Prescott, »Acquired flavor acceptance and intake facilitated by monosodium glutamate in humans«, in: *Physiology & Behavior*, Vol. 93, Issue 4–5, 18.03.2008, 958–66.

3 Morten L. Kringelbach, »The human orbitofrontal cortex: linking reward to hedonic experience«, in: *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 6, Issue 9, September 2005, 691–702.

und entspannt die Muskeln.⁴ Mein Gehirn lernt, dass dieser Geschmack — so widerlich er auch ist — zu diesem Körpergefühl gehört. Ich schmecke nie zuerst das Bier. Ich schmecke den Übergang von Spannung zu weniger Spannung.

Nach ein bis zwei Wochen ohne fällt die Erwartung weg. Die Chemie normalisiert sich. Die Lüge wird wacklig. Wiederholter Konsum rekonditioniert den Geschmack.

Hinrichtung wird fortgesetzt.

Bleibt die Substanz aus, wird Leben farblos. Und Farblosigkeit ist schwerer zu ertragen als Schmerz.

Psychologie ist Oberfläche, nicht Vorgang. Darunter liegen synaptische Gewichtungen, Neuroplastizität, Umbau auf Zellebene. Hundert Euro die Stunde, um dir beim Ertrinken zuzusehen. Mit Empathie.

Der Körper ist ein Schlachthaus, das sich für ein Spa hält. Deshalb fühlt sich Sucht nicht wie Zwang an. Sie sagt: *Das ist gut. Das Bier schmeckt. Der Kaffee hilft.* Bis es plötzlich nicht mehr schmeckt. Und ich mich frage, wie ich das jemals mochte. Solange ich trank, war Leben ohne undenkbar. Monate nach dem Aufhören konnte ich nicht mehr begreifen, wie ich so gelebt hatte. Es ist, wie auf eine Leiche zu schauen, die meine Kleider trägt. Beide Zustände können einander nicht fühlen. Wie Lebende und Tote. Nur dass beide glauben, sie seien die Lebenden.

Rauchen genauso.

Wenn ich regelmäßig trinke, rauche, Koffein konsumiere, bin ich unfähig, einen Zustand ohne Lüge auch nur zu fühlen. Ich kann Romane schreiben, Welten erschaffen. Aber mir vorstellen, ohne Kaffee am Morgen oder Bier am Abend zu leben — dazu bin ich dann unfähig. Alles jenseits des Konsums wird

4 George F. Koob, Nora D. Volkow, »Neurobiology of addiction: a neuro-circuitry analysis«, in: *The Lancet Psychiatry*, Vol. 3, Issue 8, August 2016, 760–73.

Hölle. Länger kein Bier fühlt sich an wie ersticken. Wenn ich dann mein Bier bekomme, fühlt sich das an wie atmen.

Atmen ist gut. Mehr davon. Ich will Luft.

Das sagt die Sucht. In meiner Stimme.

Die Zigarette fühlt sich an wie Befreiung. Die Zigarette, die physiologisch Ersticken ist. Jede ein kleiner Suizid mit Pausentaste. Ich kann mir vorstellen, eine Fledermaus zu sein. Ich kann mir vorstellen, wie es wäre, einen anderen Körper zu haben, in einer anderen Welt zu leben. Aber ein Leben ohne Bier als jemand, der Bier trinkt: unmöglich. Fledermäuse bedrohen meinen Körperzustand nicht. Ein Leben ohne Bier, Kaffee, Nikotin würde Selbstaflösung bedeuten. Das Gehirn blockt das ab wie einen Herzinfarkt. Panik. Notabschaltung. Nur dass niemand den Notarzt ruft.

Die Substanz löscht die Fähigkeit zur Empathie mit dem anderen Zustand. Die Vorstellungskraft selbst, neurochemisch blockiert.

Kannst du mir folgen?

Es ist keine Schwäche, sondern ein gezielter Ausfall einer ganzen geistigen Funktion, ausgelöst durch regelmäßigen Konsum. Mein Gehirn tut, was man sonst nur aus Pathologien kennt. *Zustandsblindheit*. Und die geht tiefer als Dopaminrezeptoren. Tiefer als Tumore. (Die wachsen wenigstens langsam.)

Das Gehirn eines Süchtigen funktioniert einwandfrei. Es arbeitet nur nicht mehr für dich. Das heißt *zustandsabhängige Kognition*.⁵ Das Gehirn speichert Gedanken nicht neutral. Müde

5 Donald W. Goodwin, Barbara Powell, David Bremer, et al., »Alcohol and Recall: State-Dependent Effects in Man«, in: *Science*, Vol. 163, Issue 3873, 21.03.1969, 1358—60.

Ruth Weissenborn, Theodora Duka, »State-dependent effects of alcohol on explicit memory: the role of semantic associations«, in: *Psychopharmacology*, Vol. 149, Issue 1, März 2000, 98—106.

Gedanken, verliebte Gedanken, wütende Gedanken — jeder Zustand ein eigener Abgrund. Bei Drogen wird daraus ein Krebsgeschwür. Das Gehirn sagt dann nicht: *Ich verändere mich*. Sondern: *Das bin ich*. Diebstahl von innen.

Die Umkehr nach dem Aufhören entlarvt den freien Willen. Nach Abstinenz normalisiert sich die Chemie. Die alten Zustände verlieren ihre Markierung. Die Wissenschaft nennt das *asymmetrische Zustandsinkompatibilität*. Deshalb ist jede Diskussion über Sucht sinnlos. Man redet über Identität. Präzise, reproduzierbar, vorhersagbar. Und trotzdem glauben Menschen, sie hätten da gerade eine Meinung.

Mit Kaffee fühle ich mich schlechter, bin weniger leistungsfähig. Ich trinke ihn trotzdem. Kaputte Interozeption. Wie die Viszeroseption bei Adipösen.⁶ Die Propriozeption bei Kiffern. Interozeption ist das erste Opfer jeder Sucht.⁷ Erst wenn ich verstehe, dass mein Gehirn sich das Leben ohne nicht vorstellen kann, solange es süchtig ist, kann ich es trotzdem versuchen. Solange ich den Mechanismus nicht sehe, ist er ein blinder Fleck. Und was ich nicht sehe, kontrolliert mich.

Wir versuchen seit Jahrzehnten, Sucht zu verhindern, ohne das Sinnesorgan zu benennen, das durch Sucht zerstört wird. Die Forschung weiß das. Die Öffentlichkeit nicht. Der Begriff fehlt. Was keinen Begriff hat, kann nicht gedacht werden. Was nicht gedacht werden kann, kann nicht verhandelt werden. Was

6 Beate M. Herbert, Olga Pollatos, »Attenuated interoceptive sensitivity in overweight and obese individuals«, in: *Eating Behaviors*, Vol. 15, Issue 3, August 2014, 445—8.

7 Martin P. Paulus, Jennifer L. Stewart, »Interoception and Drug Addiction«, in: *Neuropharmacology*, Vol. 76 (Pt. B), Januar 2014, 342—50.

Antonio Verdejo-García, Luke Clark, Barnaby D. Dunn, »The role of interoception in addiction: A critical review«, in: *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, Vol. 36, Issue 8, September 2012, 1857—69.

nicht verhandelt werden kann, wird moralisiert oder ignoriert. Die öffentliche Erzählung lautet Genuss, Entspannung, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung. Alles Begriffe oberhalb der Körperebene.

Sucht passiert darunter.

Wenn ich sage, mein Urteil ist manipuliert, ist das keine Metapher. Es ist ein defekter Sensor, der falsche Daten liefert. Und wir reden darüber, als wäre es Meinung.

Der Unterschied zwischen Sucht und Meinung ist eine Blutanalyse.

Was wir Aufklärung nennen, ist Abschreckung, Moral, Statistik, Panikbilder. Die verlässlichsten Mittel, Menschen in der Sucht zu halten. Man hat uns allein gelassen. Niemand erklärte, warum das eigene Empfinden nicht mehr vertrauenswürdig ist. Man sagte: *Du willst es nur*. Statt: *Dein Wahrnehmungsapparat ist defekt*. Als würde man einem Farbenblinden sagen: *Dann streng dich halt an, Rot zu sehen*.

Das ist Suchtprävention. Dafür gibt es Fördermittel.

Niemand lacht.

Entzugserscheinungen sind läppisch verglichen mit dem, was folgt. Das wahre Problem ist die Phase danach. Die Interozeption ist noch falsch, aber der Entzug vorbei, und der Kopf sagt: *Siehst du, war doch Quatsch!*

Ich fühle mich leer, flach, richtungslos. Unkalibriert. Ich hätte es durchgestanden, wenn mir jemand gesagt hätte: *Das ist der kritische Punkt, das ist normal, das ist der letzte Trick*.

Menschen konsumieren weiter, obwohl es ihnen ohne besser ginge. Weil ihr innerer Kompass spinnt. Falsches Verhalten fühlt sich richtig an. Und wir leben in einer Kultur, die sagt: *Hör auf dein Gefühl. Fühle dein inneres Kind*. Während dein inneres Kind längst Stammkunde ist. Und alles normalisiert wird, was dieses Gefühl verzerrt.

Trink deinen Kaffee. Du hast es dir verdient.

Cannabis, Alkohol, Kaffee sind Varianten desselben Problems. Cannabis zerlegt das Zeitgefühl.⁸ Alkohol dämpft das Selbstfeedback. Koffein erzeugt künstliche Dringlichkeit.⁹ Drei Wege, einen Zustand zu erzeugen, der sich wie *ich selbst* anfühlt, und alles andere zur Abweichung zu erklären. Und dann fragen wir uns, warum Menschen nicht zuhören.

Der entscheidende Satz, den niemand ausspricht, gehört in jedes Klassenzimmer:

Dass man sich ein Leben ohne etwas nicht vorstellen kann, ist kein Argument gegen den Verzicht, sondern das Symptom.

Stattdessen steht da ein Lehrer, der drei Tassen braucht, um wach zu sein. Er erklärt Kindern etwas über Verantwortung.

Wir romantisieren Empfindung und tarnen Selbstschädigung als Lifestyle. Es ist bequemer zu sagen: *Jeder muss selbst wissen, was ihm gut tut.* Als zu sagen: *Dein Gut-tun-Sensor ist manipuliert.* Letzteres hätte Konsequenzen.

Also schweigt man. Deine Eltern haben dir Zucker gegeben, damit du ruhig bist. Deine Freunde laden dich auf Bier ein, damit sie nicht alleine trinken. Dein Partner raucht mit dir, weil geteilte Sucht wie Intimität aussieht. Alle schweigen.

Der Süchtige glaubt, seine Gedanken und Gefühle seien er selbst. Dieser Glaube ist das Kernproblem. Du trägst deinen Mörder spazieren und nennst ihn Persönlichkeit. Ihn verhungern zu lassen ist der einzige Weg raus.

8 Zerrin Atakan, Sagnik Bhattacharyya, Paul Allen, et al., »Cannabis affects people differently: inter-subject variation in the psychotogenic effects of $\Delta 9$ -tetrahydrocannabinol: a functional magnetic resonance imaging study with healthy volunteers«, in: *Psychological Medicine*, Vol. 43, Issue 6, Juni 2013, 1255—67.

9 Merideth A. Addicott, Paul J. Laurienti, »A comparison of the effects of caffeine following abstinence and normal caffeine use«, in: *Psychopharmacology*, Vol. 207, Issue 3, 24.09.2009, 423—31.

Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber ich weiß, warum. Also probiere ich es trotzdem.

Ohne diesen Satz bleibt alles Gerede wertlos.

Mein Mitbewohner war bescheuert genug, Nikotin-Kaugummis zu kauen und zu glauben, er hätte mit dem Rauchen aufgehört. Wenn man sich das Heroin anders verabreicht, hat man das Problem auch nicht gelöst. — Bemerkenswert, das überhaupt erklären zu müssen.

Der Übergang begann, als ich meine Gefühle nicht mehr ernst nahm. Mein Verlangen, meine »vernünftigen« Argumente, jetzt unbedingt trinken zu müssen, weil ich sonst angeblich »nicht funktioniere« — ich ignorierte sie eiskalt. Mein Gefühl, das sich anfühlte wie ich selbst, gab mir alle Argumente, die ich brauchte, um weiterzumachen. *Noch eine Zigarette, noch ein Bier. Ich muss jetzt noch das machen und das ist existenziell wichtig und dafür brauche ich die Zigarette, dafür brauche ich das Bier, sonst klappt das alles nicht. Ich kann das jetzt nicht. Ich mache es dann demnächst.*

Bla, bla, bla. Jeder Süchtige kennt diesen inneren Monolog. Er klingt wie man selbst. Er denkt wie man selbst. Er ist es nicht.

Ich habe alle emotionalen und intellektuellen Argumente ins Leere laufen lassen. Nicht reagiert. Nicht gehandelt. Es gibt nicht nur den Gedanken. Auch den Blick auf den Gedanken. Und dann den Blick auf den Blick. Von dort aus handelte ich. Als der, der zusah, wie etwas anderes meinen Körper bewohnt.

Und das kann auch jeder andere, der sich jetzt gerade dabei wahrnehmen kann, wie er diesen Text liest.

Meine Gefühle und meine Vernunft haben mich verkauft, bevor ich aufwachte. Was ich als Süchtiger für mich selbst halte, ist eine Maske, auf die ich spucken muss. Mit Gewalt hat das nichts zu tun. Es ist die Schifffahrt zum eigenen Ufer.

Drei Dogmen tragen unsere Kultur:

Mein Gefühl ist ein valider Zugang zu mir.

Meine Vernunft ist zumindest im Prinzip korrigierbar.

Authentizität ist moralisch gut.

Sucht zerlegt alle drei.

Im Zustand der Sucht sind Gefühl und Vernunft funktional unwahr. Sie führen systematisch zu falschen Handlungen. Das ist kulturell toxisch. Weil es stimmt. Weil jeder es spürt. Weil niemand es aussprechen darf, ohne seinen Platz am Tisch zu verlieren.

Kaugummis und Pflaster lassen das Kernproblem unberührt, die Identitätskopplung an den Stoff. Wenn Nikotin das Medium ist, in dem das Selbstgefühl organisiert ist, dann ist Nikotin ohne Rauch nur ein anderes Kabel. Als würde man sagen: *Ich bin nicht mehr abhängig von der Brille. Ich trage jetzt Kontaktlinsen.*

Schön.

Ändert nichts am Sehen.

Ich bin immer noch kurzsichtig.

Willenskraft ist ein Märchen für Ratgeberregale. Ich habe meinem Innenleben die Entscheidungsbefugnis entzogen. Der entscheidende Schritt ist der Entzug von Autorität. *Du darfst reden, aber du darfst nichts entscheiden.*

Das ist Odysseus und die Sirenen. Er war nicht stärker als die Verführung. Er war klüger als sein zukünftiges Ich. Er baute eine Struktur, die seinen Willen überflüssig machte. Menschen bleiben trotz Neurochemie unheilbar frei. Das ist unser Fluch und gleichzeitig der Ausweg aus der Hölle. Die Reiz-Reaktions-Marionette in uns ist real — wenn wird das wollen. Aber sie bestimmt nicht, wer wir werden. Gäbe es da nicht auch den Proteus und Prometheus in uns, säßen wir immer noch in der Höhle und hätten nie ein Pantheon gebaut.

Die Meta-Meta-Ebene, die niemand lehrt, ist kein esoterisches Gedöns. Es ist eine Verschiebung dessen, wer ich bin. Ich habe keinen Gegengedanken formuliert, kein besseres Gefühl gesucht, kein positives Mindset. Ich habe nicht übersetzt, nicht

gehandelt, nicht gehorcht. Das ist der Unterschied zwischen innerem Dialog und innerer Entmachtung. Und genau das wird nicht gelehrt. Weil es den Markt stört. Weil man dann erklären müsste, dass Authentizität kein Wert an sich ist. Dass Gefühle epistemisch unzuverlässig sein können. Dass Selbstverleugnung kein Verrat, sondern Rettung sein kann. Es ist bequemer zu sagen: *Du musst dich selbst lieben.* Als zu sagen: *Dein momentanes Selbst ist ein Parasit.*

Letzteres lässt sich nicht mit Goldkonfetti als Jubiläumsausgabe herausgeben. Es verlangt etwas, das Schule, Werbung und Therapiemarkt systematisch abgezüchtet haben: *einen Zeitraum, in dem man sich selbst nicht traut. Nicht hasst. Nicht bekämpft. Nicht ernst nimmt.* Und genau das ist kulturell unerträglich.

Im Zustand der Sucht bist du nicht du. Und wenn du wartest, bis du dich wieder wie du fühlst, kommst du nie raus. Du kommst raus, bevor du es fühlen kannst.

Wenn du aufhörst, dir zu glauben.

BODY POSITIVITY TÖTET

Ich esse, um zu verschwinden.

Die ästhetische Akzeptanz von Übergewicht macht mich krank. Sie insinuiert, dass Übergewicht ein Charakterzug sei. Obwohl es ein chronisch entzündlicher Zustand ist. Viszerales Fett ist ein endokrines Organ, das permanent Entzündungsbotschaften produziert. Das Nervensystem reagiert darauf mit Angst, Verlust von Klarheit, geringerer Impulskontrolle und Resilienz.

Eine Kultur, die Übergewicht ästhetisch normalisiert, verhindert medizinisch notwendige Veränderung. Sie praktiziert kein Mitgefühl, sondern Konfliktvermeidung. Dies hilft Übergewichtigen nicht, es beutet sie aus. *Body Positivity* ist keine Befreiung. Sie ist die Verletzung der Würde übergewichtiger Menschen, Hilfe zu bekommen. Ihr richtiger Name wäre Körper selbstverachtung oder *Body Denial*.

Body Positivity sagt: *Du bist gut, wie du bist. Tu, was du willst.*

Der Körper sagt: *Ich bin entzündet, ich bin überlastet, ich halte das nicht aus. Bitte tu das nicht.*

Das ist Entmündigung.

Die Industrie verdient mit Ersterem mehr Geld, weil das Menschen dazu bringt, ihr als Akzeptanz verkleidetes Dauerleiden weiter zu betäuben, statt das Kernproblem anzugehen. Krankheit wird zur Identität umetikettiert. Entzündung zur Konstitution, Atemlosigkeit zu Stress, Adipositas zu Körperdiversität. Sprache als Sedativum.

Die Wahrheit: Gesundheit ist schön. Ein Körper, der nicht permanent gegen sich selbst arbeitet, ist schön. Ein schlanker Körper ist keine Geschmacksfrage, sondern ein Funktionszustand. Man kann Krankheit akzeptieren oder man kann sie beenden. Beides gleichzeitig geht nicht.

Übergewicht ästhetisch entzaubern erlaubt Veränderung.

Die Körperselbstverleugnung im Westen ist älter als jede Mode. Sie sitzt in den Knochen. Das Fleisch drumherum hat sie nie interessiert.

Die Reformation erschuf das moderne Subjekt¹: allein vor Gott, allein mit seinem Gewissen, allein in seinem Kämmerlein. *Sola Fide* — allein der Glaube. Nicht Leib, nicht Welt, nicht Erfahrung. Was nicht Glaube war, wurde verdächtig. Der Körper wurde zur Prüfung, die Lust zur Anfechtung, die Sinne zum Störsignal. Luther befreite das Gewissen und sperrte den Leib ein. Der Körper war fortan Trägermaterial.

Descartes machte daraus ein System. *Res cogitans, res extensa* — Geist hier, Materie dort. Der Körper wurde zur Maschine, die der Geist bewohnt wie ein Untermieter meine Wohnung. Kaum ein Philosoph hat mehr Schaden angerichtet mit weniger Wörtern.

Kant vollendete die Amputation. Moral ist Vernunft, nicht Empfindung. Wer den Körper braucht, um gut zu handeln, handelt nicht gut genug. Der Mensch, den Kant entwarf, denkt, urteilt, folgt dem *kategorischen Imperativ*. Er schwitzt nicht dabei.

Drei Männer. Drei Jahrhunderte. Eine Leiche: der Körper als Teil des Selbst.²

1 Max Weber, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, Tübingen 1920[1905].

2 Zur Entkörperlichung der Moderne: Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*, Cambridge 1989.

Die Spaltung wurde nie repariert. Sie wurde säkularisiert, psychologisiert, umetikettiert. Das Ergebnis: eine Gesellschaft, die den Körper nicht mehr spürt, aber permanent über ihn verhandelt. Body Positivity vollendet dieses Projekt. Dieselbe Zelle, fünfhundert Jahre später. Der Calvinist verachtete den Leib, weil er der Seele im Weg stand. Wir ignorieren ihn, weil er dem Selbstbild im Weg steht. Der Calvinist wusste wenigstens, dass er einen Körper hat. Derselbe Mechanismus wie Zigarette, Alkohol, Binge Eating. Ein Zustand, der weh tut, umgedeutet in einen, der zu mir gehört.

Übergewicht schreit. Diese Kultur hat den Schrei zum Schlaflied erklärt. Body Positivity bringt Konfetti.

Meine Texte brechen Tabus. Wenn ich über Körper schreibe, reagieren die Leute »getriggert«. Wer seinen Narzissmus infrage gestellt sieht, erklärt sich für »traumatisiert«. Also werde ich dämonisiert. Beim Körper passiert das schnell. Er ist sichtbar, physikalisch, indiskutabel. Und was indiskutabel ist, heißt für viele automatisch: diskriminierend.

Fast lehrbuchhaft zeigte dies eine Diskussion auf Substack. Ich schrieb, dass ein dünner Körper schön sei. In Deutschland sind über sechzig Prozent der Männer übergewichtig, knapp die Hälfte der Frauen.³ Übergewicht ist der Mehrheitszustand. Aber häufig ist nicht normal. Häufig ist nur häufig.

Eine Kultur, in der die Mehrheit krank ist, hält Krankheit für normal und Gesundheit für extrem. Normalgewicht gilt als anorektisch. Was medizinisch gesund ist, wird als

3 Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), *Übergewicht und Adipositas in Deutschland — Lebensbedingungen müssen gesünder werden*, Presseinformation, 2025.

Deutsches Ärzteblatt, *Zwei Drittel der Männer in Deutschland sind übergewichtig*, 30.10.2018.

krank wahrgenommen. Also konterkarierte ich die verbreitete Wahrnehmungstörung.

Ich schrieb auch, dass die Abwesenheit von Gift schön ist. Ein Körper, der nicht permanent gegen sich selbst kämpft, ist schön. Übergewicht ist ein proinflammatorischer Zustand — eine chronische Entzündung. Entzündung hat wenig mit Identität zu tun, eher mit Krankheit.

Dann erhielt ich folgenden Kommentar:

»Ich hab auch Übergewicht trotz Bewegung, das liegt an der Menopause und den Nebenwirkungen der Neuroleptika. Veränderter Stoffwechsel und Hormone geben den Ausschlag, weshalb viele Frauen ab fünfzig wie Hefeteig aufgehen. Ich war zwar früher schlank, aber dürre Hungerhaken mit flachen, knöchigen Hintern fand ich immer unattraktiv und unsexy.«

Bemerkenswert war, wie sie versuchte, meine Rede zu disqualifizieren, indem sie dünne Menschen zur Fratze machte, sie überzeichnete, vorführte. Gleichzeitig verteidigte sie ihr Übergewicht durch Determinismus (Hormone, Menopause, Medikamente, Stoffwechsel). Als Abschluss der Debatte. Ein metaphysischer Riegel. *So bin ich, Punkt.*

Ich antwortete: *»Ich schreibe nicht über ästhetische Präferenzen, sondern über Entzündung und metabolischen Stress. Neuroleptika und Menopause sind real. Mein Text richtet sich gegen eine Kultur, die Krankheit verteidigt, nicht gegen Menschen, die kämpfen.«*

Ihre Antwort: *»Wenn du schreibst, ein dünner Körper ist schön, verstehe ich es anders. Sorry.«*

Das war kein Missverständnis, sondern die Weigerung, die Ebene zu wechseln. Sie sagte damit: *Ich bleibe bei meiner Lesart, weil ich sonst etwas an mir infrage stellen müsste.*

Ich liefere eine Beschreibung. Sie liefert eine Rechtfertigung. In der Philosophie heißt das *Kategorienfehler*.

Ich sage: *Übergewicht ist ein entzündlicher Zustand.*

Sie hört: *Ich werde moralisch bewertet.*

Der Grund: weil Pathologie bei ihr zur Identität geronnen ist. Und Identität ist sakrosankt.

Der eigentliche Trigger ist nicht der Satz *Diinn ist schön*. Sondern die Implikation: *Es könnte anders sein*. Wenn etwas krank ist, ist es veränderbar. Wenn es veränderbar ist, gibt es Handlungsspielraum. Handlungsspielraum bedeutet Verantwortung. Und Verantwortung ist in Deutschland das größte Tabu.

Der Satz »*Dürre Hungerhaken mit flachen, knochigen Hintern*« macht drei Dinge gleichzeitig: Er karikiert meine Aussage, um sie lächerlich zu machen. Er ersetzt Gesundheit durch sexuelle Attraktivität, um das Thema zu moralisieren. Er wirft mir Körperverachtung vor, während er selbst abwertend spricht. Reaktive Abwehr. Mehr Reflex als böse Absicht.

Über Körper zu schreiben ist gefährlich geworden, denn der Körper ist sichtbar, entzieht sich Narrativen, zeigt Erschöpfung, Atemnot, Trägheit, Leistungsabfall. Das sind Rückmeldungen, die sich bloßem Dafürhalten entziehen.

Wer sein Selbstbild über Narrative stabilisiert, hat im Körper einen Feind. Deshalb muss er die Sprache angreifen, den Sprecher moralisieren, die Aussage pathologisieren.

Ich habe eine kulturelle Beschreibung geliefert, und sie wurde als Angriff gelesen.

Das ist der Preis von Klarheit.

Wer verstehen will, versteht. Wer sich verteidigen will, missversteht. Meine Provokation ist funktional, weil sie Abwehrmechanismen offenlegt. Wäre sie das nicht, wäre mein Text harmlos.

Wer über Fettleibigkeit streitet, streitet nicht über Körper. Er streitet über *Realität versus Identität*. Sobald Realität benannt wird, fühlen sich Leute angegriffen, obwohl niemand sie angreift.

Man versteht Übergewicht nicht, solange man es als Essproblem begreift. Ich habe es lange als Essproblem begriffen. Ich esse nicht,

weil ich Hunger habe. Ich esse, weil etwas in mir still werden soll. Essen ist die höflichste Form der Betäubung. Man nennt es Genuss, Bedürfnis, Selbstfürsorge. Hunger ist ruhig. Er meldet sich, wartet, geht wieder. Das hier wartet nicht. Das hier drängt, drückt, wird lauter, wenn ich es ignoriere. Es fühlt sich an wie Notfall, und es ist Unruhe, die gelernt hat, dass sie gefüttert wird. Sobald mein Körper voll ist, wird es dumpf und still. Und genau da verliere ich jedes Mal.

Die Lüge lautet: *Das bin ich*. Als wäre dieses Drängen mein Wesen. Je schneller ich esse, desto weniger bin ich da. Je voller der Körper, desto leerer der Raum. Ich habe mir beigebracht, Leere zu verschlucken. Die fortgesetzte Entscheidung, mich selbst zu unterbrechen.

Das, was jetzt in mir auftaucht, darf nicht da sein.

Appetit wäre etwas anderes. Der entsteht, wenn der Sinn differenzieren kann. Wenn er schmeckt, statt zu füllen. Wer schmecken kann, braucht weniger. Wer nichts mehr schmeckt, braucht mehr. Abstumpfung.⁴

Hunger ist ein Geräusch. Oft das Geräusch von Gift, das seinen Nachschub verlangt.⁵ Wer adipös ist und Hunger spürt, hungert nicht. Er entwöhnt sich. Der Körper schreit, weil er aufhört, vergiftet zu werden.⁶ Wer jedes Verlangen ernst nimmt,

4 Kevin D. Hall, Alexis Ayuketah, Robert Brychta, et al., »Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: An inpatient randomized controlled trial of ad libitum food intake«, in: *Cell Metabolism*, Vol. 30, Issue 1, 16.05.2019, 67–77.

Dana M. Small, »Flavor is in the brain«, in: *Physiology & Behavior*, Vol. 107, Issue 4, 05.11.2012, 540–52.

5 Nora D. Volkow, Roy A. Wise, Ruben Baler, »The dopamine motive system: implications for drug and food addiction«, in: *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 18, Issue 12, 16.11.2017, 741–52.

6 Nahrungsreduktion rekaliibriert Insulinsensitivität, Entzündungsmarker, Stressachsen.

bleibt krank. Wer lernt, Hunger auszuhalten, bekommt seinen Körper zurück.

ÜBERGEWICHT IST EINE GEHIRNKRANKHEIT

Über 2,5 Milliarden Erwachsene weltweit gelten als übergewichtig, 890 Millionen davon als fettleibig oder adipös. Jedes Jahr sterben 3,7 Millionen Menschen an den Folgen. Das entspricht der Bevölkerung Berlins.⁷

Vor vierzig Jahren war Adipositas bei jungen Erwachsenen eine Seltenheit. Heute ist sie Normalzustand.

In Industriestaaten führen Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursachen-Statistik an. Medizinisch handelt es sich um Symptomkomplexe, nicht um Grundursachen. Übergewicht ist die Hauptursache von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und damit die weltweit tödlichste nicht-infektiöse Epidemie.⁸ Ein bedeutender Faktor für Übergewicht wiederum sind Umweltschadstoffe (Schwermetalle, Mikroplastik, Industrie- und Agrarchemikalien, Strahlung), gefolgt vom Mangel an essenziellen Nährstoffen (Vitamin D₃, Omega-3-Fettsäuren).⁹

Valter D. Longo, Mark P. Mattson, »Fasting: Molecular Mechanisms and Clinical Applications«, in: *Cell Metabolism*, Vol. 19, Issue 2, 2014, 181—92.

7 World Health Organization, »Obesity and overweight«, Fact sheet, Dezember 2024.

8 Antonino De Lorenzo, Santo Gratteri, Paola Gualtieri, et al., »Why primary obesity is a disease?«, in: *Journal of Translational Medicine*, Vol. 17, Issue 1, 22.05.2019, Art. 169.

9 Jerrold J. Heindel, Sarah Howard, Keren Agay-Shay, et al., »Obesity II: Establishing Causal Links Between Chemical Exposures and Obesity«, in: *Biochemical Pharmacology*, Vol. 199, Mai 2022, 115015.

Dies., et al., »Obesogens and Obesity: State-of-the-Science and Future Directions«, in: *American Journal of Clinical Nutrition*, Vol. 118, No. 1, Juli 2023, 329—37.

Was in meinem Körper passiert, wenn Fettgewebe über Jahre hinweg wächst, hat wenig mit Kalorien zu tun. Es geht um eine Kaskade zellulärer Ereignisse, die in meinen Fettzellen beginnt und in meinem Gehirn endet. Übergewicht löst im Fettgewebe einen chronischen Brand aus. Dieser überwindet die Schutzmauern des Gehirns, verursacht dort Neuroinflammation und legt zelluläre Kraftwerke lahm.

Ergebnis: spürbarer kognitiver Abbau.

Fettleibigkeit ist langsamer Selbstmord.

Übergewicht ist keine Ästhetikfrage. *Übergewicht ist eine Entzündungskrankheit.*¹⁰ Fettgewebe ist kein passiver Speicher, sondern ein Kontrollturm, der permanent mit dem Körper kommuniziert — ein Sender. Es ist ein endokrines Organ, das permanent Entzündungshormone produziert. Neurodegeneration ist nicht »body-positive«. Das Gehirn kennt keine Diskursethik. Es kennt Sauerstoff, Glukose und Entzündung. Biologische Systeme reagieren auf Belastung. Haltung interessiert sie nicht.

In gesundem Zustand reguliert es Appetit und Immunsystem. Aber wenn dieser Kontrollturm permanent überlastet wird, kippt das System. Die Fettzellen blähen sich auf. Irgendwann ist die Grenze erreicht, dann produziert der Körper einfach mehr Fettzellen. Erst dicker, dann mehr. Das wachsende Gewebe wird nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Sauerstoffmangel löst Stress in den Zellen aus. Diese senden Notsignale, und das Immunsystem reagiert.

Es entsteht eine chronische niedriggradige Entzündung. Fettgewebe produziert Entzündungsbotenstoffe und Hormone, die die Blut-Hirn-Schranke stören. Die Forschung kennt sie unter Kürzeln wie IL-6, TNF- α , Leptin. Dem Gehirn ist die

10 Luisa O. Schmitt, Joana M. Gaspar, »Obesity-Induced Brain Neuroinflammatory and Mitochondrial Changes«, in: *Metabolites*, Vol. 13, Issue 1, 05.01.2023, Artikel 86.

Nomenklatur egal. Kein akutes Fieber, sondern ein ständiges leises Schwelen im Hintergrund. Pathogene und Toxine dringen ins zentrale Nervensystem, lösen Neuroinflammation aus, die wiederum kognitiven Abbau beschleunigt.¹¹ Immunzellen umzingeln tote oder sterbende Fettzellen. Unter dem Mikroskop erscheinen diese als kronenförmige Struktur.

Adipozyten und Makrophagen schütten Signalstoffe aus, die ins Gehirn wandern und dort das lymphatische System und die Hirnhäute verletzen. Das Gehirn wird von innen aufgefressen. Besonders betroffen sind Hirnareale nahe dem dritten Ventrikel, darunter der Hypothalamus. Das stört die Energiehomöostase und bewirkt kognitive Degeneration.¹²

Eigentlich ist die Blut-Hirn-Schranke die strengste Quarantänestation der Welt. Sie kontrolliert extrem genau, was ins Gehirn darf und was nicht. Aber das permanente Schwelen im Körper macht sie mürbe. Entzündungsbotenstoffe machen sie durchlässig, und entzündungsfördernde Moleküle schlüpfen durch. Im Gehirn gibt es eigene Immunzellen, die Mikroglia. Die eindringenden Entzündungsstoffe alarmieren sie, und die Mikroglia heizen die Entzündung vor Ort weiter an.

Dieser Daueralarmzustand führt zu strukturellen Veränderungen. Die Synapsen, die Verbindungen zwischen Nervenzellen, werden beschädigt, die ganze Verkabelung gerät ins Chaos. Nervenzellen sterben ab, die Neubildung stockt. Der Hippocampus, zuständig für Lernen und Gedächtnis, leidet besonders.

11 Verónica Salas-Venegas, Rosa Pamela Flores-Torres, Yesica María Rodríguez-Cortés, et al., »The Obese Brain: Mechanisms of Systemic and Local Inflammation, and Interventions to Reverse the Cognitive Deficit«, in: *Frontiers in Integrative Neuroscience*, Vol. 16, 29.03.2022, 798995.

12 Ophélie Le Thuc, Cristina García-Cáceres, »Obesity-induced inflammation: connecting the periphery to the brain«, in: *Nature Metabolism*, Vol. 6, 12.07.2024, 1237—52.

Eine fettreiche Ernährung führt messbar zu Defiziten im Arbeitsgedächtnis, eine direkte Verbindung von Ernährung über Entzündung bis zu kognitiven Leistungseinbußen.¹³

Die Mitochondrien, die Zellkraftwerke, produzieren über neunzig Prozent meiner Energie. Das Gehirn verbraucht rund zwanzig Prozent davon. Nervenzellen sind auf funktionierende Kraftwerke angewiesen, und genau diese Kraftwerke geraten bei Übergewicht unter Beschuss.

Bei der Energieproduktion entsteht immer Zellmüll, den die Zelle normalerweise entsorgt, aber die chronische Entzündung führt zu massiver Überproduktion. Das Ergebnis ist oxidativer Stress, der die Mitochondrien schädigt. Die Zellmembran wird undicht, die Energieproduktion bricht zusammen.

Wenn die Gehirnzellen ihre Energieversorgung verlieren, ist das ungefähr so wie eine ganze Stadt mit ein paar AA-Batterien zu betreiben. Wartungsprozesse fallen aus, was Schäden durch Neuroinflammation weiter verschärft. Angst steigt. Reizbarkeit steigt. Schlaf sinkt. Konzentration sinkt. Kreativität sinkt. Weil mein Körper im Alarmmodus ist.¹⁴

Hässlich werde ich. Und dümmer.

Der Schaden endet nicht an den äußeren Grenzen meiner Epidermis. *Übergewicht macht meinen Körper zum Depot für Industrieabfälle.* Fettgewebe speichert persistente organische Schadstoffe (POPs) — PCBs, Dioxine, Pestizide —, die sich aufgrund ihrer Lipophilie dort anreichern. Diese Moleküle sind fettlöslich und extrem langlebig, reichern sich in der Nahrungskette an und landen am Ende im Körperfett. Je mehr Fett, desto größer

13 Salas-Venegas et al., ebd.

14 Robert Dantzer, Jason C. O'Connor, Gregory G. Freund, et al., »From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain«, in: *Nature Reviews Neuroscience*, Vol. 9, Issue 1, Januar 2008, 46—56.

die Ladung.¹⁵ Das Gehirn ist das Endlager. Schwermetalle, radioaktive Partikel, endokrine Disruptoren wandern durch Nahrungsketten, Grundwasser, Atemluft und enden im empfindlichsten Organ des Körpers.

Wer die Umwelt vergiftet, vergiftet das Denken. Übergewicht und Umweltgifte degenerieren die menschliche Intelligenz. Industriestaaten produzieren beides im Überfluss.¹⁶

Übergewicht potenziert praktisch jeden anderen Risikofaktor. Ich werde von praktisch allem stärker verletzt, sobald ich übergewichtig bin. Und damit das klar ist: Nur weil jemand schlank aussieht, heißt das nicht, dass sein Stoffwechsel gesund ist. Übergewicht beginnt nicht erst dort, wo man es sieht. Menschen mit gleichem BMI, gleicher Größe und gleichem Alter können völlig unterschiedliche Mengen an innerem Fett haben.¹⁷

Es gibt zwei Hauptarten von Körperfett: *Unterhautfettgewebe* und *viszerales Fettgewebe*.

15 Erin Jackson, Robin Shoemaker, Nika Larian, Lisa Cassis, »Adipose Tissue as a Site of Toxin Accumulation«, in: *Comprehensive Physiology*, Vol. 7, Issue 4, 12.09.2017, 1085—135.

Michele La Merrill, Claude Emond, Min Ji Kim, et al., »Toxicological Function of Adipose Tissue: Focus on Persistent Organic Pollutants«, in: *Environmental Health Perspectives*, Vol. 121, Issue 2, 05.12.2012, 162—9.

16 Heindel et al. 2022.

Ders. et al. 2023.

17 Isabel Huang-Doran, Alison Sleight, Justin J. Rochford, »Lipodystrophy: metabolic insights from a rare disorder«, in: *Journal of Endocrinology*, Vol. 207, 2010, 245—55.

Elif Arioglu Oral, Vinaya Simha, Elaine Ruiz, et al., »Leptin-Replacement Therapy for Lipodystrophy«, in: *The New England Journal of Medicine*, Vol. 346, 2002, 570—8.

E. Louise Thomas, Gary Frost, Simon D. Taylor-Robinson, Jimmy D. Bell, »Excess body fat in obese and normal-weight subjects«, in: *Nutrition Research Reviews*, Vol. 25, 25.05.2012, 150—61.

Unterhautfettgewebe macht bei gesunden Menschen etwa neunzig Prozent des gesamten Körperfetts aus. Viszerales Fett hingegen liegt tief unter der Bauchmuskulatur, in den Zwischenräumen um Leber, Darm und andere Organe.

Letzteres ist das gefährlichere Fett. Fettzellen sind biologisch aktiv. Viszerale Fettzellen aber sind noch aktiver. Sie sondern Hormone und andere Moleküle ab, die Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben.¹⁸ Viszeralfettansammlung ist mit Insulinresistenz, Entzündungen und Fettstoffwechselstörungen assoziiert¹⁹, was wiederum Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz begünstigt.

Viszerales Fett ist nicht immer von außen sichtbar. Ich kann einen flachen Bauch haben und trotzdem viszerales Fett in mir tragen.²⁰ Der Spiegel zeigt nichts. Die Waage zeigt nichts. Der Bauchumfang lügt mit. Zwei Personen mit identischen 84 Zentimetern Bauchumfang können völlig unterschiedliche Mengen an viszeralem Fett tragen — der eine metabolisch gesund, der andere am Verrotten.²¹

Bei TOFI-Typen — »Thin Outside, Fat Inside« — tragen Menschen bei normalem BMI fast sechs Liter viszerales Fett. Die Medizin nennt es Normalgewichtsadipositas.²² Der Haus-

18 Harvard Health Publishing, »Taking aim at belly fat«, 26.03.2024.

19 Sahakyan et al., ebd.

20 Thomas et al., ebd.

21 Ellen Louise Thomas, Joanne R. Parkinson, Gary S. Frost, et al., »The Missing Risk: MRI and MRS Phenotyping of Abdominal Adiposity and Ectopic Fat«, in: *Obesity*, Vol. 20, Issue 1, 06.09.2012, 76—87.

André Tchernof, Jean-Pierre Després, »Pathophysiology of Human Visceral Obesity: An Update«, in: *Physiological Reviews*, Vol. 93, Issue 1, 359—404.

22 Estefania Oliveros, Virend K. Somers, Ondrej Sochor, et al., »The Concept of Normal Weight Obesity«, in: *Progress in Cardiovascular Diseases*, Vol. 56, Issue 4, 2014, 426—33.

arzt nennt es kerngesund. Vier bis fünf Kilogramm metabolisch aktives Gewebe, das permanent Entzündungsstoffe produziert, während man sich schlank wähnt.²³

Es gibt Menschen, die speichern Fett unter der Haut. Sichtbar, metabolisch harmlos. Und es gibt Menschen wie mich. Was andere puffern, landet bei mir zwischen den Organen.

Normalgewichtige Menschen mit Fett in der Körpermitte haben ein höheres Sterberisiko als übergewichtige oder adipöse Menschen mit normaler Fettverteilung.²⁴ Menschen also, die dein Hausarzt als »kerngesund« einstuft, sterben früher als sichtbar Übergewichtige.

In einer 15-Jahres-Studie verfolgten Forscher junge Erwachsene. Nach Bereinigung aller Faktoren blieb kein statistisch nachweisbarer Zusammenhang zwischen BMI und Sterberisiko.²⁵ Der BMI teilt Gewicht durch Körpergröße und ignoriert, woraus dieses Gewicht besteht. Er klassifiziert Kranke als gesund und Gesunde als krank. Für Übergewicht ist er so zuverlässig wie Bleigießen für Herzdiagnosen.

Übergewicht bildet mit dem Tabak die tödlichste aller Allianzen.²⁶ Wer raucht und zunimmt, addiert nicht. Er multipliziert. Dreißig Prozent der Übergewichtigen rauchen. Gao und

23 Bell, zit. n. Ian Sample, »Are you a Tofi? (That's thin on the outside, fat inside)«, in: *The Guardian*, 10.12.2006.

24 Karine R. Sahakyan, Virend K. Somers, Juan P. Rodriguez-Escudero, et al., »Normal-Weight Central Obesity: Implications for Total and Cardiovascular Mortality«, in: *Annals of Internal Medicine*, Vol. 163, No. 11, 10.11.2015, 827—35.

25 Arch G. Mainous III, Lu Yin, Velyn Wu, et al., »Body Mass Index vs Body Fat Percentage as a Predictor of Mortality in Adults Aged 20—49 Years«, in: *Annals of Family Medicine*, Vol. 23, Issue 6, Juni 2025, 240330.

26 De Lorenzo et al. 2019.

Kollegen kartographierten diese doppelte Gehirnverwüstung.²⁷ Während Rauchen die Kreativitätszentren (Präfrontalkortex, Precuneus) vernichtet, zerstört Übergewicht Belohnungs- und Kontrollzentren (frontaler und temporaler Kortex). Wer raucht und zugleich übergewichtig ist, verstärkt seine nikotinbedingte Neurodegeneration exponentiell. Schon leichtes Übergewicht — nicht erst Adipositas — genügt.

Raucher sehen schlanker aus, da Nikotin den Stoffwechsel künstlich anheizt. Doch ihr Bauchfett wuchert toxischer, die Fettverteilung wird pathologisch. Je mehr Zigaretten, desto mehr viszerale, verstecktes Fett. Nach meinem Rauchstopp kamen fünfundzwanzig Kilo. Suchtverschiebung durch Bier, Salz, fettreiche Kost. Auch Salz ist ein Betäubungsmittel. Das viszerale Fett explodierte, weil mein Körper Unterhautfett nicht speichern kann. Der zerstörte Stoffwechsel liefert die perfekte Rückfall-Ausrede.²⁸

Bei Langzeitrauchern schrumpft das Stirnhirn, der parietale Kortex versucht krampfhaft zu kompensieren. Bei Übergewichtigen kollabieren zusätzlich die Kontrollzentren. Beide Schädigungsmuster überlagern sich, das Gehirn verwebt beide Süchte unlösbar. Getrennte Therapien scheitern systematisch. Raucherstudien ohne Gewichtskontrolle sind Selbsttäuschung — sie unterschätzen die wahre Zerstörung.²⁹

27 Xinyu Gao, Mengzhe Zhang, Zhengui Yang, et al., »Explore the effects of overweight and smoking on spontaneous brain activity: Independent and reverse«, in: *Frontiers in Neuroscience*, Vol. 16, 12.10.2022.

28 Gao et al., ebd.

29 Gao et al., ebd.

SCHÖNHEIT

Michelangelos David. Das ist ein schöner Körper. Kein Schwabbeln, keine Aufblähung. Klarheit, in Stein gehauen.

Gesundheit ist schön. Ein dünner Körper ist schön. Wer heute »normalgewichtig« sagt, meint meist Übergewicht. Das Wertesystem ist so verzerrt, dass tatsächliches Normalgewicht als anorektisch gilt.

Ein Körper, der wenig trägt, kann viel leisten. Ein Körper, der nicht entzündet ist, denkt klarer. Ein Körper, der nicht vollgestopft ist, fühlt präziser. Dünnheit heißt nicht Verhungern. Das hat man uns beigebracht. Damit wir Schönheit relativieren. Damit wir Krankheit nicht benennen, nur bezahlen. Das Ergebnis — Verwirrung. Wir sehen Krankheit. An uns. An anderen. Wir schweigen. Sind wirr im Kopf. Manchmal sogar so wirr, dass wir denken, das sei normal.

Wenn zwei Drittel der Leute in deiner Umgebung übergewichtig sind, kommt dir Gesundheit plötzlich radikal vor. Glaubst du ernsthaft, deine Wahrnehmung ist ungetrübt?

Ein fatter Körper ist sensorisch laut. Man sieht ihn, bevor man ihn erkennt. Man riecht ihn, bevor man ihn berührt. Süßlich, säuerlich, abgestanden riecht er. Nicht wegen der Hygiene, sondern wegen des Stoffwechsels — er ist entzündet. Schweiß trieft aus seinen Poren. Haut, die spannt, glänzt, aufgedunsen wirkt. Bewegungen, die nicht fließen, sondern geschoben werden. Ach, wie anstrengend doch alles ist.

Beim Sitzen sackt der fette Körper zusammen. Die Wirbelsäule gibt nach, als würde sie wissen, dass sie zu viel tragen muss. Die Schultern fallen nach vorne. Der Brustkorb kollabiert. Der Atem bleibt oben hängen — flach, unruhig, immer zu kurz.

Das habe ich alles am eigenen Leib erfahren. Es ist keine Stigmatisierung, nur Lebenserfahrung plus Beobachtung. Der fettgefressene und gesoffene Körper ist ständig beschäftigt. Mit sich selbst, dem eigenen Dafürhalten, den eigenen Wahnsinnsideen.

Er braucht Pausen, bevor er begonnen hat. Er schwitzt ohne Anlass. Er sucht Halt, wo kein Halt ist. Fetter, stinkender, kranker Körper. Das nennst du Akzeptanz?

Du siehst es im Gesicht. Nicht als Schuld, sondern als Zeichen. Die Augen wirken stumpf. Der Blick hat keine Tiefe. Die Mimik grob. Mikroreaktionen hinfort getilgt, weil das Nervensystem bereits mit Grundrauschen ausgelastet ist.

Ein dünner Körper dagegen. Der wirkt leer. Und das macht ihn schön. Leer sein heißt frei. Die Haut liegt ruhig auf dem Muskel, kein Druck von innen. Die Bewegung ist ökonomisch. Ein Schritt ist keine Verhandlung. Ein Atemzug ist tief, geräuschlos, vollständig. Schön ist das, ganz ohne dass mein Denken das mit »positivity« verklebt.

Einfach gesunder Menschenverstand. Intuition.

Dünnere schöner gesunder Körper riecht nach nichts. Er steht im Raum, ohne ihn zu dominieren. Nimmt Platz ein, ohne sich auszubreiten. Präsenz ohne Masse. Wirkung ohne Volumen. Michelangelos David zeigt einen Körper, der nicht gegen sich selbst arbeitet. Körper, die kämpfen könnten. Keine Körper, die sich selbst wie Abfall verwalten.

Wer nicht mit sich selbst beschäftigt ist, kann sich der Welt zuwenden.

Für das Gehirn dasselbe. Ein von Alkohol, Zucker, Koffein und Dauerreiz zerstörtes Gehirn ist nicht authentisch. Es ist vernebelt. Dass man diesen Nebel heute Identität nennt, ändert nichts daran, was er ist. Gesundheit ist nicht verhandelbar. Wer aufhört, sich zu vergiften, wird schöner. Wahrnehmbarer, klarer, anwesender. Wer es nicht tut, stinkt einfach.

Biologie ist unhöflich. Sie fragt nicht nach Identität. Sie fragt nach Blutwerten. Entzündungsmarkern. Taillenumfang. Arterien. Biologie ist Realität. Du kannst acht Semester Soziologie studieren. Du stinkst immer noch. Und die Mode, Realität als Gewalt zu lesen, ändert die Physik ebenso wenig. Du stinkst.

Man kann die Wahrnehmung umschreiben. Man kann sie psychotisch brechen. Man kann Sprache verbiegen. Man kann Statistiken auslegen. Aber man kann Entzündung nicht wegdiskutieren. Der Körper bleibt unerbittlich analog. Und genau deshalb ist er der Ort, an dem jedwede Ideologie scheitert.

Auch deine.

Es gibt zwei Arten Frieden. Der eine ist Betäubung. Es ist halt so. *Ich bin so. Lass mich.* Der andere ist Realität. *Es ist so. Und es kann anders werden.* Der erste kostet das Leben, mal langsam, mal schnell. Der zweite kostet kurzfristig Komfort.

Ich muss wählen. Identität oder Körper.

Beides geht nicht.

BEOBACHTUNG VERASCHT JEDEN DÄMON

*Wenn wir aufhören, das Falsche zu tun,
geschieht das Richtige von selbst.*

F. M. Alexander

Der Satz klingt wie eine Binsenweisheit. Er ist das Gegenteil. Er zerlegt die gesamte Selbstoptimierungsindustrie in einen Atemzug. Nicht das Richtige tun müssen wir lernen. Wir müssen aufhören, störend einzugreifen.

Das Falsche ist kein moralischer Fehler. Es ist das ständige, zwanghafte Einmischen des Egos in alles, was geschieht. Gedanke — Reaktion. Gefühl — Reaktion. Das kostet Kraft. Das versklavt. Und wir tun es trotzdem, weil ein Glaubenssatz in uns arbeitet, der älter ist als wir selbst: *Ich muss es kontrollieren.*

Allein dieser Gedanke, jetzt sofort etwas tun müssen, um das Problem zu lösen, ist bereits die Störung. Er verspannt das gesamte Nervensystem. Das Falsche nach Alexander ist der neurotische Impuls einzugreifen.

Das heißt nicht, gar nichts zu tun. Reaktives Handeln zum Schutz des eigenen Lebens ist Körperintelligenz, kein Problem. Falsche Einmischung bezieht sich auf den inneren Zustand. Wer Angst hat und sich verpflichtet fühlt, diese Angst wegzubekommen — das ist Einmischung. Wer traurig ist und eine Stimme in sich hört, die sagt »*Reiß dich zusammen*« — das ist Einmischung. Der Kampf gegen das, was gerade ist. Der innere Bürgerkrieg, den wir ständig führen.

Bei den Samurai heißt dieses Prinzip 無心, *mushin* — der leere Geist. Ein Zustand frei von Gedanken, Emotionen, Angst, der

zu spontanen, perfekten Reaktionen führt. Die Basis ist *Wu Wei*, 無為: Handeln im Einklang mit dem natürlichen Fluss, ohne Widerstand, wie Wasser, das seinen Weg findet.

Miyamoto Musashi sagte, dass das höchste Ziel der Kampfkunst ist, sie nicht einsetzen zu müssen. Der eigentliche Sieg führt gar nicht erst zum Kampf. Ich muss meine Ängste sortieren, mein Ego besiegen, dann erst besiege ich meine Gegner.

Die Samurai konzentrierten sich nicht auf den Feind, sondern auf die Handlung. Jede Bewegung war effizient, notwendig, ohne Zutat durch Ego oder Angst. Das Ich löst sich auf, weil es mit der Handlung in eins fällt. Es gibt kein vom Kampf separiertes Ich. Es löst sich in dem, was es tut, vollständig auf. Handeln so mühelos, dass es wie Nicht-Handeln erscheint, aber in Wahrheit die ultimative Form des Handelns ist, weil es wirklich einen Unterschied macht.

Die meisten Menschen machen ihren Kopf schwer durch Sorgen, Anspannung im Nacken, die Idee »*Ich muss meinen Kopf halten*«. Eine Giraffe tut nichts, um ihren Kopf auf diesem langen Hals zu balancieren. Das ist ihre Natur. Der Mensch hingegen produziert Störung. Wer damit aufhört, dessen Kopf kehrt in seinen natürlichen Zustand zurück. Das Richtige wächst, sobald wir aufhören einzugreifen.

Das ist das Gegenteil von allem, was heute propagiert wird. Ziele setzen. Visualisieren. Kämpfen. All das Gehetze ist verschenkte Liebesmüh. Die krampfhafte Anstrengung selbst hält das Problem aufrecht, weil sie der Annahme entspringt, so wie ich bin, sei ich nicht in Ordnung.

Diese Selbstsabotage wird von einem Teil in uns angetrieben, den Alexander »das falsche Selbst« nannte.¹ Ein Patchwork aus belasteter Biografie, nachgeplapperten Überzeugungen,

1 *The Use of the Self*, New York 1932.

täuschenden Gefühlen, entfremdenden Konditionierungen. Der Irrtum ist, zu glauben, das alles seien wir. Ein Kartenhaus, das nur steht, weil wir daran glauben.

Wer im Laden Schlange steht und denkt »*Na toll, jetzt komme ich zu spät, der Tag ist ruiniert*« — das ist nicht das wahre Selbst. Das ist das Patchwork-Ich, das alles so rahmt, dass es dem unausgesprochenen Imperativ »*Du darfst nicht glücklich sein*« entspricht. Egal wie gut es läuft: Das Patchwork-Ich erfindet sich immer etwas, worüber es sich ärgern kann.

Die Frage ist nicht, ob die eigene Geschichte wahr ist, sondern ob ich Gefangener meiner Geschichte bin oder der Raum, in dem sie erscheinen darf.

Das Patchwork-Ich ist die Rolle im Theaterstück. Das wahre Selbst ist die Bühne. Oder genauer: das Bewusstsein, das alles wahrnimmt. Ein wortlos beobachtendes Selbst, das nicht nur Gedanken und Gefühle beobachtet, sondern auch den Beobachter dieser Gedanken und Gefühle. *Wir denken, wir seien eine Person, die das Universum betrachtet. In Wahrheit sind wir das Universum, das eine Person betrachtet.*

Gedanken und Gefühle sind Wolken. Sie kommen und gehen, mal dunkel, mal hell. Der Himmel, in dem sie ziehen, bleibt unberührt. Friedlich, weit, still. Das wahre Selbst ist dieser Himmel. Kein Ort, sondern eine Gemütslage. Pure Präsenz. Der Himmel leidet nicht, egal wie stürmisch die Wolken.

Während meines geschichtswissenschaftlichen Studiums las ich Berichte von KZ-Häftlingen, die das Grauen überlebten, weil sie nie über das große Ganze nachdachten. Sie konzentrierten sich auf diesen einen Moment. Das Leid wurde kleinteilig, sequenziell, erträglicher als das Gesamtbild. So schützten sie sich davor zu zerbrechen.

Nicht äußerer Druck sperrt uns in die Mittelmäßigkeit. Ein innerer Dämon tut das, den wir für uns selbst halten.

Praktisch heißt das: reine Beobachtung. Normalerweise verschmelzen wir mit unseren Problemen. Wir sagen »*Ich bin ängstlich*«, »*Ich bin krank*«. Keine Trennung, nur Identität. Beobachtung schafft Distanz. Das »*Ich bin ängstlich*« wird zu »*Ich nehme wahr, dass Angst auftaucht*«. Die Angst wird vom Teil der Identität zum Objekt. Niemand ist mehr ängstlich. Jemand ist derjenige, der die Angst wahrnimmt.

Ein Mann, der unter extremer Erschöpfung litt, hörte auf, den Satz »*Ich bin erschöpft*« zu glauben. Stattdessen beobachtete er die Müdigkeit als Phänomen in seinem Körper. Neugierig, ohne zu bewerten, ohne sie weghaben zu wollen. Der Zustand verwandelte sich von selbst in etwas von Frische und Licht Durchzogenes.

Das ist der Kern. Das krampfhaftes Tun — Analysieren, Kämpfen, Lösen-Wollen — wird ersetzt durch absichtsloses Sehen.

Es geht nicht darum, die bösen Geister loszuwerden, sondern sie willkommen zu heißen. Beobachtung verascht jeden Dämon. Sobald ich auf ihn einsteige, reagiere, antworte, zweifle — hat er gewonnen. Der Kampf gegen die Angst ist das Problem. Es ist, als würde man Wellen mit einem Bügeleisen glätten. Man erzeugt nur mehr Chaos.

Im Wahrnehmungsmodus sind wir intelligenter als unser Denken. Die Quelle fließt, sobald wir aufhören, den Staudamm zu bauen. Wir müssen die Heilung nicht machen. Wir müssen aufhören, sie zu blockieren.

Heilung bedeutet nicht, dass Symptome verschwinden müssen. Heilung ist die Erkenntnis des Ortes in uns, der bereits heil ist. Der immer unversehrte Teil, gleich welches Skript im Körper oder Geist abläuft. Frieden entsteht wenn wir entdecken, dass wir nicht unsere Probleme sind.

Der Schlüssel ist, das Theaterstück zu durchschauen. Nicht länger der Schauspieler zu sein, sondern die Bühne. Der stille Raum, in dem alles erscheinen und verschwinden darf.

Wer das nächste Mal mit einem Problem kämpft und sich fragt, wie das zu lösen sei: *Die Frage ist falsch. Nicht das Problem braucht eine Lösung. Das Ich, das glaubt, ein Problem zu haben, braucht eine Untersuchung.*

